

근거 기반 영유아 발달·양육 실행 매뉴얼 · 0~5세

# 돌아올 자리

첫 5년, 무엇을 하고  
무엇을 생각하고 무엇을 준비할 것인가

40장 + 부록 A~M

AAP · CDC · WHO · 하버드 아동발달센터

질병관리청 · 국민건강보험공단(K-DST)

이 책은 교육 목적의 정리본이며 진단·치료를 대체하지 않습니다.

아이 상태에 대한 판단은 반드시 소아청소년과 전문의와 상의하세요.

예방접종 일정·검진 차수·정부 지원금은 정책 변경이 잦으므로 40장의 공식 확인처에서 최신본을 확인하세요.

# 목차

---

## 이 책을 읽는 법

### 여는 글 — 약속

#### 1부 · 판 읽기

- 1장 · 아이는 나갔다 돌아온다
- 2장 · 뇌는 쓰는 대로 만들어진다
- 3장 · 아이는 다르게 태어난다
- 4장 · 무엇을 믿을 것인가

#### 2부 · 도구함

- 5장 · 네 박자
- 6장 · 감정 코칭
- 7장 · 훈육
- 8장 · 환경 설계
- 9장 · 놀이와 말

#### 3부 · 시기별 적용

- 10장 · 임신 후기 ~ 출생
- 11장 · 0~3개월
- 12장 · 4~6개월
- 13장 · 7~12개월
- 14장 · 13~24개월
- 15장 · 24~36개월
- 16장 · 만 3~5세

#### 4부 · 몸의 일

- 17장 · 수유
- 18장 · 이유식 · 알레르기 · 편식
- 19장 · 재우기
- 20장 · 열
- 21장 · 흔한 병 12가지
- 22장 · 응급처치 실전
- 23장 · 피부 · 치아 · 약 먹이기

#### 5부 · 나를 지킨다

- 24장 · 산모의 몸 회복

- 25장 · 산후우울

- 26장 · 부부

- 27장 · 죄책감과 번아웃

- 28장 · 복직과 인계

#### 6부 · 제도를 쓴다

- 29장 · 출생 직후 행정 30일
- 30장 · 영유아 건강검진 완전 가이드
- 31장 · 예방접종 완전 가이드
- 32장 · 현금성 지원
- 33장 · 서비스 지원 — 사람이 오는 도움
- 34장 · 어린이집 · 유치원
- 35장 · 아플 때 어디로 가나
- 36장 · 발달지연이 의심될 때

#### 7부 · 확인한다

- 37장 · 경고 신호 총정리
- 38장 · 걱정하지 않아도 되는 것 12가지
- 39장 · 흔한 걱정 행동
- 40장 · 정보의 진위를 가리는 법

#### 부록 A · 시기별 준비물 마스터

#### 부록 B · 5년 캘린더

#### 부록 C · 월간 점검표

#### 부록 D · 병원 방문 준비 시트

#### 부록 E · 응급 대응 한 장 — 채워서 붙이는 양식

#### 부록 F · 부부 합의서

#### 부록 G · 조부모·양육자 위임 한 장

#### 부록 H · 여아 건강·위생 요약

#### 부록 I · 성장 기록 · 첫 순간

#### 부록 J · 기관 연락처

#### 부록 K · 환경 · 이동

#### 부록 L · 이 책 활용 순서

#### 부록 M · 이 책의 출처

#### ♥ 닫는 글

# 이 책을 읽는 법

여기만 읽으셔도 이 책 전체를 쓰실 수 있어요.

## 이건 어떤 책인가요

처음부터 끝까지 읽는 책이 아니라, 필요할 때 펴는 책입니다.

요리책을 생각하시면 됩니다. 요리책을 1장부터 읽는 사람은 없지요. 오늘 만들 것을 찾아 그 쪽만 펴고, 다 되면 덮습니다. 이 책도 그렇게 쓰시라고 만들었어요.

그래서 다음 세 가지가 이 책의 규칙입니다.

- 끝까지 읽지 않으셔도 됩니다. 처음 40쪽에 핵심이 다 들어 있어요.
- 같은 말이 여러 번 나옵니다. 일부러 그랬습니다. 21장만 펴는 사람도 필요한 걸 다 얻어야 하니까요.
- 읽고 나서 하는 게 아니라, 하면서 읽는 책입니다. 각 장 끝에 「👉 이번 주 한 가지」가 있어요. 그거 하나면 됩니다.

## 어떻게 읽나요 — 세 가지 진입로

| 상황     | 이렇게 하세요                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 처음 펼쳤다 | 여는 글 → 1부 → 2부. 여기까지가 핵심입니다. 3부부터는 사전처럼 쓰세요                                |
| 아이가 있다 | 3부에서 <b>지금 월령의 장 하나만</b> . 잠이 부족한 날엔 그 장 첫머리의 「👁 이번 달 딱 3가지」 세 줄만 읽으셔도 됩니다 |
| 급하다    | 아프다 → 4부 · 열난다 → 20장 · 뭔가 이상하다 → 37장 · 월 사나 → 부록 A · 내가 힘들다 → 5부           |

맨 뒤의 색인은 증상·주제 가나다순입니다. 새벽에 뭔가를 찾아야 할 때는 목차보다 색인이 빠릅니다.

## 본문에 붙은 기호들

장마다 같은 순서로 같은 블록이 나옵니다. 기호만 알면 필요한 곳으로 바로 뛰어넘을 수 있어요.

| 기호                             | 뜻                             | 잠이 부족한 날엔 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 👁 이번 달 딱 3가지                   | 그 시기에 이것만 하면 되는 세 가지          | 여기만       |
| 💖 위로 블록                        | 마음에 대한 이야기. 지시가 아니라 말 걸기      | 힘들 때만     |
| 📊 발달 이정표                       | CDC 기준 "이 나이 아이 넷 중 셋이 하는 것"  | 건너뛰어도 됨   |
| 👉 행동 / 🧠 생각 / 📦 물건             | 할 것 / 버리고 붙잡을 생각 / 살 것과 안 살 것 | 📦만 봐도 됨   |
| 🕒 하루 일과 · 👩‍👧 여아 건강·위생 · ❓ FAQ | 예시 일과 / 딸아이 특화 / 자주 묻는 것      | 필요할 때만    |
| 🚩 경고 신호                        | 병원에 가야 하는 선. 이 책에서 가장 중요한 블록  | 꼭         |
| ⚖️ 결론만 말하면                     | 논쟁이 있는 주제의 현재 결론 한 줄          | 궁금할 때     |
| ✅ 체크리스트                        | 펜으로 체크하며 쓰는 칸                 | 월말에       |
| 👉 이번 주 한 가지                    | 그 장에서 딱 하나만 한다면 이것            | 여기만       |

| 기호        | 뜻                                 | 잠이 부족한 날엔 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 요약 3줄     | 장 끝의 세 줄 요약                       | 여기만       |
| 오려 쓰는 한 장 | 읽지 말고 인쇄해 벽에 붙이는 회색 상자<br>(아래 설명) | 미리 붙여두기   |

세 줄로 줄이면: 급할 땐 , 오늘 뭘 할지 모르겠으면 과 , 다 읽기 싫으면 .

## 「오려 쓰는 한 장」이 뭔가요

책 곳곳에 회색 상자가 나옵니다. 그건 읽는 부분이 아니에요.

인쇄하거나 옮겨 적어서, 벽에 붙이라고 만든 한 장짜리 요약입니다.

이유는 단순합니다 — 급할 때는 책을 펼 수 없거든요. 새벽 두 시에 아이가 39℃로 열이 나는데 180쪽짜리 책의 목차를 뒤지고 있을 수는 없습니다. 그래서 그 순간에 필요한 것만 뽑아, **문에 붙여두는 형태로** 따로 만들었습니다.

붙일 곳은 **냉장고 문, 아이 방문, 시터가 보는 자리, 조부모 댁** — 손이 닿는 곳이면 어디든 좋습니다.

여덟 장이 본문 곳곳에 있고, 부록에 하나가 더 있어요.

| 시트             | 어디에   | 언제 쓰나                  |
|----------------|-------|------------------------|
| ① 1부 요약        | 1부 끝  | 원리를 잊었을 때              |
| ② 감정 코칭        | 6장 끝  | 아이가 떼쓸 때               |
| ③ 안전 필수 8      | 8장 끝  | <b>집에 아이가 오기 전</b>     |
| ④ 도구함 전체       | 2부 끝  | 이 책의 기술 전체             |
| ⑤ 「병원에 가야 하나?」 | 21장 끝 | <b>아플 때</b>            |
| ⑥ 응급 대응        | 22장 끝 | <b>응급 상황</b>           |
| ⑦ 부모를 위한 것     | 5부 끝  | 내가 무너질 때               |
| ⑧ 제도           | 6부 끝  | 신청할 게 있을 때             |
| 부록 E           | 부록    | 빈칸에 우리 아이 정보를 적어 넣는 양식 |

지금 딱 하나만 하신다면 **부록 E**입니다. 아이 체중, 해열제 용량, 소아과 전화, 야간 병원, 119·1339를 적는 칸이 있어요. 인쇄해서 채우는 데 5분, 그리고 언젠가 그 5분이 새벽을 구합니다.

## 표기 규칙 세 가지

① 근거의 세기가 문장 끝에 붙습니다

| 표시        | 뜻                                             |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>강함</b> | 학회 권고나 체계적 고찰에서 일관되게 지지됨. <b>그대로 따르셔도 됩니다</b> |
| <b>보통</b> | 근거는 있으나 논쟁 중이거나 연구가 제한적                       |
| <b>관행</b> | 널리 쓰이지만 근거는 약함. <b>안 하셔도 크게 문제없습니다</b>        |

**관행**이 붙은 것들 때문에 죄책감 느끼지 마세요. 그러라고 붙인 표시입니다.

## ② 말투가 두 번 바뀝니다

| 목소리            | 쓰는 곳            | 예                            |
|----------------|-----------------|------------------------------|
| 말을 거는 목소리(해요체) | 💛 위로 블록, 장면, 마음 | "힘든 건 당신이 못해서가 아니에요."        |
| 알려주는 목소리(합니다체) | 🚩 경고·응급·안전·근거   | "3개월 미만 + 38.0℃는 즉시 응급실입니다." |

안전과 응급에서는 일부러 부드럽게 쓰지 **않았습니다**. 그 자리에서 말이 물러지면 위험하니까요.

## ③ 정책 숫자는 본문에 박지 **않았습니다**

예방접종 일정, 검진 차수, 지원금 액수는 자주 바뀝니다. 그래서 **금액 대신 확인처와 신청 시점**을 적어두었어요. 이 책이 낡아도 확인처는 낡지 않습니다. (→ 40장)

**한 문장으로:** 🚩는 꼭 보시고, ✂️는 인쇄해서 붙이시고, 나머지는 필요할 때 펴세요.

→ 다음: 여는 글 · 약속

# 여는 글 — 약속

## 지금, 어떤 마음이신가요

이 책을 펼치신 이유가 여러 가지겠지요.

곧 아이가 태어나서 설레는 마음일 수도 있고, 이미 태어난 아이 옆에서 잠이 부족한 채로 뭐라도 붙잡고 싶은 마음일 수도 있어요. 어쩌면 오늘 아이에게 소리를 질렀고, 그게 마음에 걸려서 열어보셨을지도 모르겠습니다.

어느 쪽이든, 잘 오셨어요.

먼저 한 가지만 말씀드리고 시작할게요.

**당신은 이미 충분히 잘하고 있습니다.** 이 책을 펼쳤다는 것이 그 증거예요. 아무래도 상관없는 사람은 이런 책을 찾지 않거든요.

## 이 책이 태어난 자리

새벽 두 시를 상상해볼게요.

아이가 사십 분째 울고 있어요. 안아도 안 그치고, 먹여도 안 그칩니다. 당신은 결국 한 손으로 아이를 안은 채 검색창에 "신생아 계속 울 때"를 칩니다.

스크롤을 내리면 서로 다른 말을 하는 글이 열 개쯤 나와요. 어떤 글은 안아주라 하고, 어떤 글은 울려야 한다고 합니다. 그중 절반은 무언가를 팔고 있고요. 결국 아무것도 결정하지 못한 채 휴대폰을 내려놓습니다. 그리고 아이는 여전히 울고 있어요.

**이 책은 그 새벽을 위해 만들어졌습니다.**

당신에게 필요한 건 더 많은 정보가 아니라, 믿을 만한 정보 하나와 "이건 정상이예요"라는 한 마디니까요.

## 이 책을 덮을 때 당신이 할 수 있게 되는 것

1. **아이의 신호에 반응하는 법을 안다.** 이름 붙은 기술이 하나 있고, 그게 0개월부터 5세까지 쭉 통해요.
2. **떼쓰는 아이 앞에서 무슨 말을 할지 안다.** 열두 가지 상황의 대사를 그대로 쓰셔도 됩니다.
3. **아플 때 집에서 볼 것과 병원 갈 신호를 구분할 수 있다.** 흔한 병 열두 가지가 반 페이지씩 정리돼 있어요.
4. **무엇을 사고 무엇을 안 사도 되는지 안다.**
5. **국가가 주는 것을 놓치지 않는다.** 검진 열두 번, 접종, 지원금.
6. **정보의 진위를 스스로 가릴 수 있다.** 이게 가장 오래 쓰실 능력이에요.

그리고 하나 더 — 덜 불안해집니다.

이 책의 절반은 "무엇을 해야 하는가"이고, 나머지 절반은 "무엇을 안 해도 되는가"예요. 사실 후자가 더 중요할지도 모르겠습니다.

## 이 책을 쓴 사람에 대해

이 말씀을 먼저 드리는 게 맞을 것 같습니다.

**저는 의사가 아닙니다.** 소아과 전문의도, 발달 연구자도 아니예요.

그래서 이 책에는 **제 의견이 거의 없습니다.** 대신 미국소아과학회(AAP), 미국질병통제예방센터(CDC), 세계보건기구(WHO), 하버드대 아동발달센터, 질병관리청, 국민건강보험공단이 공개한 권고문을 읽고, **한국의 부모가 실제로 쓸 수**

있는 순서로 옮겨 적었습니다.

그러니까 이 책의 역할은 전문가가 아니라 정리하는 사람에 가깝습니다.

이게 왜 중요하냐면 —

- 이 책에서 어떤 판단이 애매하게 느껴진다면, **그건 제 판단이 아니라 원 권고가 그렇다는** 뜻입니다. 부록 M에서 원 출처를 확인하실 수 있어요.
- 반대로 이 책과 **담당 소아과 의사의 말이 다르다면, 의사를 따르세요.** 의사는 당신의 아이를 봤고 저는 못 봤습니다.
- 그리고 이 책은 **한 번도 의료 전문가의 검토를 받지 않았**습니다. 그 사실을 숨기지 않는 편이 낫다고 생각했어요.

정책·권고는 바뀝니다. 특히 예방접종 일정, 검진 차수, 정부 지원금은 40장의 공식 확인처에서 최신본을 보세요.  
이 책이 낡았을 때 낡은 줄 알 수 있게, 확인처를 본문 곳곳에 적어두었습니다.

## 이 책이 하지 않는 약속

솔직하게 말씀드릴게요.

- **아이를 잘 재우게 만들어 드리지는 못해요.** 그건 아이가 결정합니다. 대신 무엇이 정상이고 무엇이 아닌지는 알려드릴게요.
- **완벽한 부모로 만들어 드리지도 않습니다.** 오히려 그 목표를 내려놓으시라고 설득할 거예요.
- **영재로 키우는 법은 없어요.** 그런 방법의 근거는 존재하지 않고, 이 책은 근거 없는 걸 쓰지 않습니다.

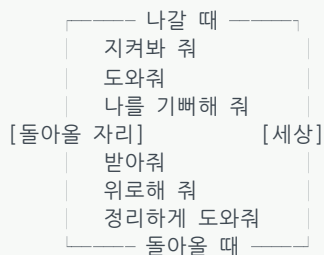
대신 이걸 약속드릴 수 있어요. **당신을 겁주지 않겠습니다.** "지금 안 하면 늦는다"는 말은 이 책에 나오지 않아요.

## 이 책의 뼈대 두 가지

하나 — 나가는 힘, 돌아올 자리

첫 5년 동안 부모가 하는 일을 최대한 줄이고 줄이면, 결국 두 가지만 남습니다.

**아이가 세상으로 나가게 하는 것. 그리고 아이가 돌아올 자리가 되는 것.**



이 그림이 이 책 전체의 지도예요.

그리고 여기에 위로가 하나 숨어 있어요. **자리는 완벽할 필요가 없습니다.** 그냥 거기 있으면 됩니다. 아이가 돌아왔을 때 문이 열려 있기로 하면, 그걸로 자리는 자리 노릇을 한 거예요.

그래서 이 책은 이렇게 짜여 있습니다.

| 부  | 다루는 것                     |
|----|---------------------------|
| 1부 | 이 순환이 왜 작동하는지             |
| 2부 | 자리가 되는 <b>기술</b> 다섯 가지    |
| 3부 | 시기마다 아이가 <b>어디까지</b> 나가는지 |
| 4부 | 돌아올 자리가 가장 필요한 때 — 아플 때   |

| 부  | 다루는 것                   |
|----|-------------------------|
| 5부 | 자리가 무너지지 않게 — 당신을 돌보는 법 |
| 6부 | 자리를 떠받치는 것 — 제도         |
| 7부 | 제대로 가고 있는지 확인하기         |

## 둘 — 네 박자

이 책의 심장입니다. 이름은 제가 붙였지만 발명한 건 아니고, 하버드대 아동발달센터가 정리한 **주고받기(Serve and Return)**를 실행 순서로 옮긴 거예요.

### 멈춤 → 되돌림 → 이름 → 기다림

① **멈춤** — 하던 걸 멈추고, 아이가 보는 곳을 봐요 ② **되돌림** — 소리나 표정을 따라 해요 ③ **이름** — 본 것, 느낀 것에 단어를 붙여요 ④ **기다림** — 5초 기다려요

네 박자는 시기마다 옷을 갈아입습니다.

| 시기      | 네 박자의 모습                                |
|---------|-----------------------------------------|
| 0~3개월   | 아기가 "아~" 하면 → 똑같이 "아~" → "기분 좋구나" → 기다림 |
| 7~12개월  | 아기가 가리키면 → 그쪽을 봄 → "비행기!" → 기다림         |
| 13~24개월 | "차!" → "빨간 차!" → 기다림                    |
| 24~36개월 | 우는 아이를 봄 → 앓음 → "블록이 무너져서 화났구나" → 기다림   |
| 만 3~5세  | "왜 밤이 와?" → "너는 왜 그럴 것 같아?" → 기다림       |

하나의 기술이 다섯 해에 걸쳐 자라는 거예요.

이 책에서 가장 자주 반복될 문장이 하나 있다면, 아마 이것일 거예요.

**말하고, 5초 기다려보세요.**

그리고 이 네 박자, **하루에 딱 스무 번이면 충분해요.** 따로 시간을 내실 필요도 없어요. 기저귀 갈 때, 먹일 때, 목욕할 때 — 이미 있는 순간에 얹으면 됩니다.

## 월령별 빠른 조건표

한 장으로 보는 첫 5년입니다. 이 표 하나가 3부 전체의 지도예요. 복사해 붙이셔도 됩니다.

| 시기             | 이번 달 딱 3가지                              | 확인                              | 사야 할 것              |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>출산 전</b>    | 카시트 장착 연습 · 야간 교대 합의 · 검진·접종 달력 등록      | 소아과 정하기                         | 카시트, 평평한 잠자리, 수면조끼  |
| <b>0~3개월</b>   | 울면 반응 · 배밀이 하루 30분 · <b>부모가 자기</b>      | 검진 1차 14~35일 <br>BCG 4주 이내      | 더 살 것 없어요           |
| <b>4~6개월</b>   | 옹알이 왕복 20회 · 이유식은 철분부터 · 첫니 나면 칫솔       | 검진 2차 4~6개월 <br>K-DST 시작        | 이유식 의자, 칫솔, 치발기     |
| <b>7~12개월</b>  | 가리키면 따라 보고 이름 붙이기 · 안전용품 설치 · 5초 기다리기   | 검진 3차 9~12개월 <br>12개월 가리키기 확인   | 안전용품 일체, 가구 벽 고정    |
| <b>13~24개월</b> | 한 단어 더 붙여주기 · "안 돼" 줄이고 선택지 · M-CHAT 요청 | 검진 4차 18~24개월 <br>구강 1차 18~29개월 | 굵은 크레용, 큰 블록, 낮은 책장 |



| 시기      | 이번 달 딱 3가지                               | 확인                                 | 사야 할 것                  |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 24~36개월 | 감정에 이름 붙이고 한계 정하기<br>· 과정 칭찬 · 배변은 신호 보고 | 검진 5차 30~36개월 <br>구강<br>2차 30~41개월 | 역할놀이 소품, 유아 변기          |
| 만 3~5세  | 억제 조절 놀이 · 되물어주기 ·<br>시력검사               | 검진 6~8차<br>취학 전 접종                 | 보드게임, 가위·풀, 자전거<br>+안전모 |

## 마지막으로, 한 문장만

아이에게 필요한 것은 완벽한 부모가 아니라, 충분히 좋은 부모다. — D.W. Winnicott

이 말은 그냥 듣기 좋으라고 하는 위로가 아니라 **이론**이에요.

부모가 아이의 욕구를 100% 즉시 채워주면, 아이는 좌절을 견디는 힘과 독립성을 배울 기회를 잃습니다. **적절한 실패와 회복이 오히려 아이를 키워요.**

그러니까 오늘 못 해준 것, 오늘 화낸 것, 오늘 휴대폰을 보여준 것 — 그게 아이를 망치지 않습니다. 정말입니다.

앞으로 이 책에서 여러 번 반복할 이야기가 있어요. 미리 한 번 해둘게요.

**힘든 게 정상이에요. 당신 탓이 아니고요. 그리고 지나갑니다.**

### 이 장의 요약 3줄

1. 부모의 일은 두 가지 — 나가게 하는 것, **돌아올 자리가 되는 것**. 자리는 완벽할 필요 없이 그냥 거기 있으면 돼요.
2. 기술은 하나 — **멈춤 · 되돌림 · 이름 · 기다림**. 하루 스무 번이면 충분해요.
3. 이 책의 절반은 **"무엇을 안 해도 되는가"**입니다.

→ 다음: 1부 · 판 읽기

# 1부 · 판 읽기

---

## 첫 5년에 실제로 일어나는 일

이 부는 10페이지예요. 한 번만 읽어두시면 나머지 전부의 "왜"가 이해됩니다. 개별 요령을 백 개 외우는 것보다, 여기 있는 네 가지를 아는 편이 훨씬 편해요.

그리고 이 부를 읽고 나면 아마 이런 마음이 드실 겁니다. **"생각보다 해야 할 일이 적네."** 맞아요. 그게 이 부의 목적입니다.

# 1장 · 아이는 나갔다 돌아온다

## 장면

두 살 아이가 놀이터에 도착합니다. 처음엔 당신 다리를 붙잡고 서 있습니다. 몇 분 뒤 미끄럼틀 쪽으로 세 걸음 갑니다. 뒤를 돌아봅니다. 당신이 보고 있는 걸 확인합니다. 다시 다섯 걸음. 또 돌아봅니다. 그러다 미끄럼틀을 타고, 신이 나서 당신에게 뛰어옵니다. 안깁니다. 삼십 초쯤 안겨 있다가 다시 빠져나가 뛰어갑니다.

이 장면이 이 책의 전부입니다.

## 무슨 일이 일어나는가

아이는 지금 두 가지를 번갈아 하고 있습니다. **나가는 것과 돌아오는 것.**

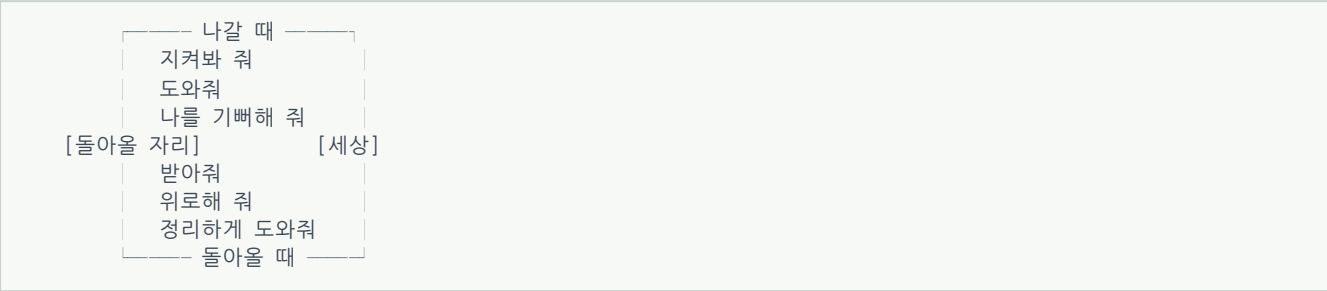
영국의 정신과 의사 **존 볼비(John Bowlby)**는 애착이 감정의 문제가 아니라 **생존을 위한 생물학적 시스템**이라고 봤습니다. 위협을 느끼면 양육자에게 다가가고, 안전하다고 느끼면 탐색하러 나갑니다. 그의 동료 **메리 에인스워스(Mary Ainsworth)**는 이 시스템을 실험실에서 관찰할 수 있게 만들었습니다.

여기서 가장 자주 오해되는 지점이 있습니다.

**안정 애착 아이는 부모에게 더 잘 붙어 있는 아이가 아니라, 더 멀리 나가는 아이입니다.**

돌아올 곳이 확실하기 때문에 멀리 갈 수 있습니다. 이것이 **안전기지(secure base)**입니다.

## 안전감의 순환



부모가 실패하는 지점은 둘 중 하나입니다.

- **나갈 때 붙잡는다** — "위험해", "이리 와", "그건 하지 마" → 탐색이 줄어듭니다.
- **돌아올 때 밀어낸다** — "왜 또 왔어", "다 컸으면서", "울지 마" → 다음에 나가지 못합니다.

## 이렇게 말하면 / 이렇게 말하면

| ✗                     | ✓                    |
|-----------------------|----------------------|
| (나갈 때) "위험해, 오지 마!"   | "여기서 아빠가 보고 있어. 가봐." |
| (나갈 때) "그거 아빠가 해줄게."  | "해볼래? 안 되면 아빠 불러."   |
| (돌아올 때) "뭘 이런 걸로 울어." | "무서웠구나. 이리 와."       |
| (돌아올 때) "다 컸으면서 안기긴." | (그냥 안아준다)            |
| (돌아올 때) "울지 마, 똑!"    | "많이 놀랐지. 아빠 여기 있어."  |

## 세 가지 오해

- ① "완벽하게 반응해야 한다" 아닙니다. 발달심리학자 에드 트로닉(Ed Tronick)의 연구에 따르면, 정상적인 부모-아이 상호작용에서도 어긋남이 수시로 일어납니다. **중요한 것은 어긋남 자체가 아니라 회복(rupture and repair)입니다.** 화를 내고 나서 "아까 아빠가 큰 소리 내서 미안해"라고 말하는 그 과정이, 아이에게 **관계는 깨져도 고칠 수 있다**는 것을 가르칩니다. 한 번도 어긋나지 않은 관계에서는 이걸 배울 수 없습니다.
- ② "24시간 붙어 있어야 한다" 아닙니다. 미국 NICHD의 대규모 종단연구에서, 어린이집에 다니는 아이도 안정 애착을 형성했습니다. 결정적인 것은 **함께 있는 시간의 양이 아니라 반응의 일관성과 민감성**입니다. **보통**
- ③ "애착 대상은 엄마 하나여야 한다" 아닙니다. 아빠, 조부모와 각각 별도의 애착이 형성됩니다. 애착은 총량이 정해진 자원이 아닙니다.

## 스틸 페이스 실험

부모가 아이와 즐겁게 상호작용하다가 **갑자기 무표정으로 반응을 끊습니다.** 생후 2~3개월 아기도 몇 초 안에 알아챱니다. 웃어 보이고, 손을 뻗고, 소리를 내며 부모를 되돌리려 애씁니다. 그래도 반응이 없으면 몸을 뒤틀고, 결국 시선을 돌리고 위축됩니다.

부모가 다시 웃으면? 아기는 곧바로 회복합니다.

**반응이 곧 아이의 세계입니다.** 유튜브에서 "Still Face Experiment"로 직접 볼 수 있습니다. 3분짜리 영상이고, 이 책의 어떤 설명보다 강력합니다.

 **지금 해보기** 오늘 아이가(혹은 태어나면) 당신에게 무언가를 보여주려 가져올 때, **하던 일을 멈추고 그것을 보세요.** 3초면 됩니다. 그 3초가 순환을 완성합니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 부모의 일은 나가게 하는 것과 돌아올 자리가 되는 것, 둘뿐이다.
2. 안정 애착 아이는 더 붙어 있는 아이가 아니라 **더 멀리 나가는** 아이다.
3. 완벽한 반응이 아니라 **어긋난 뒤의 회복**이 아이를 키운다.

## 2장 · 뇌는 쓰는 대로 만들어진다

### 장면

당신은 검색합니다. "0세 두뇌발달 교구". 결과가 쏟아집니다. 흑백 모빌 세트, 오감 자극 놀이북, 클래식 전집, 영어 노출 DVD. 어떤 광고는 "골든타임"이라는 말을 씁니다. 지금 안 하면 늦는다고.

이 장은 그 광고를 끄기 위한 장입니다.

### 무슨 일이 일어나는가

출생 시 아기의 뇌는 성인의 약 25% 무게입니다. 만 3세에 약 80~85%, 만 5세에 약 90%에 도달합니다. 첫 5년이 중요하다는 말은 사실입니다.

그런데 **어떻게** 중요한지가 광고와 다릅니다.

생후 초기에 시냅스는 필요한 것보다 **훨씬 많이** 만들어집니다. 그다음 쓰이는 회로만 남기고 나머지를 잘라냅니다 (synaptic pruning). 조각가가 돌을 깎아내며 형태를 만드는 것과 같습니다.

결정적인 것은 "무엇을 더 넣느냐"가 아니라 "무엇을 반복적으로 쓰느냐"입니다.

### 그래서 무엇이 중요해지는가

기저귀를 갈면서 말을 겁니다. 하루 8번. 1년이면 **2,900번**입니다. 교구는 몇 번 쓰다 서랍에 들어갑니다.

반복되는 일상적 상호작용이 뇌 구조를 만듭니다. 특별한 활동이 아니라.

### 결론만 말하면 — 조기 자극

- 결핍은 해롭습니다. 방치, 대화 없는 환경, 만성적 스트레스는 실제로 발달을 손상시킵니다. **강함**
- 과잉은 이득이 아닙니다. 평균적인 환경 이상으로 자극을 늘려서 인지가 향상된다는 근거는 없습니다.
- 따라서 자극을 늘리는 것보다 결핍을 없애는 것이 훨씬 효과가 큼니다.
- 그리고 대부분의 가정은 이미 결핍 상태가 아닙니다.

### "골든타임"의 진실

민감기(sensitive period)는 존재합니다. 그러나 광고가 말하는 방식과 다릅니다.

| 영역           | 민감기            | 이후에도 발달하나                        |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| 시각·청각        | 생후 초기 몇 년 (강함) | 제한적 — <b>약시·난청 조기 발견이 중요한 이유</b> |
| 언어 (모국어 음운)  | 생후 첫 1년        | 어휘·문법은 평생                        |
| 애착           | 생후 2~3년        | 이후에도 변화 가능                       |
| 실행기능·정서조절    | 만 3~5세 시작      | <b>청소년기~20대까지 계속</b>             |
| 학업 기술 (글자·수) | 민감기 없음         | 언제든                              |

"이때 놓치면 끝"이 적용되는 것은 사실상 감각(시각·청각)뿐입니다. 그래서 이 책은 시력검사와 난청 선별검사를 반복해서 강조하고, 한글 조기교육은 강조하지 않습니다.

## 무엇이 실제로 뇌를 만드는가

다섯 가지입니다. 전부 무료입니다.

1. **주고받는 대화** — 2부 5장 「네 박자」
2. **반응받은 경험** — 울면 누군가 온다는 확신
3. **놀이** — 특히 아이가 주도하는 놀이
4. **움직임** — 바닥 시간, 실외 활동
5. **예측 가능한 일과** — 다음에 무슨 일이 일어날지 아는 안정감

여기 없는 것: 교구, 전집, 영상, 학습지.

---

👉 지금 해보기 장난감이나 교구를 사기 전에 물어보세요. "이건 장난감이 90%를 하고 아이가 10%를 하는가, 아니면 그 반대인가?" 후자만 사세요.

### 📌 이 강의 요약 3줄

1. 뇌는 더 넣어서가 아니라 **반복해서 쓰는 회로만 남겨서** 만들어진단다.
2. 결핍은 해롭지만 과잉은 이득이 아니다. **결핍을 없애는 게 자극을 늘리는 것보다 효과가 크다.**
3. "골든타임"이 실제로 적용되는 것은 시각·청각이다. 한글이 아니다.

# 3장 · 아이는 다르게 태어난다

## 장면

친구의 아이는 낯선 사람이 안아도 방긋 웃습니다. 밤에 잘 자고, 새로운 음식도 잘 먹습니다. 당신의 아이는 낯선 사람만 보면 울고, 자주 깨고, 처음 보는 음식은 입에 대지도 않습니다.

친구는 말합니다. "우리 애는 순해서." 당신은 생각합니다. "내가 뭘 잘못했나."

아닙니다. 아이는 다르게 태어납니다.

## 무슨 일이 일어나는가

1950년대 토마스와 체스(Thomas & Chess)의 뉴욕종단연구는 아기들을 태어난 직후부터 추적해, 기질이 타고나며 상당히 안정적이라는 것을 보여줬습니다. 그들은 기질을 9개 차원(활동수준, 규칙성, 접근/회피, 적응성, 반응 역치, 반응 강도, 기분, 주의산만도, 지속성)으로 나누고 세 유형으로 묶었습니다.

| 유형      | 대략 비율 | 특징                     | 부모가 조심할 것              |
|---------|-------|------------------------|------------------------|
| 순한 아이   | 약 40% | 규칙적, 새로운 수용, 대체로 기분 좋음 | 요구가 적어 관심에서 밀리기 쉽다     |
| 까다로운 아이 | 약 10% | 불규칙, 강한 반응, 적응 느림      | 부모가 자책하기 쉽다. 부모 탓이 아니다 |
| 느린 아이   | 약 15% | 새로움에 위축, 천천히 적응        | 밀어붙이면 역효과. 예고와 시간을 준다  |

나머지는 혼합형입니다.

## 핵심 개념 — 궁합(goodness of fit)

"좋은 기질"은 없습니다. 결과를 결정하는 것은 기질 자체가 아니라 기질과 환경의 궁합입니다.

- 활동적인 아이에게 "가만히 있어"를 요구하는 환경 → 문제가 됩니다.
- 같은 아이에게 뭘 공간을 주는 환경 → 장점이 됩니다.

부모가 할 일은 아이의 기질을 바꾸는 것이 아니라 맞는 환경을 찾아주는 것입니다.

### 기질별 실전 대응

| 아이가 이렇다면         | 이렇게                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 새로운 상황에 위축된다     | 미리 예고한다. "내일은 할머니 집에 갈 거야. 처음엔 낯설 수 있어." 도착해서 관찰할 시간을 준다. 억지로 인사시키지 않는다 |
| 반응이 강하고 크게 운다    | 강도를 문제 삼지 않는다. "많이 속상했구나"로 크기를 인정한다                                     |
| 활동량이 많다          | 하루 일과에 실외 시간을 먼저 배치한다. 앉히기 전에 뛰게 한다                                     |
| 잠·식사가 불규칙하다      | 시간표를 강요하지 말고 순서를 고정한다 (먹기→놀이→자기)                                        |
| 예민해서 자극에 쉽게 압도된다 | 자극의 총량을 줄인다. 장난감 개수, 소음, 일정                                             |

## 난초와 민들레

최근 연구는 여기에 한 겹을 더합니다. 차등 민감성(differential susceptibility)입니다.

일부 아이(난초형)는 환경에 양방향으로 더 민감합니다.

- 나쁜 환경에서는 평균보다 더 나빠집니다.
- 그러나 좋은 환경에서는 평균보다 더 크게 좋아집니다. **보통**

민들레형 아이는 어떤 환경에서도 비교적 무난하게 자랍니다.

**예민한 아이를 키우고 있다면, 그것은 위험이자 동시에 기회입니다. 당신의 노력이 평균적인 아이보다 더 크게 돌아옵니다.**

 **지금 해보기** 아이의 기질 중 가장 다루기 어려운 특성 하나를 골라, 그것이 강점이 되는 상황을 하나만 적어보세요.  
(예민함 → 다른 사람의 기분을 잘 알아챈다 / 고집 → 쉽게 포기하지 않는다)

#### 이 장의 요약 3줄

1. 기질은 타고나며, 아이가 다른 것은 부모 탓이 아니다.
2. 좋은 기질은 없다. **기질과 환경의 궁합만 있다.**
3. 예민한 아이는 나쁜 환경에서 더 나빠지지만 **좋은 환경에서 더 크게 좋아진다.**



## 4장 · 무엇을 믿을 것인가

### 장면

산후조리원 동기 단톡방에 링크가 하나 올라옵니다. "충격! 소아과 의사들이 알려주지 않는 진실". 열 명 중 세 명이 하트를 누릅니다. 당신은 읽어야 할지 말아야 할지 모릅니다.

### 근거의 위계

욱아 정보는 서로 다른 말을 합니다. 판단 기준을 미리 세워두면 흔들리지 않습니다.

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 높음 | 체계적 고찰 / 메타분석 (Cochrane 등)          |
|    | 무작위 대조 시험 (RCT)                     |
|    | 전문학회 정책성명 (AAP, WHO, 대한소아청소년과학회)    |
|    | 대규모 전향적 코호트 (NICHD, ALSPAC 등)       |
|    | 관찰연구 / 상관연구      ← "~와 연관"은 인과가 아니다 |
|    | 전문가 의견                              |
| 낮음 | 개인 경험담 / 인플루언서 / 제품 광고              |

이 책은 문장 끝에 **강함** **보통** **관행**으로 근거 수준을 표시합니다. 저자가 확신하는 것과 그렇지 않은 것을 구분해서 읽으실 수 있습니다.

### 네 가지 함정

#### ① 상관을 인과로 읽기

"책을 많이 읽어준 집 아이가 성적이 좋다" — 사실입니다. 그러나 책을 읽어주는 부모는 다른 것도 다르게 합니다. 소득, 교육 수준, 대화량. **형제 비교 연구나 무작위 시험**이 있는지 확인해야 합니다.

#### ② 재현되지 않은 유명 연구를 믿기

| 유명한 주장                    | 이후 어떻게 되었나                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 마시멜로 테스트 — 참는 아이가 성공한다    | 대규모 재현 연구(Watts et al., 2018)에서 가정 배경을 통제하자 예측력이 크게 줄었습니다 |
| 3천만 단어 격차 (Hart & Risley) | 표본이 42가구로 작고 후속 재현이 부분적입니다. 방향은 유효하나 숫자를 그대로 믿을 필요는 없습니다  |
| 모차르트 효과                   | 유아 IQ 상승 근거는 사실상 없습니다                                     |

#### ③ 효과 크기를 무시하기

"통계적으로 유의미"해도 실제 차이는 미미할 수 있습니다. 표본이 크면 아주 작은 차이도 유의미하게 나옵니다.

#### ④ 누가 돈을 냈는지 안 보기

분유·교구·사교육 업체가 후원한 연구는 별도로 취급합니다.

### 위험 신호 체크리스트

다음 중 하나라도 해당하면 **일단 의심**하세요.

- ☐ **제품을 팔고 있다** — 특히 그 제품이 유일한 해결책인 것처럼 말할 때
- ☐ "의사들이 알려주지 않는", "충격적인 진실" 같은 표현
- ☐ **단정적이고 극단적이다** — "절대", "무조건", "이것만"

- ☐ 출처가 없거나 "○○ 연구에 따르면"만 있고 어떤 연구인지 없다
- ☐ 한 편의 연구만, 특히 표본이 작은 연구만 근거로 든다
- ☐ 공포를 이용한다 — "지금 안 하면 늦는다", "골든타임"
- ☐ 학회 권고와 정면으로 배치되는데 그 이유를 설명하지 않는다
- ☐ 자격이 불분명하다 — 자칭 전문가, 어떤 분야인지 불명확한 "박사"
- ☐ 후기와 댓글이 유일한 근거다

## 상충할 때의 결정 규칙

이 네 줄이 이 책에서 가장 오래 쓰실 부분일 수 있습니다.

안전에 관한 것 (수면·카시트·접종·삼킴)

→ 학회 권고를 그대로 따른다. 개인 판단의 여지를 두지 않는다.

건강·의학적 판단 (발달·질병·영양)

→ 담당 소아과의 판단을 우선한다. 불안하면 2차 소견을 받는다.

교육·훈육 방식

→ 근거 있는 여러 방법 중 우리 아이 기질과 우리 집 상황에 맞는 것을 고른다.  
정답 하나는 없다.

제품 구매

→ 기본값은 "안 산다". 필요성이 증명되면 그때 산다.

## 예방접종 정보에 대한 특별 주의

접종 반대 정보는 정교하게 포장되어 유통됩니다.

**MMR 백신과 자폐의 연관성은 존재하지 않습니다.** 이 주장의 원 논문(Wakefield, 1998)은 데이터 조작으로 철회되었고 저자는 의사 면허를 박탈당했습니다. 이후 수백만 명 규모의 후속 연구에서 연관성이 반복적으로 부정되었습니다. **강함**

걱정되는 점이 있으면 접종을 미루지 말고 **의사와 상의**하세요. 정보는 **질병관리청 예방접종도우미**에서 확인합니다.

 **지금 해보기** 지금 휴대폰에 저장해두세요. [healthychildren.org](http://healthychildren.org) (AAP) · [cdc.gov/ncbddd/actearly](http://cdc.gov/ncbddd/actearly) (발달 이정표) · [nip.kdca.go.kr](http://nip.kdca.go.kr) (예방접종). 새벽에 검색창을 여는 대신 여기부터 보세요.

### 이 장의 요약 3줄

1. "~와 연관"은 인과가 아니다. 재현되지 않은 유명 연구가 많다.
2. 안전은 학회 권고를 그대로, 교육은 우리 아이에 맞게, 제품은 기본값이 "안 산다".
3. 공포를 파는 정보는 대개 무언가를 함께 판다.

## 오려 쓰는 한 장 ① — 1부 요약

이 회색 상자는 읽는 부분이 아닙니다. 인쇄하거나 옮겨 적어 벽에 붙이라고 만든 한 장이에요. 급할 때는 책을 펼 수 없으니깐요. 책 전체에 여덟 장 있고 (목록은 이 책을 읽는 법), 붙일 곳은 냉장고 문이든 아이 방문이든 손이 닿는 곳이면 됩니다.

아이는 나갔다 돌아온다

나갈 때 → 지켜봐 준다 (붙잡지 않는다)  
돌아올 때 → 받아준다 (밀어내지 않는다)

뇌는 더 넣어서가 아니라 반복해서 쓰는  
회로만 남겨서 만들어진단다.  
→ 교구보다 매일의 대화

아이가 까다로운 것은 부모 탓이 아니다.  
기질은 바꾸는 게 아니라 맞는 환경을 준다.

안전 = 학회 권고 그대로  
교육 = 우리 아이에 맞게  
제품 = 기본값은 "안 산다"

→ 다음: 2부 · 도구함

## 2부 · 도구함

---

### 시기와 무관한 다섯 가지 기술

여기 있는 다섯 가지는 0개월에도 5세에도 씁니다. 3부의 시기별 장은 이 도구들을 그 시기에 어떻게 쓰는지를 다룹니다. 그러니 이 부를 먼저 읽으면 3부가 훨씬 짧아집니다.

## 5장 · 네 박자

### 이 책의 심장

#### 장면

생후 두 달 된 아기가 기저귀 갈이대에 누워 있습니다. 당신은 새 기저귀를 채우며 휴대폰으로 오늘 처리할 일을 확인합니다. 아기가 "어어~" 소리를 냅니다. 당신은 "응 그래" 하고 계속 기저귀를 채웁니다. 아기가 한 번 더 소리를 냅니다. 당신은 못 들었습니다.

방금 학습 기회 하나가 지나갔습니다. 그리고 오늘 그런 기회가 서른 번쯤 더 옵니다.

#### 무슨 일이 일어나는가

아기가 소리를 내거나, 눈을 맞추거나, 손을 뻗거나, 무언가를 가리킬 때 — 그것은 **서브(serve)**입니다. 테니스에서 공을 넘기는 것처럼, 아기가 당신에게 신호를 보낸 겁니다.

당신이 반응하면 **리턴(return)**입니다. 공이 돌아갑니다.

하버드대 아동발달센터는 이 왕복을 **아동 발달의 기본 단위**로 규정합니다. 뇌 회로는 이 주고받기 위에서 만들어집니다.

#### 결정적인 연구

MIT의 **로메오(Romeo)**와 동료들이 2018년 \*Psychological Science\*에 발표한 연구는 이 분야의 전환점이었습니다.

4~6세 아동의 가정 대화를 녹음하고 뇌 영상을 찍었습니다. 그리고 두 가지를 비교했습니다.

- 아이가 들은 단어의 총량
- 부모와 아이가 주고받은 대화 차례의 횟수

결과: **주고받은 횟수가 브로카 영역의 활성화와 언어 능력을 더 잘 예측했습니다.** 단어 총량의 효과는 이 변수를 통제하자 사라졌습니다. 사회경제적 지위의 영향도 상당 부분 이 변수가 매개했습니다. **강함**

**말을 많이 하는 것이 아니라, 주고받는 것이 뇌를 만듭니다.**

이것이 이 책이 "하루 몇 단어"를 세지 않고 **"하루 몇 번 주고받았나"**를 세는 이유입니다. 그리고 영상 노출이 언어 발달에 거의 도움이 되지 않는 이유이기도 합니다. **영상은 리턴하지 않습니다.**

#### 네 박자

실행 순서로 옮기면 이렇습니다.

① 멈춤 → ② 되돌림 → ③ 이름 → ④ 기다림

#### ① 멈춤 (Notice)

하던 걸 멈추고, 아이가 보는 곳을 봅니다.

핵심은 **아이의 관심을 따라가는 것**입니다. 부모가 보여주고 싶은 것이 아니라.

- ❌ (아이는 강아지를 보는데) "여기 봐, 이견 사과야."
- ✅ (아이 시선을 따라가며) "아, 강아지 봤구나."

아이 관심을 따라간 발화가 어휘 습득에 더 효과적입니다. **보통** 이유는 단순합니다. 아이가 이미 보고 있는 것에 이름이 붙으면 연결이 즉시 일어나지만, 다른 데 있는 것에 이름을 붙이면 무엇을 가리키는지 알 수 없습니다.

## ② 되돌림 (Return)

소리나 표정을 따라 합니다.

- 아기가 "아~" → 당신도 "아~"
- 아기가 웃음 → 당신도 웃음
- 아기가 손을 뻗음 → 그 물건을 함께 봄

이게 유치해 보인다면, 그것이 바로 요점입니다. 아기는 **자기 행동이 세상에 영향을 준다**는 것을 여기서 처음 배웁니다. 이것이 자기효능감의 씨앗입니다.

## ③ 이름 (Name it)

본 것, 느낀 것에 단어를 붙입니다.

- 사물에: "강아지네. 갈색 강아지."
- 행동에: "물을 쏟았구나."
- 감정에: "화났구나." ← 이것이 6장 감정 코칭의 출발점입니다.

단어는 정확하게 발음합니다. 억양은 과장해도 됩니다.

| ❌ 아기말투    | ✅ parentese                |
|-----------|----------------------------|
| "무무 먹을까?" | "물 먹을까?" (높은 톤, 느리게, 또렷하게) |
| "맘마 쭈쭈"   | "밥 먹자"                     |
| "까까 줄까?"  | "과자 줄까?"                   |

parentese는 근거가 있는 방식입니다. 높은 음높이, 느린 속도, 과장된 억양, 또렷한 모음은 아기가 말소리를 구분하는 데 실제로 도움이 됩니다. 그러나 단어를 뭉개는 아기말투와는 다릅니다. 억양만 과장하고 단어는 정확하게 하세요.

## ④ 기다림 (Wait)

5초 침묵합니다.

이것이 이 책에서 가장 많이 반복될 지시이고, 대부분의 부모가 놓치는 박자입니다.

| 시기       | 기다릴 시간 |
|----------|--------|
| 신생아      | 3~5초   |
| 돌 이후     | 5~10초  |
| 말이 늦은 아이 | 10초 이상 |

어른의 대화 리듬으로는 5초가 어색할 만큼 깁니다. 그런데 아기의 신경계는 느립니다. 듣고, 처리하고, 반응을 준비하는 데 시간이 걸립니다. 부모가 그 시간을 주지 않으면 아기는 리턴할 기회 자체가 없습니다.

## ⑤ 그리고 — 끝맺음을 존중한다

아이가 고개를 돌리거나 흥미를 잃으면 **그만합니다**. 억지로 끌지 않습니다. 다시 신호를 보내면 그때 다시 시작합니다.

## 이렇게 말하면 / 이렇게 말하면

| 상황          | ❌                   | ✅                          |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| 아기가 "바바" 한다 | "응~ 그래그래" (계속 하던 일) | "바바!" (따라 하고) ... (5초 기다림) |

| 상황           | ✗               | ✓                                      |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|
| 아기가 창밖을 본다   | "여기 책 봐, 책."    | "밖에 뭐 있어? 아, 나무가 흔들리네." ... (기다림)      |
| 아이가 컵을 가리킨다  | 말없이 컵을 준다       | "물? 물 줄까?" ... (기다림) ... "물!" 하면 준다    |
| 아이가 그림을 보여준다 | "잘 그렸네~" (안 보고) | (보고) "여기 색을 여러 개 썼네. 이건 뭐야?" ... (기다림) |
| 아이가 넘어져 운다   | "괜찮아 괜찮아, 똥!"   | "아팠구나." ... (기다림) ... "어디 아파?"         |

## 이런 경우엔요?

"하루 종일 이렇게 할 순 없잖아요." 맞습니다. 하지 마세요. **하루 20회면 충분합니다.** 그리고 따로 시간을 낼 필요도 없습니다. 기저귀 갈 때(하루 8회), 먹일 때(하루 5회), 목욕할 때, 안고 이동할 때 — 이미 있는 순간에 얹으면 됩니다.

"아기가 아직 말을 못 하는데 무슨 대화예요?" 말은 대화의 결과이지 조건이 아닙니다. 웅알이, 눈맞춤, 손짓, 표정 전부가 서브입니다. 오히려 **말하기 전 시기의 주고받기가 이후 언어를 예측합니다.**

"제가 원래 말수가 적어요." 많이 말하라는 게 아니라 **주고받으라는** 것입니다. 말수가 적어도 됩니다. 아이 소리를 따라 하고 기다리는 것만으로 왕복은 성립합니다.

"둘째가 있어서 첫째한테 이럴 시간이 없어요." 그럴 땐 **하루 10분, 방해 없는 시간 하나**를 고정하세요. 흠어진 두 시간보다 집중된 10분이 낫습니다.

## 🔊 결론만 말하면 — 영상으로 언어를 배울 수 있나

2세 미만은 **화면에서 본 것을 현실에 거의 전이하지 못합니다.** 이를 **video deficit effect**라고 합니다. 같은 내용을 사람이 직접 보여주면 배우지만, 화면으로 보여주면 배우지 못합니다. **강함**

이유는 네 박자로 설명됩니다. **영상은 ②되돌림과 ④기다림을 하지 않습니다.** 아이가 무엇을 하든 영상은 똑같이 진행됩니다.

예외는 **영상통화**입니다. 반대편에 사람이 있고 리턴이 일어나기 때문입니다.

**배경 TV도 해롭습니다.** 아이가 보고 있지 않아도, 부모-아이 대화량과 아이의 놀이 집중 시간을 줄입니다. **보통**

## 시기별로 네 박자는 이렇게 변합니다

| 시기      | 서브(아이)       | 리턴(부모)                       |
|---------|--------------|------------------------------|
| 0~3개월   | "아~" 소리, 눈맞춤 | 같은 소리 따라 하기 → "기분 좋구나" → 기다림 |
| 4~6개월   | "바바바" 웅알이    | "바바!" → "밥? 밥 먹을까?" → 기다림    |
| 7~12개월  | <b>가리키기</b>  | 그쪽을 봄 → "비행기! 하늘에 있네" → 기다림  |
| 13~24개월 | "차!"         | "빨간 차!" (한 단어 더) → 기다림       |
| 24~36개월 | 울음, 떼쓰기      | 앉음 → "블록이 무너져서 화났구나" → 기다림   |
| 만 3~5세  | "왜 밤이 와?"    | "너는 왜 그럴 것 같아?" → 기다림        |

하나의 기술이 다섯 해에 걸쳐 자랍니다.

👉 **지금 해보기** 오늘 한 번만, 아이가 소리를 내면 **똑같이 따라** 하고 **손목시계로 5초를 재**보세요. 대부분의 부모가 이때 처음으로 "5초가 이렇게 길구나"를 느낍니다. 그리고 아기가 그 침묵을 채우는 것을 봅니다.

### 📌 **이 장의 요약 3줄**

1. 단어의 총량보다 **주고받은 횟수**가 언어와 뇌 발달을 예측한다.
2. **멈춤 · 되돌림 · 이름 · 기다림**. 하루 20회, 따로 시간 내지 않고.
3. 놓치는 박자는 언제나 **네 번째, 기다림**이다.

→ 다음: 6장 · 감정 코칭



## 6장 · 감정 코칭

감정은 인정, 행동은 제한

### 장면

두 살 반 아이가 마트 바닥에 누웠습니다. 초콜릿을 사주지 않았기 때문입니다. 소리를 지르고 발을 구릅니다. 지나가던 사람이 힐끗 봅니다. 당신의 얼굴이 뜨거워집니다.

머릿속에 세 가지 선택지가 떠오릅니다. ① 사준다 ② 소리를 지른다 ③ 끌고 나간다

셋 다 답이 아닙니다.

그런데 그 순간에 정답을 떠올릴 수 있는 사람은 거의 없어요. 얼굴은 뜨겁고, 사람들은 쳐다보고, 아이는 바닥에 누워 있으니까요. 그 상황에서 제대로 못 했다고 자책하지 마세요. 이건 연습이 필요한 기술이지, 알면 바로 되는 게 아닙니다.

### 무슨 일이 일어나는가

아이는 지금 감정을 조절할 능력이 물리적으로 없습니다.

감정을 만드는 편도체는 태어날 때부터 작동합니다. 그것을 억제하는 전전두엽은 20대까지 미성숙합니다. 두 살 아이에게 "참아"는 다리가 없는 사람에게 뛰라고 하는 것과 비슷합니다.

그래서 이 시기 아이는 혼자 진정하지 못합니다. 대신 부모의 침착한 신경계에 동기화되면서 진정하는 법을 배웁니다. 이것을 공동조절(co-regulation)이라고 합니다.

부모가 진정하는 것이 곧 교육입니다. 부모가 흥분하면 아이는 더 흥분합니다.

그리고 시간이 지나면서 아이는 이 과정을 내면화합니다. 어른이 대신 해주던 조절을 스스로 하게 되는 것 — 그것이 자기조절(self-regulation)의 발달 경로입니다.

### 핵심 원칙 한 줄

감정은 모두 허용한다. 행동은 일부 제한한다.

| 감정          | 행동                 |
|-------------|--------------------|
| 화나는 것 — 허용  | 때리는 것 — 금지         |
| 슬픈 것 — 허용   | 물건 던지는 것 — 금지      |
| 질투하는 것 — 허용 | 동생 미는 것 — 금지       |
| 싫은 것 — 허용   | 소리 지르며 요구하는 것 — 제한 |

아이가 배워야 하는 것은 "화내지 않는 법"이 아니라 "화났을 때 무엇을 할 수 있는가"입니다.

### 감정 코칭 5단계

심리학자 존 가트맨(John Gottman)이 정리한 순서입니다. [보통](#)

#### ① 알아차린다

아이의 작은 감정 신호를 놓치지 않습니다. 폭발한 뒤가 아니라 그전에 알아채면 훨씬 쉽습니다.

- 입이 삐죽 나옴, 목소리가 높아짐, 몸이 굳음, 갑자기 조용해짐

## ② 기회로 본다

떼쓰기를 **문제**가 아니라 **가르칠 순간**으로 봅니다. 감정이 올라온 순간이 감정을 배울 유일한 순간입니다.

## ③ 공감하며 듣는다

판단하지 않고 듣습니다. 이 단계에서 하지 말아야 할 말들:

- "별거 아니야" (아이에게 별거입니다)
- "왜 그런 걸로 울어"
- "울면 안 돼"
- "형은 안 그러는데"

## ④ 이름을 붙여준다 ★

이 단계가 5단계 중 가장 강력하고, 가장 자주 건너뛰어집니다.

"실망했구나." "부러웠구나." "답답했구나." "무서웠구나."

감정에 이름이 붙으면 아이는 그 감정을 **다룰 수 있는 대상으로** 인식하기 시작합니다. 영어권에서는 이를 **"name it to tame it"**이라고 부릅니다.

이것이 5장 네 박자의 ③이름 박자입니다. 사물에 이름을 붙이던 것이, 이제 감정에 이름을 붙이는 것으로 자란 겁니다.

## ⑤ 한계를 정하고 함께 해결한다

여기서 **비로소** 행동에 선을 긋습니다.

"화나도 때리는 건 안 돼. 대신 어떻게 할 수 있을까?"

대부분의 부모는 ③④를 건너뛰고 ⑤부터 시작합니다. 그래서 아이가 듣지 않습니다. 감정이 인정되지 않은 상태에서는 어떤 말도 들리지 않습니다.

## 이렇게 말하면 / 이렇게 말하면

| 상황             | ✗                    | ✓                                                          |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 블록이 무너져 운다     | "괜찮아, 다시 하면 되지."     | "열심히 쌓았는데 무너져서 속상하구나."                                     |
| 친구가 장난감을 뺏았다   | "같이 놀아야지."           | "네 거 뺏겨서 화났구나. 말로 해볼까? '내가 먼저 놓고 있었어'"                     |
| 어린이집 가기 싫다고 운다 | "다 가는 거야. 똑!"        | "엄마랑 더 있고 싶구나. 아쉽지."                                       |
| 동생을 밀었다        | "동생한테 왜 그래!"         | (동생 먼저 살핀 뒤) "동생이 네 걸 만져서 화났구나. 미는 건 안 돼. 대신 '하지 마'라고 말해." |
| 넘어져서 운다        | "안 아파, 괜찮아."         | "아팠지. 어디 보자."                                              |
| 자고 싶지 않다고 운다   | "지금 자야 돼!"           | "더 놀고 싶구나. 아쉬워도 이제 잘 시간이야."                                |
| 무섭다고 한다        | "괴물 없어. 무서울 게 뭐 있어." | "무섭구나. 아빠가 문 열어둘게. 여기 불도 켜둘까?"                             |

패턴이 보이시나요? 왼쪽은 전부 감정을 부정합니다. 오른쪽은 전부 감정을 인정한 뒤 필요하면 한계를 긋습니다.

## 떼쓰기(탄트럼) 실전 매뉴얼

### 알아둘 것

떼쓰기는 18~36개월에 정상적으로 최고조에 이릅니다. 아이가 잘못된 것도, 부모가 못하는 것도 아닙니다. 하고 싶은 것은 많은데 능력과 언어가 못 따라가서 생기는 좌절입니다.

### 진행 중일 때 — 4단계

1. **안전을 확보한다** 위험한 물건을 치웁니다. 다치지 않게만 합니다. 그 외엔 개입하지 않습니다.
2. **말을 줄인다** 흥분 상태에서 아이의 언어 처리 능력은 크게 떨어집니다. **긴 설명은 소음입니다.** 낮은 목소리, 낮은 자세. 아이 눈높이로 앉습니다. **한 문장만:** "화났구나. 아빠 여기 있어."
3. **곁에 있는다** 말없이 앉아 있습니다. 안기려 하면 안아주고, 밀어내면 조금 물러나 있습니다. **사라지지 않는 것**이 메시지입니다.
4. **진정된 뒤에 짧게** 훈계는 **한 문장.** "화낼 수 있어. 그래도 던지는 건 안 돼." 그리고 **다시 연결**합니다. "이제 괜찮아졌네. 안아줄까?"

### 절대 하지 말 것

- 떼쓰는 중에 요구를 들어주기 — 떼쓰기가 효과적인 수단이라고 가르칩니다
- 떼쓰는 중에 협상하기 — 그 상태에서는 협상이 성립하지 않습니다
- 아이를 낙인찍기 — "너는 왜 맨날 이래"는 자기개념을 손상시킵니다
- 창피 주기 — "사람들이 다 쳐다보잖아"

### 공공장소라면

조용한 곳으로 데리고 나갑니다. 창피함 때문에 요구를 들어주면 그 패턴이 학습됩니다. 주변 시선보다 다음 백 번의 마트가 더 중요합니다.

## 떼쓰기를 줄이는 예방책 (대응보다 효과적)

떼쓰기의 절반 이상은 배고픔과 졸림입니다. 대응 기술보다 예방이 훨씬 효율적입니다.

| 예방책           | 방법                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 배고픔·졸림 관리     | 외출은 낮잠·식사 시간을 피해서 잡는다                                    |
| 예고하기          | "5분 뒤에 나갈 거야" → "이제 두 번만 더 타고 가자". 숫자를 몰라도 예고 자체가 효과가 있다 |
| 선택지 주기        | "가자" 대신 "신발 신을래, 아빠가 신겨줄까?" 통제권을 조금 넘기면 저항이 줄어든다         |
| "안 돼"의 총량 줄이기 | 만지면 안 되는 물건은 <b>치운다</b> . 8장 환경 설계                       |
| 미리 규칙 말하기     | 마트 도착 <b>전에</b> "오늘은 과자 안 살 거야"                          |
| 전환 시간 주기      | 놀다가 갑자기 끄지 않는다. "이거 끝나면 끄는 거야"                           |

## 감정 어휘 가르치기

감정에 이름을 붙일 수 있는 아이가 감정을 더 잘 조절합니다.

① 일상에서 감정 단어를 자주 씁니다 기쁘다 · 슬프다 · 화나다 · 무섭다 · 부럽다 · 답답하다 · 실망하다 · 신나다 · 서운하다 · 창피하다 · 뿌듯하다

② 책을 보며 묻습니다 "애는 지금 기분이 어떨까?" "왜 그럴까?"

③ 부모 자신의 감정도 말합니다 "아빠 지금 좀 피곤해서 답답해. 잠깐 쉬고 올게." → 이것이 **감정 조절의 시범**입니다. 아이는 설명보다 시범에서 배웁니다.

④ 평온할 때 진정 도구를 함께 정합니다 "화날 때 할 수 있는 것" 3가지를 아이와 정해 그림으로 붙여둡니다. 심호흡 / 베개 안기 / 조용한 자리로 가기.

**반드시 평온할 때 연습해야 합니다.** 폭발한 순간에 새로운 기술을 가르칠 수는 없습니다.

## 부모의 감정이 폭발할 것 같을 때

이것도 감정 코칭의 일부입니다. 오히려 더 중요합니다.

1. 아이를 안전한 곳에 둔다 (아기침대, 방바닥)
2. 방을 나온다
3. 5~10분 진정한다 - 물 마시기, 심호흡, 세수
4. 돌아간다

잠깐 우는 것은 안전하지만, 흔들거나 때리는 것은 안전하지 않습니다. 자리를 뜨는 것은 방임이 아니라 안전 조치입니다.

### 이미 소리를 질렀다면 — 회복(repair)

"아빠가 아까 큰 소리 내서 미안해.  
아빠도 화가 났었어.  
그래도 소리 지르는 건 아빠가 잘못된 거야."

이 세 문장이 아이에게 세 가지를 가르칩니다. ① 어른도 감정이 있다 ② 잘못하면 사과한다 ③ 관계는 깨져도 고칠 수 있다

어긋남 자체보다 회복이 아이를 키웁니다. 한 번도 어긋나지 않은 관계에서는 회복을 배울 수 없습니다.

## 이런 경우엔요?

"감정을 다 받아주면 버릇없어지지 않나요?" 감정을 받아주는 것과 **행동을 허용하는 것**은 다릅니다. "화났구나"는 감정 인정이고, "그래서 때려도 돼"는 행동 허용입니다. 이 책은 앞의 것만 하라고 합니다.

"이렇게 말해도 안 그쳐요." 그치게 하는 게 목적이 아닙니다. 감정 코칭은 **진정 스위치가 아니라 장기 학습**입니다. 지금 당장의 효과는 크지 않고, 몇 년에 걸쳐 나타납니다.

"조부모님은 다르게 하세요." 타협 불가 항목(체벌 금지 등)만 명확히 하고 나머지는 유연하게 두세요. **일관성은 한 사람 안에서 지켜지면 충분합니다.** 부록 G의 위임 시트를 쓰세요.

## 오려 쓰는 한 장 ② — 감정 코칭

감정은 모두 허용. 행동은 일부 제한.

- ① 알아차린다 ② 기회로 본다
- ③ 공감하며 듣는다
- ④ 이름을 붙인다 ← 가장 자주 건너뛰다
- ⑤ 한계를 정하고 함께 해결한다

떼쓰는 중에는 → 말을 줄이고, 곁에 있다  
"화났구나. 아빠 여기 있어." (한 문장)

떼쓰기의 절반은 배고픔과 졸림이다.

화가 나면 → 아이를 안전한 곳에 두고 나온다  
소리 질렀으면 → 사과한다. 회복이 교육이다.

 **지금 해보기** 오늘 아이가 울면, 첫 마디를 "괜찮아"가 아니라 **감정 이름**으로 시작해보세요. "속상했구나." 그 한 마디의 차이가 이 장의 전부입니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 아이는 **혼자 진정하지 못한다**. 부모의 침착함에 동기화되며 배운다.
2. **감정은 모두 허용, 행동은 일부 제한**. 감정에 이름을 붙이는 ④단계가 핵심이다.
3. 떼쓰는 중엔 말을 줄이고 곁에 있다. 예방(배고픔·졸림·예고)이 대응보다 효과적이다.

→ 다음: 7장 · 훈육

## 7장 · 훈육

연결 먼저, 그다음 방향

### 장면

세 살 아이가 벽에 크레용으로 낙서를 했습니다. 당신은 그 벽을 지난달에 칠했습니다. 순간적으로 목소리가 올라갑니다. "야! 여기서 하면 어떡해!" 아이가 얼어붙습니다. 그리고 읊니다.

십 분 뒤 당신은 후회합니다. 그런데 다음에 어떻게 해야 할지는 여전히 모릅니다.

#### ♡ 먼저, 소리 지른 적 있는 분들에게

이 장을 읽기 전에 이 말씀부터 드리고 싶어요.

아이에게 소리를 질러본 적 없는 부모는 거의 없습니다. 그리고 그중 대부분은 그날 밤 자책하며 잠들죠. "나는 왜 이럴까", "우리 엄마아빠처럼 되고 있나" 하면서요.

이 장은 앞으로 체벌이 왜 효과가 없는지, 고함이 왜 해로운지를 근거를 들어 말할 겁니다. 그걸 읽으면서 이미 한 일에 대한 죄책감이 커지실 수도 있어요. 그래서 미리 두 가지를 말씀드립니다.

첫째, 몇 번의 실수가 아이를 결정하지 않습니다. 아이 발달을 예측하는 건 한두 번의 사건이 아니라 전체적인 패턴이에요. 대체로 안전하고 대체로 따뜻한 관계라면, 가끔의 실수는 그 안에 흡수됩니다.

둘째, 회복이 실수보다 강합니다. 화를 내고 나서 "아까 아빠가 큰 소리 내서 미안해"라고 말하는 그 과정이, 아이에게 관계는 깨져도 고칠 수 있다는 걸 가르쳐요. 한 번도 어긋나지 않은 관계에서는 배울 수 없는 것입니다.

그러니 이 장은 자책하시라고 쓴 게 아니라, 다음번을 위해 쓴 것입니다. 지나간 일은 사과 한 번으로 정리하고, 여기서부터 시작하셔도 충분해요.

### 먼저 정리할 것 — 훈육은 벌이 아니다

discipline의 어원은 라틴어 \*disciplina\*, "가르침"입니다. 벌이 아닙니다.

이 장의 목표는 아이가 다음에 다르게 행동하게 만드는 것이지, 지금 아이가 미안해하게 만드는 것이 아닙니다. 이 둘은 자주 반대 방향입니다.

### 근거가 정리된 결론 세 가지

#### ① 체벌은 효과가 없고 해롭다 강함

미국소아과학회(AAP)의 2018년 정책성명 \*Effective Discipline to Raise Healthy Children\*은 다음을 명시합니다.

- 체벌은 단기적으로도 행동 개선 효과가 낮습니다.
- 장기적으로는 공격성 증가, 인지 발달 저하, 정신건강 문제와 연관됩니다.
- 고함과 모욕 같은 언어적 공격도 유사한 부정적 결과와 연관됩니다.

대한민국은 2021년 민법 제915조(징계권)를 삭제해, 부모의 체벌 근거 조항이 법적으로 사라졌습니다.

체벌이 "효과 있어 보이는" 이유는 아이가 즉시 멈추기 때문입니다. 그러나 그건 학습이 아니라 공포 반응입니다. 아이가 배우는 것은 "이 행동을 하지 말아야겠다"가 아니라 "부모가 볼 때는 하지 말아야겠다"입니다.

## ② 가장 강력한 도구는 벌이 아니라 긍정적 관심이다 강함

Incredible Years, Triple P, PCIT 등 무작위 연구로 효과가 검증된 부모교육 프로그램들이 **공통으로 가장 먼저 가르치는 기술**은 벌이 아닙니다. **아이가 잘하고 있을 때 알아봐 주기**입니다.

아이는 관심을 얻으려 합니다. 그리고 **부정적 관심(야단)도 관심**입니다. 잘하고 있을 때 아무도 안 보고 문제를 일으킬 때만 관심을 받는다면, 아이는 문제를 일으키는 쪽을 학습합니다.

## ③ 일관성이 강도보다 중요하다

같은 규칙을 **매번 같게** 적용하는 것이, 가끔 세게 혼내는 것보다 효과가 큼니다.

**다섯 번 중 한 번 들어주면, 아이는 다섯 번 다 시도합니다.** 행동심리학에서 **간헐적 강화**는 행동을 가장 끈질기게 만드는 방식으로 알려져 있습니다. 슬롯머신이 그 원리로 작동합니다.

## 훈육의 다섯 단계 — 모든 연령 공통

- |       |              |                        |
|-------|--------------|------------------------|
| 1. 예방 | 상황을 만들지 않는다  | (배고픔·졸림·지루함 관리, 환경 정리) |
| 2. 연결 | 감정을 먼저 인정한다  | "화났구나"                 |
| 3. 제한 | 행동에 선을 긋는다   | "그래도 때리는 건 안 돼"        |
| 4. 대안 | 할 수 있는 것을 준다 | "화나면 베개를 치자"           |
| 5. 회복 | 관계를 다시 잇는다   | "이제 괜찮아? 안아줄까?"        |

**대부분의 부모는 2번을 건너뛰고 3번부터 시작합니다.** 그러면 아이는 방어에 들어가고, 아무것도 배우지 못합니다.

이것이 시겔과 브라이슨이 **Connect & Redirect(연결하고, 방향을 바꾼다)**라고 부른 것입니다. 순서가 바뀌면 작동하지 않습니다.

## 나이별로 통하는 것

### 0~12개월 — 훈육 개념이 없다

이 시기 아이는 **의도적으로 말을 안 듣는 것이 물리적으로 불가능**합니다.

- "안 돼"가 필요한 상황은 **환경을 바꿔서** 해결합니다. 만지면 안 되는 물건은 치웁니다.
- 위험한 행동은 **말이 아니라 물리적으로 옮겨서** 막고, 다른 것으로 관심을 돌립니다.
- 이 시기에 "버릇 들이기"는 개념적으로 존재하지 않습니다.

### 12~24개월 — 주의 전환이 최고의 도구

아이는 "안 돼"를 이해하기 시작하지만 **충동을 억제할 능력은 없습니다.**

- **주의 전환(redirection):** "그건 안 돼" + 즉시 다른 것을 손에 쥐어주기
- **짧고 단순하게.** "뜨거워. 안 돼." 설명은 필요 없습니다.
- **"안 돼"의 횟수를 줄입니다.** 하루 종일 들으면 단어의 힘이 사라집니다.

### 2~3세 — 감정 이름 + 선택지

- **감정 명명:** "실망했구나."
- **선택지:** "빨간 옷 입을래, 파란 옷 입을래?"
- **When-then:** "신발 신으면, 그 다음에 나갈 거야." — 협박이 아니라 **순서 안내**입니다
- **협상하지 않습니다.** 결정한 것은 유지하되, 감정은 계속 인정합니다

### 3~5세 — 결과 + 문제 해결

이제 원인과 결과를 이해합니다.

- **자연적 결과:** 장갑을 안 끼면 손이 시립니다 (안전한 범위에서 경험하게 합니다)
- **논리적 결과:** 벽에 낙서하면 → **같이 닦습니다.** 행동과 관련이 있어야 합니다
- **문제 해결에 참여시키기:** "매일 아침 늦어지네. 어떻게 하면 좋을까?"

→ 아이가 낸 해결책은 지켜질 확률이 훨씬 높습니다.

- 가족 규칙을 3~5개로 짧게 정해 그림으로 붙입니다

며칠 뒤 장난감 압수는 어린 아이에게 연결되지 않습니다. 결과는 즉각적이고, 관련이 있어야 합니다.

## 상황별 대응 스크립트 12

실제로 벌어지는 열두 가지입니다. 대사를 그대로 쓰셔도 됩니다.

### 1. 마트에서 과자를 사달라며 눕는다

| ✗                         | ✓                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사준다 / 소리 지른다 / "사람들이 다 봐" | <b>도착 전에</b> "오늘은 과자 안 살 거야"를 미리 말한다. 그래도 하면 조용한 곳으로 옮겨 <b>"과자 못 사서 속상하구나."</b> 요구는 들어주지 않고 감정만 받는다 |

### 2. 친구나 동생을 때렸다

| ✗                | ✓                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아이를 때리며 "때리면 아파" | ① 즉시 분리 ② <b>피해 아이를 먼저 돌본다</b> (가해 아이에게 관심이 물리지 않게) ③ "때리는 건 안 돼. 화나면 말로 해." ④ 나중에 대안을 연습 |

### 3. 밥을 안 먹는다

| ✗                         | ✓                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 쫓아다니며 먹인다 / "다 먹으면 아이스크림" | 정해진 시간·자리에서만. 20~30분 뒤 조용히 치운다. 다음 식사까지 간식 없음. <b>양은 아이가 정한다</b> (18장 책임 분담 모델) |

### 4. 잠자리에서 계속 나온다

| ✗             | ✓                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 화낸다 / 매번 설득한다 | <b>말없이</b> 조용히 다시 눕힌다. 반복. 눈맞춤과 대화를 최소화한다. 말을 섞을수록 길어진다 |

### 5. "싫어"만 반복한다

| ✗    | ✓                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 힘겨루기 | 선택지를 준다. <b>중요하지 않은 건 저준다.</b> 정말 중요한 것만 고집한다 (안전·타인에게 해가 되는 것) |



## 6. 형제와 싸운다

| ✖             | ✔                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 누가 잘못했는지 재판한다 | 양쪽 감정을 통역한다. "너는 그 차로 놀고 싶었고, 애는 아직 다 못 놀았대." → <b>해결책을 아이들에게 묻는다.</b> "어떻게 하면 둘 다 놀 수 있을까?" |

## 7. 물건을 던진다

| ✖      | ✔                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 뺏고 벌준다 | "던지는 건 공만. 이걸 놓는 거야." + <b>던져도 되는 것을 준다.</b> 욕구를 없애지 말고 방향을 바꾼다 |

## 8. 거짓말을 한다

| ✖                       | ✔                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| "네가 그랬지!" 추궁 (함정에 빠뜨리기) | "무슨 일이 있었는지 같이 보자." <b>사실을 말하면 칭찬한다.</b><br>"사실대로 말해줘서 고마워" |

## 9. 화면을 끄면 운다

| ✖               | ✔                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 갑자기 끈다 / 더 보여준다 | <b>미리 끝을 정한다.</b> "이거 하나 끝나면 끄는 거야." 끝나면 예외 없이 끈다. 끄는 순간의 울음은 예상된 비용 |

## 10. 어린이집 갈 때 매달린다

| ✖                  | ✔                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 몰래 나간다 / 작별을 길게 끈다 | <b>짧고 일관된 작별 의식.</b> "뽀뽀 한 번, 안아주기 한 번, 빠이빠이. 낮잠 자고 나면 아빠 올 거야." 그리고 <b>바로 나간다</b> |

## 11. 옷을 안 입겠다고 한다

| ✖       | ✔                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 억지로 입힌다 | 선택지. "이거 입을래, 저거 입을래?" 시간이 없으면 <b>"지금은 아빠가 정할게"</b> 라고 솔직히 말하고 입힌다. 감정은 인정: "네가 고르고 싶었지" |

## 12. 공공장소에서 된다

| ✖            | ✔                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| "뛰지 마!" (반복) | <b>금지어 대신 대안.</b> "여기서는 걸어. 뛰는 건 놀이터에서." + 뭘 곳을 실제로 만들어준다. 그 전에 <b>에너지를 미리 소진</b> 시킨다 |

## 타임아웃을 쓸 것인가

쓴다면 이렇게.

- 만 2세 이상부터. 그 전엔 이해하지 못합니다
- 나이당 1분 (3세면 3분)
- 벌이 아니라 진정 시간으로 설계합니다
- 정서적으로 어린 아이에겐 혼자 두는 대신 **곁에서 함께 진정하기(time-in)**가 더 적합할 수 있습니다

- 끝난 뒤 반드시 다시 연결합니다. "이제 괜찮아졌네."

 **결론만 말하면:** 타임아웃은 일부 프로그램에서 효과가 확인되었지만, 격리 자체보다 그 앞뒤의 연결과 일관성이 효과를 만듭니다. 안 써도 됩니다. 쓸 거면 짧고 예측 가능하게.

## 칭찬 — 결과가 아니라 과정

캐롤 드웍(Carol Dweck)과 건더슨(Gunderson) 등의 연구에서, **과정 칭찬(process praise)**을 많이 들은 아이가 이후 도전을 더 잘 견뎌냈습니다. **보통**

| ❌ 사람 칭찬    | ✅ 과정 칭찬            |
|------------|--------------------|
| "우와 천재네!"  | "포기 안 하고 끝까지 했네."  |
| "예쁘게 그렸다!" | "여기 색을 여러 개 섞었구나." |
| "착한 아이네."  | "동생한테 먼저 양보했구나."   |
| "잘했어!"     | "혼자 신발 신었네."       |

인격("착한 아이")보다 **행동**을 짚습니다. 그리고 구체적으로.

### 보상(스티커 등)을 쓴다면

- 단기적·한정적으로. 배변 훈련처럼 특정 목표에만
- 이미 아이가 좋아서 하는 일에는 **보상을 붙이지 않습니다**. 내재적 동기가 오히려 줄어듭니다(과잉정당화 효과) **보통**
- 목표 달성 후에는 자연스럽게 걷어냅니다

## 이런 경우엔요?

"부부가 훈육 방식이 달라요." 완전히 같을 필요는 없습니다. **타협 불가 항목 3~5개만 합의**하세요 (체벌 금지, 안전 규칙, 일관된 취침 시간 등). 나머지는 각자 스타일로 두어도 아이는 적응합니다.

"조부모님이 다 받아주세요." 집집마다 규칙이 다를 수 있다는 것을 아이는 생각보다 잘 이해합니다. 다만 **안전과 체벌은 예외 없이 전달**하세요. 부록 G의 위임 시트를 쓰세요.

"이미 몇 년째 소리 지르며 키웠어요." 늦지 않았습니다. 관계 회복의 효과는 어느 시점에 시작해도 나타납니다. **오늘의 사과 한 번**이 시작입니다.

## 전문가 상담을 고려할 때

- 공격 행동(때리기·물기)이 **만 4세 이후에도 자주** 나타날 때
- 떼쓰기가 **하루 여러 번, 30분 이상**, 자해나 심한 파괴를 동반할 때
- 또래·기관에서 지속적으로 문제가 보고될 때
- 부모가 **아이에게 화를 참기 어렵다고 느낄 때** — 이걸 아이 문제가 아니라 지원이 필요하다는 신호입니다
- 아이가 **위축·무기력하고 반응이 거의 없을 때** — 겉으로 드러나는 문제보다 놓치기 쉽습니다

**경로:** 소아청소년과 → 소아정신건강의학과 / 지역 정신건강복지센터 / 육아종합지원센터

### 근거 기반 부모교육 프로그램

| 프로그램             | 대상    | 특징                          |
|------------------|-------|-----------------------------|
| Triple P         | 0~12세 | 근거 축적이 가장 방대. 여러 나라 공공 프로그램 |
| Incredible Years | 0~12세 | 놀이 중심 관계 형성 + 행동 관리         |

| 프로그램               | 대상   | 특징                       |
|--------------------|------|--------------------------|
| PCIT               | 2~7세 | 행동 문제가 뚜렷할 때. 치료자 실시간 코칭 |
| Circle of Security | 0~5세 | 애착 중심                    |

국내에서는 **육아종합지원센터, 건강가정지원센터, 보건소 정신건강복지센터**에서 부모교육을 운영합니다. 무료인 경우가 많습니다.

👉 **지금 해보기** 오늘 하루 "안 돼"를 몇 번 말하는지 세어보세요. 열 번이 넘는다면, 그중 절반은 **환경을 바꿔서 없앨 수** 있는 것입니다. 다음 장이 그 이야기입니다.

### 📌 이 장의 요약 3줄

1. 체벌은 효과가 없고 해롭다. 가장 강력한 도구는 **잘하고 있을 때 알아봐 주는 것**이다.
2. 순서는 **예방 → 연결 → 제한 → 대안 → 회복**. 연결을 건너뛰면 아무것도 전달되지 않는다.
3. 일관성이 강도를 이긴다. **다섯 번 중 한 번 들어주면 다섯 번 다 시도한다**.

→ 다음: 8장 · 환경 설계

## 8장 · 환경 설계

말보다 빠른 것

### 장면

거실 탁자 위에 리모컨, 안경, 화분, 머그컵이 있습니다. 아홉 달 된 아기가 기어와 손을 뻗습니다. 당신은 "안 돼"라고 말합니다. 아기가 다시 손을 뻗습니다. "안 돼." 또 뻗습니다. "안 돼!"

하루에 이 장면이 마흔 번 반복됩니다.

탁자 위를 치우는 데는 3분이 걸립니다.

### 이 장의 원칙 한 줄

말로 막지 말고 환경으로 막는다.

아이의 자기조절 능력은 미성숙합니다. 그것에 의존하는 전략은 실패합니다. 반면 **환경은 아이의 의지와 무관하게 작동합니다.**

이 원칙은 두 방향으로 씁니다.

| 방향    | 뜻               | 예                   |
|-------|-----------------|---------------------|
| 막는 환경 | 위험한 것을 물리적으로 차단 | 서랍 잠금, 가구 벽 고정, 안전문 |
| 여는 환경 | 하길 바라는 행동을 쉽게   | 낮은 책장, 아이 키 옷걸이, 발판 |

7장에서 "안 돼"를 줄이라고 한 이유가 이것입니다. 줄이는 방법은 참는 것이 아니라 **치우는 것**입니다.

### 1부 — 막는 환경 (안전)

육아에서 통계적으로 아이의 생명에 가장 큰 영향을 주는 것은 교육법이 아닙니다. **안전한 수면, 카시트, 익수 예방, 삼킴 사고 예방**입니다. 이 절의 항목들은 **선택이 아니라 기본값**으로 다루세요.

#### ① 안전한 수면 — 만 1세까지

미국소아과학회의 2022년 안전 수면 권고입니다. **강함**

Alone - 혼자 (같은 방, 다른 잠자리)  
Back - 등을 대고  
Crib - 단단하고 평평한 잠자리에서

| 항목    | 내용                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 자세    | <b>항상 등을 대고.</b> 낮잠 포함, 만 1세까지. 스스로 뒤집을 수 있게 되면 되돌리지 않아도 됩니다(눕힐 때만 등으로) |
| 바닥    | 단단하고 <b>평평한</b> 매트리스 + 딱 맞는 시트 1장. <b>경사진 제품 금지</b>                     |
| 잠자리 안 | 베개·이불·범퍼·인형·수면쿠션·포지셔너 <b>전부 없음</b>                                      |
| 방     | <b>같은 방, 다른 잠자리</b> — 최소 6개월, 가능하면 12개월                                 |
| 온도    | 서늘하게. 이불 대신 <b>수면조끼</b> . 과열은 위험 요인                                     |
| 금연    | 임신 중·출생 후 흡연 노출은 주요 위험 요인                                               |

| 항목   | 내용                                    |
|------|---------------------------------------|
| 모유수유 | 위험을 낮추는 것으로 보고됨                       |
| 쪽쪽이  | 모유수유 확립 후(대략 3~4주) 낮잠·밤잠 시 사용은 위험을 낮춤 |

### 절대 하면 안 되는 것

- 소파나 안락의자에서 아기와 함께 잠들기 — 침대에서의 동침보다도 위험이 높습니다
- 카시트·유모차·아기띠·바운서에서 재우기 (이동 중 잠들었다면 도착 후 평평한 곳으로)
- 부모가 음주·약물·극심한 피로 상태에서 같은 잠자리 사용
- 뒤집기 시작한 뒤의 속싸개
- SIDS 예방을 표방하는 상업용 모니터를 **안전 대책으로 신뢰**하는 것 (의학적 근거 없음)

### ② 카시트 — 탈 때마다, 예외 없이

1. 뒤보기(후방보기)를 최대한 오래. 최소 만 2세, 가능하면 제품이 허용하는 신장·체중 한계까지. 충돌 시 목과 척추 손상을 크게 줄입니다 **강함**
2. 뒷좌석. 조수석 에어백은 아이에게 치명적일 수 있습니다
3. 하네스 조임: 어깨끈을 잡아당겼을 때 손가락으로 접히는 여유가 없을 정도. 가슴 클립은 **겨드랑이 높이**
4. 두꺼운 외투는 벗기고 태웁니다. 패딩이 압축되면 하네스에 큰 여유가 생겨 충돌 시 튕겨 나갈 수 있습니다. 태운 뒤 담요를 덮으세요
5. 대한민국 도로교통법상 **만 6세 미만은 카시트 착용 의무**입니다. 실제 안전을 위해서는 신장 약 150cm까지 부스터 사용이 권고됩니다

### 흔한 실수

- 설치 각도 부정확 — 신생아는 고개가 앞으로 꺾이면 기도가 막힐 수 있습니다
- 고정이 느슨함 — 벨트 경로에서 좌우로 2.5cm 이상 움직이면 다시 설치
- 중고·사고 이력 카시트 사용
- 차 안에 아이를 혼자 두기 — 짧은 시간이라도 안 됩니다. 차내 온도는 매우 빠르게 치명적 수준에 도달합니다

### ③ 물 — 조용하고 빠르다

- 영유아는 2~3cm 깊이에서도 익사할 수 있습니다. 욕조, 세숫대야, 변기, 양동이
- 익사는 소리 없이 일어납니다. 침병거리며 소리치는 장면은 영화입니다
- 목욕 중에는 절대 자리를 뜨지 않습니다. 초인종이 울려도 아이를 안고 이동합니다
- 목욕 후 즉시 물을 뺍니다. 변기 뚜껑 잠금
- 물놀이 시 팔튜브는 안전장비가 아닙니다. 구명조끼 + 팔 뺀으면 닿는 거리에서 감독

### ④ 삼킴·질식

화장지 심(지름 약 3.2cm)을 통과하는 물건은 삼킬 수 있습니다. 이 기준으로 집을 점검하세요.

### 삼키면 즉시 응급실

| 물건            | 왜                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 버튼형 리튬 전지     | 식도에 걸리면 2시간 내에도 화학 화상·천공. 리모컨, 자동차 키, 체중계, 전자 촛불, 노래하는 카드 확인 |
| 자석 구슬 2개 이상   | 장을 사이에 두고 붙어 천공                                              |
| 동전, 바늘, 뾰족한 것 | 위치에 따라 응급                                                    |

| 물건         | 왜               |
|------------|-----------------|
| 약물, 캡슐형 세제 | 색이 예뻐서 아이가 삼킵니다 |

**질식 위험 음식 (만 4세까지)** 통 견과류 · 통 포도 · 방울토마토 · 팝콘 · 사탕 · 동그랗게 썬 소시지 · 딱딱한 생당근 · 껌 · 떡

→ 포도·방울토마토는 **세로로 4등분**, 소시지는 세로로 갈라서, 견과류는 갈아서. **앉아서 먹고, 걸어 다니며 먹지 않기.**

**기타 교살 위험:** 블라인드 줄(줄 없는 제품으로 교체 권장) · 비닐봉지 · 풍선(터진 조각) · 목에 거는 것 일체

## 월령별 안전 설치 타이밍

아이가 할 수 있게 되기 전에 미리 끝내야 합니다. 하고 나서는 늦습니다.

| 시기      | 해야 할 것                       |
|---------|------------------------------|
| 출생 전    | 카시트, 안전한 잠자리                 |
| 4~6개월   | 가구·TV 벽 고정, 작은 물건 정리 (뒤집기 전) |
| 6~9개월   | 전면 안전 점검 완료 (기기 시작 전)        |
| 9~12개월  | 계단 안전문, 서랍 잠금 (서가·크루징)       |
| 12~24개월 | 창문·베란다, 높은 곳 오르기 대비          |

### 전면 점검 체크리스트

- ☐ 가구·TV 벽 고정 — 넘어짐 사고는 치명적입니다. 서랍장, 책장, TV 전부
- ☐ 콘센트 안전커버
- ☐ 계단 위·아래 안전문 — 위쪽은 반드시 벽에 나사로 고정하는 방식
- ☐ 서랍·수납장 잠금 — 세제, 약, 칼, 비닐
- ☐ 모서리 보호대
- ☐ 블라인드 줄 제거·정리
- ☐ 식탁보 치우기 (당기면 위의 것이 쏟아집니다)
- ☐ 정수기 온수 잠금, 전기포트·밥솥 위치, 냄비 손잡이는 안쪽으로
- ☐ 창문 잠금. 방충망은 추락을 막지 못합니다. 창가에 올라갈 가구를 두지 않기
- ☐ 베란다 문 잠금
- ☐ 화장실 문 닫기, 변기 잠금
- ☐ 반려동물과 아이를 단둘이 두지 않기
- ☐ 화재경보기 설치 및 배터리 점검
- ☐ 약·비타민은 높고 잠긴 곳에 (어린이 보호 뚜껑도 완전하지 않습니다)
- ☐ 담배·전자담배 액상 — 니코틴은 소량으로도 치명적
- ☐ 유모차·유아용 의자·쇼핑카트: 항상 안전벨트
- ☐ 보행기 사용하지 않기 (AAP 권고 — 낙상 위험, 걷기 지연) **강함**

**화상 예방:** 목욕물 37~38℃, 팔꿈치나 온도계로 확인. 온수기 최고 온도를 낮춰 설정. 아이를 안고 뜨거운 음료를 들지 않기. 전자레인지로 데운 것은 반드시 저어서 온도 확인

## 2부 — 여는 환경

막기만 하는 집에서는 아이가 아무것도 못 합니다. 균형이 필요합니다.

### ① 아이 키에 맞추기 (몬테소리식)

"준비된 환경"의 핵심은 단순합니다. **아이가 스스로 할 수 있게 만드는 것.**

| 바꾸는 것           | 아이가 할 수 있게 되는 것 |
|-----------------|-----------------|
| 낮은 옷걸이 / 낮은 서랍  | 스스로 옷 꺼내기, 걸기   |
| 세면대 발판          | 손 씻기, 양치        |
| 물병과 컵을 낮은 곳에    | 스스로 물 따라 마시기    |
| 낮은 책장 (표지가 보이게) | 스스로 책 골라 오기     |
| 신발장 아래 칸 비우기    | 스스로 신발 신고 정리    |
| 작은 빗자루·행주       | 치우기에 참여         |

**이게 왜 훈육 도구인가:** "혼자 하고 싶다"는 욕구는 13~24개월에 폭발합니다. 환경이 막고 있으면 그 욕구는 **좌절 → 떼쓰기**로 나타납니다. 환경이 열려 있으면 같은 욕구가 **자조 능력**으로 나타납니다. 같은 아이, 다른 결과입니다.

### ② 장난감 순환(rotation)

- 전부 꺼내두지 말고 **6~8개 정도만 노출**, 2~3주마다 교체
- 장난감 수가 적을 때 아이가 **한 가지에 더 오래, 더 창의적으로** 논다는 연구가 있습니다 **보통**
- 나머지는 상자에 담아 보이지 않는 곳에. 다시 꺼내면 새 장난감이 됩니다

### ③ 좋은 장난감의 기준

장난감이 90%를 하고 아이가 10%를 하는 것이 아니라, 그 반대여야 합니다.

- **열린 결말(open-ended):** 블록, 인형, 천, 상자 — 여러 방식으로 쓸 수 있는 것
- 단순할수록 놀이 방식이 다양해집니다
- 소리·불빛이 요란한 전자 장난감은 **부모-아이의 언어 상호작용을 줄인다는** 연구가 있습니다 **보통**

### ④ 화면 환경

의지로 관리하려 하지 말고 **환경으로** 관리하세요.

- **침실과 식탁에는 화면을 두지 않습니다** (규칙보다 배치가 강력합니다)
- 정해진 시간·장소만 (예: 주말 오후, 거실에서만)
- 끝내는 규칙을 미리 정합니다. "이거 하나 끝나면 끄는 거야"
- 아이를 진정시키는 수단으로 **화면을 쓰지 않습니다**. 스스로 감정을 조절하는 법을 배울 기회를 잃습니다 **보통**

연령 기준 (AAP·WHO)

| 나이      | 기준                          |
|---------|-----------------------------|
| 18개월 미만 | 영상통화 외 권장하지 않음              |
| 18~24개월 | 도입한다면 고품질 콘텐츠를 부모가 함께 보며 설명 |
| 2~5세    | 하루 1시간 이내, 가능하면 함께 시청       |

## 응급 대비 — 미리 해둘 것

### ① 영유아 심폐소생술을 배운다

부모라면 반드시 배워야 합니다. 영아와 소아의 방법은 성인과 다릅니다. 대한적십자사·소방서·보건소에서 무료 또는 저가 교육을 운영합니다. 배우자와 함께, 그리고 아이를 돌볼 조부모·도우미도 함께 받으세요. (절차 요약은 22장)

### ② 냉장고에 붙여둘 정보

119 (응급)                      1339 (응급의료 상담)  
소아 응급실 ①: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
소아 응급실 ②: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
다니는 소아과: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
아이 생년월일 / 체중 / 알레르기 / 복용약:  
집 주소 (구급대에게 불러줄 정확한 주소):

### ③ 가정 구급함

체온계(직장·구강 검용 1개 필수) · 아세트아미노펜 시럽 · (6개월 이후) 이부프로펜 시럽 · 체중별 용량을 미리 의사에게 확인해 적어둔 메모 · 생리식염수 · 코 흡입기 · 밴드·소독약·거즈 · 경구수액제(ORS) · 손톱가위 · 핀셋

## 이런 경우엔요?

"집이 좁아서 안전용품이 다 못 달아요." 우선순위가 있습니다. ① 가구 벽 고정 ② 카시트 ③ 안전한 잠자리 ④ 창문·베란다. 이 넷이 사고 심각도가 가장 높습니다. 나머지는 그다음입니다.

"조부모님 댁은 안전 조치가 안 되어 있어요." 자주 가는 집이라면 최소 세 가지만 부탁하세요. 가구 고정, 약과 세제 치우기, 베란다·창문 잠금. 부록 G 시트에 포함되어 있습니다.

"너무 막으면 아이가 겁이 많아지지 않나요?" 반대입니다. 안전이 확보된 공간에서 아이는 더 자유롭게 탐색합니다. 부모가 계속 쫓아다니며 "안 돼"를 외치는 집보다, 안전하게 만들어 놓고 지켜보는 집에서 아이가 더 멀리 나갑니다. 1부의 순환 그림 그대로입니다.



## 오려 쓰는 한 장 ③ — 안전 필수 8

1. 등을 대고, 평평한 곳에, 잠자리엔 아무것도
2. 카시트 - 뒤보기, 뒷좌석, 외투 벗기고
3. 목욕 중 절대 자리 뜨지 않기 · 물 즉시 빼기
4. 화장지 심을 통과하는 것은 다 치우기
5. 버튼형 전지·자석 구슬 = 삼키면 즉시 응급실
6. 가구와 TV는 벽에 고정
7. 창문 잠금 (방충망은 추락을 못 막는다)
8. 보행기 쓰지 않기

포도·방울토마토는 세로로 4등분  
차 안에 아이를 혼자 두지 않기 (단 1분도)

 **지금 해보기** 지금 서 있는 방에서 **무릎으로 앉아 아이 눈높이로 둘러보세요.** 서 있을 때 안 보이던 것들이 보입니다. 그것이 오늘 치울 목록입니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. **말로 막지 말고 환경으로 막는다.** "안 돼"의 절반은 3분이면 없앨 수 있다.
2. 안전은 **기기 시작 전에** 끝낸다. 우선순위는 가구 고정·카시트·잠자리·창문.
3. 막는 환경만큼 **여는 환경도** 만든다. 낮은 책장과 발판이 자조 능력을 만든다.

→ 다음: 9장 · 놀이와 말

## 9장 · 놀이와 말

### 가장 강력한 교육 도구

#### 장면

다섯 살 아이가 소파 쿠션을 전부 바닥에 내려놓고 그 위에 담요를 덮었습니다. "여기는 배야. 아빠는 선장 해." 당신은 저녁 준비를 하다 말고 생각합니다. '이걸 하는 시간에 한글이라도 한 자 더 가르치는 게 낫지 않을까.'

아닙니다. 지금 아이가 하고 있는 것이 이 나이에 할 수 있는 **가장 고급한 학습**입니다.

#### 놀이가 왜 학습인가

미국소아과학회는 2018년 임상보고서 \*The Power of Play\*에서 놀이를 **아동 발달의 핵심 기전**으로 규정했습니다. 놀이는 언어·실행기능·사회정서·스트레스 조절을 **동시에** 발달시키며, 구조화된 학습으로 대체되지 않습니다. **[보통~강함]**

방금 그 장면에서 아이는 이걸 하고 있었습니다.

| 아이가 한 것         | 발달하는 것                    |
|-----------------|---------------------------|
| 쿠션을 배로 "정한 것"   | 상징 사고 — 이것이 저것을 나타낼 수 있다  |
| 아빠에게 역할을 준 것    | 마음이론 — 타인도 이 놀이에 참여할 수 있다 |
| 배 모양으로 쌓은 것     | 계획과 공간 지각                 |
| 선장 역할을 유지하는 것   | 자기조절 — 규칙을 스스로 지키기        |
| "여기는 배야"라고 말한 것 | 탈맥락적 언어 — 지금 없는 것에 대해 말하기 |

한글 학습지 한 장이 이 중 몇 개를 할까요.

#### 놀이의 유형과 효과

| 유형       | 예                        | 주로 기르는 것              |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| 자유놀이     | 아이가 주도하는 모든 놀이           | 창의성, 자기조절, 문제 해결      |
| 가장놀이     | 소꿉놀이, 병원놀이               | 추상 사고, 언어, 마음이론, 자기조절 |
| 구성놀이     | 블록, 레고, 모래               | 공간 지각, 계획, 소근육        |
| 신체놀이     | 뒹굴기, 몸싸움 놀이              | 정서 조절, 사회적 신호 읽기      |
| 규칙 있는 놀이 | 보드게임, 술래잡기               | 억제 조절, 순서, 지는 것 견디기   |
| 안내된 놀이   | 부모가 목표를 두되 <b>아이가 주도</b> | ← 아래                  |

#### 안내된 놀이(guided play)가 핵심

완전 방임도 아니고 직접 교습도 아닌 중간 지대입니다. 여러 연구에서 **안내된 놀이가 직접 교습보다 어휘·공간·수 개념 학습에 더 효과적**이라는 결과가 나왔습니다. **[보통]**

**방법:** 아이가 주도하게 두되, 부모가 **질문과 언어로 확장**합니다.

| 아이가 하는 것 | 부모의 한 마디                    |
|----------|-----------------------------|
| 블록을 쌓는다  | "이번 건 더 높네. 어떻게 하면 안 넘어질까?" |
| 소꿉놀이 중   | "손님이 몇 명 왔지? 접시는 몇 개 필요할까?" |

| 아이가 하는 것 | 부모의 한 마디                   |
|----------|----------------------------|
| 물을 붓는다   | "이 컵이 더 많이 들어가네. 왜 그럴까?"   |
| 그림을 그린다  | "여기 이건 뭐야? 다음엔 무슨 일이 일어나?" |

주도권은 아이에게 두고, 부모는 조연입니다. 부모가 주도하면 그건 수업이지 놀이가 아닙니다.

## 언어 — 시기별 실전 기법

5장 네 박자가 뼈대이고, 여기에 시기별 살을 붙입니다.

### 0~12개월

- parentese — 높은 톤, 느린 속도, 또렷한 모음. 단어는 정확하게
- 해설(narrating) — 지금 하는 일을 계속 말로. "기저귀 갈자. 다리 들고. 어이구 시원하다"
- 모방과 기다림 — 아이 소리를 따라 하고 3~5초 침묵
- 하루 목표: 주고받기 20회

### 12~24개월

- +1 확장 — 아이 한 단어 → 부모 두 단어. "차!" → "빨간 차!"
- 선택 질문 — "물 마실래?" 대신 "물 줄까, 우유 줄까?" 단어를 쓰게 만든다
- 몸짓을 함께 — 몸짓 사용은 이후 어휘와 정적 상관이 있습니다 **보통**
- 일부러 기다리기 — 원하는 걸 바로 주지 말고 5초. 소리라도 내면 반응해준다

### 24~36개월

- 문법 재구성(recast) ★

아이: "물 마셨어 나" → 부모: "아, 네가 물을 마셨구나." 틀렸다고 지적하지 않고 바르게 되돌려줍니다. 이것이 문법 습득의 주 경로입니다 **강함**

- ✖ "그렇게 말하는 거 아니야. '내가 물을 마셨어'라고 해봐."
- ✔ "아, 네가 물을 마셨구나. 시원했어?"
- 되짚어 말하기(remiscing) — 하루에 있었던 일을 함께 이야기. 자서전적 기억과 서사 능력을 키웁니다 **보통**

### 만 3~5세

- 탈맥락적 언어 — 지금 여기 없는 것에 대해 말하기. 어제 일, 내일 계획, 상상. 이것이 학교 언어의 토대입니다
- 드문 단어 일부러 쓰기 — "거대한", "실망했어", "곧바로", "결국". 어려운 단어 노출이 어휘 성장을 예측합니다
- 이야기 만들기 — 글 없는 그림책, 사진 보고 이야기 짓기. 표현 언어에 매우 효과적

## 책 읽기 — 최고의 투자

### 기본

- 출생 직후부터 매일. AAP의 공식 권고입니다
- 시간보다 빈도. 하루 10분 매일 > 주말에 1시간
- 잠자리 루틴에 고정하면 유지가 쉽습니다

## 연령별

| 나이     | 책                    | 방식                        |
|--------|----------------------|---------------------------|
| 0~6개월  | 형겉책, 흑백 대비, 보드북      | 소리와 리듬 중심. 씹어도 됨          |
| 6~12개월 | 플랩북, 촉감책, <b>사진책</b> | "○○ 어디 있지?" 가리키기 유도       |
| 1~2세   | 반복 구조의 그림책           | 빈칸 채우기, <b>같은 책 반복</b>    |
| 2~3세   | 이야기가 있는 그림책          | <b>대화식 읽기</b> (아래)        |
| 3~5세   | 긴 그림책, 짧은 챕터북        | 추론 질문, 이야기 구조, 아이가 이야기 짓기 |

### 대화식 책읽기 (Dialogic Reading) ★ **강함**

휘트허스트(Whitehurst)의 방법으로, 여러 무작위 연구에서 표현 언어 향상이 확인되었습니다. **핵심은 부모가 읽어주는 사람이 아니라 듣는 사람이 되는 것입니다.**

#### PEER — 한 페이지에서 하는 것

1. Prompt 질문한다 — "이게 뭐지?"
2. Evaluate 인정한다 — "맞아!"
3. Expand 확장한다 — "그래, 큰 갈색 곰이네."
4. Repeat 다시 말해보게 한다 — "큰 곰이라고 해볼까?"

#### CROWD — 다섯 가지 질문 유형

- Completion 빈칸 채우기: "달님이 ○○을 했어요"
- Recall 회상: "아까 곰이 어디 갔었지?"
- Open-ended 열린 질문: "이 그림에서 무슨 일이 일어나고 있어?"
- Wh- 질문: 누가 / 뭐 / 어디 / 왜
- Distancing 연결: "우리도 지난번에 동물원 갔었지?"

#### 효과를 키우는 다섯 가지

1. 아이가 고르게 합니다. 같은 책을 반복해도 좋습니다 — **반복이 어휘 학습에 유리합니다**
2. 읽는 중에 멈추고 질문합니다. 완독이 목표가 아닙니다
3. 손가락으로 짚으며 읽으면 글자 인식이 자연스럽게 생깁니다
4. 표지가 보이는 낮은 책장에 두면 아이가 스스로 꺼냅니다 (8장 여는 환경)
5. 부모가 책 읽는 모습을 보여줍니다

 **결론만 말하면 — 전자책은?** 종이책이 상호작용 면에서 우세하다는 연구가 다수입니다. 특히 **소리·애니메이션이 많은 전자책은 이야기 이해를 오히려 방해할 수 있습니다.** **보통** 오디오북은 3세 이후 보조 수단으로 유용하지만, 부모가 읽어주는 것을 대체하지 못합니다.

## 실행기능 — 만 3~5세 최우선 투자

실행기능(작업기억 · 억제 조절 · 인지 유연성)은 이후 학업 성취를 IQ만큼, 때로는 더 잘 예측합니다. **보통**

| 능력    | 놀이 (교구 불필요)                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 억제 조절 | 무궁화꽃이 피었습니다 · 얼음땀 · 사이먼 가라사대 · <b>반대로 말하기</b> (내가 "크다" 하면 너는 "작다") · 조용히 걷기 시험 |
| 작업기억  | 카드 짝 맞추기 · <b>3단계 심부름</b> ("책 가져와서 소파에 놓아줘") · "시장에 가면~"                       |

| 능력     | 놀이 (교구 불필요)                             |
|--------|-----------------------------------------|
| 인지 유연성 | 규칙 바뀌가며 분류하기 (색 → 모양) · 같은 물건의 다른 용도 찾기 |
| 계획·조직  | 요리하기(순서대로) · 설명서 보고 만들기 · 하루 계획을 그림으로   |

특히 효과적인 것: **역할극**. 아이가 스스로 정한 역할을 유지하는 것 자체가 강력한 자기조절 훈련입니다. "선장은 그렇게 안 해"라고 스스로를 규제하는 것 — 이것이 억제 조절입니다. **보통**

## 수학적 사고 — 학습지 없이

취학 전 수 개념은 이후 수학 성취를 잘 예측하지만, 필요한 것은 학습지가 아니라 **일상의 수학 언어**입니다.

### 핵심 순서

1. 수 세기 — 숫자 순서 외우기
2. 기수성(cardinality) — 마지막에 센 숫자가 **전체 개수**라는 이해. ← **진짜 관문입니다**. "몇 개야?" 물었을 때 다시 세지 않고 답할 수 있는가
3. 수량 비교 — 더 많다/적다
4. 간단한 더하기·빼기 (사물로)
5. 공간·도형·패턴

### 일상에서

- 계단 세기, 간식 나누기 ("셋씩 나눠줄까?")
- 비교 언어: "네 컵이 더 크네", "이게 반이야"
- 공간 언어: 위/아래/사이/뒤/앞 — 공간 어휘 사용량이 이후 공간 능력과 수학 성취를 예측한다는 연구가 있습니다 **보통**
- 패턴: 빨강-파랑-빨강-파랑 다음은?
- 요리: 계량, 순서, 분수
- 선형 보드게임 — 숫자가 적힌 칸을 주사위로 이동하는 게임은 수 감각 향상 효과가 무작위 연구로 확인되었습니다 **강함**

## 문해력 준비 — 무엇을, 어떤 순서로

초등학교 읽기 능력을 예측하는 요소는 잘 정리되어 있습니다. **순서가 중요합니다**.

1. 구어 능력과 어휘 ← 가장 중요
2. 음운 인식
3. 글자-소리 대응
4. 읽기 유창성 (초등 이후)

### 음운 인식 놀이 (한국어)

- 음절 나누기: "사·과" 손뼉 치며 — 한국어는 음절 단위가 자연스러워 여기서 시작
- 첫소리 찾기: "'ㄱ' 소리로 시작하는 말은?"
- 끝말잇기, 라임이 있는 동요

### 자모 노출 (강요 없이)

- 아이 이름의 글자부터. 가장 동기가 높습니다
- 냉장고 자석 글자, 간판 읽기
- 쓰기 강요는 **하지 않습니다**. 소근육이 준비되지 않은 상태의 연필 쥐기는 잘못된 습관을 만듭니다. 대신 점토, 가위질, 구슬 꿰기로 손 힘을 기릅니다

 결론만 말하면 — 한글 조기교육 만 5세 이전 문자 교육의 장기적 학업 이점은 확인되지 않았습니다. 학습 중심 프로그램이 단기적으로 글자·숫자 성과를 높여도, 장기적으로는 놀이 중심과 차이가 없거나 오히려 사회정서 면에서 불리하다는 연구들이 있습니다. **보통** 아이가 스스로 관심을 보이면 그때 따라가면 됩니다. 먼저 밀지 마세요.

## 이중언어 환경이라면

- 이중언어는 언어 지연의 원인이 아닙니다. **강함**
- 초기에는 각 언어 어휘가 단일언어 아이보다 적을 수 있으나, 두 언어를 합치면 비슷하거나 더 많습니다
- 언어 섞임(code-switching)은 정상이며 혼란의 증거가 아닙니다
- 효과적인 방식: 한 사람-한 언어 또는 한 장소-한 언어로 일관성 유지
- 무엇보다 각 언어에서 충분한 상호작용 양이 필요합니다. 영상으로는 배우지 못합니다

## 신체 활동 (WHO 권고)

| 나이   | 신체 활동                               | 좌식 제한                                  | 수면                                    |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0~1세 | 하루 여러 번 바닥 놀이, <b>배밀이 자세 30분 이상</b> | 유모차·의자에 <b>1시간 이상 연속 구속 금지</b> · 화면 금지 | 14~17시간(0~3개월)<br><br>12~16시간(4~11개월) |
| 1~2세 | <b>하루 180분 이상</b>                   | 1시간 이상 연속 구속 금지                        | 11~14시간                               |
| 3~4세 | <b>하루 180분 이상</b> (그중 60분은 중강도 이상)  | 화면 1시간 이하                              | 10~13시간                               |

**실외 활동을 따로 강조하는 이유:** 실외 활동 시간이 길수록 근시 발생이 낮다는 연구가 축적되어 있습니다. **[보통~강함]** 한국은 아동 근시 유병률이 매우 높습니다. **목표: 하루 최소 1~2시간 실외.**

## 하지 않아도 되는 것들

| 흔히 권유되는 것             | 실제 근거                    |
|-----------------------|--------------------------|
| 조기 영어 DVD/앱           | 2세 미만 화면 학습 효과 거의 없음     |
| 플래시카드 암기              | 단기 암기는 되나 이해·전이 효과 근거 없음 |
| 고가 두뇌개발 교구            | 일반 놀이 대비 우위 근거 없음        |
| 클래식 노출로 지능 향상         | "모차르트 효과"는 유아에서 재현되지 않음  |
| 만 5세 이전 한글·연산 선행      | 장기적 학업 이점 확인되지 않음        |
| 오메가3 등 두뇌영양제 (건강한 아동) | 결핍이 없는 한 인지 향상 근거 부족     |

**그 시간과 돈을:** 책, 실외 활동, 대화, 그리고 **부모의 여유**에 쓰세요.

## 오려 쓰는 한 장 ④ — 2부 도구함 전체

- ① 네 박자  
멈춤 · 되돌림 · 이름 · 기다림(5초)
- ② 감정 코칭  
감정은 모두 허용. 행동은 일부 제한.
- ③ 훈육  
예방 → 연결 → 제한 → 대안 → 회복  
체벌 없음. 잘할 때 알아봐 주기.
- ④ 환경 설계  
말로 막지 말고 환경으로 막는다.
- ⑤ 놀이와 말  
아이가 주도, 부모가 질문으로 확장.  
매일 책. 완독보다 질문.

 **지금 해보기** 오늘 책을 읽어줄 때 한 페이지에서 딱 한 번만 멈추고 질문해보세요. "이게 뭐야?" 그리고 기다리세요. 완독하지 않아도 됩니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 놀이는 학습의 대체물이 아니라 **이 나이의 학습 그 자체**다.
2. **아이가 주도하고 부모가 질문으로 확장**하는 안내된 놀이가 직접 교습보다 효과적이다.
3. 문해력 순서는 **어휘 → 음운 인식 → 글자**. 만 5세 이전 한글 선행의 장기 이점은 없다.

→ 다음: 3부 · 시기별 적용

## 3부 · 시기별 적용

---

여기부터는 사전입니다. **지금 월령의 장 하나만** 펴세요. 각 장은 「이번 달 딱 3가지」로 시작합니다. 잠이 부족한 날엔 그 세 줄이면 충분합니다. 각 장의 **행동**은 2부 도구함(네 박자·감정 코칭·훈육·환경 설계·놀이)을 그 시기에 맞게 쓴 것입니다.



## 10장 · 임신 후기 ~ 출생

### 준비

#### 🎯 이번 달 딱 3가지

1. 카시트를 사서 차에 직접 장착해본다 (퇴원 당일 필요)
2. 배우자와 야간 교대 원칙을 종이에 적어 합의한다
3. 검진·접종 일정을 달력 앱에 전부 등록한다

#### 장면

만삭의 배로 아기용품 매장에 서 있습니다. 직원이 "이건 다들 사세요"라고 말합니다. 카트에는 이미 물건이 열두 개 들어 있습니다. 그런데 집에 돌아오면 이상하게 준비가 된 것 같지 않습니다.

당연합니다. 부족한 건 물건이 아니기 때문입니다.

#### 💖 지금, 이런 마음이실 거예요

기대와 불안이 같이 오는 시기예요. 그리고 그 둘이 하루에도 몇 번씩 자리를 바꿉니다.

"내가 잘할 수 있을까." 아마 이 생각이 가장 자주 찾아올 거예요. 특히 밤에요.

미리 말씀드리고 싶은 게 있어요. **아무도 준비된 채로 부모가 되지 않습니다.** 책을 열 권 읽어도, 조카를 백 번 안아봤어도 마찬가지예요. 부모가 되는 건 배워서 되는 게 아니라 **하면서 되는 것**이거든요.

그리고 이 시기에 물건을 자꾸 사게 되는 건, 사실 불안을 다루는 방법이기도 합니다. 뭐라도 준비하면 마음이 놓이니까요. 그 마음은 아주 자연스러워요. 다만 이 장이 드리고 싶은 말은, **그 에너지를 물건이 아니라 사람과 시스템에 쓰시라는 것**입니다.

카시트 하나만 제대로 준비하고, 첫 4주를 누가 도와줄지 정하고, 배우자와 야간 교대를 합의해두면 — **나머지는 태어난 뒤에 사도 늦지 않아요.**

마지막으로, 출산이 계획대로 되지 않을 수도 있습니다. 자연분만을 원했는데 제왕절개가 될 수도 있고, 모유가 안 나올 수도 있어요. 그런 일이 생겨도 **당신이 실패한 게 아닙니다.** 미리 이 말을 적어둘게요. 그때 다시 이 페이지를 펴보셔도 좋겠습니다.

#### 한 장 요약

이 시기의 목표는 물건을 사는 것이 아니라 첫 6주를 버틸 시스템을 만드는 것입니다.

신생아 초기에 무너지는 가정은 대개 물건이 없어서가 아닙니다. **잠, 식사, 역할 분담이 정리되지 않아서**입니다. 그리고 그 세 가지는 아이가 태어난 뒤에는 정리할 여유가 없습니다.

#### 👉 행동 — 출산 전에 결정할 다섯 가지

##### ① 첫 4주를 누가, 어떻게 지원하는가 ★ 가장 중요

산모는 회복 중이고 신생아는 2~3시간마다 먹습니다. **두 사람만으로 4주를 버티는 계획은 대부분 실패합니다.**

선택지를 지금 확정하세요.

- 산후조리원 (기간·비용)

- 정부 산모·신생아 건강관리 지원사업 — 건강관리사 방문 바우처. **출산 예정일 40일 전부터 신청 가능**하므로 미리 알아두세요 (33장)
- 양가 부모님 도움 — 일정과 **경계**를 미리 합의
- 유료 산후도우미

## ② 소아청소년과 정하기

- 조건: 집에서 **15분 이내** / 예방접종 가능 / 대기 예약 시스템
- 야간·주말 대응 가능한 인근 병원도 하나 파악해두세요 (35장 달빛어린이병원)
- 출산 전 한 번 방문해 접수 방식을 확인해두면, 신생아를 안고 헤매지 않습니다

## ③ 카시트 — 퇴원 당일 필요

- 신생아부터 뒤보기(후방보기). 되도록 오래 유지 **강함**
- 대한민국 도로교통법상 만 6세 미만 카시트 착용 의무
- ★ 출산 전에 차에 직접 설치하고, 인형으로 벨트 조이기까지 연습하세요. 실제 장착 오류율이 매우 높습니다
- 중고 카시트는 사고 이력·유효기간을 알 수 없으므로 권장하지 않습니다

## ④ 아기 잠자리

8장 안전 수면 원칙 그대로입니다.

- 같은 방, 다른 잠자리 — 최소 6개월 **강함**
- 단단하고 **평평한** 매트리스, 딱 맞는 시트 1장만
- 침대 안에 베개·이불·범퍼·인형·수면쿠션 없음
- 경사진 수면기구 사용 금지

## ⑤ 수유 계획 — 유연하게

- 모유수유를 원한다면: 출산 직후 피부 접촉과 조기 수유가 성공률을 높입니다. 병원·조리원의 수유 지원 여부를 확인하세요
- 동시에 **분유를 대안으로 열어두세요**. 모유가 늦게 나오거나 안 나오는 것은 흔한 일입니다
- 유축기는 대여 가능 여부를 미리 확인

## 👉 행동 — 배우자와 반드시 합의할 것

물건보다 이 대화가 첫 3개월을 좌우합니다. **말로 하지 말고 종이에 적으세요**. (부록 F에 양식이 있습니다)

### ① 야간 교대 원칙 ★

가장 흔한 갈등 원인입니다.

| 방식         | 내용                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A안 (분할 수면) | 21시~2시는 A가, 2시~7시는 B가. 각자 <b>연속 4~5시간</b> 확보 — 조각난 8시간보다 연속 4시간이 회복에 낫습니다 |
| B안 (요일 교대) | 홀수일/짝수일로 야간 담당                                                            |

모유수유 중이라도 트림·기저귀·재우기는 비수유자가 맡으면 산모의 수면이 확보됩니다.

### ② "도와준다"는 표현 금지

육아는 한 사람의 일을 다른 사람이 돕는 구조가 아닙니다. **각자 담당 영역을 나눕니다** — 기억하고 계획하는 것(정신적 부하)까지 포함해서.

예: 예방접종 일정 관리·예약 = B 담당. "언제 맞아야 하지?"를 묻는 것이 아니라 **B가 기억하고 예약까지** 하는 것.

### ③ 방문객 규칙

- 첫 2주 방문 허용 여부, 시간 제한, 손 씻기 원칙
- **거절은 산모가 아니라 배우자가 대신 한다** — 미리 정해두면 산모가 죄책감을 덜 느낍니다
- 발열·기침 있는 사람은 방문 금지. 신생아 대면 시 손 위생 필수

### ④ 위험 신호 공유

산후우울증은 산모의 **10~15%**에서 발생하고, 배우자도 상당 비율에서 나타납니다. **25장의 EPDS 자가 문항을 미리 함께 읽어두고**, "이 상태가 2주 이상이면 병원 간다"를 약속해두세요.

### ⑤ 돈과 제도

지원 제도는 자주 바뀌므로 **복지로·정부24에서 최신 확인**이 필요합니다. 확인할 항목은 32장에 정리되어 있습니다.

## 🧠 생각

| 버릴 생각               | 붙잡을 생각                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| "준비물을 다 사야 안심이 된다"  | <b>부족한 건 물건이 아니라 시스템이다.</b> 대부분은 하루면 배송된다         |
| "우리 둘이서 어떻게든 될 것이다" | 첫 4주는 <b>외부 도움 없이는 대부분 실패한다.</b> 미리 부르는 게 이기는 것이다 |
| "모유수유는 꼭 성공해야 한다"   | 안 될 수도 있다. <b>부모의 상태가 수유 방식보다 중요하다</b>            |

## 📦 물건

### 반드시 (출산 전)

#### 안전 — 타협 없음

- ☐ 카시트 (뒤보기, 차에 미리 장착 연습)
- ☐ 아기 잠자리 + **단단하고 평평한 매트리스**
- ☐ 방수 패드 2장, 딱 맞는 시트 2~3장
- ☐ 수면조끼 (이불 대신)

#### 수유

- ☐ 젖병 2~3개 + 신생아용 젖꼭지 (완모 예정이어도)
- ☐ 젖병 세척솔, 소독 방법
- ☐ 분유 1통 (모유가 늦게 나오는 경우 대비)
- ☐ 수유패드, 유두 보호크림, 수유쿠션

#### 기저귀·목욕

- ☐ 신생아용 기저귀 **1팩만** (대량 구매 금지 — 금방 사이즈가 바뀝니다)
- ☐ 물티슈, 기저귀 갈이 매트
- ☐ 아기 욕조, 순한 세정제, 보습제
- ☐ 가제 수건 10장 이상
- ☐ 손톱가위, **코 흡입기**
- ☐ **체온계** — 비접촉식 + **직장/구강 겸용 1개** (3개월 미만은 직장 체온이 기준)

## 의류 (적게)

- ☐ 배냇저고리·바디수트 5~7벌, 우주복 2~3벌
- ☐ 속싸개 2~3장 (뒤집기 시작 시 중단)
- ☐ 손싸개, 모자, 양말
- ☐ 신생아 신발은 필요 없습니다

## 기타

- ☐ 아기 세제, 젖병 건조대, 기저귀 휴지통, 수유등
- ☐ 그림책 5권 (형겉책·보드북)

## 있으면 좋음

유모차(아이를 본 뒤 사도 됨) · 아기띠(M자 자세) · 백색소음기 · 바운서 · 유축기 · 기저귀 가방

## 사지 않을 것

보행기 · 아기침대 범퍼 · 수면 포지셔너 · 경사형 수면기구 · 만 1세 미만 베개 · 중고 카시트 · SIDS 예방 표방 웨어러블 모니터 · 신생아 신발 · 흑백 모빌 세트 · 물티슈 워머 · 전자 학습교구

## 출산가방 (실제로 쓰이는 것만)

**산모:** 신분증·산모수첩·보험서류 / 앞트임 잠옷 2벌, 수유브라, 산모패드 / 슬리퍼, 세면도구, 립밤, 머리끈 / 빨대 물병, 간식 / 긴 휴대폰 충전 케이블(병원 콘센트가 멀다)

**아기:** 퇴원복 1벌, 속싸개 2장, 손싸개 / 기저귀 소량 / 카시트(차에 장착)

**배우자:** 갈아입을 옷, 세면도구, 현금·카드, 목베개

## 17 출생 직후 행정 (자세히는 29장)

| 기한        | 할 일                 |
|-----------|---------------------|
| 생후 4주 이내  | BCG 접종              |
| 생후 14~35일 | 영유아 건강검진 1차         |
| 생후 1개월 이내 | 출생신고 + 행복출산 원스톱 서비스 |
| 생후 1개월    | B형간염 2차             |
| 가능한 빨리    | 아기 실손보험 검토, 통장 개설   |

신생아 선천성 대사이상 검사와 난청 선별검사는 출산 병원에서 시행됩니다. 결과를 반드시 확인하고, 재검 안내를 받으면 미루지 마세요.

## 미리 알아둘 것 — 여아

태어난 뒤 놀라지 않도록 미리 적어둡니다.

- 신생아 여아에게 생후 며칠 내 소량의 질 분비물이나 약간의 출혈이 보일 수 있습니다. 엄마의 호르몬이 태반을 통해 전달됐다가 끊기면서 나타나는 정상 현상이며, 대개 며칠 안에 사라집니다.
- 유방이 약간 부풀어 보이는 것도 같은 이유이며 정상입니다. **짜지 마세요.**
- 기저귀를 갈 때는 처음부터 **앞에서 뒤로** 닦는 습관을 들이세요. 요로감염 예방의 기본입니다.

## | ? 자주 묻는 것

Q. 아기 옷은 몇 벌이나 필요한가요? 생각보다 적게. 배냇저고리 5~7벌이면 시작할 수 있고, 선물로 많이 들어옵니다. 부족하면 그때 사세요.

Q. 산후조리원은 꼭 가야 하나요? 필수가 아닙니다. 핵심은 산모가 회복할 시간과 도움을 확보하는 것이고, 조리원은 그 방법 중 하나일 뿐입니다. 집에서 도우미를 쓰는 것도 같은 목적을 달성합니다.

Q. 유모차와 아기띠 중 뭘 먼저 사야 하나요? 둘 다 급하지 않습니다. 아이를 본 뒤에 생활 환경(엘리베이터, 대중교통, 차 트렁크)에 맞춰 고르는 게 낫습니다. 퇴원 당일 필요한 것은 카시트뿐입니다.

Q. 태교로 뭘 해야 할까요? 근거가 확인된 것은 산모의 스트레스와 수면 관리입니다. 특정 음악이나 교재의 효과는 근거가 없습니다. 잘 자고, 잘 먹고, 스트레스를 줄이는 것이 태교입니다.

## | ⚠ 이 시기 병원에 가야 할 때 (산모)

- 태동이 평소보다 뚜렷하게 줄었을 때
- 질 출혈, 양수가 새는 느낌
- 심한 두통, 시야 흐림, 상복부 통증, 갑작스러운 부종 → 전자간증 의심
- 38℃ 이상의 발열
- 규칙적인 진통

## | ✓ 출산 전 체크리스트

- ☐ 카시트 구입 + 차에 장착 연습 완료
- ☐ 아기 잠자리 세팅 (평평, 침구 없음)
- ☐ 소아청소년과 결정
- ☐ 야간·휴일 진료 가능한 병원 파악
- ☐ 첫 4주 지원 인력 확정
- ☐ 산모·신생아 건강관리 지원사업 확인 (예정일 40일 전부터)
- ☐ 배우자와 야간 교대 원칙 합의 (부록 F)
- ☐ 방문객 규칙 합의
- ☐ EPDS 문항 함께 읽어두기
- ☐ 달력에 등록: BCG(4주 이내), 건강검진 1차(14~35일)
- ☐ 출산가방 완성
- ☐ 그림책 5권
- ☐ 냉장고에 응급 연락처 붙이기 (부록 E)
- ☐ 신생아 옷 미리 세탁
- ☐ 냉동식 만들어두기

## | 🖐 이번 주 한 가지

카시트를 사서 차에 직접 장착해보세요. 설명서를 펴고 30분이면 됩니다.

이번 주에 딱 이것만 해도 됩니다. 나머지는 나중에 해도 늦지 않아요. 퇴원 당일 반드시 있어야 하는 물건은 이것 하나뿐입니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 준비는 물건이 아니라 첫 6주를 버틸 시스템이다.
2. 첫 4주 지원 인력과 야간 교대 원칙 두 가지가 나머지 전부보다 중요하다.
3. 퇴원 당일 반드시 필요한 물건은 카시트 하나다.

→ 다음: 11장 · 0~3개월

# 11장 · 0~3개월

## 생존과 애착

### 🎯 이번 달 딱 3가지

1. 울면 반응해요 (이 시기엔 '버릇' 개념이 없어요)
2. 배밀이 자세 하루 누적 30분
3. 부모가 자요 ← 셋 중 가장 어렵고, 가장 중요해요

### 장면

새벽 3시 40분입니다.

아기를 겨우 재우고 침대에 누웠는데, 20분 만에 다시 울음소리가 들려요. 당신은 천장을 뽐니다. 이번 주에 연속으로 세 시간 이상 자본 적이 없어요.

그리고 문득 이런 생각이 듭니다.

**'나는 지금 아이를 위해 아무것도 안 해주고 있는 것 같다.'**

#### 💛 지금, 많이 힘드시죠

먼저 이 말씀부터 드리고 싶어요.

**이 시기가 힘든 건 당신이 못해서가 아닙니다. 원래 힘든 시기예요.**

생각해보면 당연해요. 회복이 필요한 몸으로, 두세 시간마다 깨서, 말도 못 하는 사람의 요구를 추측해서 맞춰야 하잖아요. 그것도 24시간, 쉬는 날 없어요. 이건 어떤 기준으로 봐도 가혹한 조건입니다.

그런데 이 시기 부모들은 대부분 **자기가 부족해서 힘든 거라고 생각해요**. 다른 집 아기는 잘 자는 것 같고, 다른 엄마 아빠는 여유로워 보이니까요. (그분들도 사실 새벽에 천장 보고 계실 거예요.)

그리고 아까 그 생각 — "아무것도 안 해주고 있는 것 같다" — 이것도 아주 흔한 생각이예요. 그런데 사실은 정반대입니다.

**당신은 지금 가장 중요한 일을 하고 있어요.**

아이가 울고, 누군가 온다. 배가 고프고, 누군가 먹여준다. 불편하고, 누군가 알아준다. 이 반복이 아이 뇌에 **"세상은 안전한 곳"**이라는 첫 번째 믿음을 새기는 중입니다. 교구도, 학습도, 특별한 활동도 아니예요. 그냥 반응하는 것이 이 시기의 전부입니다.

**먹이고, 재우고, 반응해주면 이 시기는 성공이에요.** 그 이상을 요구하는 목소리가 있다면, 잠시 꺼두셔도 됩니다.

### 한 장 요약

이 시기의 목표는 **교육이 아니라 안정화**예요.

아기는 자궁 밖 환경에 적응하는 중이고, 부모는 수면 부족과 싸웁니다. "무언가를 더 해줘야 한다"는 압박을 내려놓는 것이 이 시기의 정답이에요.

1부에서 본 순환으로 보면, 이 시기 아이는 아직 나가지 않습니다. **오직 돌아올 자리만 필요해요.** 그리고 그 자리는, 당신이 거기 있는 것만으로 이미 만들어지고 있습니다.



## 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

### 생후 2개월

| 영역    | 이정표                                            |
|-------|------------------------------------------------|
| 사회·정서 | 사람을 보면 미소 짓는다(사회적 미소) · 사람 얼굴을 쳐다본다 · 달래면 진정된다 |
| 언어    | "아~", "우~" 같은 소리를 낸다 · 큰 소리에 반응한다              |
| 인지    | 움직이는 것을 눈으로 따라간다 · 몇 초간 얼굴을 응시한다               |
| 운동    | 엎드렸을 때 머리를 잠깐 든다 · 팔다리를 움직인다 · 손을 입으로 가져간다     |

이 값은 "평균"이 아니라 **75% 기준**이에요. 아직 못 한다고 해서 바로 문제인 건 아니고, **한번 여쭙볼 만한 신호**로 만들어진 값입니다. 목록을 보고 조금해지지 마세요.

## 👉 행동

### ① 반응하기 — 이 시기 교육의 전부

- 울면 확인하고 반응해주세요. 0~6개월에 "버릇 들이기"는 개념 자체가 성립하지 않아요.
- 이 시기 울음은 조종이 아니라 **아이가 가진 유일한 말**입니다.
- 혹시 "그러다 손 탄다"는 말을 들으셨다면, 안심하셔도 돼요. 근거가 없는 이야기입니다.

### ② 네 박자 — 이 시기 버전

5장의 도구를 여기서는 이렇게 씁니다.

- ① 멈춤 아기가 소리를 내면 하던 걸 멈춰요
- ② 되돌림 똑같이 "아~" 하고 소리를 내요
- ③ 이름 "기분 좋구나" / "배고팠구나"
- ④ 기다림 3~5초 조용히 기다려요 ← 아기가 이 침묵을 채웁니다

하루 스무 번이면 충분해요. 그리고 따로 시간을 내실 필요가 전혀 없습니다. 기저귀 갈 때(하루 8회), 먹일 때(하루 5~8회), 목욕할 때 하시면 이미 스무 번이 넘어요.

지쳐서 못 하는 날도 있을 거예요. 그런 날은 안 하셔도 됩니다. 이건 매일 채워야 하는 숙제가 아니에요.

### ③ 배밀이 자세(터미 타임)

아기가 깨어 있고, 지켜볼 수 있을 때만 해요.

| 시기      | 하루 누적                       |
|---------|-----------------------------|
| 출생 직후~  | 하루 2~3회, 회당 3~5분부터          |
| 7주 무렵~  | 15~30분                      |
| 3개월 무렵~ | 30분~1시간 (WHO는 하루 30분 이상 권고) |

아기가 싫어해도 정상이에요. 대부분 처음엔 울어요. 이런 방법이 도움이 됩니다.

- 부모 가슴 위에 엎드리게 하기 ← 이게 제일 잘 통해요
- 무릎 위에 가로로 눕히기
- 눈높이에 부모 얼굴을 두고 말 걸기



- 수유 직후는 피하고, 짧게 여러 번

**왜 하나요:** 목·어깨·몸통 근육이 자라고, 뒤집기와 기기를 준비하고, **사두증(머리 한쪽이 납작해지는 것)**을 예방합니다. 등을 대고 재우는 건 안전을 위해 꼭 필요하니, 깨어 있을 때 엎드리는 시간으로 균형을 맞추는 거예요.

#### ④ 감각 자극 — 돈 들 일이 없어요

- 거리 20~30cm에서 **얼굴 보여주기**. 신생아의 초점 거리가 정확히 안았을 때 부모 얼굴 거리예요. 우연이 아닙니다. **최고의 교구는 당신 얼굴이에요.**
- 흑백 대비 이미지 — 신생아 시력은 낮고 고대비를 잘 봅니다. 3개월 무렵부터 색 구분이 좋아져요
- 같은 자장가를 반복해서 — **예측 가능한 것이 아기에겐 안정감**입니다
- 안고 집안을 돌며 사물 이름 말해주기

#### ⑤ 매일 책 (하루 5~10분)

- 형견책·보드북·흑백 그림책이면 돼요
- **내용을 다 읽으실 필요 없어요.** 그림 하나 짚고 "곰이네, 곰" 하시면 그걸로 충분합니다
- 읽는 시간을 일과에 고정해두시면(예: 목욕 후) 습관이 쉽게 잡혀요

#### ⑥ 일과의 리듬 (시간표가 아니에요)

신생아에게 시간표를 강요하지 마세요. 대신 **순서**만 반복하면 됩니다.

먹기 → 깨어 놀기 → 재우기

- **낮에는** 밝게, 소리도 평소처럼
- **밤에는** 어둡고 조용하게, 최소한의 상호작용

이 대비가 **생후 6~12주경** 생기는 **밤낮 리듬**을 만드는 데 도움이 됩니다. 그전까지 아기가 밤낮이 바뀐 것처럼 보여도, 고장난 게 아니에요. 아직 리듬이 안 생겼을 뿐입니다.

### 🥹 울음 다루기

#### 울음에는 정상적인 곡선이 있어요

울음은 **생후 6주경 최고조**에 이르고 3~4개월경 줄어듭니다.

이게 왜 중요하냐면 — 많은 부모가 생후 6주쯤 "내가 뭘 잘못하고 있나" 하고 무너지시거든요. 그런데 그건 당신이 잘못해서가 아니라, **원래 그때가 제일 많이 우는 시기**예요. 아이가 잘못된 것도 아니고요.

#### 5S — 진정시키는 순서

1. Swaddle 속싸개로 감싸기 — 뒤집기 조짐이 보이면 **즉시 중단**. 다리 쪽은 헐렁하게(고관절)
2. Side/Stomach 옆으로 안기 — **안고 있을 때만**. 재울 땐 반드시 등으로
3. Shush "쉬~" 소리 또는 백색소음 — 볼륨은 낮게, 아기 귀에서 떨어뜨려서
4. Swing 작고 빠르게 흔들기 — **절대 세게 흔들지 마세요**
5. Suck 빨기 — 쪽쪽이, 손가락

다 해봐도 안 그치는 날이 있어요. 그것도 정상입니다.

#### 🚩 이것만은 꼭 — 흔들지 마세요

**아기를 흔들면 안 됩니다.** 흔들린 아기 증후군은 영구적인 뇌손상이나 사망으로 이어집니다.

그리고 이 말을 덧붙이고 싶어요. **아기 울음소리에 화가 나는 건 이상한 게 아니에요.** 그건 당신이 나쁜 부모라는 뜻이 아니라, 잠을 못 잔 사람의 신경계가 보내는 정상적인 반응입니다.

중요한 건 그 순간에 무엇을 하느냐예요.

1. 아기를 안전한 잠자리에 눕혀요
2. 방을 나와요
3. 10분 진정해요 - 물 마시기, 심호흡, 세수
4. 돌아가요

**잠깐 우는 건 안전해요. 혼드는 건 안전하지 않아요.** 방을 나오는 건 방임이 아니라, 두 사람 모두를 지키는 행동입니다.

## 수면

### 필요량

- 0~3개월: 하루 **14~17시간** (낮잠 포함, 개인차가 커요)

### 이 시기의 현실

- 밤에 **2~4시간 간격으로 깨는 게 정상**이에요. 위가 작고 모유는 빨리 소화되거든요
- "통잠"은 보통 생후 3~6개월 이후에 조금씩 나타나고, **개인차가 정말 큼**
- **수면 교육은 이 시기에 하지 않아요.** 대부분의 방법이 생후 4~6개월 이후를 대상으로 합니다

혹시 주변에서 "우리 애는 100일에 통잠 잤어"라는 말을 들으셨다면 — 그런 아기도 있고, 돌까지 밤에 서너 번 깨는 아기도 있어요. **둘 다 정상 범위입니다.** 비교는 도움이 안 됩니다.

### 안전 수면 — 여기만은 단호하게

이 부분만큼은 부드럽게 말씀드리지 않을게요. 아이의 생명과 직결되기 때문입니다.

8장의 원칙 그대로입니다. **혼자(같은 방, 다른 잠자리) · 등을 대고 · 단단하고 평평한 곳에서.** 잠자리 안에는 아무것도 두지 않습니다.

## 수유 (자세히는 17장)

- **신호 수유** — 울기 전 신호에 반응해요. 입 오물거리기, 손 빨기, 고개 돌려 찾기. **우는 건 이미 늦은 신호예요**
- 신생아는 하루 **8~12회 이상** 먹어요
- **충분히 먹고 있다는 신호:** 생후 5일 이후 하루 젖은 기저귀 6장 이상 / 약 2주 내 출생 체중 회복 / 이후 꾸준한 증가
- **비타민 D:** 완전 모유수유아는 생후 며칠 이내부터 **하루 400 IU** 보충이 권고됩니다. 의사와 확인하세요
- **꿀은 만 1세 전까지 절대 안 됩니다** (영아 보툴리누스증)

모유가 잘 안 나오시나요? 그것도 아주 흔한 일이고, 대부분 지나갑니다. 그리고 지나가지 않아도 괜찮아요. 자세한 이야기는 17장에 있습니다.

## 생각

| 내려놓아도 되는 생각             | 붙잡으면 좋은 생각                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| "많이 안아주면 손 탄다"          | 근거 없어요. 이 시기 즉각적인 반응은 오히려 이후 독립성과 정서 안정을 높입니다 |
| "뭔가 더 해줘야 하는데 못 해주고 있다" | 먹이고 재우고 반응하면 이 시기는 성공이에요. 교구도 학습도 필요 없습니다     |
|                         |                                               |

| 내려놓아도 되는 생각           | 붙잡으면 좋은 생각                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| "내가 잘못해서 아기가 우는 것 같다" | 울음은 <b>6주경 최고조에 이르는 정상 곡선</b> 이에요. 당신 탓이 아닙니다 |
| "다른 집 아기는 잘 자던데"      | 통잠 시기는 개인차가 아주 커요. <b>비교는 도움이 안 됩니다</b>       |

## 📦 물건

### 이미 있는 것으로 충분해요

10장에서 준비하신 것 외에 새로 사실 게 거의 없습니다. **최고의 교구**는 20~30cm 거리의 부모 얼굴이니깐요.

### 이 시기에 실제로 쓸모 있는 것

- 코 흡입기 (감기 때 정말 필요해요)
- 수유등 (밝지 않은 조명)
- 백색소음기 — **낮은 볼륨, 아기와 거리를 두고**
- 수면조끼 (계절에 맞는 TOG)

### 지금은 안 사셔도 되는 것

장난감 대부분 · 흑백 모빌 세트 · 신생아 신발 · 대형 놀이매트 · 값비싼 교구 · 이유식 도구

### 🔔 구매 트리거

| 이 모습이 보이면 | 그때 사요                      |
|-----------|----------------------------|
| 뒤집기 조짐    | 속싸개 중단 → 수면조끼 / 가구 벽 고정 시작 |

## 🕒 하루 일과 예시 (생후 2개월)

시간표가 아니라 **순서**예요. 시계보다 아기 신호를 따르시면 됩니다. **이대로 안 되어도 전혀 문제없어요.**

07:00 수유 → 기저귀 → 잠깐 놀기(네 박자) → 낮잠  
09:30 수유 → 배밀이 자세 5분 → 낮잠  
12:00 수유 → 산책(유모차/아기띠) → 낮잠  
14:30 수유 → 배밀이 자세 5분 → 낮잠  
17:00 수유 → 안고 집안 돌며 말 걸기 → 짧은 낮잠  
19:00 목욕 → 로션 → 책 1권 → 수유 → 밤잠  
(이후 2~4시간 간격 야간 수유)

**깨어 있는 시간(wake window):** 0~2개월은 보통 **45~90분**이면 다시 졸려 해요. 그보다 오래 깨어 있으면 과피로해져서 오히려 못 잡니다. "많이 놀려야 잘 잔다"는 이 시기엔 역효과예요.

## 👩 여아 건강·위생

- 기저귀를 갈 때는 앞에서 뒤로 닦아주세요. 반대 방향은 대장균을 요도 쪽으로 옮깁니다
- 물티슈를 너무 자주 쓰지 않으셔도 돼요. 대변이 아닐 땐 미지근한 물에 적신 가제 수건이 자극이 적습니다
- 외음부 안쪽은 씻지 않아요. 겉면만 부드럽게, 비누는 최소한으로
- 생후 며칠 내 소량의 질 분비물이나 약간의 출혈이 보일 수 있어요. 놀라지 마세요. 엄마 호르몬 때문에 생기는 **정상 현상**이고 며칠 안에 사라집니다. 유방이 살짝 부풀어 보이는 것도 같은 이유예요. **짜지 마세요**
- 기저귀를 자주 갈고, 가끔은 벗겨서 통풍시켜 주세요

## ? 자주 묻는 것

Q. 밤에 몇 시간 자면 깨워서 먹여야 하나요? 출생 체중을 회복하기 전(대개 첫 2~3주)에는 4~5시간 이상 자면 깨워서 먹입니다. 체중이 잘 늘기 시작하면 스스로 깰 때까지 두셔도 돼요. 담당 의사와 확인하세요.

Q. 쪽쪽이를 물려도 되나요? 됩니다. 모유수유가 자리 잡은 뒤(대략 3~4주) **낮잠·밤잠 시 사용은 오히려 영아 돌연사 위험을 낮추는 것으로 보고되고** 있어요. 잠든 뒤 빠지면 다시 물리지 않으셔도 됩니다.

Q. 트림을 못 시키면 어떡하죠? 5~10분 시도해도 안 나오면 그냥 눕히셔도 괜찮아요. 모든 수유 후에 반드시 트림이 나오는 건 아닙니다.

Q. 배꼽은 언제 떨어지나요? 보통 1~3주예요. 마른 상태를 유지해주시고, **진물·붉은기·악취·발열**이 있으면 병원에 가세요.

Q. 산후조리원에서 나오니 갑자기 무섭습니다. 정말 흔한 감정이에요. 도와주는 사람이 사라지고 온전히 둘이 남는 순간이니까요. 이럴 때 도움이 되는 건 완벽한 계획이 아니라 **다음 한 시간만 생각하는 것**입니다. 그리고 5부를 한 번 읽어보세요.

## 경고 신호

여기서는 단호하게 씁니다. 하나라도 해당하면 망설이지 마세요.

### 즉시 응급실

| 상황                                | 이유                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 생후 3개월 미만 + 38.0℃ 이상(직장 체온)       | 신생아 중증 감염 가능성. <b>해열제 먹이고 지켜보지 마세요</b> |
| 호흡 곤란 — 갈비뼈 사이 함몰, 코 벌렁임, 신음, 청색증 | 호흡부전                                   |
| 촉 늘어지고 깨워도 반응이 약함                 | 중증 감염·대사 이상                            |
| 경련                                | 즉시                                     |
| 12시간 이상 소변 없음 / 수유 거부 지속          | 탈수                                     |
| 황달이 심해지거나 팔다리까지 노랗게               | 고빌리루빈혈증                                |
| 생후 2주 이후에도 지속되는 황달 + 회백색 대변       | 담도폐쇄증 감별 필요                            |
| 달래지지 않는 고음의 비명 같은 울음              | 확인 필요                                  |

**애매하면 가는 쪽을 고르세요.** 가서 아무 일 아니면 그게 제일 좋은 결과입니다. "괜히 왔나" 싶어도 괜찮아요. 그러라고 있는 곳입니다.

### 발달 경고 신호 (2개월)

- 큰 소리에 반응이 없다
- 움직이는 물체를 눈으로 따라가지 않는다
- 사람을 보고 미소 짓지 않는다
- 손을 입으로 가져가지 않는다
- 엎드렸을 때 머리를 전혀 들지 못한다

## ✓ 3개월 무렵 체크리스트

- ☐ 사람을 보고 미소 짓는다
- ☐ 소리 내어 반응한다 ("아~", "우~")

- ☐ 엎드렸을 때 머리를 들고 잠시 버틴다
- ☐ 눈으로 물체를 따라간다
- ☐ 큰 소리에 반응한다
- ☐ 하루 누적 30분 정도 배밀이 자세를 한다
- ☐ 잠자리에 아무것도 없이 등을 대고 잔다
- ☐ BCG(4주 이내) 완료
- ☐ 영유아 건강검진 1차(14~35일) 완료
- ☐ B형간염 2차(1개월) 완료
- ☐ 2개월 접종 세트 완료
- ☐ 부모 점검: 2주 이상 우울·불안·무기력이 지속되지 않는가 (25장)

마지막 항목, 그냥 넘기지 마세요. **아이 체크리스트만큼 중요합니다.**

### ♥ 이 장을 닫으며

이 시기가 끝나갈 무렵이면, 아기가 당신을 보고 웃기 시작할 거예요.

그 미소가 오면 많은 게 달라집니다. 지금까지는 일방적으로 주기만 하는 것 같았는데, 처음으로 **돌아오는 것**이 생기거든요. 많은 부모가 그때 "아, 이제 좀 살 것 같다"고 하십니다.

거기까지 몇 주 남았어요. 그때까지는 그냥 버티셔도 됩니다. **버티는 것도 육아예요.**

### 👉 이번 주 한 가지

**아기가 소리를 내면 똑같이 따라 하고, 5초 기다려보세요.** 하루에 딱 한 번만요.

시계로 재보시면 5초가 생각보다 깁니다. 그리고 그 침묵을 아기가 채우는 순간을 한 번 보시면, 이 책의 나머지가 필요 없어질지도 몰라요.

이번 주에 이것 말고는 아무것도 안 하셔도 됩니다. **자는 것이 우선입니다.**

### 📌 이 장의 요약 3줄

1. 이 시기는 교육이 아니라 **안정화**예요. 먹이고 재우고 반응하면 성공입니다.
2. "손 탄다"는 근거가 없어요. **0~6개월에 버릇 들이기는 존재하지 않습니다.**
3. 울음은 6주경 최고조에 이르는 **정상 곡선**이에요. 한계에 다다르면 아기를 눕히고 방을 나오세요. 그건 잘못이 아닙니다.

→ 다음: 12장 · 4~6개월

## 12장 · 4~6개월

### 감각의 확장, 이유식의 시작

#### 이번 달 딱 3가지

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. 웅얼이 왕복 하루 20회 | (아이가 "바바" 하면 따라 하고 5초 기다린다) |
| 2. 이유식은 철분부터     | (쌀미음보다 철분이 우선이다)            |
| 3. 첫니가 나면 즉시 칫솔  | (쌀알 크기 불소치약)                |

#### 장면

아기가 처음으로 소리 내어 웃었습니다. 당신이 얼굴을 가렸다 나타났더니 까르르 웃습니다. 한 번 더 하니 또 웃습니다. 열 번을 했는데 열 번 다 웃습니다.

그리고 당신은 이 아기가 지금 인지 실험을 하고 있다는 걸 모릅니다.

#### 이 시기, 이런 마음이 드실 거예요

이제 좀 살 만해졌다 싶은데, 새로운 걱정이 시작되는 시기예요.

**"이유식을 잘못 시작하면 어쩌지."** 아마 이게 제일 클 겁니다. 검색하면 순서표가 쏟아지고, 무엇을 며칠에 어떻게 줘야 한다는 규칙이 끝없이 나오죠. 그러다 아이가 뱀기라도 하면 내가 뭘 잘못했나 싶어집니다.

미리 말씀드릴게요. **이유식은 영양이 아니라 연습이에요.** 첫돌까지 아이의 주 영양원은 여전히 모유나 분유입니다. 그러니까 이유식은 좀 실패해도 됩니다. 오늘 한 숟갈도 못 먹었다고 아이가 잘못되지 않아요.

그리고 이 무렵 많은 분들이 **4개월 수면 퇴행**을 만납니다. 겨우 잘 자기 시작했는데 갑자기 밤에 서너 번씩 깨는 거죠. "내가 뭘 잘못 건드렸나" 싶으실 텐데, 아닙니다. **아이 뇌가 성숙하면서 수면 구조가 바뀌는 정상 과정**이에요. 고장이 아니라 발달입니다.

한 가지 좋은 소식도 있어요. 이 시기부터 아이가 **소리 내어 웃기 시작합니다.** 지금까지 일방적으로 주기만 하는 것 같았다면, 이제 확실히 돌아오는 게 생겨요.

#### 한 장 요약

손이 자유로워지고, 입이 새로운 일을 시작합니다.

아기가 사람처럼 반응하기 시작하는 시기입니다. 웃고, 소리 내고, 손을 뻗습니다. 부모 입장에서는 처음으로 "재미있어지는" 구간이며, 동시에 **이유식이라는 큰 이벤트**가 시작됩니다.

1부의 순환으로 보면, 아이가 **처음으로 조금씩 나가기 시작**하는 시기입니다. 손을 뻗는 것이 첫 번째 외출입니다.

#### 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

##### 생후 4개월

| 영역    | 이정표                                              |
|-------|--------------------------------------------------|
| 사회·정서 | 관심을 끌려고 <b>소리 내어 웃는다</b> · 사람을 보고 저절로 미소 짓는다     |
| 언어    | <b>웅얼이를 한다</b> · 자기 소리를 즐긴다 · 배고픔과 기쁨을 다른 소리로 표현 |

| 영역 | 이정표                                                 |
|----|-----------------------------------------------------|
| 인지 | 먹을 것을 보면 입을 벌린다 · 자기 손을 쳐다본다                        |
| 운동 | 머리를 흔들림 없이 가누다 · 팔꿈치로 상체를 든다 · 장난감을 잡는다 · 모든 것을 입으로 |

## 생후 6개월

| 영역    | 이정표                                             |
|-------|-------------------------------------------------|
| 사회·정서 | 아는 사람을 알아본다 · 거울 속 자신을 보고 웃는다 · 웃으면 따라 웃는다      |
| 언어    | 자음이 섞인 웅얼이("바바", "다다") · 이름을 부르면 반응 · 소리로 감정 표현 |
| 인지    | 물건을 입에 넣어 탐색 · 손이 닿지 않는 장난감에 손을 뻗는다             |
| 운동    | 뒤집는다 · 받쳐주면 앉는다 · 한 손에서 다른 손으로 물건을 옮긴다          |

뒤집기를 시작하면 속싸개는 즉시 중단합니다. 엎드린 채 못 돌아오면 위험합니다.

## 👉 행동

### ① 네 박자 — 웅얼이 버전 ★ 이 시기의 핵심

6개월경 나타나는 자음 반복 웅얼이(babbling)는 언어 발달의 핵심 지표입니다.

- ① 멈춤    아기가 "바바바" 한다 → 하던 걸 멈춘다
- ② 되돌림    "바바바!" 똑같이 따라 한다
- ③ 이름    "바바? 아, 밥? 밥 먹을까?" (소리를 단어로 확장)
- ④ 기다림    5초 침묵    ← 아기가 다시 소리를 낸다

하루 목표: 왕복 20회. 기저귀 갈 때, 목욕할 때, 안고 있을 때.

### ② 까꿍놀이 시작

대상영속성(눈에 안 보여도 존재한다)의 준비 단계입니다. 아직 완성되지 않아서, 사라졌다 나타나는 것이 놀랍고 재미있습니다.

- 손으로 얼굴 가리기 → 나타나기
- 수건으로 장난감 살짝 덮기 → 아이가 치우도록 기다리기

아까 그 장면에서 아기가 열 번 다 웃은 이유가 이것입니다. 아기는 지금 "사라진 것이 다시 나타나는가"를 열 번 검증한 겁니다.

### ③ 손 쓰기 놀이 (소근육 + 인과관계)

- 잡기 쉬운 물건(딸랑이, 실리콘 링, 형겔책)을 손을 뻗어야 닿는 거리에 둡니다
- 인과관계 장난감: 누르면 소리 나는 것, 흔들면 소리 나는 것

→ "내가 하면 무슨 일이 일어난다"는 자기효능감의 시작입니다

- 서로 다른 질감(까슬까슬, 매끈, 폭신)

### ④ 배밀이 자세와 자세 다양화

- 하루 누적 1시간 이상을 목표로, 여러 번 나눠서

- 바닥 시간을 늘리고 기구 시간을 줄입니다. 바운서·스윙·범보의자에 오래 두면 스스로 자세를 조절하는 연습 기회가 줄어듭니다
- 보행기는 사용하지 않습니다 (AAP 권고) **강함**

#### ⑤ 매일 책 (하루 10분)

- 보드북, 촉감책, 플랩북
- 이 시기엔 책을 씹습니다. 정상입니다. 씹어도 되는 재질을 쓰세요
- 그림 하나를 짚고 이름을 말하고, **아이 반응을 기다립니다**. 글자를 다 읽지 않아도 됩니다

### 이유식 — 이 시기 최대 이벤트

자세히는 18장. 여기서는 시작 판단만.

#### 언제 시작하나 — 준비 신호가 기준

만 4개월 이전에는 시작하지 않습니다. 아래가 모두 충족될 때(대개 6개월 전후):

- ☐ 목을 잘 가누고, 받쳐주면 앉을 수 있다
- ☐ 혀 내밀기 반사가 사라졌다 — 손가락을 넣어도 혀로 밀어내지 않는다
- ☐ 음식에 관심을 보이고 입을 벌린다
- ☐ 체중이 출생 시의 약 2배

#### 시작 방법

1. 첫 음식은 철분이 풍부한 것 — 철분 강화 곡물, 소고기 퓨레

➢ 생후 6개월경 태아기에 저장된 철분이 고갈됩니다. 이것이 철분을 최우선으로 두는 이유입니다

1. 한 번에 한 가지, 3~5일 간격 — 알레르기 반응 식별
2. 하루 1회, 한두 손가락으로 시작
3. 모유·분유가 여전히 주 영양원입니다. 이유식은 연습입니다

#### 결론만 말하면 — 알레르기 유발 식품은 늦추지 않는다

과거에는 계란·땅콩을 늦게 시작하라고 했지만, LEAP 연구(2015, NEJM) 이후 권고가 뒤집혔습니다.

**이유식 시작 후 알레르기 유발 식품을 이른 시기에 도입하고 꾸준히 먹이면 알레르기 발생이 줄어듭니다. **강함****

단, 중증 아토피 피부염이 있거나 이미 알려진 식품 알레르기가 있는 영아는 도입 전 소아과 상담이 필요합니다. 땅콩은 통째로 주지 말고 뭉개 푼 땅콩버터나 가루로 주세요(질식).

#### 절대 금지

- 꿀 — 만 1세 전 (영아 보툴리누스증)
- 생우유를 주 음료로 — 만 1세 전
- 질식 위험 음식 (8장)
- 소금·설탕 추가

### 치아 관리 — 이 시기부터

- 보통 6~10개월경 첫 아랫니가 납니다. 편차가 큼니다(3~13개월)
- 첫 치아가 나오는 즉시 하루 2회 닦습니다



- 불소 치약을 쌀알 크기만큼. 만 3세 이후엔 완두콩 크기
- 젖병을 물고 재우지 않습니다 — 젖병 우식의 주원인
- 첫 치과 방문: 첫 치아가 난 후 6개월 이내 또는 첫 돌 무렵

#### 이얹이 대응

- 차가운 치발기, 깨끗한 손가락으로 잇몸 문지르기
-  **금지:** 마취 성분(벤조카인) 젤 — 영유아에게 심각한 부작용 위험 / 호박 목걸이 등 목에 거는 제품 — 질식·교살 위험
- 이얹이는 38℃ 이상의 발열, 설사, 발진의 원인이 아닙니다. 그런 증상이면 다른 원인을 찾아야 합니다

## 수면

#### 4개월 수면 퇴행

잘 자던 아이가 갑자기 자주 깨는 시기입니다. **고장이 아니라 발달입니다.** 수면 구조가 성인과 비슷한 주기로 재편되면서 얇은 잠 구간에서 깹니다.

#### 취침 루틴 — 가장 효과 좋은 저비용 개입

같은 순서를 매일 20~30분간 반복합니다.

목욕 → 로션·마사지 → 잠옷 → 책 1권 → 자장가 → 불 끄기 → 눕히기

무작위 연구에서 **일관된 취침 루틴만으로도** 잠들기까지 시간과 야간 각성이 감소했습니다. **보통** 수면 교육을 할지 말지와 무관하게, 이건 지금 시작하세요.

수면 교육은? → 19장에서 판단 기준을 다룹니다. 결론부터 말하면 선택 사항입니다.

## 생각

| 버릴 생각                       | 붙잡을 생각                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| "이유식을 잘 먹어야 잘 크다"           | 이유식은 영양이 아니라 연습이다. 첫돌까지 주 영양원은 모유·분유다 |
| "4개월인데 갑자기 못 자게 됐다, 뭘 잘못했나" | 4개월 수면 퇴행은 정상 발달이다. 뇌가 성숙하는 증거다       |
| "이제 뭔가 가르쳐야 하지 않을까"         | 이 시기 최고의 학습은 <b>옹알이 왕복과 까꿍놀이</b> 다    |

## 물건

#### 새로 필요한 것

- ☐ **이유식 의자** — 5점식 안전벨트, 발 받침 있는 것
- ☐ 실리콘 손가락, 흡착 그릇, **소매 있는 방수 턱받이**
- ☐ 치발기 (냉장 보관 가능한 것)
- ☐ **아기 칫솔 + 불소 치약** — 첫니가 나면 즉시
- ☐ 빨대컵 또는 오픈컵
- ☐ 바닥 놀이매트

## 이제 치울 것

- 속싸개 (뒤집기 시작 시 즉시 중단)
- 신생아용 인서트

## 여전히 사지 말 것

보행기 · 점퍼루 장시간 사용 · 전자 학습교구 · 값비싼 감각 교구 세트

## 🔔 구매 트리거

| 이 모습이 보이면 | 그때 산다               |
|-----------|---------------------|
| 혼자 앉기 시작  | 이유식 의자, 이유식 도구      |
| 첫니가 남     | 아기 칫솔 + 불소 치약       |
| 뒤집기 시작    | 속싸개 중단 · 가구 벽 고정 시작 |

## 🕒 하루 일과 예시 (생후 5개월, 참고용)

07:00 기상 → 수유  
08:00 배밀이 자세 + 웅얼이 놀이 → 낮잠 1  
10:00 수유 → 이유식 한두 숟가락 → 놀기  
11:30 낮잠 2  
13:30 수유 → 산책  
15:00 낮잠 3  
16:30 수유 → 바닥 놀이(까꿍, 잡기)  
18:30 목욕 → 로션 → 책 1권  
19:00 수유 → 밤잠  
(야간 1~2회 수유)

깨어 있는 시간: 4~6개월은 보통 1.5~2.5시간입니다.

## 👶 여아 건강·위생

- 목욕할 때 외음부는 겉면만 부드럽게 씻습니다. 안쪽은 씻지 않습니다
- 비누·거품은 최소한으로. 거품 목욕(버블배스)은 자극이 되어 외음부 염증을 유발할 수 있습니다. 물로 충분합니다
- 씻은 뒤 완전히 건조시키고 기저귀를 채웁니다
- 기저귀 발진이 반복되면 통풍 시간을 늘리고, 딸기처럼 붉고 위성 발진이 있으면 칸디다 감염일 수 있으니 진료를 받으세요 (23장)

## ? 자주 묻는 것

Q. 이유식을 뱉어요. 싫어하는 걸까요? 초기에는 삼키는 것 자체가 새로운 기술입니다. 뱉는 것은 거부가 아니라 연습 중입니다. 스트레스 없이 계속 제안하세요.

Q. 밤중 수유는 언제 끝나요? 6~9개월 이후 영양학적으로는 대개 불필요해지지만, 강제로 끊을 필요는 없습니다. 아이와 가족의 상황에 따라 결정하세요.

Q. 뒤집기를 아직 안 해요. 6개월까지 양쪽 어느 방향으로도 뒤집지 못하면 상담 대상입니다. 한쪽만 뒤집는 것은 흔합니다.

Q. 아기가 자주 물건을 입에 넣어요. 정상이며 필요한 탐색입니다. 입은 이 시기 가장 예민한 감각기관입니다. 삼킬 수 있는 크기의 물건만 치우면 됩니다 (화장지 심 기준, 8장).

## 🚩 경고 신호 (4~6개월)

### 4개월

- 머리를 가누지 못한다
- 소리를 내지 않는다(옹알이 없음)
- 물건을 입으로 가져가지 않는다
- 사람을 보고 웃지 않는다
- 다리에 힘을 주고 딛으려 하지 않는다
- 한쪽 팔·다리만 주로 쓴다 (좌우 비대칭)

### 6개월

- 양쪽 어느 방향으로도 뒤집지 못한다
- 웃거나 기쁨을 표현하지 않는다
- 자음이 섞인 옹알이가 없다
- 물건에 손을 뻗지 않는다
- 몸이 축 늘어지거나 반대로 지나치게 뻣뻣하다
- 눈이 지속적으로 물린다 → 생후 4개월 이후에도 지속되면 안과 진료

## ✅ 6개월 체크리스트

- ☐ 뒤집는다
- ☐ 자음이 섞인 옹알이("바바", "다다")를 한다
- ☐ 이름을 부르면 쳐다본다
- ☐ 아는 사람과 낯선 사람을 구별하는 반응을 보인다
- ☐ 물건에 손을 뻗어 잡고 입으로 가져간다
- ☐ 소리 내어 웃는다
- ☐ 이유식을 시작했고 **철분 공급원이 포함되어 있다**
- ☐ 치아가 났다면 하루 2회 닦고 있다
- ☐ 영유아 건강검진 2차(4~6개월) 완료 — K-DST 발달선별 시작
- ☐ 4개월·6개월 접종 세트 완료
- ☐ 뒤집기 시작 후 속싸개를 중단했다
- ☐ 가구 벽 고정을 시작했다

## 👏 이번 주 한 가지

아기가 "바바바" 하면, 똑같이 "바바바" 하고 나서 단어로 바꿔 돌려주세요. "바바? 밥? 밥 먹을까?"  
그리고 5초 기다리기. 하루 한 번이면 충분합니다.

이유식을 아직 시작 안 하셨어도, 늦게 시작하셨어도 괜찮아요. 준비 신호가 날짜보다 중요합니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 웅알이에 따라 하고 5초 기다리는 왕복이 이 시기 최고의 교육이다.
2. 이유식은 철분부터, 알레르기 식품은 늦추지 않는다.
3. 뒤집기 시작 = 속싸개 중단 + 안전 점검 시작 신호다.

→ 다음: 13장 · 7~12개월

## 13장 · 7~12개월

### 이동과 소통

#### 이번 달 딱 3가지

1. 아이가 가리키면 반드시 그쪽을 보고 이름을 붙인다
2. 안전용품 전면 설치 (기기 시작 전에 끝낸다)
3. 말하고 5초 기다린다

#### 장면

아홉 달 된 아기가 갑자기 손가락을 들어 창밖을 가리킵니다. 그리고 **당신을 돌아봅니다**. 다시 창밖을 봅니다. 다시 당신을 봅니다.

아기는 지금 무언가를 달라고 하는 게 아닙니다. **"저것 좀 봐"**라고 말하고 있습니다.

**이것이 이 시기, 어쩌면 첫 5년 전체에서 가장 중요한 발달 신호입니다.**

#### 이 시기, 이런 마음이 드실 거예요

몸이 갑자기 더 힘들어지는 시기예요. 아이가 움직이기 시작하면서 잠시도 눈을 땔 수 없거든요. 밥 먹다가 열 번은 일어나게 됩니다.

그리고 마음이 힘든 일도 하나 생겨요. **낮가림과 분리불안**입니다.

화장실 가는 것도 못 하게 울고, 다른 사람 품에는 안 가려 하고, 조부모님이 서운해하시고. 그러다 보면 "내가 너무 끼고 키웠나" 싶어지실 거예요.

그런데 이건 정반대입니다. **아이가 당신을 특별한 사람으로 구별하게 되었다는 증거**예요. 인지가 자란 것이지 애착이 잘못된 게 아닙니다. 오히려 이 시기에 낮을 전혀 가리지 않는 것이 확인이 필요한 경우예요.

그리고 이 시기 부모님들이 자주 놓치는 게 하나 있어요. 아이가 움직이기 시작하면 **부모의 일이 '가르치기'에서 '치우기'로 바뀝니다**. 하루에 "안 돼"를 마흔 번 말하고 계신다면, 그중 절반은 3분이면 없앨 수 있어요. 탁자 위를 치우는 게 훈육보다 빠릅니다.

#### 한 장 요약

**가르치기에서 환경 만들기로.**

아이가 움직이기 시작하면 부모의 일이 바뀝니다. 무엇을 더 해주느냐보다, **아이가 안전하게 탐색할 수 있는 집을 만드는 것**이 더 큰 일이 됩니다.

1부의 순환으로 보면, 아이가 **처음으로 진짜 나가기** 시작합니다. 그래서 동시에 **낮가림과 분리불안**이 생깁니다 — 나갈 곳이 생겼기 때문에 돌아올 자리가 중요해진 겁니다.



## 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

### 생후 9개월

| 영역    | 이정표                                |
|-------|------------------------------------|
| 사회·정서 | 낯을 가린다 · 표정으로 감정 표현(기쁨·슬픔·화·놀람)    |
| 언어    | "마마마", "바바바" 여러 음절 웅얼이 · 자기 이름에 반응 |
| 인지    | 숨긴 물건을 찾는다(대상영속성) · 까꿍놀이에서 물건을 찾음  |
| 운동    | 도움 없이 앉는다 · 배밀이/기기 · 손가락으로 물건을 옮긴다 |

### 생후 12개월

| 영역    | 이정표                                          |
|-------|----------------------------------------------|
| 사회·정서 | 까꿍 같은 간단한 놀이를 한다 · 부모를 안전기지로 삼아 탐색           |
| 언어    | "마마"/"아빠" 등 의미 있는 소리 · 손을 흔들며 인사 · "안 돼"를 이해 |
| 인지    | 물건을 컵에 넣었다 뺐다 · 원하는 것을 찾는다                   |
| 운동    | 잡고 선다 · 잡고 옆으로 걷는다 · 엄지와 검지로 작은 것을 집는다       |



## 이 시기 가장 중요한 단 하나 — 가리키기

생후 9~12개월경 나타나는 "보여주기 위한 가리키기"는, 원하는 것을 달라는 것이 아니라 부모와 관심을 공유하려는 몸짓입니다.

이것을 공동주의(joint attention)라고 하며, 이후 언어 발달과 사회성의 가장 강력한 예측 지표 중 하나입니다.

12개월에 가리키기·손 흔들기·시선 따라가기가 전혀 없으면 반드시 소아과 상담을 하세요. **강함** 기다린다고 좋아지지 않고, 조기 개입의 효과는 큼니다.



## 행동

### ① 네 박자 — 가리키기 버전 ★

- ① 멈춤 아이가 가리키면 하던 걸 멈추고 그쪽을 본다
- ② 되돌림 같이 본다. 손가락으로 함께 가리킨다
- ③ 이름 "아, 비행기! 비행기가 날아가네."
- ④ 기다림 5초 ← 아이가 소리를 내거나 다시 가리킨다

**핵심:** 아이가 보는 것에 대해 말하세요. 부모가 보여주고 싶은 것이 아니라, 아이 관심을 따라간 발화가 어휘 습득에 더 효과적입니다. **보통**

### ② 말 걸기 다섯 가지 전략

| 전략    | 방법           | 예                       |
|-------|--------------|-------------------------|
| 해설하기  | 지금 하는 일을 중계  | "이제 양말 신자. 오른발, 왼발."    |
| 확장하기  | 아이 말에 한 단어 더 | 아이 "물" → "물 줄까? 시원한 물." |
| 선택 질문 | 예/아니오 대신 선택지 | "사과 먹을까, 바나나 먹을까?"      |

| 전략        | 방법          | 예                                |
|-----------|-------------|----------------------------------|
| 기다리기      | 말하고 5초 침묵   | 아이가 채울 시간을 준다                    |
| parentese | 높은 톤, 느린 속도 | 단어는 <b>정확하게</b> ("무무" ❌ → "물" ✅) |

### ③ 대상영속성 놀이

- 컵 아래 물건 숨기기 → 찾게 하기
- 상자에 넣었다 빼기, 뚜껑 열고 닫기
- 까꿍놀이 난이도 올리기 (문 뒤, 커튼 뒤)
- "어디 갔지?" → 아이가 찾음 → 크게 반응해주면 인지와 정서가 동시에 자극됩니다

### ④ 손가락 소근육

- 집게 집기 연습: 삶은 완두콩, 잘게 자른 바나나, 시리얼 조각 (질식 주의, 항상 옆에서)
- 넣기/빼기 장난감, 큰 블록, 책장 넘기기

### ⑤ 자조 능력의 시작

- 손으로 집어 먹기(finger food)를 허용합니다. 지저분한 것이 학습입니다
- 오픈컵 또는 빨대컵 연습을 시작합니다
- 만 12개월 무렵 젖병에서 컵으로 전환을 시작합니다 (AAP는 12~18개월 완료 권고)

### ⑥ 하루 최소 1권 — 이제 상호작용이 가능

- 가리키기 유도: "강아지 어디 있지?" → 아이가 짚음 → "맞아, 강아지!"
- 반복을 지루해하지 마세요. 같은 책을 20번 읽는 것이 어휘 습득에 더 효과적입니다
- 플랩북, 소리책, 사진책(실제 사물 사진이 이 시기 학습에 유리)

## 🧐 낮가림과 분리불안 — 정상 발달

- 6~9개월경 낮가림, 8~14개월경 분리불안이 정점에 옵니다
- 이는 아이가 주 양육자를 특별한 존재로 구별하게 되었다는 인지 발달의 증거입니다. 퇴행이 아닙니다

### 대응 다섯 가지

1. 몰래 사라지지 않습니다. 반드시 인사하고 나갑니다. 몰래 가면 아이는 부모가 언제 사라질지 몰라 더 불안해합니다
2. 짧고 일관된 작별 의식을 만듭니다. "뽀뽀 한 번, 안아주기 한 번, 빠이빠이. 자고 일어나면 아빠 올 거야"
3. 질질 끌지 않습니다. 작별을 길게 하면 불안이 커집니다
4. 연습: 집 안에서 짧게 사라졌다 나타나기, 까꿍놀이
5. 새로운 사람에게 바로 안기게 강요하지 않습니다. 부모 옆에서 관찰할 시간을 줍니다

## 🔒 안전 — 이 시기에 반드시 완료

8장의 전면 점검 체크리스트를 기기 시작 전에 끝내세요.

### 우선순위 상위 6개

- ☐ 가구·TV 벽 고정
- ☐ 콘센트 안전커버
- ☐ 서랍·수납장 잠금 (세제·약품)
- ☐ 계단 안전문 (위쪽은 나사 고정식)

- ☐ 창문 잠금 (방충망은 추락을 막지 못합니다)
- ☐ 작은 물건 정리 — 화장지 심을 통과하면 삼킬 수 있습니다

#### 절대 놓치면 안 되는 것

- 버튼형 리튬전지 — 리모컨, 자동차 키, 체중계, 전자 쏫볼, 노래하는 카드
- 자석 구슬 장난감
- 블라인드 줄
- 욕조·세숫대야 물 즉시 비우기

## 수면·식사

### 수면

- 필요량: 12~16시간(낮잠 포함)
- 낮잠: 9개월경 보통 하루 2회, 12~18개월 사이 1회로 통합
- 8~10개월 수면 퇴행: 기기·서기 같은 대운동 발달과 분리불안이 겹칩니다. 낮에 새 동작을 충분히 연습시키면 도움이 됩니다

### 식사

- 이유식 횟수: 7~8개월 하루 2회 → 9~12개월 하루 3회 + 간식 1~2회
- 질감을 올립니다. 9개월 이후에도 계속 갈아만 주면 씹기 발달이 지연되고 이후 편식 위험이 커집니다
- 12개월 이후: 생우유 시작 가능(하루 약 500ml 내외), 꿀도 12개월 이후 가능
- 먹는 양의 결정권은 아이에게 — 부모는 \*무엇을·언제·어디서\*, 아이는 \*얼마나·먹을지 말지\* (18장) **보통**

## 화면 — 이 시기의 기준

- 만 18~24개월 미만: 영상통화를 제외하고 화면 노출을 권장하지 않습니다 (AAP, WHO) **강함**
- 이유는 5장에서 설명한 video deficit effect입니다. 화면은 되돌려주지도, 기다려주지도 않습니다
- 배경 TV도 해롭습니다. 아이가 안 보고 있어도 부모-아이 대화량과 놀이 집중 시간을 줄입니다 **보통**
- 현실적 조언: 0으로 만들려다 실패하기보다, 식사 시간과 잠들기 1시간 전만은 확실히 화면 없음을 지키세요

## 생각

| 버릴 생각                | 붙잡을 생각                                    |
|----------------------|-------------------------------------------|
| "낮가림이 심해져서 걱정이다"     | 낮가림은 주 양육자를 특별하게 인식했다는 인지 발달의 증거다         |
| "분리불안이 있으니 몰래 나가야겠다" | 몰래 가면 더 불안해진다. 짧고 일관된 작별 의식이 답이다          |
| "이제 뭔가 가르쳐야 하지 않을까"  | 이 시기 최고의 교육은 안전한 탐색 환경이다. 치우는 것이 가르치는 것이다 |

## 물건

### 새로 필요한 것

- ☐ 안전용품 일체 (위 목록)
- ☐ 놀이매트
- ☐ 큰 블록, 넣기/빼기 장난감, 공
- ☐ 밀기 장난감(푸시 카트) — 걸음마 연습용. 보행기 아님



- ☐ 목욕 장난감, 욕조 미끄럼 방지 매트
- ☐ 오픈컵 / 빨대컵
- ☐ 실외용 신발 — **걷기 시작 후**. 실내에서는 맨발이 발달에 유리합니다

## 여전히 사지 말 것

보행기(금지) · 전자 플래시카드 · 태블릿 학습기 · 한글/영어 조기 학습 교구

## 구매 트리거

| 이 모습이 보이면 | 그때 산다             |
|-----------|-------------------|
| 배밀이·기기 시작 | 안전용품 전면 설치        |
| 잡고 서기 시작  | 계단 안전문, 낮은 가구 재배치 |
| 걷기 시작     | 실외용 신발, 밀기 장난감    |

## 하루 일과 예시 (생후 10개월, 참고용)

07:00 기상 → 수유  
 08:00 아침 이유식 → 바닥 놀이(넙기/빠기)  
 09:30 낮잠 1  
 11:00 점심 이유식 → 산책 (실외 1시간)  
 13:30 수유 → 낮잠 2  
 15:30 간식 → 놀이 (까꿍, 블록)  
 17:30 저녁 이유식  
 18:30 목욕 → 로션 → 책 1~2권  
 19:30 수유 → 밤잠

깨어 있는 시간: 7~12개월은 보통 2.5~4시간입니다.

## 여아 건강·위생

- 기고 앉기 시작하면서 **바닥 접촉이 늘어납니다**. 기저귀를 자주 갈고, 목욕 후 완전히 건조시키세요
- 여전히 **앞에서 뒤로 닦기, 외음부 안쪽은 씻지 않기**
- **음순유착(labial adhesion)** — 양쪽 소음순이 부분적으로 붙어 보이는 것으로, 영유아기에 드물지 않습니다. **대부분 저절로 호전되며無理하게 벌리지 마세요**. 소변이 잘 나오면 대개 경과 관찰합니다. 소변 줄기가 이상하거나 반복 감염이 있으면 진료를 받으세요
- **설명되지 않는 발열이 유일한 증상일 때** 요로감염을 의심합니다 (21장)

## 자주 묻는 것

**Q. 아직 기지 않아요.** 기기를 건너뛰고 바로 걷는 아이도 흔하며 대개 문제 없습니다. 다만 **9개월에 혼자 앉지 못하면** 상담 대상입니다. 그리고 **한쪽으로만 기는 경우는** 확인이 필요합니다.

**Q. 이유식을 갑자기 거부해요.** 이얇이, 감기, 낯선 질감이 흔한 원인입니다. 며칠 지나 다시 시도하세요. **수분 섭취와 기저귀 소변량만** 확인하면 대개 괜찮습니다.

**Q. 밤에 서서 울어요.** 서기를 막 배운 아이는 자다가 서고 나서 앉는 법을 몰라 울니다. **낮에 "서서 앉기"를 연습**시키면 빨리 지나갑니다.

**Q. TV를 아예 안 보여줄 수는 없어요.** 0으로 만들 필요는 없습니다. **식사 중과 잠들기 1시간 전** 두 구간만 확실히 지키고, 볼 때는 **부모가 옆에서 설명**해주세요. 그것만으로도 큰 차이가 납니다.

## 🚩 경고 신호

### 9개월

- 도움 없이 앉지 못한다
- 자기 이름에 반응하지 않는다
- 아는 사람을 알아보지 못한다
- 웅얼이가 없거나 줄었다
- 눈을 마주치지 않는다

### 12개월 — 특히 중요

- 아무것도 가리키지 않는다 ← 가장 중요한 신호
- 손 흔들기·짝짜꿍 등 몸짓이 없다
- 잡고 서지 못한다
- 의미 있는 말소리가 전혀 없다
- 숨긴 물건을 찾지 않는다
- 이전에 하던 것을 못 하게 되었다(퇴행) ← 즉시 평가

## ✅ 12개월 체크리스트

- ☐ 도움 없이 앉고, 기고, 잡고 선다
- ☐ 무언가를 가리킨다 (요구 + 관심 공유 둘 다)
- ☐ 이름을 부르면 돌아본다
- ☐ 손 흔들기, 짝짜꿍 같은 몸짓을 한다
- ☐ 의미 있는 소리("마마", "아빠")를 낸다
- ☐ 숨긴 물건을 찾는다
- ☐ 엄지와 검지로 작은 것을 집는다
- ☐ 영유아 건강검진 3차(9~12개월) 완료
- ☐ 12개월 접종 확인 (MMR·수두·A형간염·일본뇌염·Hib·PCV)
- ☐ 안전 점검 전면 완료
- ☐ 젖병 → 컵 전환을 시작했다

## 👏 이번 주 한 가지

아이가 무언가를 가리키면, 하던 일을 멈추고 그쪽을 본 다음 이름을 붙여주세요. 이번 주에 세 번만요.

"아, 비행기! 비행기가 날아가네." 그리고 5초.

그리고 한 가지 더 — 무릎으로 앉아 거실을 한 바퀴 둘러보세요. 서 있을 때 안 보이던 것들이 보입니다. 그게 이번 주에 치울 목록이에요.

### 이 장의 요약 3줄

1. **12개월의 가리키기**가 이 시기 가장 중요한 발달 신호다. 없으면 즉시 상담.
2. 낯가림과 분리불안은 **인지 발달의 증거**다. 몰래 사라지지 말고 짧게 인사하고 나가라.
3. 기기 시작 **전에** 안전 점검을 끝내라. 이 시기 부모의 일은 가르치기가 아니라 **치우기**다.

→ 다음: 14장 · 13~24개월

## 14장 · 13~24개월

### 언어와 자율성

#### 🎯 이번 달 딱 3가지

1. 아이 말에 한 단어를 더 붙여 되돌려준다 ("차!" → "빨간 차!")
2. "안 돼"를 줄이고 선택지를 준다
3. 18개월·24개월에 자폐 선별검사(M-CHAT)를 요청한다

#### 장면

열여덟 달 된 아이가 신발을 신으려다 잘 안 되자 바닥에 던지고 눕습니다. 당신이 신겨주려 하니 더 크게 웁니다. 신발을 다시 주니 또 던집니다.

아이는 지금 신발이 미운 게 아닙니다. "내가 하고 싶은데 안 된다"는 것이 미운 겁니다.

#### 💛 이 시기, 정말 힘드시죠

솔직히 말씀드리면, 많은 부모가 첫 5년 중 가장 힘들었던 시기로 이때를 꼽습니다.

아이는 이제 걸어 다니고, 원하는 게 분명해지고, "싫어"를 배웠어요. 그런데 자기 마음을 말로 설명하지도, 참지도 못합니다. 그 간극에서 하루에도 몇 번씩 폭발이 일어나죠.

그리고 이 시기에 부모가 가장 많이 하는 생각이 있어요.

**"내가 너무 오냐오냐 키웠나." "이제 버릇을 잡아야 하는 거 아닐까."**

여기서 꼭 말씀드리고 싶은 게 있어요. 지금 아이는 **반항하는 게 아니라, 자기가 독립된 사람이라는 걸 처음 발견한 것**입니다. 에릭슨이 이 시기를 '자율성'의 시기라고 부른 이유예요.

그리고 아이가 참지 못하는 건 **뇌 구조 때문**입니다. 감정을 만드는 편도체는 이미 작동하는데, 그걸 억누르는 전전두엽은 20대까지 미성숙해요. 두 살 아이에게 "참아"는 다리 없는 사람에게 뛰라고 하는 것과 비슷합니다.

**당신이 잘못 키운 게 아니예요. 원래 이런 시기입니다.**

한 가지 위로가 되는 사실도 있어요. 이 시기 아이의 떼쓰기는 **애착이 안정적일수록 오히려 부모 앞에서 더 크게 나타납니다**. 안전한 사람 앞에서만 무너질 수 있거든요. 밖에서는 잘하다가 집에만 오면 폭발하는 아이를 보고 계신다면, 그건 당신이 안전기지라는 뜻입니다.

#### 한 장 요약

**반항이 아니라 자아의 발견입니다.**

가장 극적인 변화의 해입니다. 걷고, 말하고, "싫어"를 배웁니다. 부모 입장에서는 **처음으로 훈육이 필요해지는 시기**이며, 여기서의 대응 방식이 이후 몇 년의 패턴을 만듭니다.

에릭슨은 이 시기를 **자율성 vs 수치심**이라고 불렀습니다. 아이는 "내가 하는 것"을 확인하려 합니다. "싫어"는 **반항이 아니라 자아의 첫 표현**입니다.



## 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

### 15개월

| 영역    | 이정표                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 사회·정서 | 관심을 끌려고 물건을 보여준다 · 좋아하는 것에 손뼉을 친다                   |
| 언어    | "마마"/"아빠" 외에 의미 있는 낱말 1~3개 · 가리켜 요구한다 · 간단한 지시를 따른다 |
| 인지    | 모방한다(집안일 흉내) · 컵에 물건을 담는다                           |
| 운동    | 몇 걸음 혼자 걷는다 · 손가락으로 음식을 먹는다                         |

### 18개월

| 영역    | 이정표                                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 사회·정서 | 재미있는 것을 보여주려고 부모에게 가져온다 · 낯선 상황에서 부모에게 붙는다 |
| 언어    | 낱말 3개 이상 · 고개를 저어 "아니"를 표현                 |
| 인지    | 도구를 목적에 맞게 쓴다(컵, 빗) · 낙서를 한다               |
| 운동    | 혼자 잘 걷는다 · 컵으로 마신다 · 숟가락을 쓴다               |

### 24개월

| 영역    | 이정표                                    |
|-------|----------------------------------------|
| 사회·정서 | 다른 아이 옆에서 병행놀이 · 새 상황에서 부모 반응을 살핀다     |
| 언어    | 두 낱말을 붙여 말한다 · 신체 부위를 가리킨다 · 낱말 50개 내외 |
| 인지    | 두 단계 지시를 따른다 · 그림책의 사물 이름을 안다          |
| 운동    | 뛰다 · 공을 찬다 · 계단 오르내리기 · 블록 4개 이상 쌓기    |

24개월에 두 낱말 조합이 없거나 표현 어휘가 50개 미만이면 언어 평가를 권합니다. 이중 언어 환경이라도 두 언어를 합친 총 어휘로 판단하며, 이중 언어 자체는 지연의 원인이 아닙니다. **강함**



## 행동

### ① 네 박자 — 확장 버전 ★

- ① 멈춤 아이가 "차!" 한다
- ② 되돌림 같이 차를 본다
- ③ 이름 "빨간 차!" ← 한 단어를 더 붙인다 (+1 규칙)
- ④ 기다림 5초

### ② 어휘 폭발 활용 다섯 가지

18~24개월경 어휘가 급격히 늘어납니다. 이 시기의 언어 입력이 이후 문해력·학업과 상관이 높습니다.

| 기법     | 방법                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| +1 규칙  | 아이가 한 단어 → 두 단어로 되돌려준다                  |
| 선택지 주기 | "물 마실래?" 대신 "물 줄까, 우유 줄까?" — 단어를 쓰게 만든다 |

| 기법       | 방법                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| 일부러 기다리기 | 원하는 걸 바로 주지 말고 <b>5초</b> . 소리라도 내면 반응한다 |
| 혼잣말 해설   | "아빠는 지금 당근을 자르고 있어"                     |
| 질문 늘리기   | "이게 뭐야?" → "애는 지금 뭐 하고 있을까?"            |

### ③ 대화식 책임기 시작 ★ **강함**

9장의 PEER/CROWD를 이 시기부터 본격적으로 씁니다.

#### PEER (한 페이지에서)

1. 질문한다 — "이게 뭐지?"
2. 인정한다 — "맞아!"
3. 확장한다 — "그래, 큰 갈색 곰이네."
4. 다시 말해보게 한다 — "큰 곰이라고 해볼까?"

### ④ 자율성 살리기 — 여는 환경

8장의 "여는 환경"이 지금 가장 중요해집니다. "혼자 하고 싶다"는 욕구가 폭발하는데 환경이 막고 있으면 **좌절** → **떼쓰기**가 되고, 환경이 열려 있으면 **자조 능력**이 됩니다.

- 낮은 옷걸이·서랍 / 세면대 발판 / 낮은 곳에 물병과 컵 / 표지가 보이는 낮은 책장
- 시간을 여유 있게 잡습니다. 스스로 신발 신는 데 5분이 걸립니다. 그 5분이 교육입니다

### ⑤ 운동과 놀이

- 하루 최소 180분의 신체 활동 (WHO, 1~4세). 몰아서가 아니라 하루 전반에
- 하루 1~2시간 실외 — 근시 예방과도 관련이 보고됩니다 **[보통~강함]**
- 소근육: 굵은 크레용 낙서, 블록 쌓기, 1~4조각 퍼즐, 스티커
- 실생활 참여: 빨래 넣기, 물 붓기, 손가락으로 옮기기

### ⑥ 상징놀이의 시작

18~24개월경 블록을 자동차라 하거나 인형에게 밥을 먹입니다. **추상적 사고와 언어 발달의 중요한 지표**입니다. 부모가 함께 하면 확장됩니다.

## 🧐 떼쓰기 — 이 시기의 본질

#### 왜 이러는가

- 뇌의 구조적 한계: 감정을 만드는 편도체는 이미 작동하지만, 억제하는 전전두엽은 **20대까지 미성숙**합니다. 두 살 아이에게 "참아"는 물리적으로 불가능한 요구입니다
- 떼쓰기는 **18~36개월에 정상적으로 최고조에** 이릅니다

#### 대응 — 6장 감정 코칭 그대로

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 1. 안전 확보  | 위험한 물건만 치운다                       |
| 2. 말을 줄인다 | "화났구나. 아빠 여기 있어." (한 문장)          |
| 3. 곁에 있는다 | 말없이 앉아 있는다                        |
| 4. 진정된 뒤  | "화날 수 있어. 그래도 던지는 건 안 돼." → 다시 연결 |

## 예방이 대응보다 효과적

| 예방책          | 방법                                   |
|--------------|--------------------------------------|
| 배고픔·졸림 관리    | 떼쓰기의 절반 이상이 이 둘이다. 외출은 낮잠·식사 시간을 피해서 |
| 예고하기         | "5분 뒤에 나갈 거야" → "이제 두 번만 더"          |
| 선택지 주기       | "가자" 대신 "신발 신을래, 아빠가 신겨줄까?"          |
| "안 돼" 총량 줄이기 | 만지면 안 되는 물건은 <b>치운다</b>              |
| 미리 규칙 말하기    | 마트 도착 <b>전에</b> "오늘은 과자 안 살 거야"      |

## 하지 말 것

- **체벌** — AAP는 효과가 없고 공격성·정신건강 문제와 연관된다고 명시 **강함**
- **소리 지르기·모욕**
- **떼쓰는 중에 요구 들어주기** — 떼쓰기가 효과적이라고 학습시킵니다

## 🧠 생각

| 버릴 생각              | 붙잡을 생각                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| "이제 버릇을 잡아야 한다"    | <b>반향이 아니라 자아의 발견</b> 이다. 잡을 버릇이 아니라 열어줄 자율성이다     |
| "말을 안 듣는다"         | 두 살은 못 듣는 게 <b>아니라</b> 못 참는 것이다. 뇌가 아직 그 기능을 못 한다  |
| "다른 애는 벌써 말을 잘하는데" | 24개월 기준은 <b>두 낱말 조합과 낱말 50개</b> 다. 그 외의 비교는 의미가 적다 |

## 📦 물건

### 새로 필요한 것

- ☐ 굵은 크레용, 큰 도화지, 세척 가능한 물감
- ☐ 큰 블록(듀플로 계열), 3~6조각 퍼즐, 모양 맞추기
- ☐ 밀고 타는 장난감(라이드온), 공
- ☐ 유아용 식기(포크·숟가락), 미끄럼 방지 컵
- ☐ 실외용 신발, **안전모**(자전거·킥보드 시작 시)
- ☐ **낮은 책장** — 표지가 보이게 꽂는 형태
- ☐ 낮은 옷걸이·발판 (여는 환경)
- ☐ 유아 변기 또는 변기 커버 + 발판 — **준비 신호가 보일 때만**

## 사지 말 것

학습 태블릿 · 전자 단어 카드 · 한글 학습지 · 조기 영어 DVD **소리·불빛이 요란한 전자 장난감** — 아이의 발화량과 부모-아이 상호작용을 줄인다는 연구가 있습니다 **보통**

## 🔔 구매 트리거

| 이 모습이 보이면 | 그때 산다  |
|-----------|--------|
| 걷기 시작     | 실외용 신발 |
|           |        |

| 이 모습이 보이면            | 그때 산다            |
|----------------------|------------------|
| 아기침대 난간을 넘으려 함       | 유아 침대 전환         |
| <b>배변 준비 신호</b> (아래) | 유아 변기, 팬티        |
| 자전거·킥보드 관심           | <b>안전모</b> (동시에) |

## 🚽 배변 훈련 — 아직 서두르지 않기

- 대부분 18~30개월 사이에 준비됩니다
- 너무 일찍 시작하면 전체 기간이 오히려 길어집니다

### 준비 신호 — 모두 갖춰지면 시작

- ☐ 기저귀가 2시간 이상 마른 상태로 유지된다
- ☐ 배변 전에 표정·자세로 신호를 보인다
- ☐ 간단한 지시를 따를 수 있다
- ☐ 바지를 스스로 내리고 올릴 수 있다
- ☐ 변기·화장실에 관심을 보인다

방법은 15장에 있습니다.

## 😴 수면 · 🍽️ 식사

### 수면

- 필요량 11~14시간(낮잠 포함)
- 낮잠: 12~18개월경 2회 → 1회로 통합. 아이 신호를 따르세요
- 18개월 수면 퇴행: 분리불안 재발 + 걷기·말하기 급성장. 일과를 유지하며 지나갑니다
- 침대 전환은 서두를 필요 없습니다. 난간을 넘기 시작하면 그때가 신호입니다

### 식사

- 편식은 정상 발달입니다. 2~5세의 새 음식 거부(food neophobia)는 정상입니다
- 새 음식은 10~15회 이상 노출되어야 받아들여지기도 합니다 **보통**
- 강요·보상 금지: "다 먹으면 아이스크림"은 채소 선호를 떨어뜨립니다 **보통**
- 우유는 하루 약 500ml 이내 (과다하면 철분 결핍성 빈혈)
- 주스는 준다면 만 1~3세 하루 120ml 이내

## 📱 화면

| 나이      | 기준                 |
|---------|--------------------|
| 18개월 미만 | 영상통화 외 권장하지 않음     |
| 18~24개월 | 도입한다면 부모가 함께 보며 설명 |
| 2세~     | 하루 1시간 이내          |

아이를 진정시키는 수단으로 화면을 쓰지 않습니다. 스스로 감정을 조절하는 법을 배울 기회를 잃습니다. **보통**



## 하루 일과 예시 (20개월, 참고용)

07:00 기상 → 아침 (스스로 숟가락)  
08:30 실외 놀이 1시간 ← 오전에 에너지를 쓴다  
10:30 간식 → 실내 놀이(블록, 낙서)  
12:00 점심  
13:00 낮잠 (1.5~2시간)  
15:00 간식 → 책 읽기 (대화식)  
16:00 실외 놀이 또는 산책  
18:00 저녁 (가족과 함께)  
19:00 목욕 → 로션 → 책 2권  
19:45 잠자리 (일과를 매일 같은 순서로)

## 여아 건강·위생

- 배변 훈련을 시작하면 처음부터 "앞에서 뒤로" 닦기를 가르칩니다. 손 위에 손을 얹어 방향을 함께 익히세요
- 면 팬티를 쓰고, 젖은 옷·수영복을 오래 입히지 않습니다
- 거품 목욕과 향이 강한 비누는 외음부 자극이 될 수 있습니다
- 음순유착은 이 시기에도 보일 수 있으며 대개 저절로 호전됩니다. **무리하게 벌리지 마세요**
-  **설명되지 않는 발열 + 보챔 + 소변 볼 때 우는 모습** → 요로감염 가능성. 진료를 받으세요

## 자주 묻는 것

Q. 15개월인데 아직 걷지 않아요. 18개월까지 걷지 않으면 평가 대상입니다. 그 전까지는 정상 범위가 넓습니다.

Q. "안 돼"라고 하면 웃으면서 또 해요. 이 나이에 흔합니다. 반응 자체가 재미있는 겁니다. 말 대신 물리적으로 옮기고 다른 것으로 관심을 돌리세요. 그리고 그 물건을 치우세요.

Q. 물고 때려요. 2~3세에 흔하며 대개 언어로 표현하지 못하는 좌절이 원인입니다. 즉시 분리 → 피해 아이를 먼저 돌보고 → "무는 건 아파. 안 돼" (짧게). 반복되면 어떤 상황에서 발생하는지 기록해 패턴을 찾으세요.

Q. 어린이집을 보내도 될까요? 질 좋은 보육 환경에서 안정 애착은 충분히 형성됩니다 (NICHD 대규모 연구). 결정은 가정 상황에 따라 하시면 됩니다. 기관 선택 기준은 34장에 있습니다.

## 경고 신호

### 18개월

- 의미 있는 낱말이 없다
- 다른 사람의 행동을 흉내내지 않는다
- 재미있는 것을 보여주려고 가져오지 않는다
- 혼자 걷지 못한다
- 눈맞춤을 피한다

### 24개월

- 두 낱말을 붙여 말하지 못한다
- 사용하는 낱말이 50개 미만
- 간단한 지시를 따르지 못한다
- 흉내내기·상상놀이를 하지 않는다
- 안정적으로 걷지 못하거나 자주 넘어진다
- 획득했던 말·기술을 잃었다(퇴행) ← 즉시 평가

## ✓ 24개월 체크리스트

- ☐ 혼자 잘 걷고, 뛰고, 계단을 오른다
- ☐ 두 낱말을 붙여 말한다
- ☐ 사용하는 낱말이 50개 이상이다
- ☐ 신체 부위를 가리킬 수 있다
- ☐ 간단한 지시("공 가져와")를 따른다
- ☐ 인형에게 밥 먹이기 같은 흉내내기 놀이를 한다
- ☐ 다른 아이에게 관심을 보인다
- ☐ 블록 4개 이상을 쌓는다
- ☐ 영유아 건강검진 4차(18~24개월) 완료
- ☐ 구강검진 1차(18~29개월) 완료
- ☐ 18개월·24개월 자폐 선별검사(M-CHAT-R/F)를 받았다
- ☐ 15~18개월 DTaP 4차 완료

## 👉 이번 주 한 가지

아이가 한 단어를 말하면, 한 단어를 더 붙여 돌려주세요. "차!" → "빨간 차!"

이번 주엔 이것 하나만. 가르치려 하지 말고, 그냥 되돌려주기만 하면 됩니다.

그리고 하루에 "안 돼"를 몇 번 말하는지 세어보세요. 열 번이 넘으면 그중 절반은 3분이면 치울 수 있는 것들입니다.

## 📌 이 장의 요약 3줄

1. "싫어"는 반항이 아니라 **자아의 발견**이다. 잡을 버릇이 아니라 열어줄 자율성이다.
2. **+1 규칙** — 아이 한 단어에 한 단어를 더 붙여 되돌려준다.
3. 떼쓰기는 정상이고, **예방(배고픔·졸림·예고·선택지)**이 대응보다 효과적이다.

→ 다음: 15장 · 24~36개월

## 15장 · 24~36개월

### 감정과 상상

#### 🎯 이번 달 딱 3가지

1. 감정에 이름을 붙인 뒤에 한계를 정한다 ("화났구나. 그래도 때리는 건 안 돼.")
2. 결과가 아니라 과정을 칭찬한다 ("포기 안 하고 끝까지 했네")
3. 배변 훈련은 준비 신호를 보고 시작한다

#### 장면

두 살 반 아이가 퍼즐 조각을 억지로 끼우려다 안 되자, 퍼즐판을 통째로 집어 던집니다. 그리고 읊니다. 당신이 "괜찮아, 다시 하면 되지"라고 말하자 **더 크게** 읊니다.

**"괜찮아"가 왜 역효과였을까요?**

아이 입장에서 그 말은 이렇게 들립니다. **"네가 느끼는 건 별거 아니야."**

#### 💖 이 시기, 이런 마음이 드실 거예요

"미운 세 살"이라는 말을 정말 많이 들으실 거예요. 그리고 어떤 날은 그 말에 동의하게 되실 겁니다. 그게 나쁜 부모라는 뜻은 아니예요.

이 시기에 특히 지치는 이유가 있어요. **아이가 말을 할 줄 알게 되면서, 부모가 자주 설득하려 하기 때문**입니다. 말이 통할 것 같으니까 설명하고, 논리로 이해시키려 하고, 그게 안 되면 답답해지죠.

그런데 감정이 폭발한 순간의 아이에게는 **말이 거의 들리지 않습니다**. 그래서 이 시기 부모의 역할은 설득이 아니라 **통역**이에요. "네가 지금 느끼는 게 이거야"라고 이름을 붙여주는 것.

그리고 하나 더. 아이가 감정을 조절하지 못하는 건 당연한데, **부모까지 같이 흔들리는 게 정상**이라는 건 아무도 **말해주지 않아요**. 아이가 소리 지르면 내 심장도 뛰고, 화가 올라옵니다. 그건 당신의 신경계가 정상적으로 반응하는 거예요.

그래서 이 시기의 진짜 기술은 아이를 진정시키는 법이 아니라, **내가 먼저 진정하는 법**입니다. 그리고 그건 연습이 필요한 일이지, 타고나는 게 아니예요.

**오늘 잘 안 됐다면, 내일 다시 하면 됩니다.** 아이는 한 번의 실패로 무너지지 않아요.

#### 한 장 요약

감정은 인정하고, 행동은 제한합니다.

"미운 세 살"이라 불리지만, 실제로는 **감정을 다루는 법을 처음 배우는 시기**입니다. 아이는 하고 싶은 것은 많은데 능력과 언어가 못 따라가서 좌절합니다.

이 시기 부모의 역할은 통제가 아니라 **감정의 통역사**입니다. 그리고 1부의 순환으로 보면, 아이가 **감정에 압도되어 돌아왔을 때 받아주는 자리**가 되는 것입니다.



## 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

### 30개월

| 영역    | 이정표                                         |
|-------|---------------------------------------------|
| 사회·정서 | 부모와 떨어져 곁에서 논다 · 간단한 놀이에서 순서를 기다린다          |
| 언어    | 두 낱말 이상의 문장 · "나", "내 것" 사용 · 낱말 50개 이상     |
| 인지    | 인형·인물을 등장시켜 놀이한다 · 뚜껑을 돌려 연다 · 옷 입기를 도우려 한다 |
| 운동    | 손을 잡지 않고 계단을 오른다 · 옷을 벗는다 · 원 비슷한 것을 그린다    |

### 36개월

| 영역    | 이정표                                      |
|-------|------------------------------------------|
| 사회·정서 | 다른 아이와 함께 논다 · 부모와 헤어질 때 진정된다 · 순서를 기다린다 |
| 언어    | 2~3문장으로 대화한다 · 자기 이름·나이를 말한다 · 명료도 약 75% |
| 인지    | 간단한 퍼즐(3~4조각) · "안에/위에/아래에"를 이해          |
| 운동    | 몇 초간 한 발로 선다 · 큰 단추를 채운다 · 원을 따라 그린다     |

### 언어 명료도 기준 (지연 판단에 유용)

| 나이   | 낯선 사람이 알아듣는 비율 |
|------|----------------|
| 만 2세 | 약 50%          |
| 만 3세 | 약 75%          |
| 만 4세 | 거의 100%        |



## 행동

### ① 네 박자 — 감정 버전 ★

- ① 멈춤 우는 아이 앞에서 하던 걸 멈춘다
- ② 되돌림 아이 눈높이로 앉는다 (몸이 되돌림이다)
- ③ 이름 "퍼즐이 안 돼서 화났구나." ← 감정에 이름
- ④ 기다림 5초, 설명도 훈계도 하지 않는다

앞 장면에서 "괜찮아" 대신 필요했던 것은 이것입니다.

"열심히 맞추려고 했는데 안 돼서 속상하구나."

### ② 감정 코칭 5단계 (6장)

1. 알아차린다 → 2. 기회로 본다 → 3. 공감하며 듣는다 → 4. 이름을 붙인다 → 5. 한계를 정한다

대부분의 부모는 3·4를 건너뛰고 5부터 시작합니다. 그러면 아이는 듣지 않습니다.

### ③ 감정 어휘 가르치기

감정에 이름을 붙일 수 있는 아이가 감정을 더 잘 조절합니다.

- 일상에서 감정 단어를 자주 씁니다: 기쁘다 · 슬프다 · 화나다 · 무섭다 · 부럽다 · 답답하다 · 실망하다 · 서운하다 · 뿌듯하다
- 책을 보며 "애는 지금 기분이 어떨까?"
- 부모 자신의 감정도 말합니다. "아빠 지금 좀 피곤해서 답답해. 잠깐 쉬고 올게." ← 감정 조절의 시범

#### ④ 진정 도구 만들기 (아이와 함께)

"화날 때 할 수 있는 것" 3가지를 아이와 정해 **그림으로 그려 붙입니다**. 예: 심호흡 / 베개 안기 / 조용한 자리로 가기

**반드시 평온할 때 연습합니다.** 폭발한 순간에 새 기술을 가르칠 수는 없습니다.

#### ⑤ 과정 칭찬

| ✗          | ✓                  |
|------------|--------------------|
| "우와 천재네!"  | "포기 안 하고 끝까지 했네."  |
| "예쁘게 그렸다!" | "여기 색을 여러 개 섞었구나." |
| "착한 아이네."  | "동생한테 먼저 양보했구나."   |

인격보다 **행동**을, 결과보다 **과정**을 짚습니다. **보통**

#### ⑥ 상징놀이를 적극 확장

2~3세는 상징놀이의 폭발기입니다. **추상적 사고, 언어, 사회성, 자기조절을 동시에** 키웁니다. **보통**

- 소품 제공: 인형, 그릇, 전화기, 의사놀이, **천 조각**(무엇이든 될 수 있음)
- 부모는 **조연**으로 참여합니다. 주도권은 아이에게
- 완제품 장난감보다 **용도가 정해지지 않은 물건**(상자, 천, 나무 블록)이 상상력을 더 자극합니다

#### ⑦ 실행기능의 시작 (9장)

- **억제 조절**: 얼음땀, 무궁화꽃이 피었습니다, 사이먼 가라사대
- **작업기억**: 두세 단계 심부름 ("책 가져와서 소파에 놓아줘")
- **인지 유연성**: 분류 놀이 (색깔로 나눴다가 → 모양으로 다시)

### 배변 훈련 — 실전

#### 시작 시점

준비 신호가 모두 갖춰졌을 때 (14장 목록). 보통 24~36개월. **스트레스가 큰 시기**(동생 출생, 이사, 첫 등원)는 피합니다.

#### 4주 진행안

| 주차 | 할 것                                                    |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1주 | <b>친숙해지기</b> — 옷 입은 채 변기에 앉아보기. 하루 1~2회, 즐겁게. 실패 개념 없음 |
| 2주 | <b>연결하기</b> — 기저귀 갈 때 내용물을 변기에 넣어 보여주기. "쉬야는 여기 가는 거야" |
| 3주 | <b>시도하기</b> — 아침에 일어난 직후, 식사 후 등 가능성이 높은 시간에 앉혀보기      |

| 주차  | 할 것                                    |
|-----|----------------------------------------|
| 4주~ | 팬티로 전환 — 성공이 쌓이면 낮 동안 팬티. 실수는 반드시 생깁니다 |

## 규칙

- **혼내지 않습니다.** 실수는 100% 예상된 일입니다. 야단치면 참게 되고, **변비 → 통증 → 더 참기**의 악순환이 생깁니다
- **과한 보상도 피합니다.** 스티커 정도면 충분합니다
- **밤 기저귀는 별개입니다.** 야간 조절은 만 5~7세까지도 미완성일 수 있으며 발달 문제가 아닙니다
- **퇴행은 흔합니다.** 동생이 태어나면 다시 실수합니다. 정상입니다

## 🚩 병원에 갈 때

- 변을 참아서 변비가 심하거나 배변 시 통증·출혈
- 만 4세가 지나도 낮 배변 조절이 전혀 안 될 때
- 배변 훈련 후 완전히 퇴행하고 지속될 때

## 👥 사회성 · 또래

- **2세: 병행놀이가 정상입니다.** 옆에서 각자 놀아도 걱정할 것 없습니다
- **3세: 함께 놀기 시작합니다.** 순서 기다리기, 나눠쓰기가 서서히 가능해집니다
- **나눠쓰기는 3~4세까지 어렵습니다.** "같이 놀아"보다 **타이머로 순서 정하기**가 현실적입니다

무는 행동·때리는 행동 2~3세에 흔합니다. 대개 언어로 표현하지 못하는 좌절이 원인입니다.

즉시 개입 → "무는 건 아파. 안 돼" (짧게)  
 → 피해 아이를 먼저 돌본다 ← 가해 아이에게 관심이 물리지 않게  
 → 나중에 대안을 연습한다

반복되면 어떤 상황에서 발생하는지 기록해 패턴을 찾으세요.

## 🧠 생각

| 버릴 생각               | 붙잡을 생각                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| "감정을 다 받아주면 버릇없어진다" | <b>감정 인정과 행동 허용은 다르다.</b> "화났구나"는 인정이고 "때려도 돼"는 허용이다 |
| "괜찮다고 말해서 진정시켜야 한다" | "괜찮아"는 <b>"네 감정은 별거 아니야"</b> 로 들린다. 이름을 붙여줘야 진정된다    |
| "빨리 기저귀를 떼야 한다"     | <b>일찍 시작하면 전체 기간이 오히려 길어진다.</b> 준비 신호가 기준이다          |

## 📦 물건

### 새로 필요한 것

- ☐ 유아 변기 / 변기 커버 + **발판**, 팬티 여러 장, 방수 매트리스 커버
- ☐ 역할놀이 소품 (주방놀이, 병원놀이, 인형, **천 조각**)
- ☐ 나무 블록, 자석 블록, 4~12조각 퍼즐
- ☐ 세발자전거 또는 밸런스 바이크 + **안전모**
- ☐ 굵은 색연필, **안전 가위(3세~)**, 풀, 색종이

- ☐ 그림책 + 이야기가 있는 스토리북
- ☐ 낮은 옷걸이·발판 — 스스로 하기 환경

## 사지 말 것

한글 학습지 · 영어 전집 · 학습 태블릿 · 지능/창의력 향상을 표방하는 고가 교구

## 구매 트리거

| 이 모습이 보이면 | 그때 산다           |
|-----------|-----------------|
| 배변 준비 신호  | 유아 변기, 팬티       |
| 가위에 관심    | 안전 가위 (반드시 옆에서) |
| 세발자전거 관심  | 자전거 + 안전모 동시에   |

## 하루 일과 예시 (30개월, 참고용)

07:00 기상 → 아침 (스스로 먹기) → 스스로 옷 고르기(선택지 2개)  
 08:30 실외 놀이 1시간  
 10:00 간식 → 상징놀이 (소꿉, 병원놀이)  
 11:30 점심 → 정리 참여 (그릇 옮기기)  
 12:30 변기 알아보기 → 낮잠 (1~2시간)  
 14:30 간식 → 그리기·블록  
 15:30 실외 놀이 또는 놀이터  
 17:30 저녁  
 18:30 목욕 → 로션 → 책 2~3권 (대화식)  
 19:30 잠자리

낮잠: 2~3세는 보통 하루 1회 1~2시간. 3세 무렵부터 서서히 줄어듭니다.

## 여아 건강·위생

배변 훈련 시기라 이 절이 특히 중요합니다.

- "앞에서 뒤로" 닦기를 처음부터 가르칩니다. 아이 손 위에 손을 얹어 방향을 함께 익히세요. 이 습관 하나가 요로감염 위험을 줄입니다
- 면 팬티를 쓰고, 젖은 팬티·수영복을 오래 입히지 않습니다
- 거품 목욕과 향이 강한 비누·입욕제를 피합니다 — 유아 외음질염의 흔한 원인입니다
- 목욕은 물로 걸면만, 안쪽은 씻지 않습니다
- 배변 후 손 씻기를 함께 습관화합니다

## 진료가 필요한 신호

- 외음부가 붉고 가렵다고 하거나 자꾸 만진다
- 소변 볼 때 아프다고 한다 / 소변을 참는다
- 설명되지 않는 발열이 반복된다 → 요로감염 (21장)
- 분비물에 냄새가 나거나 색이 있다

## 자주 묻는 것

Q. 아직 문장으로 말하지 않아요. 36개월 기준은 2~3문장 대화와 낱선 사람이 75% 알아듣기입니다. 이에 크게 못 미치면 언어 평가를 권합니다. 조기 언어치료의 효과는 큼니다.

Q. 밤에 무섭다고 해요. 3세 전후로 상상력이 발달하면서 두려움이 생깁니다. "괴물 없어"라고 부정하기보다 통제감을 주세요. 수면등, "괴물 스프레이", 문 열어두기.

Q. 동생이 태어난 뒤 아기처럼 굴어요. 퇴행은 정상 반응입니다. 하루 10~15분 첫째와 단둘이 보내는 시간을 고정하는 것이 가장 효과적입니다. "형/누나니까 참아"는 쓰지 마세요.

Q. 어린이집에서 잘 못 어울린대요. 2~3세의 병행놀이는 정상입니다. 함께 놀지 않는다고 문제는 아닙니다. 다만 다른 아이에게 전혀 관심이 없다면 확인이 필요합니다.

## 경고 신호 (만 3세)

- 말이 낯선 사람에게 거의 전달되지 않는다 (명료도 75% 미만)
- 문장으로 말하지 않는다
- 다른 아이에게 관심이 없다
- 간단한 지시를 이해하지 못한다
- 상상놀이를 하지 않는다
- 눈을 마주치지 않는다
- 심하게 자주 넘어지거나 계단을 못 오른다
- 부모와 떨어질 때 전혀 진정되지 않는다
- 퇴행 — 하던 말·기술이 사라짐

## 36개월 체크리스트

- ☐ 2~3 문장으로 대화한다
- ☐ 낯선 사람이 아이 말을 대체로 알아듣는다
- ☐ 자기 이름과 나이를 말한다
- ☐ 다른 아이와 함께 논다
- ☐ 인형·인물을 등장시킨 상상놀이를 한다
- ☐ 2단계 지시를 따른다
- ☐ 한 발로 잠깐 서고, 계단을 번갈아 오른다
- ☐ 원을 따라 그린다
- ☐ 부모와 헤어질 때 결국 진정된다
- ☐ 영유아 건강검진 5차(30~36개월) 완료
- ☐ 구강검진 2차(30~41개월) 완료
- ☐ 치과 정기 검진 (6개월마다)

## 이번 주 한 가지

아이가 울면, 첫 마디를 "괜찮아" 대신 감정 이름으로 시작해보세요.

"속상했구나." "화났구나." "무서웠구나."

그리고 아무 말도 덧붙이지 말고 5초. 설명도, 해결책도 그다음입니다.

잘 안 되는 날이 대부분일 거예요. 일곱 번 중 한 번만 되어도 이번 주는 성공입니다.



### 이 장의 요약 3줄

1. "괜찮아" 대신 **감정 이름**. 감정을 인정한 뒤에야 한계가 전달된다.
2. 과정을 칭찬한다. "천재네" 대신 "**포기 안 하고 했네.**"
3. 배변 훈련은 **준비 신호가 기준**이고, 실수는 100% 예상된 일이다.

→ 다음: 16장 · 만 3~5세

## 16장 · 만 3~5세

### 또래와 실행기능

#### 이번 달 딱 3가지

1. 억제 조절 놀이를 한다 (얼음땡, 무궁화꽃, 사이먼 가라사대)
2. 질문에 답하기 전에 되물어준다 ("너는 왜 그럴 것 같아?")
3. 시력검사를 받는다 (약시는 이 시기에 발견해야 한다)

#### 장면

다섯 살 아이가 묻습니다. "아빠, 왜 밤이 와?" 당신이 지구 자전을 설명하려는 순간, 아이가 다시 묻습니다. "왜?" 설명합니다. "왜?" 또 설명합니다. "왜?"

아이는 답을 원하는 게 아닙니다. 대화를 원하는 겁니다.

#### 이 시기, 이런 마음이 드실 거예요

몸은 좀 편해지는데, 마음이 새로 복잡해지는 시기예요.

주변에서 이런 말들이 들리기 시작합니다. "그 집은 벌써 한글 땀대." "영어 유치원 안 보내?" "지금 안 하면 늦어." 그리고 그 말들은 이상하게도 밤에 더 크게 들리죠.

여기서 이 책이 드릴 수 있는 가장 확실한 말은 이겁니다.

**만 5세 이전 문자·연산 선행 교육의 장기적 학업 이점은 확인되지 않았습니다.** 보통 초등학교 성취를 가장 잘 예측하는 건 한글이 아니라 **어휘력과 자기조절**이에요.

그러니까 지금 아이와 얼음땡을 하고, 보드게임에서 지는 걸 견디게 하고, 저녁마다 오늘 있었던 일을 이야기하는 것 — 그게 학습지보다 학교 준비에 가깝습니다. **덜 하는 게 아니라 다른 걸 하는 거예요.**

그리고 이 시기엔 아이와 부딪히는 결이 달라집니다. 이제 아이가 논리로 반박하고, 규칙의 공정함을 따지고, 가끔 거짓말도 해요. 그때마다 "이게 인성 문제인가" 싶어지실 텐데 — 대부분은 **인지 발달의 신호**입니다. 거짓말은 타인의 마음을 이해해야 가능한 일이거든요.

마지막으로 하나. 이 시기가 되면 아이가 부모 없이도 꽤 잘 지냅니다. 그게 **서운하실 수 있어요.** 그 서운함은, 당신이 자리를 잘 만들어줬다는 증거입니다. 돌아올 곳이 확실하니까 멀리 나가는 거예요.

#### 한 장 요약

**학교 준비는 한글이 아니라 자기조절입니다.**

이 시기 아이는 **사회적 존재**가 됩니다. 친구가 생기고, 규칙을 배우고, 상상의 세계가 폭발합니다. 부모의 관심은 자연스럽게 "학교 준비"로 향하지만, **초등학교 성취를 가장 잘 예측하는 것은 한글·연산이 아니라 자기조절과 언어 능력**입니다.

1부의 순환으로 보면, 아이는 이제 **꽤 멀리 나갑니다.** 부모는 점점 더 자리에 머무는 역할이 됩니다.



## 발달 이정표 (CDC 2022 · 약 75% 기준)

### 만 4세

| 영역    | 이정표                                                |
|-------|----------------------------------------------------|
| 사회·정서 | 다른 아이를 위로하거나 도우려 한다 · "나 좀 봐" 하며 자랑한다 · 부모가 없어도 논다 |
| 언어    | 4단어 이상 문장 · 색을 4개 이상 안다 · 방금 있었던 일을 말한다 · 노래를 외운다  |
| 인지    | 무엇/어디/누가에 답한다 · 하루 일과의 순서를 안다                      |
| 운동    | 한 발로 여러 초 선다 · 단추를 채운다 · 사람 그림에 신체 부위 3개 이상        |

### 만 5세

| 영역    | 이정표                                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 사회·정서 | 규칙 있는 놀이의 규칙을 따른다 · 노래·춤·연기를 한다 · 도움을 요청한다 |
| 언어    | 여러 문장으로 이야기를 한다 · 대화를 주고받는다 · 이름을 쓰려고 시도한다 |
| 인지    | 10까지 센다 · 자기 이름의 글자를 알아본다 · 오늘/내일을 안다      |
| 운동    | 한 발로 강충 뛴다 · 사람 그림에 신체 부위 6개 이상            |



## 행동

### ① 네 박자 — 되물어주기 버전 ★

- ① 멈춤 "왜 밤이 와?" → 하던 걸 멈춘다
- ② 되돌림 "밤이 왜 오는지 궁금하구나."
- ③ 이름 "너는 왜 그럴 것 같아?" ← 답 대신 질문을 되돌려준다
- ④ 기다림 5초 이상. 아이가 가설을 만든다

모르면 "같이 찾아보자"라고 하세요. 모른다고 인정하는 부모의 모습이 좋은 모델입니다.

### ② 실행기능 — 이 시기 최우선 투자

실행기능(작업기억 · 억제 조절 · 인지 유연성)은 이후 학업 성취를 IQ만큼, 때로는 더 잘 예측합니다. **보통**

| 능력     | 놀이 (교구 불필요)                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 억제 조절  | 무궁화꽃이 피었습니다 · 얼음땀 · 사이먼 가라사대 · 반대로 말하기 · 조용히 걷기 시험 |
| 작업기억   | 카드 짝 맞추기 · 3단계 심부름 · "시장에 가면~"                     |
| 인지 유연성 | 규칙 바뀌며 분류하기 (색 → 모양) · 같은 물건의 다른 용도 찾기             |
| 계획·조직  | 요리하기 · 설명서 보고 만들기 · 하루 계획을 그림으로                    |

특히 효과적인 것: 규칙 있는 놀이와 역할극. 아이가 스스로 정한 역할을 유지하는 것 자체가 강력한 자기조절 훈련입니다. "선장은 그렇게 안 해"라고 스스로를 규제하는 것 — 그것이 억제 조절입니다. **보통**

보드게임이 특히 좋습니다. 순서 기다리기, 규칙 준수, 지는 것 견디기를 한 번에 연습합니다.

### ③ 문해력 준비 — 순서가 중요

1. 구어 능력과 어휘 ← 가장 중요
2. 음운 인식
3. 글자-소리 대응
4. 읽기 유창성 (초등 이후)

#### 음운 인식 놀이 (한국어)

- 음절 나누기: "사·과" 손뼉 치며 — 한국어는 음절 단위가 자연스럽습니다
- 첫소리 찾기: "'ㄱ' 소리로 시작하는 말은?"
- 끝말잇기, 라임이 있는 동요

#### 자모 노출 (강요 없이)

- 아이 이름의 글자부터. 가장 동기가 높습니다
- 냉장고 자석 글자, 간판 읽기
- 쓰기 강요 금지. 소근육이 준비되지 않은 상태의 연필 쥐기는 잘못된 습관을 만듭니다. 대신 점토·가위질·구슬 꿰기로 손 힘을 기릅니다

### ④ 책 읽기 — 계속 읽어줍니다

- 하루 20분 이상. 아이가 혼자 읽게 되어도 계속하세요
- 이야기 구조 질문: "처음에 무슨 일이 있었지? 그래서 어떻게 됐어? 마지막엔?"
- 추론 질문: "왜 그랬을까?", "다음에 어떻게 될 것 같아?"
- 글 없는 그림책으로 아이가 이야기를 지어내게 합니다 — 표현 언어에 매우 효과적

### ⑤ 탈맥락적 언어

지금 여기 없는 것에 대해 말하기 — 어제 일, 내일 계획, 상상. 이것이 학교 언어의 토대입니다.

- 저녁 식탁에서 "오늘 뭐가 제일 재미있었어?"
- "내일은 뭐 할까?"
- 드문 단어 일부러 쓰기: "거대한", "실망했어", "결국", "곧바로"

### ⑥ 수학적 사고 (학습지 없이)

- 기수성 — 마지막에 센 숫자가 전체 개수라는 이해. "몇 개야?" 물었을 때 다시 세지 않고 답하는가
- 비교·공간 언어: 더 많다/적다, 위/아래/사이/뒤 — 공간 어휘가 이후 수학 성취를 예측한다는 연구가 있습니다 **보통**
- 선형 보드게임 — 숫자 칸을 주사위로 이동하는 게임은 수 감각 향상이 무작위 연구로 확인되었습니다 **강함**
- 요리: 계량, 순서, 분수

## 또래 관계

#### 발달 양상

- 4세: 우정이 생기지만 매우 유동적. "너랑 안 놀아"는 흔하고 심각하지 않습니다
- 5세: 규칙과 공정성에 민감해집니다. "그건 반칙이야"가 자주 나옵니다
- 마음이론(Theory of Mind): 4세 전후로 타인이 나와 다른 생각을 가질 수 있다는 것을 이해하기 시작합니다. 공감의 인지적 토대입니다

#### 갈등이 생겼을 때 — 심판이 아니라 코치

1. 바로 해결해주지 않습니다. 안전 문제가 아니면 잠시 지켜봅니다

2. 개입할 때는 **양쪽의 감정을 말로 옮겨줍니다.** "너는 그 차를 갖고 놀고 싶었고, 애는 아직 다 못 놀았대."
3. **해결책을 아이들에게 묻습니다.** "어떻게 하면 둘 다 놀 수 있을까?"
4. 합의를 실행하도록 도와줍니다

## 거짓말과 상상

- 4~5세의 거짓말은 **인지 발달의 신호**입니다. 타인의 마음을 이해해야 거짓말이 가능합니다. 도덕적 결함이 아닙니다
- 대응: **함정에 빠뜨리지 않습니다.** "네가 그랬지?" 대신 "무슨 일이 있었는지 같이 보자"
- **정직을 칭찬합니다.** "사실대로 말해줘서 고마워"

## 🧠 생각

| 버릴 생각                 | 붙잡을 생각                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| "이제 한글을 시작해야 한다"      | 만 5세 이전 문자 교육의 장기 이점은 확인되지 않았다. 어휘와 자기조절이 먼저다 |
| "'왜?' 질문이 너무 많아 피곤하다" | 인지 발달의 정점이다. 다 답할 필요 없이 되물어주면 된다              |
| "친구랑 못 어울리는 것 같다"     | 4세의 우정은 유동적이다. "너랑 안 놀아"는 혼하고 심각하지 않다         |

## 🏠 유치원·기관 선택 기준

과장된 커리큘럼보다 아래를 봅니다. **유아기 교육의 질을 예측하는 것은 상호작용의 질**입니다.

- ☐ **교사와 아이의 상호작용** — 아이 눈높이에서 대화하는가, 지시만 하는가
- ☐ 교사 대 아동 비율, 교사 이직률·근속연수
- ☐ 하루 중 자유놀이 시간이 충분한가
- ☐ 매일 실외 활동이 있는가
- ☐ 화면 사용 정책
- ☐ 훈육 방침 — 체벌·수치 주기·격리를 쓰지 않는가
- ☐ 급식·위생·안전 시설
- ☐ 부모와의 소통 방식

📌 **결론만 말하면:** 학습 중심 프로그램이 단기적으로 글자·숫자 성과를 높여도, 장기적으로는 놀이 중심과 차이가 없거나 오히려 사회정서 면에서 불리하다는 연구들이 있습니다. **보통** 커리큘럼의 화려함보다 **교사의 태도**를 보세요.

기관 찾기와 입소 절차는 34장에 있습니다.

## 📦 물건

### 새로 필요한 것

- ☐ **보드게임**(간단한 규칙, 순서 있는 것), 카드 게임
- ☐ 레고, 자석 블록, 구슬 꿰기
- ☐ 가위, 풀, 색연필, 스케치북 — **연필보다 굵은 도구부터**
- ☐ 자전거(보조바퀴 또는 밸런스 바이크) + 안전모
- ☐ 줄넘기, 공, 훌라후프
- ☐ 그림책 + **짧은 챗터북**(읽어주기용), 글 없는 그림책
- ☐ 아이 키에 맞는 책상·의자 — **발이 바닥에 닿는 높이**
- ☐ 낮은 옷장·발판

## 사지 않아도 되는 것

조기 학습지 세트 · 영어 전집 · 학습 태블릿 · 지능/창의력 향상을 표방하는 고가 교구 (그런 효과의 근거는 거의 없습니다)

## 하루 일과 예시 (만 4세, 기관 다니는 경우)

07:00 기상 → 스스로 옷 입기 → 아침  
08:30 등원  
(기관: 자유놀이 · 실외활동 · 점심 · 낮잠 또는 조용한 시간)  
16:00 하원 → 간식 → 자유놀이 (개입하지 않음)  
17:00 실외 놀이 / 놀이터  
18:30 저녁 - 오늘 있었던 일 이야기하기 (탈맥락적 언어)  
19:30 목욕 → 보드게임 1판 또는 그리기  
20:00 책 20분 (이야기 구조 질문)  
20:30 잠자리

## 흔한 문제 상황

**잠들기 거부 / 밤에 무서워하기** 상상력이 발달하면서 두려움이 생깁니다. 부정하기보다 **통제감**을 주세요. 수면등, "괴물 스프레이", 문 열어두기. **잠들기 1시간 전 화면 금지.**

**형제 출생에 따른 퇴행** 배변·말·수면에서 퇴행이 흔합니다. **하루 10~15분 단둥이 보내는 시간**을 고정하는 것이 가장 효과적입니다. "형/누나니까 참아"는 쓰지 마세요.

### 화면 시간 관리

- 하루 1시간 이내, 가능하면 함께 시청
- 정해진 시간·장소만 (예: 주말 오후, 거실에서만)
- 끝내는 규칙을 미리 정합니다. "이거 하나 끝나면 끄는 거야"
- 침실·식탁에는 화면을 두지 않습니다

## 여아 건강·위생

- **유아 외음질염**이 이 나이에 가장 흔합니다. 원인은 대개 감염이 아니라 **자극**입니다
- 거품 목욕·향이 강한 비누·입욕제
- 젖은 수영복을 오래 입고 있기
- 닦는 방향이 반대일 때
- 꽉 끼는 옷, 합성섬유 팬티
- 대처: 물로만 씻기 · 완전히 건조 · 면 팬티 · 통풍 · 자극원 제거. 그래도 지속되면 진료
- 스스로 뒤에서 앞으로 닦는 습관이 남아 있는지 확인하세요. 이 나이엔 혼자 화장실을 쓰기 시작하므로 다시 한번 가르쳐야 합니다
-  **설명되지 않는 발열 · 소변 볼 때 통증 · 갑작스러운 야뇨 재발** → 요로감염 확인 (21장)

## 자주 묻는 것

**Q. 한글을 언제 시작해야 하나요?** 아이가 관심을 보일 때. 이름 글자부터 자연스럽게 노출하고, 스스로 물어보면 그때 따라가면 됩니다. 만 5세 이전 선행의 장기 이점은 확인되지 않았습니다.

**Q. 영어 유치원을 보내야 할까요?** 근거로 말할 수 있는 것은 이 정도입니다. ① 이중언어 자체는 해롭지 않습니다. ② 영상으로는 배우지 못하고 사람과의 상호작용이 필요합니다. ③ 모국어 어휘가 이후 문해력의 토대입니다. 결정은 가정의 가치관과 비용 문제이며, 발달상 필수는 아닙니다.

Q. 아이가 자주 저서 울어요. 지는 것을 견디는 연습이 이 나이의 과제입니다. 저도 게임을 계속하는 것을 칭찬하세요. "졌는데도 끝까지 했네." 그리고 부모도 가끔 지고, 그때 어떻게 반응하는지 보여주세요.

Q. 취학 전에 뭘 준비해야 하나요? 아래 체크리스트에 있습니다. 대부분 학습이 아닙니다.

## 🚩 경고 신호 (만 4~5세)

- 짧은 문장으로만 말한다
- 또래와 놀지 못하고 계속 혼자 있다
- 규칙 있는 놀이를 이해하지 못한다
- 자기 이름·나이를 모른다
- 배변 조절이 낮에도 전혀 안 된다
- 극도로 위축되거나 반대로 공격적이다
- 집중 시간이 또래에 비해 현저히 짧다
- 퇴행 — 하던 것을 못 하게 됨

## ✅ 취학 전 최종 점검 (만 5~6세)

학교가 실제로 요구하는 것

- ☐ 30분 정도 앉아서 집중할 수 있다
- ☐ 지시를 듣고 따를 수 있다
- ☐ 화장실을 스스로 이용한다
- ☐ 도움이 필요할 때 어른에게 말할 수 있다
- ☐ 자기 물건을 챙긴다
- ☐ 순서를 기다리고 규칙을 지킨다
- ☐ 좌절해도 어느 정도 진정할 수 있다
- ☐ 자기 이름을 알아보고 쓰려고 시도한다
- ☐ 10까지 세고, 개수와 연결할 수 있다
- ☐ 다른 아이와 협력해서 논다

건강 점검

- ☐ 영유아 건강검진 6차(42~48개월), 7차(54~60개월), 8차(66~71개월)
- ☐ 구강검진 3차(42~53개월), 4차(54~65개월)
- ☐ 만 4~6세 추가 접종: DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차 — 취학 전 확인 필수
- ☐ 시력 검사 — 약시는 이 시기에 발견해 치료해야 회복 가능성이 높습니다 **강함**
- ☐ 청력 확인
- ☐ 치과 정기 검진 (6개월마다)

## 👏 이번 주 한 가지

저녁 식탁에서 "오늘 뭐가 제일 재미있었어?"를 물어보세요. 매일 한 번.

이게 별것 아닌 것 같지만, 지금 여기 없는 일에 대해 말하는 연습 — **탈맥락적 언어**입니다. 학교에서 쓰는 언어가 정확히 이거예요. 학습지보다 이쪽이 취학 준비에 가깝습니다.

그리고 아직 안 하셨다면 이번 달 안에 시력검사를 예약하세요. 약시는 이 시기가 사실상 마지막 기회입니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 학교 준비는 한글이 아니라 자기조절과 어휘다.
2. 실행기능은 교구가 아니라 얼음땡·보드게임·역할극으로 자란다.
3. 시력검사를 놓치지 마라. 약시는 이 시기가 마지막 기회에 가깝다.

→ 다음: 4부 · 몸의 일



## 4부 · 몸의 일

---

### 먹이고, 재우고, 아플 때

이 부는 진단서가 아닙니다. "집에서 할 것"과 "병원 갈 신호"의 **분기점**만 알려드립니다. 진단과 처방은 의사의 일이에요. 판단이 서지 않으면 **언제나 진료를 받는 쪽**을 고르세요. 가서 아무 일 아니면 그게 제일 좋은 결과입니다.

#### ♥ 이 부를 읽는 마음에 대해

아이가 아프면 부모는 순식간에 무력해집니다. 아무리 많이 알아도, 밤에 열이 39도까지 오르면 손이 떨려요. 그건 지식이 부족해서가 아니라 **사랑하기 때문에 생기는 반응**입니다.

그래서 이 부는 최대한 **단순하게** 썼습니다. 새벽에 읽어도 판단이 서도록요.

그리고 한 가지만 미리 말씀드릴게요. **"괜히 병원 갔나" 싶은 날이 훨씬 낫습니다.** 소아과와 응급실은 그러라고 있는 곳이에요. 아무 일 아니라는 말을 듣고 돌아오는 것도 좋은 결과입니다. 눈치 보지 마세요.

## 17장 · 수유

### 확립과 트러블슈팅

#### 장면

출산 3일째. 모유가 안 나옵니다. 아기는 계속 울니다. 조리원 선생님은 "조금만 더 물려보세요"라고 합니다. 당신은 울면서 생각합니다. '나는 엄마 자격이 없나 보다.'

아닙니다. 이건 매우 흔한 일이고, 대부분 지나갑니다. 그리고 지나가지 않아도 괜찮습니다.

#### 먼저 — 이 장의 전제

먹이는 방식보다 부모의 상태가 더 중요합니다.

모유의 이점은 실재합니다(감염 감소, 소화). 그러나 형제 비교 연구에서 **인지 효과는 대부분 사회경제적 요인으로 설명됩니다**. 모유수유가 안 되는 것 때문에 산모의 정신건강이 무너지는 것이 아이에게 훨씬 나쁩니다.

분유 수유도 완전히 괜찮습니다. 이 장은 두 가지 모두를 다룹니다.

#### 1. 기본 — 얼마나, 어떻게

##### 횟수

- 신생아: 하루 **8~12회 이상**, 2~3시간 간격
- **신호 수유(responsive feeding)**: 울음은 **늦은** 신호입니다
- 이른 신호: 입을 오물거림 · 손을 빨음 · 고개를 돌려 찾음(rooting)
- 첫 2~3주, 출생 체중 회복 전까지는 밤에 **4~5시간 이상 자면 깨워서 먹입니다**

##### ✓ 충분히 먹고 있는지 확인하는 법

이것만 보면 됩니다.

| 지표 | 기준                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 소변 | 생후 5일 이후 <b>하루 젖은 기저귀 6장 이상</b>                           |
| 대변 | 모유수유아는 묽고 노란 변, 하루 여러 번 (1개월 이후엔 며칠에 한 번도 정상)             |
| 체중 | 첫 며칠 최대 7~10% 감소는 정상 → <b>약 2주 내 출생 체중 회복</b> → 이후 꾸준한 증가 |
| 상태 | 수유 후 만족스러워 보임, 잘 깸, 피부 탄력 정상                              |

수유량을 mL로 세는 것보다 이 네 가지가 정확합니다. 특히 모유수유 중에는 양을 알 수 없으므로 이 지표를 쓰세요.

## 2. 모유수유 트러블슈팅

### 젖이 안 나온다 (수유 초기)

- 정상입니다. 초유는 소량이고, 성숙유는 보통 출산 후 2~5일에 돌아옵니다
- 대응: 자주 물리기(하루 8~12회) · 피부 접촉 · 양쪽 번갈아 · 유축 병행
- 아기 체중이 걱정되면 **분유 보충을 죄책감 없이** 쓰세요. 보충하면서도 모유수유는 계속할 수 있습니다

### 유두 통증·균열

- 원인의 대부분은 **젖 물리기 자세(latch)**입니다. 유두 끝만 물면 아픉니다
- 깊게 물리기: 아기 입이 크게 벌어졌을 때, 유륜까지 깊이. 아랫입술이 바깥으로 말려 나와야 합니다
- 떼어낼 때는 **손가락을 입가에 넣어 흡입을 끊고** 뺍니다
- 수유 후 모유를 조금 발라 말리기, 순수 라놀린
- **피가 나거나 통증이 심하면** 수유 상담(모자보건센터·보건소·산부인과)을 받으세요

### 젖몸살 (울혈)

- 증상: 유방 전체가 단단하고 아프며 열감
- 대응: 수유 전 따뜻한 찜질과 부드러운 마사지 → 수유 또는 유축 → 수유 후 냉찜질
- 비우는 것이 핵심입니다. 참으면 유선염으로 진행할 수 있습니다

### 유선염

- 증상: 유방 한 부위가 붉고 단단하며 아픉 + **38℃ 이상의 발열, 몸살**
- 대응: 수유를 중단하지 마세요. 계속 비우는 것이 치료의 일부입니다. 휴식, 수분, 진통제
- 24시간 내 호전이 없거나 발열이 심하면 진료 — 항생제가 필요할 수 있습니다
- 방치하면 농양으로 진행할 수 있습니다

### 모유 보관 기준 (건강한 만삭아 기준)

| 보관            | 기간               |
|---------------|------------------|
| 실온 (약 25℃ 이하) | 약 4시간            |
| 냉장 (4℃)       | 약 4일             |
| 냉동 (가정용 냉동실)  | 약 6개월 (최대 12개월)  |
| 해동 후 냉장       | 24시간 이내          |
| 데운 뒤 남은 것     | 그 수유 시간 내, 이후 버림 |

- 해동한 모유를 다시 얼리지 않습니다
- 전자레인지 사용 금지 — 부분 과열로 화상 위험, 성분 손상
- 해동은 냉장실이나 미지근한 물에

### 유축

- 복직 예정이라면 **복직 2~4주 전부터** 하루 1회씩 여유분을 모으기 시작하세요
- 소량씩 나눠 얼리면(60~120mL) 버리는 양이 줄어듭니다
- 날짜와 양을 반드시 표기

### 3. 분유 실전

#### 조제

- 분말 분유는 무균이 아닙니다. 세계보건기구는 70℃ 이상의 물로 타서 크로노박터 등 세균 위험을 낮출 것을 권고합니다. 탄 뒤 빠르게 식혀 체온 정도로 맞춥니다
- 제품·기관에 따라 권고가 다를 수 있으니 제품 설명과 담당 의사 지시를 함께 확인하세요
- 정해진 비율을 지킵니다. 물을 더 타서 묽게 만드는 것은 위험합니다(저나트륨혈증·영양 부족)
- 먹이기 전 손목에 떨어뜨려 온도 확인. 전자레인지 사용 금지

#### 보관

- 탄 분유는 실온에서 2시간 이내, 냉장 보관 시 24시간 이내
- 아기가 입을 댄 젖병의 남은 분유는 1시간 이내에 버립니다 (침의 세균이 번식)

#### 페이스트 보틀 피딩 (권장)

- ① 아기를 세워 안는다
- ② 젖병을 수평에 가깝게 (분유가 젖꼭지에 겨우 찰 정도)
- ③ 20~30초마다 잠깐 쉬어준다
- ④ 아기가 거부하면 멈춘다

과식을 줄이고, 모유수유와 병행할 때 유두 혼동을 줄입니다.

#### 그 밖에

- 젖병을 물린 채 재우지 않습니다 (충치·중이염)
- 브랜드 전환은 대개 문제없으나, 바꾼 뒤 며칠간 변 상태가 달라질 수 있습니다
- 특수분유(가수분해 등)는 의사 지시가 있을 때만. 임의로 바꾸지 마세요

### 4. 영양 보충

| 영양소   | 대상                                               | 용량                    |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 비타민 D | 완전 모유수유아 (분유 섭취량이 적은 경우 포함)                      | 하루 400 IU, 생후 며칠 이내부터 |
| 철분    | 만삭 모유수유아는 생후 4개월경부터 보충 또는 이유식으로 확보. 미숙아는 더 이른 시기 | 소아과 지시에 따름            |

생후 6개월경 태아기에 저장된 철분이 고갈됩니다. 이유식에서 철분이 최우선인 이유입니다.

### 5. 절대 금지

- 꿀 — 만 1세 전 (영아 보툴리누스증)
- 생우유를 주 음료로 — 만 1세 전
- 6개월 이전에 물을 많이 주기 (저나트륨혈증 위험)
- 분유를 임의로 묽게 타기

## 자주 묻는 것

Q. 모유와 분유를 섞어 먹여도 되나요? 됩니다(혼합수유). 모유량이 줄 수 있으므로 모유를 유지하고 싶다면 **유축을 병행**하세요.

Q. **밤중 수유는 언제 끝나요?** 6~9개월 이후 영양학적으로는 대개 불필요해지지만, **강제로 끊을 필요는 없습니다**. 가족 상황에 따라 결정하세요.

Q. **아기가 수유 중에 자꾸 자요.** 발바닥 자극, 기저귀 갈기, 옷을 얇게. 그래도 못 먹으면 짧게 자주 먹입니다. **체중 증가가 확인되면** 크게 걱정하지 않아도 됩니다.

Q. **트림을 못 시키면 어떡하나요?** 5~10분 시도해도 안 나오면 눕혀도 괜찮습니다. 모든 수유 후에 트림이 나오는 것은 아닙니다.

Q. **자꾸 토해요.** 소량의 게워냄(역류)은 매우 흔하고, **체중이 잘 늘고 잘 논다면** 대개 문제없습니다. 다만 아래는 진료가 필요합니다.

## 병원에 갈 때

- 분수처럼 뿜는 구토가 반복(특히 생후 2~8주) → 유문협착증 감별
- 초록색(담즙성) 구토 → 즉시
- 체중이 늘지 않거나 줄어듦
- 수유 거부가 지속됨
- 12시간 이상 소변 없음
- 수유 시 심하게 보채고 등을 활처럼 젖힘
- 산모: 유방 통증 + 38℃ 이상 발열 → 유선염

## 이 장의 요약 3줄

1. 먹이는 방식보다 부모의 상태가 중요하다. 분유도 완전히 괜찮다.
2. 충분히 먹는지는 소변 6장 · 2주 내 체중 회복 · 꾸준한 증가로 확인한다.
3. 유선염이면 수유를 중단하지 말고 계속 비우면서 진료를 받는다.

→ 다음: 18장 · 이유식·알레르기·편식

## 18장 · 이유식 · 알레르기 · 편식

### 1. 언제 시작하나

만 4개월 이전에는 시작하지 않습니다. 아래가 모두 충족될 때 (대개 6개월 전후):

- ☐ 목을 잘 가누고, 받쳐주면 앉을 수 있다
- ☐ 혀 내밀기 반사가 사라졌다 — 손가락을 넣어도 혀로 밀어내지 않는다
- ☐ 음식에 관심을 보이고 입을 벌린다
- ☐ 체중이 출생 시의 약 2배

WHO는 만 6개월 전후를 권고하고, AAP는 약 6개월경(4개월 이전은 권하지 않음)을 제시합니다. **날짜가 아니라 준비 신호가 기준입니다.**

### 2. 진행 순서

| 단계  | 시기(대략)  | 형태                     | 횟수              |
|-----|---------|------------------------|-----------------|
| 초기  | 4~6개월   | 곱게 간 미음, 부드러운 퓨레       | 하루 1회 → 2회      |
| 중기  | 7~8개월   | 으깬 형태, 작은 덩어리          | 하루 2회 + 간식      |
| 후기  | 9~11개월  | 잘게 썬 형태, <b>손가락 음식</b> | 하루 3회 + 간식 1~2회 |
| 완료기 | 12~18개월 | 가족 식사에 가까운 형태          | 하루 3회 + 간식 2회   |

#### 규칙 다섯 가지

1. 첫 음식은 철분이 풍부한 것 — 철분 강화 곡물, 소고기·닭고기 퓨레, 렌틸콩

＞ 생후 6개월경 태아기 철분 저장량이 고갈됩니다

1. 한 번에 한 가지, 3~5일 간격 — 알레르기 반응 식별을 위해
2. 모유·분유가 여전히 주 영양원입니다. 첫돌까지 이유식은 보조입니다
3. 거부해도 계속 제안합니다. 새 음식은 10~15회 이상 노출되어야 받아들여지기도 합니다
4. 간을 하지 않습니다. 소금·설탕 추가 금지

#### ★ 질감을 늦추지 마세요

9~10개월 이후에도 계속 갈아만 주면 씹기 발달이 지연되고 이후 편식 위험이 커집니다. 덩어리와 손가락 음식으로 넘어가세요.

헛구역질(gagging)은 정상적인 학습 과정이며 질식(choking)과 다릅니다.

|    | 헛구역질           | 질식          |
|----|----------------|-------------|
| 소리 | 소리를 내고 기침한다    | 소리를 못 낸다    |
| 얼굴 | 붉어짐            | <b>파래짐</b>  |
| 대응 | 개입하지 않는다. 지켜본다 | 즉시 처치 (22장) |

### 3. 알레르기 유발 식품 — 늦추지 않는다

#### 결론만 말하면 — 권고가 뒤집혔습니다

과거에는 계란·땅콩·생선을 늦게 시작하라고 했지만, LEAP 연구(2015, NEJM) 이후 정반대로 바뀌었습니다.

이유식 시작 후(생후 4~6개월경) 알레르기 유발 식품을 이른 시기에 도입하고 꾸준히 먹이면 식품 알레르기 발생이 줄어듭니다. **강함**

#### 주요 알레르기 유발 식품

계란 · 땅콩 · 우유(유제품) · 밀 · 견과류 · 대두 · 생선 · 갑각류 · 참깨

#### 도입 방법

- ① 집에서, 아침이나 낮에 (반응 시 병원 갈 시간 확보)
- ② 아주 소량부터 → 이상 없으면 늘린다
- ③ 한 번에 한 가지, 3~5일 관찰
- ④ 이상 없으면 주 1~2회 이상 꾸준히 유지 ← 중단하면 다시 생길 수 있습니다

- 땅콩은 통째로 주지 않습니다(질식). 땅콩버터를 물·모유에 묽게 풀거나 가루 형태로

#### 고위험군은 먼저 상담

중증 아토피 피부염이 있거나, 이미 알려진 식품 알레르기가 있는 영아는 도입 전 소아과·알레르기 전문의 상담이 필요합니다(검사 후 도입).

#### 알레르기 반응 신호

| 정도         | 증상                                                            | 조치              |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 경증         | 입 주변 발적, 두드러기 몇 개, 가벼운 구토                                     | 중단하고 관찰, 소아과 상담 |
| 중증(아나필락시스) | 호흡곤란, 뉘뉘거림, 목이 조이는 느낌, 얼굴<br>·입술 부종, 창백·처짐, 반복 구토, 전신<br>두드러기 | 즉시 119 (22장)    |

### 4. 절대 금지 · 질식 위험

#### 만 1세 전 금지

- 꿀 (영아 보툴리누스증)
- 생우유를 주 음료로
- 소금·설탕 추가

#### 질식 위험 음식 (만 4세까지)

| 음식           | 안전하게 주는 법      |
|--------------|----------------|
| 포도·방울토마토     | 세로로 4등분        |
| 소시지·비엔나      | 세로로 잘라 잘게      |
| 견과류          | 통째로 주지 않기. 갈아서 |
| 생당근·사과       | 익히거나 얇게 저며서    |
| 떡·젤리·사탕·팝콘·껌 | 주지 않기          |

공통 원칙: 앉아서 먹기 · 걸어 다니며 먹지 않기 · 먹는 동안 지켜보기 · 차 안에서 먹이지 않기

## 5. 만 1세 이후

가능해지는 것

- 생우유 — 하루 약 500ml 이내. **과다 섭취는 철분 결핍성 빈혈을 유발합니다**
- 꿀
- 가족과 같은 음식 (질감·크기만 조정, 간은 약하게)

젖병 끊기

12~18개월 사이 **완료**를 권고합니다(AAP). 오래 쓸수록 충치·중이염 위험과 과다 우유 섭취 문제가 생깁니다.

주스

- 만 1세 미만: **주지 않습니다**
- 1~3세: 준다면 **하루 120ml 이내**, 100% 주스만
- 물과 우유가 기본 음료입니다

## 6. 편식 — 정상 발달입니다

왜 그런가

2~5세의 새 음식 거부(food neophobia)는 **정상적인 발달 단계**입니다. 스스로 움직이게 된 아이가 아무거나 먹지 않도록 형성된 반응으로 해석됩니다.

★ 책임 분담 모델 (Satter) **보통**

부모가 정한다: 무엇을, 언제, 어디서 먹을지  
아이가 정한다: 먹을지 말지, 얼마나 먹을지

이 경계를 지키는 것이 장기적으로 가장 건강한 식습관을 만듭니다.

이렇게 하면 / 이렇게 하면

| ✗                   | ✓                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 쫓아다니며 먹인다           | 정해진 자리에서만. 20~30분 뒤 조용히 치운다                      |
| "다 먹으면 아이스크림"       | 보상을 붙이지 않는다 — <b>채소 선호를 오히려 떨어뜨립니다</b> <b>보통</b> |
| 안 먹으면 따로 특별식을 만들어준다 | 가족과 같은 음식 + <b>아이가 먹을 수 있는 것 한 가지</b> 를 함께 올린다   |
| "한 입만 더!"           | 강요하지 않는다. 그 음식에 대한 혐오를 만듭니다                      |
| 식사 중 화면             | 포만감 인식을 방해합니다                                    |

효과 있는 방법

- **반복 노출** — 거부해도 계속 식탁에 올립니다(먹으라고 강요하지 않고)
- **부모가 먼저 맛있게 먹는 모습**
- **요리에 참여시키기** (씻기, 섞기) — 수용률이 올라갑니다
- 좋아하는 음식 **옆에** 새 음식을 조금
- **간식 관리**: 식사 1~2시간 전 간식·우유를 줄입니다. 배가 고파야 먹습니다



- 식사 시간을 20~30분으로 제한

### 병원에 갈 때

- 성장 곡선이 떨어질 때 ← 편식 자체보다 이게 기준입니다
- 먹는 음식 종류가 극단적으로 제한될 때(10~15가지 미만)
- 특정 질감을 전혀 못 견디거나 삼킴에 문제가 있을 때
- 식사 때마다 구역질·구토가 반복될 때

## | ? 자주 묻는 것

Q. 이유식은 직접 만들어야 하나요? 시판 이유식도 괜찮습니다. 성분표(나트륨·당)를 확인하고, **질감 진행**만 신경 쓰세요.

Q. 유기농이 더 좋은가요? 영양학적 차이는 크지 않습니다. **다양성이 더 중요합니다.**

Q. 물은 언제부터 주나요? 이유식 시작 후 소량 가능합니다. 6개월 이전에는 불필요하고 과다 시 위험합니다.

Q. 아이 영양제가 필요한가요? 비타민 D 외에는 균형 잡힌 식사를 하면 대체로 불필요합니다. 편식이 심하면 소아과와 상의하세요.

Q. 우유 알레르기와 유당 불내증은 같은 건가요? 다릅니다. 영아기 유당 불내증은 드물고, **우유 단백질 알레르기**가 더 흔합니다.

---

### 이 장의 요약 3줄

1. 이유식은 **날짜가 아니라 준비 신호**로 시작하고, **철분이 최우선**이다.
2. **알레르기 유발 식품은 늦추지 않는다.** 이른 도입 후 꾸준히 먹이는 것이 예방이다.
3. 부모는 **무엇을·언제·어디서**, 아이는 **얼마나·먹을지** 말지. 강요와 보상은 역효과다.

→ 다음: 19장 · 재우기

# 19장 · 재우기

## 장면

생후 8개월. 두 달 전만 해도 밤에 한 번만 깨던 아이가 이번 주에는 다섯 번 깹습니다. 인터넷에서 "8개월 수면 퇴행"을 검색합니다. 어떤 글은 수면 교육을 하라고 하고, 어떤 글은 절대 하지 말라고 합니다.

둘 다 맞습니다. 이 장은 그 선택을 하는 법입니다.

## 1. 필요 수면량

| 나이     | 하루 총 수면 (낮잠 포함) |
|--------|-----------------|
| 0~3개월  | 14~17시간         |
| 4~12개월 | 12~16시간         |
| 1~2세   | 11~14시간         |
| 3~5세   | 10~13시간         |

개인차가 큼니다. 아이가 낮에 기분 좋게 지내면 충분한 것입니다.

깨어 있는 시간 (wake window) — 실전에서 가장 유용한 개념

| 나이      | 다시 졸릴 때까지 |
|---------|-----------|
| 0~2개월   | 45~90분    |
| 3~5개월   | 1.5~2.5시간 |
| 6~12개월  | 2.5~4시간   |
| 12~18개월 | 4~6시간     |
| 18개월~3세 | 5~6시간     |

이 시간을 넘기면 과피로해져 오히려 못 잡니다. "많이 놀려야 잘 잔다"는 이 나이에는 자주 역효과입니다.

## 낮잠 전환

| 시기      | 낮잠           |
|---------|--------------|
| 0~3개월   | 불규칙, 하루 4~6회 |
| 4~8개월   | 하루 3회 → 2회   |
| 9~15개월  | 하루 2회        |
| 12~18개월 | 2회 → 1회로 통합  |
| 3~5세    | 1회 → 서서히 없어짐 |

전환기 요령: 갑자기 줄이지 말고, 하루는 2회 하루는 1회로 며칠 섞습니다. 1회로 넘어가면 취침 시간을 30~60분 앞당기세요.

## 2. 취침 루틴 — 가장 효과 좋은 저비용 개입

같은 순서를 매일 20~30분간 반복합니다.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 목욕 → 로션·마사지 → 잠옷 → 책 1~2권 → 자장가 → 불 끄기 → 눕히기 |
|----------------------------------------------|

무작위 연구에서 일관된 취침 루틴만으로도 잠들기까지 시간과 야간 각성이 감소했습니다. **보통**

#### 원칙

- 순서가 매일 같아야 합니다. 내용보다 순서가 중요합니다
- 점점 조용해지는 방향으로 (활동적인 놀이 → 조용한 활동)
- 잠들기 1시간 전 화면 금지
- 방은 어둡고 서늘하게

### 3. 수면 퇴행 시기별 지도

잘 자던 아이가 갑자기 자주 깨는 시기들입니다. **고장이 아니라 발달입니다.**

| 시기     | 원인                           | 대응                                         |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 4개월    | 수면 구조가 성인형으로 재편. 얇은 잠 구간에서 깬 | 취침 루틴 강화. 이 시기가 지나면 대개 안정                  |
| 8~10개월 | 기기·서기 등 대운동 급성장 + 분리불안       | 낮에 새 동작을 충분히 연습시키기. 밤에 서서 울면 앉는 법을 낮에 가르치기 |
| 12개월   | 걷기, 낮잠 전환                    | 취침 시간 앞당기기                                 |
| 18개월   | 분리불안 재발, 자율성 폭발              | 선택지 주기("어떤 잠옷 입을래") · 일과 유지                |
| 2세     | 상상력 발달로 인한 두려움, 침대 전환        | 수면등, 애착 인형 · 통제감 주기                        |

공통 대응: 일과를 바꾸지 않고 버티는 것입니다. 퇴행 때 새로운 습관(안아 재우기 등)을 만들면 그게 남습니다.

### 4. 수면 교육 — 할 것인가

#### 결론만 말하면

- 대부분의 수면 교육법은 **생후 4~6개월 이후**를 대상으로 합니다
- 여러 무작위 연구에서 **부모의 수면과 우울 점수 개선**이 보고되었습니다 **보통**
- 추적 연구에서 **장기적 애착 손상이나 정서 문제의 증거는 확인되지 않았습니다**
- 그러나 **하지 않아도 됩니다.** 아이는 결국 잡니다

**이것은 의학적 필수가 아니라 가족의 선택입니다.** 부모가 한계에 다다랐다면 하는 것이 낫고, 견딜 만하다면 안 해도 됩니다. 어느 쪽도 아이를 망치지 않습니다.

#### 전제 조건 (어떤 방법이든)

- ☐ 생후 4~6개월 이상
- ☐ 안전한 잠자리 (8장)
- ☐ 낮 동안 충분한 수유·식사
- ☐ 일관된 취침 루틴이 이미 있음
- ☐ 아프거나 큰 변화(이사·등원 시작) 중이 아님
- ☐ 부모 두 사람이 방식에 합의했음 ← 중간에 흔들리면 아이가 가장 힘듭니다

## 대표적 접근

| 방법                 | 방식                                | 특징                 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 취침 루틴 강화만          | 일과만 고정                            | 가장 부담 없음. 우선 시도할 것 |
| 점진적 소거 (Ferber)    | 정해진 간격으로 들여다보기 (3분 → 5분 → 10분...) | 근거 축적이 가장 많음       |
| 의자 기법              | 방 안에서 며칠에 걸쳐 점점 멀어짐               | 부드럽지만 오래 걸림        |
| 부모 동석(camping out) | 곁에 있되 개입을 줄임                      | 울림을 최소화하고 싶을 때     |

## 실행 요령

- 3~7일 정도는 일관되게 해야 판단이 됩니다. 이틀 하고 그만두면 아이만 혼란스럽습니다
- 아프면 중단하고 회복 후 다시 시작
- 밤중 수유가 필요한 시기라면 수유는 유지하고 재우는 방식만 바꿀 수도 있습니다

## 5. 밤에 깼을 때

- ① 잠깐 기다린다      아기는 잠결에 소리를 내다 다시 잠들기도 합니다
- ② 확인한다      기저귀 · 배고픔 · 열 · 옷이 불편한지
- ③ 최소한으로 개입      불을 켜지 않고, 말을 걸지 않고, 조용히
- ④ 잠자리에서 재운다      가능하면 안아서 재우지 않고 눕힌 채로 다독임

야간에는 자극을 최소화하는 것이 원칙입니다. 눈맞춤과 대화가 늘어날수록 각성이 길어집니다.

## 6. 야경증과 악몽 — 다릅니다

|    | 야경증(수면 경악)                            | 악몽                    |
|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 시간 | 잠든 뒤 1~3시간 (전반부)                      | 새벽 (후반부)              |
| 모습 | 비명, 눈을 뜨지만 <b>알아보지 못함</b> , 진정이 안 됨   | 깨어나서 울며 <b>부모를 찾음</b> |
| 기억 | <b>다음 날 기억하지 못함</b>                   | 기억하고 이야기함             |
| 대응 | <b>깨우지 않는다</b> . 다치지 않게 지켜보고 기다린다     | 안심시키고 위로한다            |
| 예방 | <b>충분한 수면</b> (과피로가 주요 유발 요인), 규칙적 일과 | 잠들기 전 무서운 내용 피하기      |

야경증은 대개 성장하면서 사라집니다. 매일 비슷한 시각에 발생한다면, 그 시각보다 15~30분 전에 살짝 깨웠다가 다시 재우는 방법이 도움이 되기도 합니다.

## 7. 침대 전환

- 아기침대 난간을 넘기 시작하면 그때가 신호입니다. 나이가 아니라 행동이 기준입니다
- 대개 만 2~3세
- 동생 출생과 겹치지 않게 최소 몇 주 전이나 후에 하세요
- 침대에서 떨어질 수 있으므로 바닥에 매트, 방 전체를 안전하게

## 8. 이 시기 부모가 흔히 묻는 것

Q. 안아서 재우면 버릇 되나요? 0~6개월에는 "버릇" 개념이 성립하지 않습니다. 6개월 이후에는 **연관(sleep association)**이 생길 수 있어, 밤에 깰 때마다 같은 조건을 요구할 수 있습니다. 문제가 되면 그때 바꾸면 됩니다.

Q. 백색소음을 써도 되나요? 됩니다. 다만 **볼륨을 낮게, 아기와 거리를 두고**, 밤새 크게 틀어두지 마세요.

Q. 통잠은 언제 자나요? "통잠"의 정의부터 다릅니다(보통 5~6시간 연속). 3~6개월 이후 점진적으로 나타나지만 개인차가 매우 큼니다. 돌 이후에도 자주 깨는 아이가 드물지 않습니다.

Q. 낮잠을 줄이면 밤에 잘 자나요? 대개 반대입니다. **과피로는 수면을 악화시킵니다.**

Q. 같은 방에서 자면 독립성이 떨어지나요? 근거가 없습니다. 오히려 **최소 6개월(가능하면 12개월) 같은 방, 다른 잠자리가** 영아 돌연사 위험을 낮춥니다. **강함**

## 진료가 필요한 수면 문제

- 코를 심하게 골거나 자다가 숨이 멎는 듯한 순간이 있음 → 폐쇄성 수면무호흡 감별
- 입을 벌리고 자며 낮에도 심하게 졸림
- 자다가 반복적으로 다리를 심하게 움직임
- 수면 부족이 낮 활동과 성장에 뚜렷한 영향을 줄 때
- 부모가 만성 수면 부족으로 **일상 기능이 무너질 때** ← 이것도 진료 사유입니다

### 이 장의 요약 3줄

1. 깨어 있는 시간(wake window)을 넘기면 과피로로 오히려 못 잔다.
2. 수면 퇴행은 **고장이 아니라 발달**이다. 일과를 바꾸지 말고 버텨라.
3. 수면 교육은 **의학적 필수**가 아니라 **가족의 선택**이다. 하든 안 하든 아이를 망치지 않는다.

→ 다음: 20장 · 열

# 20장 · 열

## 판단과 대응

### 장면

새벽 두 시. 아이 이마가 뜨겁습니다. 체온계를 대니 39.2℃. 손이 떨립니다.  
숨을 한 번 고르셔도 됩니다. 대부분의 열은 응급이 아니예요. 그리고 지금 필요한 건 검색이 아니라 세 가지 질문입니다.

1. 아이가 몇 개월인가?  
2. 열 말고 다른 증상이 있는가?  
3. 열이 내렸을 때 아이가 노는가?

이 장은 그 세 질문에 답하는 법입니다.

### 가장 먼저 — 나이별 기준

| 나이        | 기준                | 행동                                                                                                                 | 근거        |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 생후 3개월 미만 | 38.0℃ 이상 (직장 체온)  |  <b>즉시 응급실.</b> 해열제를 먹이고 지켜보지 마세요 | <b>강함</b> |
| 3~6개월     | 38.5℃ 이상, 또는 처짐   | 당일 진료                                                                                                              | <b>보통</b> |
| 6개월 이상    | 열 수치보다 아이의 상태가 기준 | 아래 참조                                                                                                              | <b>보통</b> |
| 모든 나이     | 5일 이상 지속되는 발열     | 진료 (가와사키병 등 감별)                                                                                                    | <b>강함</b> |

### 왜 3개월 미만은 다른가

신생아는 면역이 미성숙해서 세균 감염이 빠르게 전신으로 퍼질 수 있고, 걸으로 드러나는 증상이 거의 없을 수 있습니다. 그래서 열 자체가 응급 신호입니다. "좀 지켜보자"가 통하지 않는 몇 안 되는 상황입니다.

### 6개월 이상에서 진짜 기준

열이 내렸을 때 아이가 노는가?

- 해열제를 먹고 열이 내렸을 때 평소처럼 놀고 마신다 → 대개 안심할 수 있습니다
- 열이 내려도 축 처지고 반응이 없다 → 열 수치와 무관하게 진료

열의 높이는 병의 심각도와 비례하지 않습니다. 40℃의 단순 바이러스 감염이 38℃의 세균성 수막염보다 훨씬 흔하고 덜 위험합니다.

### 체온 재는 법

| 방법      | 대상             | 특징                            |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 직장(항문)  | 3개월 미만은 이것이 기준 | 가장 정확. 부드러운 팁, 윤활제, 1.5cm 정도만 |
| 겨드랑이    | 선별용            | 실제보다 낮게 나옴. 높게 나오면 재확인        |
| 고막(귀)   | 6개월 이상         | 귀지·각도에 따라 오차                  |
| 비접촉(이마) | 선별용            | 편하지만 오차가 큼. 결정적 판단에는 쓰지 마세요   |

집에 직장·구강 검용 체온계 하나는 반드시 두세요. 3개월 미만 시기에 필요합니다.

## 해열제

### 두 가지뿐입니다

| 약       | 사용 가능 나이            | 간격       |
|---------|---------------------|----------|
| 아세트아미노펜 | 생후 2~3개월 이후 (의사 확인) | 보통 4~6시간 |
| 이부프로펜   | 생후 6개월 이후           | 보통 6~8시간 |

- 아스피린은 절대 금지 — 라이 증후군 위험
- 용량은 나이가 아니라 체중 기준입니다

### ★ 우리 아이 용량 적어두기

지금 비워두고, 다음 진료 때 의사에게 물어서 채우세요. 새벽에 계산하지 않도록.

아이 이름: \_\_\_\_\_ 체중: \_\_\_\_\_ kg (기준일: \_\_\_\_/\_\_\_\_)

아세트아미노펜 제품명: \_\_\_\_\_ 1회 \_\_\_\_\_ mL 최소 간격 \_\_\_\_\_ 시간

이부프로펜 제품명: \_\_\_\_\_ 1회 \_\_\_\_\_ mL 최소 간격 \_\_\_\_\_ 시간

하루 최대 횟수: \_\_\_\_\_

※ 체중이 바뀌면 다시 확인할 것

### 결론만 말하면 — 교차복용

두 약을 번갈아 먹이는 방식은 일부에서 쓰이지만, 기본 권장 방식이 아닙니다.

- 열을 조금 더 낮추는 효과는 있을 수 있으나 **질병 경과를 바꾸지는 않습니다** 보통
- **용량·시간 착오로 인한 과다 투여 위험**이 실제로 보고됩니다 보통
- 애초에 해열제의 목적은 열 수치를 정상으로 만드는 것이 아니라 아이를 편하게 하는 것입니다 강함

→ 한 가지 약으로 시작하고, 교차복용은 의사 지시가 있을 때만. 먹인 약과 시각을 반드시 메모하세요.

### 해열제에 대한 오해 정리

| 오해                    | 사실                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| "열이 36~37℃까지 떨어져야 한다" | 1~1.5℃만 내려도 성공입니다. 아이가 편해지면 된 겁니다          |
| "열이 높으면 뇌가 손상된다"      | 감염으로 인한 발열 자체가 뇌를 손상시키지는 않습니다              |
| "해열제를 먹었는데 안 떨어진다"    | 30~60분 기다리세요. 그래도 아이가 처지면 진료               |
| "미온수 마사지를 해야 한다"      | 보조 수단입니다. <b>찬물·알코올은 금지</b> (오한으로 열이 오릅니다) |
| "옷을 두껍게 입혀 땀을 내야 한다"  | 반대입니다. <b>얇게 입히고 시원하게</b>                  |
| "열이 나면 굶겨야 한다"        | 아닙니다. <b>수분 섭취가 가장 중요합니다</b>               |

### 집에서 할 것

- **수분** — 조금씩 자주. 모유·분유·물·경구수액제
- 얇은 옷, 시원한 실내
- 편한 자세로 쉬게 하기

- 먹인 약과 시각을 메모 (병원에서 반드시 물어봅니다)

## 열성경련

### 알아둘 것

- 생후 6개월~5세에 발생하며, 이 연령대에서 드물지 않습니다 **강함**
- 대부분 양성(단순 열성경련)이며 뇌 손상이나 간질로 이어지지 않습니다 **강함**
- 해열제를 부지런히 먹여도 열성경련을 예방할 수는 없습니다 **강함** — 그러니 경련이 왔다면 당신 탓이 아닙니다
- 그러나 처음 겪는 부모에게는 인생에서 가장 무서운 몇 분입니다

### 대응 5단계

- ① 옆으로 눕힌다 토사물이 기도로 넘어가지 않게
- ② 시간을 잰다 몇 분 지속되는지가 가장 중요한 정보
- ③ 입에 아무것도 넣지 않는다 손가락·수건·약 전부 금지
- ④ 붙잡아 멈추려 하지 않는다 주변 위험한 물건만 치운다
- ⑤ 5분 이상 지속되면 즉시 119

### 반드시 119 / 응급실

- 경련이 5분 이상 지속
- 하루에 두 번 이상 반복
- 경련 후 의식이 잘 돌아오지 않음
- 생후 6개월 미만 또는 만 5세 이후 첫 발생
- 경련 후 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐
- 목이 뻣뻣하거나 발진 동반 → 수막염 감별

### 첫 경련이라면

멈췄더라도 그날 안에 진료를 받으세요. 원인 확인이 필요합니다.

해열제로 열성경련을 예방할 수는 없습니다. 해열제를 부지런히 먹여도 경련이 올 수 있고, 이는 부모의 잘못이 아닙니다.

### 발열 시 즉시 응급실

| 증상                                   | 의심                   |
|--------------------------------------|----------------------|
| 3개월 미만 + 38.0℃ 이상                    | 신생아 중증 감염            |
| 누르면 사라지지 않는 붉은·보라색 반점 (유리컵으로 눌러 확인)  | 수막알균 감염              |
| 목이 뻣뻣하고 빛을 심하게 싫어함                   | 수막염                  |
| 촉 늘어지고 깨워도 반응이 약함                    | 중증 감염                |
| 호흡 곤란 — 함몰호흡, 신음, 청색증                | 호흡부전                 |
| 경련 5분 이상 또는 반복                       | 상기 참조                |
| 심한 탈수 — 8~12시간 소변 없음, 눈물 없이 울        | 탈수                   |
| 5일 이상 지속되는 발열 + 눈 충혈·입술 갈라짐·발진·손발 부종 | 가와사키병 — 조기 치료가 중요합니다 |



## 🕒 새벽에 열이 날 때 — 순서

1. 나이 확인  
→ 3개월 미만 + 38℃ 이상? → 즉시 응급실. 여기서 멈춤.
2. 위 '즉시 응급실' 목록 확인  
→ 하나라도 해당? → 응급실
3. 해당 없음  
→ 해열제 (체중 용량대로) + 수분 + 얇은 옷  
→ 30~60분 뒤 아이 상태 확인
4. 열이 내렸을 때 노는가?  
→ 논다 → 아침에 소아과  
→ 처진다 → 야간 진료 또는 응급실 (35장)
5. 메모: 체온 / 시각 / 먹인 약과 용량 / 동반 증상

야간·휴일 경증이라면 응급실 대신 달빛어린이병원을 확인하세요 → 35장

👉 **지금 해보기** 지금 냉장고에 붙이세요. **아이 체중 / 해열제 용량 / 소아과 전화 / 야간 진료 병원 / 119·1339.** (부록 E에 양식이 있습니다) 새벽 두 시에 이걸 찾으러 다니지 않도록.

### 📌 이 장의 요약 3줄

1. 3개월 미만 38℃는 무조건 응급실. 그 외에는 열 수치보다 열 내렸을 때 노는가가 기준이다.
2. 해열제는 체중 기준, 목적은 정상 체온이 아니라 아이를 편하게 하는 것이다.
3. 열성경련은 옆으로 눕히고, 시간을 재고, 입에 아무것도 넣지 않는다. 5분 넘으면 119.

→ 다음: 21장 · 흔한 병 12가지

## 21장 · 흔한 병 12가지

반 페이지씩, 같은 형식으로

각 병은 다섯 칸 고정 형식입니다. **어떻게 보이나** · **집에서 할 것** · **병원 갈 신호** · **얼마나 가나** · **웁기나** · **등원**

이 장은 진단서가 아닙니다. "집에서 볼 것인가, 병원에 갈 것인가"의 분기점만 제공합니다.

### 1. 감기 (상기도감염)

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나                                                                                   | 콧물(맑음→누렇게 변할 수 있음), 재채기, 기침, 미열. 대개 3~4일째가 가장 심합니다                                   |
| 집에서 할 것                                                                                   | 수분 · 습도 유지 · 생리식염수 점비 후 코 흡입 · 상체를 약간 높여 재우기 · 필요 시 해열제                              |
|  병원 갈 신호 | 3개월 미만의 발열 · 호흡 곤란(함물호흡) · 5일 이상 지속되는 발열 · 수분 섭취 거부 · 축 처짐 · 열이 내렸다가 다시 오름(2차 감염 가능) |
| 얼마나 가나                                                                                    | 7~10일. 기침은 2~3주까지 갈 수 있습니다                                                           |
| 웁기나·등원                                                                                    | 웁습니다. 발열이 없고 활동이 가능하면 대개 등원 가능(기관 규정 확인)                                             |

꼭 알아둘 것

- 연간 6~8회 감기는 정상입니다. 어린이집에 다니면 더 많습니다 **강함**
- 콧물이 누렇다고 항생제가 필요한 것은 아닙니다. 바이러스 감염 경과에서 흔히 나타납니다 **강함**
- 만 2세 미만에게 중합감기약·기침약은 권장되지 않습니다. 효과 근거가 약하고 부작용 위험이 있습니다 **강함**
- 꿀은 만 1세 이후 기침 완화에 도움이 될 수 있습니다 **보통**
- 코 흡입·가습·수분은 근거가 강하진 않지만 널리 쓰이고 해가 없습니다 **관행**

### 2. 중이염

|                                                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나                                                                                     | 감기 며칠 뒤 <b>밤에 심하게 보챔</b> · 귀를 잡아당기거나 문지름 · 발열 · 누우면 악화 · 귀에서 진물 |
| 집에서 할 것                                                                                     | 통증 조절(해열진통제) · 상체를 높여 재우기 · <b>확인</b> 은 병원에서 (집에서 판단 불가)        |
|  병원 갈 신호 | 위 증상이 의심되면 <b>진료를 받으세요</b> · 귀 뒤가 붓고 붉음 · 고열 지속 · 6개월 미만        |
| 얼마나 가나                                                                                      | 통증은 대개 2~3일. 중이 삼출액은 몇 주 남을 수 있습니다                              |
| 웁기나·등원                                                                                      | 중이염 자체는 웁지 않습니다. 원인 감기가 웁습니다                                    |

꼭 알아둘 것

- 젖병을 물고 눕히지 않습니다. 중이염 위험을 높입니다
- 모든 중이염에 항생제가 필요한 것은 아니며, 나이·중증도에 따라 **경과 관찰**을 선택하기도 합니다
- 반복되면 청력과 언어 발달에 영향을 줄 수 있으므로 추적이 필요합니다

### 3. 모세기관지염 (RSV 등)

|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나                                                                                   | 콧물로 시작 → 2~3일 뒤 <b>쌉쌉거림·빠른 호흡·기침</b> · 수유량 감소.<br>주로 2세 미만                                |
| 집에서 할 것                                                                                   | <b>수분과 수유량 확인</b> · 코 흡입(수유 전에) · 소량씩 자주 먹이기 · 습도                                         |
|  병원 갈 신호 | <b>갈비뼈 사이·목 아래 함몰호흡</b> · 코 벌렁임 · 신음소리 · <b>입술·손톱 청색증</b> · 수유량이 평소의 절반 이하 · 무호흡 · 3개월 미만 |
| 얼마나 가나                                                                                    | 3~5일째가 가장 심하고, 기침은 2~3주                                                                   |
| 웁기나·등원                                                                                    | 잘 웁습니다. 손 위생이 중요합니다                                                                       |

#### 꼭 알아둘 것

- 영아에서 입원이 필요할 수 있는 대표 질환입니다. 어린 영아일수록 주의
- 판단의 핵심은 기침 소리가 아니라 ① **호흡 노력** ② **먹는 양** 두 가지입니다

### 4. 크루프 (후두염)

|                                                                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나                                                                                     | 경경 짓는 듯한 기침 · 쉼 목소리 · <b>밤에 갑자기 악화</b> · 숨 들이실 때 "깹" 하는 소리(협착음)           |
| 집에서 할 것                                                                                     | <b>부모가 침착할 것</b> (울면 더 나빠집니다) · 아이를 세워 안고 <b>찬 밤공기</b> 또는 서늘한 공기를 쐬기 · 수분 |
|  병원 갈 신호 | <b>가만히 있을 때도 협착음</b> · 함몰호흡 · 침을 흘리며 삼키지 못함 · 청색증 · 심하게 처짐 → <b>즉시</b>    |
| 얼마나 가나                                                                                      | 3~5일, 보통 밤에 2~3일간 심합니다                                                    |
| 웁기나·등원                                                                                      | 바이러스성이라 웁습니다                                                              |

#### 꼭 알아둘 것

- 밤에 급격히 나빠졌다가 아침엔 멀쩡해 보이는 것이 특징입니다. **그날 밤 다시 심해질 수 있습니다**
- 침을 흘리며 목을 앞으로 빼고 앉아 있으면 **후두개염** 감별이 필요합니다 — 즉시 응급실

### 5. 수족구병

|                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나                                                                                     | 발열 후 <b>입안 궤양</b> · 손·발·엉덩이의 물집성 발진 · <b>아파서 못 먹는</b> 것이 진짜 문제              |
| 집에서 할 것                                                                                     | <b>차갑고 부드러운 음식</b> (아이스크림, 요구르트, 미음) · 신 것·짠 것 피하기 · 통증 조절 · <b>수분 최우선</b>  |
|  병원 갈 신호 | <b>탈수 신호</b> (8~12시간 소변 없음, 눈물 없이 웁, 입안 건조) · 고열 지속 · 심한 처짐 · 목 뻣뻣함 · 걷지 못함 |
| 얼마나 가나                                                                                      | 7~10일. 몇 주 뒤 손발톱이 벗겨질 수 있는데 정상입니다                                           |
| 웁기나·등원                                                                                      | 잘 웁습니다. <b>발열이 없고 입안 궤양이 아물어 잘 먹을 수 있을 때까지</b> 가정 보육 (기관 규정 확인)             |

#### 꼭 알아둘 것

- 이 병의 위험은 발진이 아니라 **탈수**입니다. 먹는 양과 소변량만 보세요

## 6. 장염 (로타·노로 등)

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 구토로 시작해 설사로 이어지는 경우가 많음 · 발열 · 복통                                                      |
| 집에서 할 것   | 경구수액제(ORS)를 조금씩 자주 — 5~10분마다 한 술갈부터 · 모유수유는 계속 · 회복되면 평소 식사로 빨리 복귀                     |
| 🚩 병원 갈 신호 | 초록색(담즙성) 구토 · 혈변 또는 젤리 같은 점액혈변 · 탈수 신호 · 8~12시간 소변 없음 · 심한 복통으로 몸을 웅크림 · 6개월 미만 · 축 처짐 |
| 얼마나 가나    | 구토 1~2일, 설사 5~7일                                                                       |
| 웁기나·등원    | 매우 잘 웁습니다. 구토·설사가 멈추고 24~48시간 뒤 등원 (기관 규정 확인)                                          |

### 꼭 알아둘 것

- 이온음료·주스로 대체하지 마세요. 당 농도가 높아 설사를 악화시킬 수 있습니다. 약국의 경구수액제(ORS)를 쓰세요 **강함**
- 지사제를 임의로 쓰지 않습니다 **강함**
- 회복되면 평소 식사로 빨리 복귀하는 편이 낫습니다. 오래 굶기지 마세요 **강함**
- 한 번에 많이 주면 다시 토합니다. 소량씩 자주가 원칙입니다 **보통**
- 젤리 같은 점액혈변 + 발작적 복통 → 장중첩증 감별. 즉시 응급실 **강함**

탈수 5징후: 소변 감소 · 눈물 없이 웁 · 입안 건조 · 축 처짐 · 대천문 함몰

## 7. 인후염

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 목 통증 · 발열 · 삼키기 힘들어함. 바이러스성은 콧물·기침 동반, 세균성(A군 연쇄상구균)은 콧물·기침 없이 고열과 목 통증         |
| 집에서 할 것   | 차갑고 부드러운 음식 · 수분 · 통증 조절                                                        |
| 🚩 병원 갈 신호 | 콧물·기침 없이 고열 + 심한 목 통증 → 검사 필요 · 침을 흘리며 삼키지 못함 · 목소리가 이상함 · 호흡 곤란 · 목이 한쪽만 크게 부음 |
| 얼마나 가나    | 바이러스성 3~5일. 세균성은 항생제 시작 후 빠르게 호전                                                |
| 웁기나·등원    | 웁습니다. 세균성은 항생제 시작 후 24시간이 지나야 등원                                                |

### 꼭 알아둘 것

- 세균성은 검사로 구분하며, 진단되면 항생제를 끝까지 복용해야 합니다(합병증 예방)
- 3세 미만에서는 세균성 인후염이 상대적으로 드뭅니다

## 8. 결막염

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 눈 충혈 · 눈곱 · 눈물 · 가려움. 세균성은 노란 화농성 눈곱, 바이러스성은 맑은 분비물, 알레르기성은 가려움과 양쪽 발생 |
| 집에서 할 것   | 깨끗한 손으로 생리식염수·미지근한 물로 닦기 · 수건 따로 쓰기 · 손 위생 철저                          |
| 🚩 병원 갈 신호 | 눈 주변이 붓고 붉게 번짐 · 통증 · 시야 이상 · 빛을 심하게 싫어함 · 신생아의 눈곱(별도 감별 필요)           |
| 얼마나 가나    | 바이러스성 1~2주, 세균성은 치료 시작 후 며칠                                            |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 웁기나·등원 | 바이러스성은 매우 잘 웁습니다. 기관 규정에 따라 등원 제한 |
|--------|-----------------------------------|

#### 꼭 알아둘 것

- 신생아·영아의 지속적 눈물과 눈곱은 눈물길 막힘(비루관 폐쇄)일 수 있습니다. 흔하며 대개 저절로 좋아지지만 진료로 확인하세요
- 눈 주변이 붓고 붉어지면 안와주위 봉와직염 감별이 필요합니다 — 즉시 진료

## 9. 요로감염 ★ 놓치기 쉬움

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 영유아에서는 "설명되지 않는 발열"이 유일한 증상일 수 있습니다. 그 외 보챌, 소변 볼 때 울기, 약취 나는 소변, 갑작스러운 야뇨 재발, 구토·식욕 저하 |
| 집에서 할 것   | 집에서 진단할 수 없습니다. 의심되면 진료 — 소변검사가 필요합니다                                                   |
| 🚩 병원 갈 신호 | 다른 증상 없이 발열이 지속될 때 · 소변 볼 때 아파할 때 · 배변 훈련이 끝난 아이의 갑작스러운 실수 · 옆구리 통증                     |
| 얼마나 가나    | 항생제 시작 후 대개 24~48시간 내 호전                                                                |
| 웁기나·등원    | 웁지 않습니다                                                                                 |

#### 꼭 알아둘 것

- 여아에서 더 흔합니다. 요도가 짧아 세균이 방광에 도달하기 쉽습니다 **강함**
- 영유아 발열의 원인 중 놓치기 쉬운 대표 질환입니다. 다른 증상이 없다고 안심하지 마세요 **강함**
- 예방: 변비 관리(변비가 요로감염 위험을 높입니다) **보통** · 앞에서 뒤로 닦기 · 소변 참지 않기 · 충분한 수분 · 거품 목욕과 꽉 끼는 옷 피하기 **관행**
- 반복되면 신장 손상 위험이 있어 영상검사 등 추가 평가를 합니다. 반복 여부를 반드시 의사에게 알려주세요 **강함**

## 10. 구내염 (헤르페스성 치은구내염 등)

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 고열 · 입안과 잇몸의 궤양 · 침 많이 흘림 · 입 냄새 · 아파서 못 먹고 못 마심                    |
| 집에서 할 것   | 차갑고 부드러운 것 — 아이스크림, 차가운 요구르트, 미음 · 빨대 사용 · 신 것·짠 것·뜨거운 것 금지 · 통증 조절 |
| 🚩 병원 갈 신호 | 탈수 · 8~12시간 소변 없음 · 완전한 수분 거부 · 고열 지속 · 심한 처짐                       |
| 얼마나 가나    | 7~14일                                                               |
| 웁기나·등원    | 웁습니다. 침 접촉 주의                                                       |

#### 꼭 알아둘 것

- 이 병의 관리 목표는 오직 하나, 수분 유지입니다
- 첫 감염 시 증상이 가장 심하고, 이후에는 훨씬 가볍습니다

## 11. 변비

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 딱딱하고 굵은 변 · 배변 시 통증과 울음 · 다리를 꼬거나 까치발로 참는 자세 · 소량의 변이 새어 나옴(유분증)                                 |
| 집에서 할 것   | 수분 늘리기 · 배·자두·완두콩 등 · 전곡류 · 우유 과다 섭취 줄이기 (하루 500ml 이내) · 활동량 늘리기 · 배변 시간을 규칙적으로(식후 5~10분 변기에 앉기) |
| 🚩 병원 갈 신호 | 배변 시 출혈 · 심한 복통 · 체중 감소 · 구토 동반 · 신생아기부터의 변비 · 약을 써도 호전 없음                                       |
| 얼마나 가나    | 원인 제거 시 며칠~몇 주. 악순환이 생기면 오래 갑니다                                                                  |
| 웁기나·등원    | 해당 없음                                                                                            |

### 꼭 알아둘 것

- 이유식 전환기와 배변 훈련기에 호발합니다
- 핵심은 악순환입니다: 아파서 참음 → 변이 더 딱딱해짐 → 더 아픔 → 더 참음. 일찍 개입해야 합니다
- 관장을 습관적으로 쓰지 않습니다. 필요하다면 의사와 상의해 약물로 관리합니다
- 배변 훈련 중이라면 혼내지 마세요. 참는 행동을 강화합니다

## 12. 아구창 · 기저귀 칸디다

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어떻게 보이나   | 아구창: 입안·혀에 닳아도 잘 지워지지 않는 흰 막(우유 찌꺼기는 잘 닳임) · 수유 시 보챔<br>기저귀 칸디다: 딸기처럼 선명하게 붉고, 주변에 작은 위성 발진 · 접히는 부위까지 침범 |
| 집에서 할 것   | 절병·쪽쪽이 소독 · 기저귀 자주 갈고 통풍 · 물티슈 대신 물로 씻고 완전히 건조                                                            |
| 🚩 병원 갈 신호 | 진단과 치료는 병원에서 — 항진균제가 필요합니다 · 수유 거부 · 잘 낫지 않는 기저귀 발진                                                       |
| 얼마나 가나    | 치료 시작 후 1~2주                                                                                              |
| 웁기나·등원    | 모유수유 중이면 엄마 유두와 아기 입 사이를 오갈 수 있어 함께 치료해야 합니다                                                              |

### 꼭 알아둘 것

- 일반 기저귀 발진(자극성 피부염)과 다릅니다. 일반 발진은 접히는 부위가 비교적 깨끗하고, 칸디다는 접히는 부위까지 붉습니다
- 항생제 복용 후에 잘 생깁니다

## 오려 쓰는 한 장 ⑤ — "병원에 가야 하나?"

### 즉시 응급실

- 3개월 미만 + 38℃ 이상
- 함몰호흡 · 신음 · 입술이 파래짐
- 경련 5분 이상 · 깨워도 반응 약함
- 눌러도 안 사라지는 붉은 반점
- 초록색 구토 · 혈변 · 젤리 같은 점액혈변
- 버튼전지 · 자석 삼킴

### 당일 진료

- 8~12시간 소변 없음 (탈수)
- 5일 이상 지속되는 발열
- 다른 증상 없는 발열 (요로감염?)
- 귀를 잡아당기며 밤에 심하게 보챔

### 집에서 보되 관찰

- 열이 내렸을 때 잘 논다
- 잘 먹고 소변이 나온다

판단이 안 서면 → 1339 (24시간 상담)

### 이 장의 요약 3줄

1. 판단의 축은 병명이 아니라 ① 호흡 ② 먹는 양·소변량 ③ 열 내렸을 때의 상태 세 가지다.
2. 장염은 경구수액제(ORS)로, 이온음료로 대체하지 않는다.
3. 다른 증상 없는 발열은 요로감염을 의심한다. 특히 여아에서.

→ 다음: 22장 · 응급처치 실전

# 22장 · 응급처치 실전

**⚠ 이 장은 실습 교육을 대체하지 않습니다. 심폐소생술과 기도폐쇄 처치는 몸으로 배워야 합니다. 이 장은 배운 것을 급할 때 떠올리기 위한 기억용입니다.**

대한적십자사 · 소방서 · 보건소에서 무료 또는 저가로 영유아 심폐소생술 교육을 운영합니다. 배우자와 함께, 그리고 아이를 돌볼 조부모·도우미도 함께 받으세요.

## 0. 모든 응급의 첫 3초

- 1. 주변 안전 확인
- 2. 아이 반응 확인 (이름 부르기, 발바닥 자극 - 흔들지 않는다)
- 3. 도움 요청 119 / 주변 사람 지목 ("파란 옷 입으신 분, 119 불러주세요")

혼자라면 스피커폰으로 119를 연결하고 지시를 받으며 처치하세요.

## 1. 기도폐쇄 (음식·이물)

먼저 판단 — 개입할 것인가

| 상태                          | 판단     | 행동                                                    | 근거 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----|
| 기침하거나 소리를 낸다                | 불완전 폐쇄 | 개입하지 않습니다. 기침을 유도하고 지켜봅니다. 손가락을 넣으면 더 깊이 밀어 넣을 수 있습니다 | 강함 |
| 소리를 못 내고, 얼굴이 파래지고, 목을 움켜쥔다 | 완전 폐쇄  | 즉시 처치                                                 | 강함 |

만 1세 미만 — 등 두드리기 ↔ 가슴 압박

- ① 아이를 팔 위에 엎어 놓는다. 머리가 몸통보다 낮게, 턱을 받쳐 기도 확보
- ② 어깨뼈 사이를 손바닥 아래쪽으로 5회 강하게 두드린다
- ③ 뒤집어 눕히고, 젖꼭지 연결선 바로 아래 가슴 중앙을 손가락 두 개로 5회 압박 (약 4cm 깊이, 빠르게)
- ④ 이물이 나오거나 아이가 울 때까지 ②③ 반복
- ⑤ 의식을 잃으면 → 즉시 CPR + 119

만 1세 이상 — 복부 밀어내기(하임리히)

- ① 아이 뒤에 무릎을 꿇고 앉아 허리를 감싼다
- ② 주먹을 배꼽과 명치 사이에 대고, 다른 손으로 감싼다
- ③ 안쪽 위 방향으로 빠르게 밀어 올린다 (5회)
- ④ 이물이 나올 때까지 반복
- ⑤ 의식을 잃으면 → 즉시 CPR + 119

입안에 보이지 않는 이물을 손가락으로 훑지 마세요. 보이는 것만 꺼냅니다.



## 2. 심폐소생술 (CPR)

### 만 1세 미만 (영아)

- ① 반응 없음 확인 → 119 (스피커폰)
- ② 단단하고 평평한 곳에 눕힌다
- ③ 가슴 압박 30회
  - 위치: 젖꼭지 연결선 바로 아래 가슴 중앙
  - 방법: 손가락 두 개 (또는 두 엄지로 가슴을 감싸 안고)
  - 깊이: 가슴 두께의 약 1/3 (약 4cm)
  - 속도: 분당 100~120회 ("때는 늦으리" 리듬)
  - 압박 후 가슴이 완전히 올라오게 한다
- ④ 인공호흡 2회
  - 머리를 살짝만 젖힌다 (너무 젖히면 기도가 막힘)
  - 입과 코를 함께 덮고, 가슴이 살짝 올라올 정도만 불어넣는다
- ⑤ 30:2 반복. 구급대 도착 또는 아이가 반응할 때까지

### 만 1세 이상 (소아)

- 위치: 가슴 중앙 (젖꼭지 연결선)
- 방법: 한 손바닥 아래쪽 (큰 아이는 두 손)
- 깊이: 가슴 두께의 약 1/3 (약 5cm)
- 속도: 분당 100~120회
- 30:2 반복

인공호흡에 자신이 없다면 가슴 압박만이라도 계속하세요. 아무것도 하지 않는 것보다 훨씬 낫습니다.

## 3. 화상

- ① 즉시 흐르는 미지근한 물에 20분 - 가장 중요
- ② 옷은 억지로 떼지 않는다 (달라붙었으면 그대로 두고 병원)
- ③ 깨끗한 거즈나 랩으로 느슨하게 덮는다
- ④ 통증 조절 (해열진통제)

 **금지:** 얼음 · 된장 · 소주 · 치약 · 연고 · 물질 터뜨리기 **강함**

흐르는 물 20분은 화상 깊이를 실제로 줄입니다. **강함** 민간요법은 감염 위험을 높이고 이후 치료를 방해합니다.

### 병원에 가야 할 때

- 손·발·얼굴·회음부·관절 부위
- 물집이 생겼거나 면적이 아이 손바닥보다 넓을 때
- 화학물질·전기 화상
- 영유아의 화상은 대부분 진료를 받는 쪽이 안전합니다

## 4. 이물 삼킴

| 삼킨 것        | 행동                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버튼형 리튬 전지   |  <b>증상이 없어도 즉시 응급실.</b> 식도에 걸리면 2시간 내에도 화학 화상·천공이 생길 수 있습니다. 먹이거나 토하게 하지 마세요 |
| 자석 구슬 2개 이상 |  <b>즉시 응급실.</b> 장을 사이에 두고 붙어 천공                                              |
| 동전          | 진료. 삼킨 시각과 크기를 기록                                                                                                                                               |

| 삼킨 것                  | 행동                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 뽀족한 것 (바늘, 이쑤시개)      | 즉시 응급실                                                                                                                                     |
| 세제·약물                 |  즉시 응급실. <b>토하게 하지 마세요</b> (식도 재손상) · <b>제품 용기를 가져가세요</b> |
| 작고 매끄러운 것 (플라스틱 조각 등) | 증상 없으면 관찰 가능하나 <b>진료 권장</b>                                                                                                                |

**공통:** 무엇을, 언제, 얼마나 삼켰는지 **메모**하고 남은 제품을 가져가세요.

## 5. 머리 부딪힘

대부분은 **괜찮습니다**

울고 나서 평소처럼 놀면 대개 관찰 가능합니다. 혹은 냉찜질.

### 즉시 응급실

- **의식 소실** (아주 잠깐이라도)
- 반복적인 구토 (2회 이상)
- 깨워도 반응이 둔하거나 계속 자려고 함
- **경련**
- 한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나 걸음이 이상함
- 동공 크기가 다름, 시야 이상, 말이 어눌함
- 귀나 코에서 맑은 액체나 피가 나옴
- **생후 12개월 미만**의 머리 부딪힘 — 낮은 기준으로 진료
- 1m 이상 높이에서 떨어짐, 딱딱한 바닥

**관찰 기간:** 첫 24시간. 밤에 자더라도 **몇 시간 간격으로 반응을 확인**하세요(깨워서 반응하면 됩니다).

## 6. 아나필락시스 (심한 알레르기 반응)

**인지 — 두 개 이상의 신체 계통에 증상이 나타나면 의심**

| 계통 | 증상                           |
|----|------------------------------|
| 피부 | 전신 두드러기, 얼굴·입술·눈 부종          |
| 호흡 | 쌉쌉거림, 숨 가쁨, 목이 조이는 느낌, 쉼 목소리 |
| 소화 | 반복 구토, 심한 복통                 |
| 순환 | 창백, 축 처짐, 의식 저하              |

### 행동

- ① 즉시 119
- ② 자가주사기(에피네프린)가 있으면 즉시 사용 - 허벅지 바깥쪽
- ③ 눕히고 다리를 올린다 (숨이 차면 앉힌다. 갑자기 일으켜 세우지 않는다)
- ④ 토하면 옆으로 눕힌다
- ⑤ 좋아 보여도 반드시 병원으로 - 몇 시간 뒤 재발할 수 있습니다

**의심되면 기다리지 말고 주사합니다. 늦게 쓰는 것이 위험합니다.**

## 7. 그 밖의 흔한 상황

| 상황                      | 대응                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 코피                      | 앉아서 <b>고개를 앞으로 숙이고</b> 콧볼을 10분간 계속 눌러줍니다.<br><b>고개를 뒤로 젖히지 마세요</b> (피를 삼킵니다). 20분 넘게 멈추지 않으면 진료 |
| 베인 상처                   | 깨끗한 물로 씻고 압박 지혈. 깊거나 벌어지면 진료(봉합은 대개 몇 시간 이내)                                                    |
| 치아 외상                   | <b>유치는 다시 끼우지 않습니다</b> (영구치 손상 위험). 지혈 후 치과 진료.<br><b>영구치는</b> 우유나 생리식염수에 담가 즉시 치과로             |
| 손가락이 끼임                 | 냉찜질. 부종·변형·움직임 제한이 있으면 진료                                                                       |
| 팔을 갑자기 안 쓴다 (팔을 잡아당긴 뒤) | <b>팔꿈치 아탈구(주관절 아탈구)</b> 가능성. 억지로 움직이지 말고 진료<br>— 정복하면 즉시 좋아집니다                                  |
| 벌레 물림                   | 냉찜질, 긁지 않게. 전신 증상 있으면 아나필락시스 대응                                                                 |
| 눈에 이물·화학물질              | <b>흐르는 미지근한 물로 15~20분 세척</b> 후 즉시 진료                                                            |

## 오려 쓰는 한 장 ⑥ — 응급 대응

119 (응급)                      1339 (24시간 상담)

기도폐쇄

기침·소리 0 → 개입하지 않는다

소리 X, 파래짐 → 1세 미만: 등5회+가슴5회  
1세 이상: 하임리히

CPR    가슴 30 : 인공호흡 2

분당 100~120회, 가슴 두께의 1/3

화상    흐르는 물 20분. 얼음·연고·된장 금지

삼킴    버튼전지·자석 = 무증상이어도 즉시  
         토하게 하지 않는다

머리    의식소실·반복구토·경련 → 즉시

경련    옆으로 눕히고 · 시간 재고 ·  
         입에 아무것도 넣지 않는다 · 5분~119

아이 체중 \_\_\_\_kg    알레르기 \_\_\_\_\_

집 주소(구급대에게 불러줄): \_\_\_\_\_

 **지금 해보기 이번 달 안에 영유아 심폐소생술 교육을 예약하세요.** 관할 소방서나 보건소에 전화 한 통이면 됩니다. 이 장을 백 번 읽는 것보다 두 시간 실습이 낫습니다.

### 이 장의 요약 3줄

1. 기침하거나 소리를 내면 개입하지 않는다. 완전 폐쇄일 때만 처치한다.
2. 버튼형 전지와 자석 구슬은 증상이 없어도 즉시 응급실이다.
3. 이 장은 기억용이다. 실습 교육을 받아라. 배우자와 조부모도 함께.

→ 다음: 23장 · 피부·치아·약

## 23장 · 피부 · 치아 · 약 먹이기

### 피부

#### 아토피 피부염

##### 어떻게 보이나

- 영아기: **볼·이마·두피·팔다리 바깥쪽**에 붉고 진물 나는 발진
- 유아기 이후: **팔꿈치 안쪽, 무릎 뒤**의 건조하고 두꺼워진 피부
- 공통: **가려움**. 밤에 심하고, 긁어서 악화됩니다

##### 관리의 90%는 보습입니다

- ① 목욕: 하루 1회, 미지근한 물(37~38℃), 10분 이내
- ② 세정: 향료 없는 순한 제품을 최소한으로. 때수건 금지
- ③ 물기: 문지르지 말고 눌러서 톡톡
- ④ 보습: 물기가 남아 있는 3분 이내에 두껍게 ← 가장 중요
- ⑤ 횟수: 하루 2회 이상. 심하면 더 자주

**보습제는 아끼지 마세요.** 영유아는 주당 상당한 양을 쓰게 됩니다. 비싼 제품보다 **자주, 많이** 바르는 것이 중요합니다.

강함

목욕 후 3분 이내 보습이라는 "3분 규칙"의 정확한 시간 자체는 근거가 강하지 않습니다 **관행**. 중요한 건 **물기가 남아 있을 때 바르는 것**입니다.

#### ⚖️ 결론만 말하면 — 스테로이드 연고

스테로이드 공포로 치료를 미루는 것이 오히려 더 해롭습니다.

- 의사가 처방한 **적절한 강도의 국소 스테로이드**를 정해진 기간 동안 쓰는 것은 안전한 것으로 받아들여집니다 **강함**
- 반대로 **염증을 방치하면** 긁어서 감염이 생기고, 피부가 두꺼워지고, 수면과 성장에 영향을 줍니다 **보통**
- 두려운 것은 **강한 스테로이드를 오래, 넓게, 임의로** 쓰는 것입니다
- 처방받았다면 **제대로 쓰고, 좋아지면 의사 지시에 따라 줄이세요**. 겁이 나면 처방한 의사에게 직접 물어보세요

##### 악화 요인 줄이기

- 땀·과열 (실내 온도를 낮게)
- 건조한 공기 (가습)
- 거친 섬유(울) → **면 옷**
- 향료·세제 잔여물 → **헹굼 한 번 더**
- 손톱을 짧게, 밤에는 면장갑

#### 🚩 병원에 갈 때

- 진물이 노랗게 딱지 지고 냄새가 남 → **2차 세균 감염**
- 발열 동반
- 물집이 무리 지어 생김 → **헤르페스 감염** 가능, 즉시
- 보습과 처방 연고로 조절되지 않을 때

- 잠을 못 잘 정도의 가려움

**식품 알레르기와의 관계:** 중증 아토피 영아는 식품 알레르기 위험이 높으므로, 알레르기 유발 식품 도입 전에 소아과·알레르기 전문의와 상의하세요 (18장).

## 기저귀 발진

| 유형          | 모습                                  | 대처                                                             |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 자극성 (가장 흔함) | 볼록한 부위가 붉고, <b>접히는 부위는 비교적 깨끗</b>   | 자주 갈기 · 물로 씻고 <b>완전히 건조</b> · 산화아연 등 <b>배리어 크림</b> 두껍게 · 통풍 시간 |
| 칸디다         | 딸기처럼 선명하게 붉고 <b>위성 발진, 접히는 부위까지</b> | 항진균제 필요 → <b>진료</b>                                            |
| 세균 감염       | 노란 딱지, 물집, 고름                       | 진료                                                             |

**공통 원칙:** 물티슈보다 **물로 씻고 말리기** · 기저귀를 조이지 않기 · **하루 몇 번은 벗겨두기**

## 그 밖의 흔한 피부 문제

| 이름            | 모습                    | 대처                                        |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 신생아 여드름·태열    | 생후 2~4주경 얼굴의 붉은 좁쌀    | 대개 저절로 사라집니다. 짜거나 연고를 바르지 마세요             |
| 지루성 피부염(유아지루) | 두피의 노랑고 기름진 각질        | 오일로 불린 뒤 부드러운 빗으로. 대개 몇 개월 내 호전           |
| 땀띠            | 목·겨드랑이·기저귀 주변 좁쌀      | 시원하게, 통풍, 얇은 면 옷                          |
| 몽고반점          | 영덩이·등의 푸른 반점          | 정상. 대개 학령기까지 없어집니다                        |
| 혈관종           | 붉게 튀어나온 점, 생후 몇 주에 커짐 | 대부분 저절로 좋아지나 <b>눈·코·입 주변이나 빠르게 커지면 진료</b> |
| 두드러기          | 모기 물린 듯 부풀고 이동함       | 대개 며칠 내 소실. <b>호흡 곤란·얼굴 부종 동반 시 응급</b>    |

# 치아

## 시기별 할 일

| 시기                | 할 일                             |
|-------------------|---------------------------------|
| 첫니 전              | 수유 후 거즈로 잇몸 닦기 (선택)             |
| 첫니가 나면 즉시         | <b>하루 2회 칫솔 + 불소 치약 (쌀알 크기)</b> |
| 첫니 후 6개월 이내 또는 첫들 | <b>첫 치과 방문</b>                  |
| 만 3세~             | 불소 치약 <b>완두콩 크기</b>             |
| 치아가 서로 닿기 시작하면    | <b>치실 시작</b>                    |
| 이후                | 6개월마다 정기 검진                     |

## 젖병 우식 (유아기 우식증)

원인: 젖병이나 컵을 물고 자거나, 당분이 든 음료를 오래 물고 있는 것. **결과**: 위쪽 앞니부터 갈색으로 착습니다.

### 예방

- 젖병을 물고 재우지 않습니다 ← 이 하나가 가장 중요합니다 **강함**
- 첫니가 나면 즉시 **불소 치약**으로 하루 2회 **강함**
- 만 12~18개월까지 **젖병** → **컵 전환** 완료 **보통**
- 밤중 수유 후 가능하면 잇몸·치아를 닦기 **관행**
- 주스·단 음료를 물처럼 주지 않기 **강함**

"유치는 어차피 빠지니까 괜찮다"는 틀렸습니다. 유치 우식은 통증, 영구치 배열, 감염으로 이어집니다.

## 이얇이

- 차가운 치발기, 깨끗한 손가락으로 잇몸 문지르기
- **금지**: 벤조카인 등 마취 성분 젤(영유아 부작용 위험) · **호박 목걸이** 등 목에 거는 제품(질식·교살)
- 이얇이는 38℃ 이상의 발열, 설사, 발진의 원인이 아닙니다. 그런 증상이면 다른 원인을 찾으세요

## 치아 외상

| 상황          | 대응                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 유치가 빠짐      | 다시 끼우지 않습니다. 아래 영구치 싹을 손상시킬 수 있습니다. 지혈 후 치과 <b>강함</b> |
| 영구치가 빠짐     | 뿌리를 만지지 말고 우유나 생리식염수에 담가 즉시 치과로. 시간이 결정적입니다 <b>강함</b> |
| 이가 흔들림·금이 감 | 부드러운 음식, 빠른 시일 내 치과                                   |
| 잇몸·입술 출혈    | 거즈로 압박. 깊게 찢어졌으면 진료                                   |

## 약 먹이기

### 기본

- 용량은 나이가 아니라 체중 기준입니다
- 계량스푼·주사기형 계량기를 쓰세요. 밥숟가락은 부정확합니다
- 먹인 약과 시각을 반드시 메모하세요. 특히 두 사람이 번갈아 돌볼 때
- 아이 약을 다른 아이에게 쓰지 않습니다

### 거부할 때

| 방법         | 설명                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| 볼 안쪽으로 천천히 | 주사기형 계량기로 혀 위가 아니라 <b>볼 안쪽</b> 에 조금씩. 사례가 덜 걸립니다 |
| 차갑게        | 냉장 보관 가능한 약은 차가우면 맛이 덜 느껴집니다                     |
| 선택지 주기     | "컵으로 먹을래, 주사기로 먹을래?"                             |

| 방법         | 설명                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 소량의 음식에 섞기 | 약사·의사에게 가능 여부를 먼저 확인. 우유·분유 전체에 섞으면 다 못 먹었을 때 용량을 알 수 없습니다 |
| 먹인 직후 토했다면 | 다시 먹이기 전에 문의하세요. 임의로 재투여하면 과량이 될 수 있습니다                    |

## 항생제

- 처방된 기간을 끝까지 복용합니다. 증상이 좋아졌다고 중단하면 재발과 내성 위험이 있습니다
- 설사가 흔한 부작용입니다. 심하면 문의
- 감기·대부분의 인후염·기관지염은 바이러스이므로 항생제가 듣지 않습니다. 처방을 요구하지 마세요

## 보관과 안전

- 모든 약은 높고 잠긴 곳에. 어린이 보호 뚜껑도 완전하지 않습니다
- 유효기간 확인. 개봉 후 사용기한이 짧은 약(항생제 시럽 등) 주의
- 남은 약을 임의로 재사용하지 않습니다
- 방문한 병원마다 현재 복용 중인 약을 알려주세요

## 가정 구급함

- ☐ 체온계 — 직장·구강 겸용 1개 필수
- ☐ 아세트아미노펜 시럽
- ☐ (6개월 이후) 이부프로펜 시럽
- ☐ 체중별 용량 메모 (20장 양식)
- ☐ 경구수액제(ORS)
- ☐ 생리식염수, 코 흡입기
- ☐ 밴드, 소독약, 거즈, 화상 거즈
- ☐ 손톱가위, 핀셋
- ☐ 보습제, 처방받은 연고

### 이 장의 요약 3줄

1. 아토피 관리의 90%는 목욕 후 3분 이내 보습이다. 스테로이드 공포가 치료를 미루면 더 해롭다.
2. 첫니가 나면 즉시 불소 치약으로 닦고, 젖병을 물고 채우지 않는다.
3. 약은 체중 기준, 계량기 사용, 먹인 시각을 메모한다.

→ 다음: 5부 · 나를 지킨다



## 5부 · 나를 지킨다

---

이 부를 "여유가 생기면 챙길 것"으로 미루지 마세요.

부모의 정신건강은 감성적인 이야기가 아니라 **아이 발달의 직접적인 변수**입니다. 산모의 우울은 아이의 언어·인지·정서 발달 지연과 연관되고, **치료하면 아이의 결과도 함께 좋아진다는 것**이 확인되어 있어요. **강함**  
그러니까 당신을 돌보는 건 이기적인 일이 아니라, **아이에게 하는 가장 확실한 투자**입니다.

## 24장 · 산모의 몸 회복

### 아무도 자세히 말해주지 않는 것

출산 준비는 다들 열심히 하는데, **출산 이후 내 몸에 무슨 일이 일어나는지는** 의외로 잘 모른 채 맞이하게 됩니다. 그래서 겪으면서 "이게 정상인가?" 하고 혼자 검색하게 되죠.

미리 알아두시면 덜 놀라실 거예요.

| 항목           | 정상 경과                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 오로(산후 질 분비물) | 붉은색 → 갈색 → 노란빛으로 변하며 <b>4~6주</b> 지속                |
| 자궁 수축통(뱃배아픔) | 수유할 때 심해집니다. 며칠~1주                                 |
| 회음부 통증       | 열상·절개가 있었다면 2~3주. 냉찜질 → 좌욕                         |
| 제왕절개 상처      | 통증 2주 전후, 완전 회복 6주 이상. 무거운 것 들지 마세요                |
| 유방 울혈        | 성숙유가 돌 때(2~5일) 단단하고 아픕니다                           |
| 탈모           | 산후 3~6개월에 심해졌다가 회복돼요. <b>정상입니다</b> . 많이 놀라시는 부분이에요 |
| 땀·야간 발한      | 호르몬 변화 때문이에요. 몇 주                                  |

### 회복을 돕는 것들

몸이 예전 같지 않은 게 답답하실 거예요. 회복에는 시간이 걸리고, 그건 당신이 게을러서가 아닙니다.

- **골반저근 운동(케겔)**: 가능해지면 시작하세요. 요실금 예방과 회복에 도움이 됩니다 **보통**
- **운동 재개**: 걷기는 편해지면 곧, 본격적인 운동은 **산후 검진에서 확인 후**(대개 6주). 제왕절개는 더 늦게
- **변비 관리**: 수분·섬유질. 회음부가 아프면 힘주기가 무서워서 더 심해지기 쉬워요
- **수분과 식사**: 수유 중에는 열량과 수분이 더 필요합니다. **다이어트는 나중에 생각하세요**
- **산후 검진**: 대개 출산 4~6주. **꼭 받으세요**. 몸만 보는 게 아니라 우울 선별도 여기서 이뤄집니다

### 즉시 진료

이 목록은 단호하게 봐주세요.

- **38℃ 이상의 발열**
- 오로에서 **악취**가 나거나, 갑자기 양이 늘거나 큰 덩어리가 나옴
- **한 시간에 패드 하나를 적실 정도의 출혈**
- 회음부·제왕절개 상처의 발적·고름·벌어짐
- **한쪽 종아리의 통증과 부종** → 혈전 의심
- **심한 두통, 시야 흐림, 상복부 통증** → 산후 전자간증 가능. **출산 후에도 생길 수 있어요**
- 숨이 차고 가슴이 아픔
- 유방 통증 + 발열 → 유선염 (17장)

### 24장의 요약 3줄

1. 오로 4~6주, 산후 탈모 3~6개월 — **정상 경과를 미리 알면 덜 놀랍니다.**
2. **다이어트는 나중에**. 수유 중에는 열량과 수분이 더 필요합니다.
3. 산후 검진(4~6주)은 몸만 보는 자리가 아니라 **우울 선별**을 하는 자리입니다. 꼭 받으세요.

## 25장 · 산후우울

### 먼저, 이건 의지의 문제가 아닙니다

산후우울을 겪는 분들이 가장 많이 하시는 말이 있어요.

"내가 마음을 강하게 먹으면 될 것 같은데."

아닙니다. 이건 마음가짐의 문제가 아니에요. 급격한 호르몬 변화, 극심한 수면 부족, 삶의 통제권 상실, 사회적 고립이 한꺼번에 겹쳐서 생기는 **의학적 상태**입니다. 감기에 걸린 사람에게 "정신력으로 이겨내라"고 하지 않는 것처럼요.

그리고 이건 **아이를 사랑하지 않는다는 뜻이 전혀 아닙니다**. 아이를 깊이 사랑하면서도 산후우울을 겪을 수 있어요. 이 둘은 완전히 별개입니다.

### 베이비 블루스 vs 산후우울증

|    | 베이비 블루스        | 산후우울증                                                |
|----|----------------|------------------------------------------------------|
| 빈도 | 산모의 50~80%     | 산모의 약 10~15%                                         |
| 시작 | 출산 후 2~3일      | 언제든 (출산 후 1년 이내)                                     |
| 기간 | 2주 이내 호전       | 2주 이상 지속·악화                                          |
| 증상 | 눈물, 기분 변화, 예민함 | 지속적 우울, 무가치감, 아이에 대한 무감정, 아이가 자도 못 자는 불면, 식욕 변화, 죄책감 |
| 조치 | 휴식·지지          | 치료가 필요합니다                                            |

기준은 2주예요. 2주 넘게 지속되면 병원에 가세요. 그건 약해서가 아니라 아파서입니다.

### 아빠도 겪습니다

배우자의 산후 우울도 상당한 비율(연구에 따라 10% 내외)에서 보고됩니다.

다만 남성은 우울감보다 **짜증·분노·회피·과로·음주**로 나타나는 경우가 많아서 본인도 주변도 알아채기 어려워요. "요즘 왜 이렇게 예민하지" 싶다면, 그게 신호일 수 있습니다.

### 자가 점검

에든버러 산후우울척도(EPDS)는 검증된 10문항 자가 도구예요. 아래는 핵심 요약이고, 정식 검사를 대체하지는 않습니다.

지난 7일 동안,

1. 웃을 수 있었고 재미있는 것을 재미있게 느꼈다
2. 앞으로의 일을 기대하며 즐거워했다
3. 일이 잘못되면 필요 이상으로 나를 탓했다
4. 뚜렷한 이유 없이 불안하거나 걱정스러웠다
5. 뚜렷한 이유 없이 무섭거나 두려웠다
6. 일이 감당하기 어렵게 느껴졌다
7. 너무 불행해서 잠을 잘 못 잤다
8. 슬프거나 비참하게 느꼈다

9. 너무 불행해서 울었다

10. 나 자신을 해치는 생각이 들었다

- 통상 **총점 10점 이상(또는 13점 이상)**을 추가 평가 기준으로 씁니다
- 10번에 해당하신다면, 점수와 상관없이 지금 도움을 구하세요. 부끄러운 일이 아닙니다

## 지금 갈 것인가, 내일 가도 되는가

20장에서 아이의 열을 다룰 때 "집에서 볼 것과 병원 갈 신호"를 갈랐습니다. 산후우울에도 같은 기준선이 필요합니다. 판단이 가장 어려운 상태에 있는 사람이 판단해야 하기 때문입니다.

| 상태                                                                                                                     | 언제                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>지금 당장</b> — 119 / 응급실 / 1577-0199 | · 자신이나 아이를 해치고 싶은 생각이 든다<br>· 현실감이 없거나 이상한 생각·환각이 있다 → <b>산후 정신병은 응급입니다</b> <br>· 아이를 돌볼 수 없다고 느낀다<br>· 며칠간 먹지도 자지도 못했다              |
|  <b>이번 주 안에</b> — 산부인과 또는 정신건강의학과     | · 2주 넘게 우울·불안이 지속된다<br>· <b>아이가 자는데도 잠이 오지 않는다</b> <br>· 아이에게 아무 감정이 들지 않는다<br>· 하루 대부분 울거나, 울 수조차 없다<br>· 일상적인 일(밥·샤워·외출)이 감당이 안 된다 |
|  <b>먼저 전화라도</b> — 정신건강복지센터(무료)        | · 위 항목에 딱 맞진 않지만 "뭔가 이상하다"<br>· 병원까지는 부담스럽다<br>· 배우자가 걱정된다                                                                           |
|  <b>일단 지켜봐도</b>                       | · 출산 2주 이내의 기분 변화와 눈물 (베이비 블루스)<br>· 잠을 자고 나면 나아진다<br>· 좋은 순간이 하루에 몇 번은 있다                                                           |

**애매하면 위쪽을 고르세요.** 확인해서 아무 일 아니면 그게 제일 좋은 결과입니다. 그리고 **혼자 판단하지 않으셔도 됩니다.** 1577-0199는 24시간 열려 있고, 진단하려고 받는 전화가 아닙니다.

## 병원에 가기가 망설여진다면

이런 생각들이 발목을 잡습니다. 하나씩 답해둘게요.

| 이런 생각이 들면           | 실제로는                                           |
|---------------------|------------------------------------------------|
| "이 정도로 병원에 가도 되나"   | 됩니다. 판단은 의사가 합니다                               |
| "약을 먹으면 수유를 못 하잖아"  | <b>수유 중에도 쓸 수 있는 약이 있습니다.</b> 그 판단도 의사가 합니다    |
| "기록이 남을까 봐"         | 걱정되시면 진료 시 직접 물어보세요. 다만 <b>치료를 미루는 대가가 더 큼</b> |
| "시간이 없다"            | 산후 검진(4~6주) 때 함께 말하세요. 그 자리가 원래 그런 자리입니다       |
| "남편/가족이 유난이라고 할까 봐" | 이 페이지를 보여주세요. 그러라고 적어둔 것입니다                    |

## 즉시 도움이 필요한 신호 (다시 한번)

- 자신이나 아이를 해치고 싶은 생각
- **현실감이 없거나 이상한 생각·환각** → **산후 정신병은 응급입니다. 즉시 응급실로 가세요**
- 아이를 돌볼 수 없다고 느낌
- 며칠간 먹지도 자지도 못함

## 도움받는 곳

| 곳              | 내용                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 산부인과 / 정신건강의학과 | 수유 중에도 쓸 수 있는 약이 있어요. 진료를 미루지 마세요                       |
| 정신건강복지센터 (지역별) | 무료 상담                                                   |
| 1577-0199      | 정신건강 위기상담 (24시간)                                        |
| 109            | 자살예방상담                                                  |
| 영유아 건강검진 문진표   | 산모 우울 문항이 있어요 — 솔직하게 답하세요. 잘 보이려고 좋게 체크하면 도움받을 기회를 놓칩니다 |

병원에 가는 게 망설여지신다면, 이렇게 생각해보세요. **치료받는 것이 아이에게 해주는 가장 큰 일입니다.** 실제로 연구가 그렇게 말하고 있어요.

## 👉 지금 해보기

EPDS 10문항을 지금 한 번 읽어보세요. 점수를 세지 않으셔도 됩니다. **10번 문항 하나만** 확인하세요. 그리고 배우자와 이 한 문장만 약속해두세요.

**"2주 넘게 이러면 병원에 간다. 서로에게 말해준다."**

미리 정해두면, 정작 판단이 흐려졌을 때 그 약속이 대신 판단해줍니다.

## 📌 25장의 요약 3줄

1. **기준은 2주.** 베이비 블루스는 2주 내 호전하고, 그 이상은 치료가 필요한 상태입니다.
2. **이건 의지의 문제가 아닙니다.** 아이를 깊이 사랑하면서도 산후우울을 겪을 수 있습니다.
3. **수유 중에도 쓸 수 있는 약이 있습니다.** 치료받는 것이 아이에게 해주는 가장 큰 일입니다.

# 26장 · 부부

## 미리 알아두면 덜 놀라는 사실

Gottman 등의 종단연구를 보면, 첫 아이가 태어난 뒤 상당수의 부부가 관계 만족도 하락을 겪습니다.

이걸 미리 말씀드리는 이유는, 그 시기가 왔을 때 "우리 부부만 이상한가" 하고 놀라지 않으시길 바라서예요. 서로가 미워진 게 아니라, **잠이 부족한 두 사람이 처음 해보는 일을 24시간 하고 있는 것**뿐입니다.

연구에서 예외였던 부부들에게는 공통점이 있었어요. **역할 분담과 대화 방식을 미리 정해둔 부부**였습니다.

## ① "도와준다"는 말부터 없애기

육아는 한 사람의 일을 다른 사람이 돕는 구조가 아니예요. **각자 완전히 담당하는 영역**을 나눠야 합니다. 그것도 실행뿐 아니라 **기억하고 계획하는 것까지** 포함해서요.

"언제 접종이지?"라고 묻는 것과, **접종 시기를 기억하고 예약까지 하는 것**은 완전히 다른 일이에요. 앞의 것만 하면서 "나도 같이 한다"고 느끼기 쉬운데, 지치는 쪽은 뒤의 것을 하는 사람입니다.

분담표 (채워서 벽에 붙여주세요)

| 영역                 | 담당 |
|--------------------|----|
| 예방접종·검진 일정 관리 및 예약 |    |
| 기저귀·분유 재고 관리 및 주문  |    |
| 목욕                 |    |
| 야간 담당 (요일/시간대)     |    |
| 병원 동행              |    |
| 어린이집 준비물·연락        |    |
| 식사 준비              |    |
| 청소·빨래              |    |
| 아이 옷 사이즈 확인·구매     |    |

## ② 주 15분 점검 대화

거창할 필요 없어요. 15분이면 됩니다.

- 잘 되고 있는 것 하나, 바꾸고 싶은 것 하나, 다음 주 일정
- 아이가 자는 시간에, 화면 끄고, **정해진 요일에**

## ③ 비난이 아니라 요청으로

지쳐 있을 때는 말이 날카로워집니다. 그럴 때 쓸 문장을 미리 준비해두면 도움이 돼요.

| ❌ 이렇게 말하면       | ✅ 이렇게 말하면                                |
|-----------------|------------------------------------------|
| "당신은 아무것도 안 해." | "이번 주는 밤에 너무 못 잤어. 목요일 밤은 당신이 맡아줄 수 있어?" |
| "왜 나만 신경 써?"    | "접종 일정 관리는 당신이 맡아줬으면 좋겠어."               |
| "그렇게 하는 거 아니야." | "나는 이렇게 하고 있어. 방식을 하나로 맞출까?"             |

#### ④ 각자의 회복 시간을 보장하기

주 1회, 2~3시간씩 **혼자만의 시간**을 서로 보장해주세요.

이걸 사치라고 느끼실 수도 있어요. 그런데 이건 **지속 가능성의 문제**입니다. 방전된 사람은 좋은 부모가 되기 어렵고, 그건 의지의 문제가 아니에요.

#### ⑤ 조부모·친척과의 경계

육아 방식을 두고 부딪히는 건 아주 흔한 일이에요. 그리고 대부분 **애정에서 나온 말**이라 더 어렵죠.

- 결정은 부모가 하고, 그 결정을 배우자가 자기 부모에게 전달합니다. 자기 쪽 가족은 자기가 응대하는 게 원칙이에요. 며느리·사위가 시부모·처부모에게 직접 반박하는 구조는 관계를 상하게 합니다
- 타협 불가 항목(안전 수면, 카시트, 체벌 금지, 꿀 금지, 흡연)은 미리 명확히 전달하세요. 부록 G의 위임 시트를 쓰시면 감정 상하지 않게 전달하기 좋습니다

#### 26장의 요약 3줄

1. 첫 아이 출생 후 관계 만족도가 떨어지는 건 **흔한 일**입니다. 예외는 미리 분담을 정한 부부였습니다.
2. "도와준다"는 말을 없애세요. 기억하고 계획하는 일까지 나눠야 합니다.
3. 각자 주 1회 **혼자만의 시간 2~3시간**. 사치가 아니라 지속 가능성의 문제입니다.

## 27장 · 죄책감과 번아웃

### 죄책감은 사랑의 부작용입니다

부모가 되면 죄책감이 늘 따라다닙니다. 그런데 이건 당신이 부족해서가 아니라, **잘하고 싶은 마음이 커서** 생기는 감정이에요.

문제는 이 감정이 너무 자주, 너무 근거 없이 찾아온다는 겁니다. 하나씩 정리해볼게요.

| 죄책감                | 실제로는                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 모유수유를 못 했다         | 분유로 잘 자란 아이가 대다수예요. <b>부모의 상태가 더 중요합니다</b>                |
| 화를 냈다              | 완벽한 부모는 없어요. <b>사과하고 다시 안아주는 그 과정이 오히려 교육이 됩니다</b>        |
| 일 때문에 함께 있는 시간이 적다 | 시간의 양보다 <b>함께 있을 때의 질</b> 이 더 잘 예측해요                      |
| 어린이집에 일찍 보냈다       | 질 좋은 보육 환경에서 안정 애착은 충분히 형성됩니다                             |
| 화면을 보여줬다           | 하루 몇 분이 아이를 망치지 않아요. <b>전체 패턴이 중요합니다</b>                  |
| 아이가 싫을 때가 있다       | 아주 흔한 감정이에요. 나쁜 부모라는 뜻이 아닙니다. 다만 <b>오래 지속되면 상담을 받아보세요</b> |

**"충분히 좋은 부모(good enough parent)"** — Winnicott의 이 말은 위로가 아니라 이론입니다. 부모의 적절한 불완전함이 아이의 회복탄력성을 만들어요. 완벽한 부모 밑에서는 배울 수 없는 것들이 있습니다.

### 번아웃 신호

아래 중 몇 개가 해당된다면, 게으른 게 아니라 **지친** 겁니다.

- 아이의 울음에 분노나 **무감각**으로 반응
- 아이와 함께 있는 것이 기쁘지 않고 **견디는** 일이 됨
- 사소한 일에 폭발
- 자신이 나쁜 부모라는 생각이 반복됨
- 몸이 계속 아프고, 아무것도 즐겁지 않음

### 지금 할 수 있는 것

거창한 계획 말고, 이 다섯 개만요.

1. **잠** — 하루라도 연속 6시간. 다른 무엇보다 먼저
2. **혼자만의 시간 2시간** — 배우자에게 구체적으로 요청하세요
3. **말하기** — 배우자, 친구, 상담. 혼자 견디지 마세요
4. **기준 낮추기** — 집이 지저분해도 됩니다. 배달 음식 먹어도 됩니다. **정말로 괜찮아요**
5. **전문가 상담** — 부모 상담은 아이를 위한 개입입니다

### 아이에게 화가 통제되지 않을 때

이건 부끄러운 일이 아니라, 지친 사람에게 일어나는 일입니다. 중요한 건 그 순간에 무엇을 하느냐예요.



1. 아이를 안전한 곳(아기침대, 방바닥)에 눕혀요
2. 방을 나와요
3. 5~10분 진정해요 - 물 마시기, 심호흡, 세수
4. 돌아가요

잠깐 우는 건 안전해요. 흔들거나 때리는 건 안전하지 않아요. 자리를 뜨는 건 방임이 아니라 안전 조치입니다.

### 이미 소리를 질렀다면

자책하며 하루를 보내지 마시고, 대신 **회복**을 하세요.

"아빠가 아까 큰 소리 내서 미안해. 아빠도 화가 났었어. 그래도 소리 지르는 건 아빠가 잘못된 거야."

이 세 문장이 아이에게 세 가지를 가르칩니다. ① 어른도 감정이 있다 ② 잘못하면 사과한다 ③ 관계는 깨져도 고칠 수 있다

세 번째가 특히 중요해요. 한 번도 어긋나지 않은 관계에서는 이걸 배울 수가 없거든요. 그러니까 오늘의 실수는, 잘 회복하면 오히려 아이가 배울 기회가 됩니다.

### 👉 지금 해보기

배우자에게 구체적인 요청 한 문장을 오늘 보내세요. 비난이 아니라 요청으로요.

❌ "나 너무 힘들어" (상대는 무엇을 해야 할지 모릅니다) ✅ "이번 주 목요일 밤은 당신이 맡아줄 수 있어? 연속으로 자본 지가 오래됐어."

요일과 시간을 넣으면 실행됩니다. 안 넣으면 대화로 끝납니다.

그리고 하나 더 — 이번 주에 2시간만 혼자 있을 시간을 잡으세요. 캘린더에 적어야 진짜입니다.

### 📌 27장의 요약 3줄

1. 죄책감은 부족해서가 아니라 **잘하고 싶어서** 생깁니다. 목록의 대부분은 근거가 없습니다.
2. 화가 통제되지 않으면 **아이를 안전한 곳에 눕히고 방을 나오세요**. 그건 방임이 아니라 안전 조치입니다.
3. **소리 질렀으면 사과하세요**. 회복하는 과정이 아이에게는 배움이 됩니다.

## 28장 · 복직과 인계

### 복직 전에 마음부터

복직을 앞두고 죄책감이 밀려오는 건 아주 흔한 일이에요. "이 작은 아이를 두고 나가도 되나" 싶은 마음이에요.

근거로 말씀드리면 — **질 좋은 보육 환경에서 안정 애착은 충분히 형성됩니다**(NICHD 대규모 종단연구). 결정적인 건 함께 있는 시간의 **양이 아니라 반응의 민감성**이에요.

그러니 **하루 15분, 화면 없이 아이가 주도하는 놀이 시간**을 고정하는 것이, 두 시간을 흠어 쓰는 것보다 낫습니다. 이 15분이 당신의 죄책감에 대한 가장 현실적인 답이에요.

### 복직 전 4주 계획

| 시점   | 할 일                                  |
|------|--------------------------------------|
| 4주 전 | 보육 기관·돌봄 인력 확정 · <b>적응 시작</b> (짧게부터) |
| 3주 전 | 유축 시작해 여유분 비축 · 질병 수용 연습             |
| 2주 전 | 아침 루틴 리허설 — 실제 시간에 맞춰 옮겨보기           |
| 1주 전 | 아이 취침·기상 시간을 복직 후 일정으로 조정            |
| 복직 주 | 가능하면 <b>주 중반(수·목)에 시작</b> — 첫 주를 짧게  |

### 인계 문서 만들기

조부모·시터·기관 모두에게 씁니다. 부록 G 시트를 쓰시거나 아래를 적어 전달하세요.

아이 이름 / 생년월일 / 체중 / 알레르기 / 복용약  
하루 일과 (수유·식사·낮잠 시간)  
좋아하는 것 / 달래는 방법  
금지 사항 (꿀, 질식 위험 음식, 화면)  
안전 원칙 (등을 대고 재우기, 카시트, 체벌 금지)  
연락처: 부모 / 소아과 / 119 / 1339

### 적응 요령

- 적응에는 보통 2~6주가 걸려요. 우는 것이 곧 문제는 아닙니다. 첫날 우는 아이가 대부분이에요
- **짧고 일관된 작별 의식**. 몰래 가지 마세요 (13장)
- 적응기에는 **다른 변화를 겹치지 않게** 하세요 (침대 전환, 배변 훈련 등)
- **익숙한 물건**(애착 인형·이불) 반입 가능 여부를 확인하세요

### 모유수유를 유지하려면

- 직장에서 **3~4시간마다 유축**
- 보관 기준은 17장
- 사업장 상황(수유 공간·시간)을 미리 확인하세요

그리고 유지가 어려우면 **그만두셔도 됩니다**. 복직과 모유수유를 둘 다 완벽하게 하려다 무너지는 것보다, 하나를 놓고 버티는 게 낫습니다.

### 28장의 요약 3줄

1. 결정적인 것은 함께 있는 시간의 양이 아니라 반응의 민감성입니다.
2. 하루 15분, 화면 없이 아이가 주도하는 놀이. 흠어진 두 시간보다 낫습니다.
3. 적응에는 2~6주가 걸립니다. 우는 것이 곧 문제는 아닙니다.

## 오려 쓰는 한 장 ⑦ — 부모를 위한 것

기준은 2주다.

2주 넘게 우울·불안이 지속되면 병원.

약해서가 아니라 아파서다.

"나 자신을 해치는 생각" → 점수와 무관하게  
지금 도움을 구한다.

1577-0199 (24시간) / 109

화가 통제되지 않을 때

① 아이를 안전한 곳에 눕힌다

② 방을 나온다 ③ 10분 ④ 돌아간다

잠깐 우는 건 안전하다. 혼드는 건 아니다.

소리 질렀으면 사과한다.

"관계는 깨져도 고칠 수 있다"를

아이가 배우는 순간이다.

각자 주 1회, 2~3시간 혼자만의 시간

주 15분 부부 점검 대화 (요일: \_\_\_\_\_)

"도와준다"는 말을 쓰지 않는다.

기억하고 계획하는 일까지 나눈다.

집이 지저분해도 된다.

배달 음식 먹어도 된다.

오늘 못 한 것이 아이를 망치지 않는다.

### 이 부를 닫으며

이 부를 쓰면서 가장 하고 싶었던 말은 이겁니다.

**당신이 잘 지내는 것이 육아의 일부입니다.** 결다리가 아니라고.

아이는 완벽하게 정리된 집도, 매일 다른 이유식도, 지치지 않는 부모도 필요로 하지 않아요. 아이에게 필요한 건  
**곁에 있어주는, 웬만큼 안정된 어른 한 명**입니다.

그러니 오늘 아무것도 못 했다고 느껴지는 날엔, 이렇게 세어보세요. 아이를 먹였고, 재웠고, 안아줬다면 — **오늘 할 일은 다 하신 겁니다.**

### 5부의 요약 3줄

1. **기준은 2주.** 베이비 블루스는 2주 내 호전하고, 그 이상은 치료가 필요한 상태입니다.
2. 육아는 "돕는" 일이 아니에요. **기억하고 계획하는 것까지 나눠야** 관계가 유지됩니다.
3. 부모 상담은 **아이를 위한 개입**입니다. 당신의 회복이 아이의 발달이에요.

→ 다음: 6부 · 제도를 쓴다

## 6부 · 제도를 쓴다

### 한국에서 아이 키우기

한국은 국가가 무료 검진·접종 체계를 갖추고 있습니다. 이 일정만 놓치지 않아도 상당 부분의 조기 발견이 가능합니다.

⚠ 정책은 바뀝니다. 이 부는 금액과 세부 조건을 본문에 박지 않습니다. 대신 무엇을·언제·어디서 확인하는지를 씁니다. 금액을 적으면 책이 1년 만에 낡기 때문입니다.

### 즐거찾기에 넣어둘 세 곳

| 곳                    | 주소             | 용도                                  |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 예방접종도우미              | nip.kdca.go.kr | 표준일정표, 자녀 등록 시 개인별 일정 자동 관리, 증명서 출력 |
| 국민건강보험공단 / The건강보험 앱 | nhis.or.kr     | 검진 대상 조회, 문진표 온라인 작성, 검진기관 찾기       |
| 복지로                  | bokjiro.go.kr  | 지원금 자격 조회 (변경이 가장 잦은 영역)            |

## 29장 · 출생 직후 행정 30일

### 날짜순 체크리스트

| 기한          | 할 일                    | 어디서                       |
|-------------|------------------------|---------------------------|
| 생후 4주 이내    | BCG 접종                 | 보건소 또는 지정 의료기관            |
| 출생 후 가급적 빨리 | 아기 실손보험 검토             | 선천 이상 발견 전 가입이 유리         |
| 생후 14~35일   | 영유아 건강검진 1차            | 지정 검진기관                   |
| 생후 1개월 이내   | 출생신고                   | 주민센터 또는 온라인(대법원 전자가족관계등록) |
| 출생신고와 동시    | 행복출산 원스톱 서비스           | 주민센터 / 정부24               |
| 생후 1개월      | B형간염 2차                | 소아과                       |
| 이후          | 아기 이름 통장 개설, 국민행복카드 등록 | 은행 / 카드사                  |

### 행복출산 원스톱 서비스

출생신고를 하면서 여러 지원을 한 번에 신청할 수 있는 제도입니다. 주민센터 방문 또는 정부24 온라인으로 가능합니다.

- 통상 함께 신청되는 것: 첫만남이용권, 아동수당, 부모급여, 양육수당, 전기료 경감, 지자체 출산지원금 등
- 다만 지자체·제도별로 별도 신청이 필요한 것이 있습니다. 주민센터에서 "이걸로 다 신청된 건가요? 따로 해야 할 게 있나요?"를 반드시 물어보세요

### 놓치기 쉬운 것

- 신생아 선천성 대사이상 검사와 난청 선별검사 결과 확인. 재검 안내를 받으면 미루지 마세요. 난청은 조기 발견 시 언어 발달 결과가 크게 달라집니다
- 출생신고 지연 시 과태료가 발생할 수 있습니다
- 지자체 출산지원금은 거주 기간 요건이 있는 경우가 있습니다

### 29장의 요약 3줄

1. 출생신고 때 행복출산 원스톱으로 대부분 일괄 신청됩니다. 다만 "따로 해야 할 게 있나요?"를 꼭 물어보세요.
2. BCG는 4주 이내, 건강검진 1차는 14~35일. 이 둘이 가장 촉박합니다.
3. 신생아 선별검사 결과를 확인하세요. 재검 안내를 받으면 미루지 마세요 — 난청은 조기 발견이 결과를 바꿉니다.

# 30장 · 영유아 건강검진 완전 가이드

## 총 12회, 전액 무료

### 일반 건강검진 8차

| 차수 | 시기         | 주요 항목             |
|----|------------|-------------------|
| 1차 | 생후 14~35일  | 문진·진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 2차 | 생후 4~6개월   | + 발달평가(K-DST) 시작  |
| 3차 | 생후 9~12개월  | + 발달평가, 안전사고 예방   |
| 4차 | 생후 18~24개월 | + 발달평가            |
| 5차 | 생후 30~36개월 | + 발달평가            |
| 6차 | 생후 42~48개월 | + 발달평가, 시력검사      |
| 7차 | 생후 54~60개월 | + 발달평가, 시력·청력     |
| 8차 | 생후 66~71개월 | + 발달평가, 취학 전 준비   |

### 구강검진 4회

| 차수 | 시기         |
|----|------------|
| 1차 | 생후 18~29개월 |
| 2차 | 생후 30~41개월 |
| 3차 | 생후 42~53개월 |
| 4차 | 생후 54~65개월 |

## 실무 요령

- 문진표는 미리 온라인으로 작성하세요. 병원에서 급하게 쓰면 부정확해집니다
- 해당 기간을 넘기면 무료 대상에서 제외될 수 있습니다. 달력에 미리 등록하세요
- 1차는 신생아 시기라 가장 놓치기 쉽습니다. 출산 전에 표시해두세요
- 다니는 소아과가 검진기관인지 미리 확인하세요

## K-DST — 한국 영유아 발달선별검사

### 무엇인가

건강검진 2차(생후 4개월)부터 8차(71개월)까지, 부모가 작성하는 문진표 형식으로 발달을 선별합니다.

### 평가 영역 6가지

대근육운동 · 소근육운동 · 인지 · 언어 · 사회성 · 자조(18개월 이후 추가)

### 결과 해석

| 판정    | 의미      | 조치         |
|-------|---------|------------|
| 빠른 수준 | 또래보다 앞섬 | 특별한 조치 불필요 |



| 판정      | 의미    | 조치                         |
|---------|-------|----------------------------|
| 또래 수준   | 정상 범위 | 유지                         |
| 추적검사 요망 | 경계선   | 1~2개월 뒤 재검사 또는 자극 활동 후 재평가 |
| 심화평가 권고 | 지연 의심 | 정밀 평가 의뢰 (36장)             |

### ★ 가장 중요한 것 — 솔직하게 답하기

잘 보이려고 실제보다 높게 체크하면 조기 발견 기회를 잃습니다.

- "가끔 한다"와 "잘 한다"를 구분해서 체크하세요
- 선별검사는 진단이 아닙니다. "심화평가 권고"가 곧 장애를 의미하지 않습니다
- 반대로 "또래 수준"이 나와도 부모가 걱정된다면 말하세요. 부모의 우려는 유의미한 임상 정보입니다
- 미숙아는 교정연령(예정일 기준)으로 평가합니다. 보통 만 2세까지 적용합니다

### 자폐 스펙트럼 선별 — M-CHAT-R/F

- 대상: 생후 16~30개월. AAP는 18개월과 24개월에 모든 아동에게 시행할 것을 권고합니다 **강함**
- 20문항의 부모 작성 설문이며, 위험도가 나오면 후속 면담으로 확인합니다
- 한국어판이 있습니다. 국내에서 일상적으로 시행되지 않는 경우도 있으니 먼저 요청하세요
- 왜 중요한가: 조기 개입 시 결과가 크게 달라집니다. 평균 진단 연령은 여전히 늦고, 조기 발견이 가장 큰 개선 여지입니다

### 성장 곡선 읽는 법

- 0~24개월은 WHO 성장기준, 이후는 국내 소아청소년 성장도표를 사용합니다
- 한 시점의 백분위수보다 곡선의 추세가 중요합니다
- 3백분위수여도 자기 곡선을 따라 꾸준히 크면 대개 정상
- 50백분위에서 15백분위로 두 개 이상의 주요 백분위선을 가로질러 떨어지면 평가 필요
- 머리둘레는 뇌 성장의 지표입니다. 급격한 증가나 정체는 반드시 확인합니다

### 30장의 요약 3줄

1. 일반 8회 + 구강 4회, 전액 무료입니다. 기간을 넘기면 대상에서 빠질 수 있습니다.
2. K-DST 문진표는 솔직하게 체크하세요. 좋게 적으면 도움받을 기회를 놓칩니다.
3. "또래 수준"이 나와도 걱정되면 말하세요. 부모의 우려는 유의미한 임상 정보입니다.

# 31장 · 예방접종 완전 가이드

아래는 개요입니다. 반드시 예방접종도우미에서 최신 표준일정표를 확인하세요. 백신 종류(콤보 백신), 횟수, 대상 연령은 변경될 수 있습니다.

## 국가예방접종 (무료)

| 백신   | 예방 질병          | 시기                                          |
|------|----------------|---------------------------------------------|
| BCG  | 결핵             | 생후 4주 이내 1회                                 |
| HepB | B형간염           | 0, 1, 6개월 (3회)                              |
| DTaP | 디프테리아·파상풍·백일해  | 2, 4, 6개월 · 15~18개월 · 만 4~6세 (5회)           |
| IPV  | 폴리오            | 2, 4, 6~18개월 · 만 4~6세 (4회)                  |
| Hib  | b형 헤모필루스 인플루엔자 | 2, 4, 6개월 · 12~15개월                         |
| PCV  | 폐렴구균           | 2, 4, 6개월 · 12~15개월                         |
| RV   | 로타바이러스         | RV1: 2, 4개월 / RV5: 2, 4, 6개월 — 생후 8개월 이전 완료 |
| MMR  | 홍역·유행성이하선염·풍진  | 12~15개월 · 만 4~6세                            |
| VAR  | 수두             | 12~15개월 1회                                  |
| HepA | A형간염           | 12~23개월 1차, 6개월 이상 간격 후 2차                  |
| JE   | 일본뇌염           | 불활성화 백신과 약독화 생백신 중 선택, 12~23개월부터            |
| IIV  | 인플루엔자          | 생후 6개월부터 매년. 첫 접종 연도는 4주 간격 2회              |
| HPV  | 사람유두종바이러스      | 만 12세 전후 (대상·성별 정책 확인)                      |

## ★ 가장 확실한 관리법

예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)에 자녀를 등록하세요. 개인별 일정이 자동으로 관리되고, 어린이집·유치원 제출용 증명서도 여기서 출력됩니다. 이것 하나로 대부분의 실수가 사라집니다.

## 접종 실무

- 접종 후 30분은 병원 내 또는 근처에 머무릅니다 (즉시형 이상반응 관찰)
- 접종 부위 발적·미열은 흔합니다. 38.5℃ 이상 지속되거나 축 처지면 병원
- 예방접종 전 미리 해열제를 먹이지 않습니다 — 항체 형성을 낮출 수 있다는 보고가 있습니다
- 감기 정도의 가벼운 질환은 대부분 접종 가능합니다. 판단은 의사에게
- 일정이 밀렸다면 처음부터 다시 하지 않습니다. 이어서 하면 됩니다
- 여러 백신을 같은 날 접종하는 것은 안전합니다

## 유료(선택) 접종

정책과 권고가 자주 바뀝니다. 수막구균, RSV 예방 항체, 코로나19 등은 소아과와 상의하세요.

## 결론만 말하면 — 백신과 자폐

MMR 백신과 자폐의 연관성은 존재하지 않습니다. 원 논문(Wakefield, 1998)은 데이터 조작으로 철회되었고 저자는 의사 면허를 박탈당했습니다. 이후 수백만 명 규모의 후속 연구에서 연관성이 반복적으로 부정되었습니다. **강함**  
걱정되는 점이 있으면 **접종을 미루지 말고 의사와 상의**하세요.

### 31장의 요약 3줄

1. 예방접종도우미에 자녀를 등록하는 것 하나로 접종 실수의 대부분이 사라집니다.
2. 접종 전에 미리 해열제를 먹이지 않습니다. 일정이 밀렸어도 처음부터 다시 하지 않습니다.
3. MMR과 자폐는 무관합니다. 원 논문은 조작으로 철회됐고 이후 대규모 연구가 반복 부정했습니다 **강함**

# 32장 · 현금성 지원

## 확인해야 할 항목

| 지원           | 성격                     | 확인처         |
|--------------|------------------------|-------------|
| 첫만남이용권       | 출생아당 바우처(국민행복카드)       | 복지로 / 주민센터  |
| 부모급여         | 영아기 현금 지원 (연령별 차등)     | 복지로         |
| 아동수당         | 일정 연령까지 매월             | 복지로         |
| 양육수당 / 보육료   | 가정양육 vs 어린이집 이용에 따라 다름 | 아이사랑        |
| 지자체 출산지원금    | 지역 편차가 매우 큼            | 거주지 주민센터    |
| 전기료·가스료 경감   | 다자녀·출산 가구              | 한전 / 도시가스사  |
| 출산휴가·육아휴직 급여 | 고용보험                   | 고용24 / 고용센터 |

## 실무 요령

- 금액과 조건은 매년 바뀝니다. 이 책에 적지 않은 이유입니다. **복지로에서 "복지서비스 모의계산"**으로 조회하세요
- 출생신고 시 **행복출산 원스톱**으로 상당수가 일괄 신청됩니다
- 놓치기 쉬운 조건
- 지자체 지원금의 **거주 기간 요건**
- 신청 **기한**이 있는 항목
- 어린이집 이용 여부에 따라 **양육수당 ↔ 보육료 전환 신청**이 필요한 경우
- 육아휴직은 **부부가 함께 쓸 때 인센티브**가 있는 제도들이 있습니다. 고용24에서 확인하세요

### 32장의 요약 3줄

1. 금액과 조건은 매년 바뀝니다. **복지로 모의계산**으로 확인하세요.
2. 출생신고 시 **행복출산 원스톱**으로 상당수가 일괄 신청됩니다.
3. 놓치기 쉬운 것 — **지자체 지원금의 거주 기간 요건**, 신청 기한, 양육수당 ↔ 보육료 전환 신청.

## 33장 · 서비스 지원 — 사람이 오는 도움

돈보다 **사람**이 필요한 순간이 많습니다.

| 서비스              | 내용                        | 핵심                                                 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 산모·신생아 건강관리 지원사업 | 건강관리사가 가정 방문              | ★ <b>출산 예정일 40일 전부터</b> 신청 가능.<br>미리 알아두세요. 관할 보건소 |
| 아이돌봄서비스          | 시간제·종일제 돌봄                | ★ <b>급할 때 쓰려면 미리 등록해두어야 합니다.</b> 대기가 있을 수 있습니다     |
| 시간제 보육           | 필요할 때 시간 단위 이용            | 아이사랑 예약                                            |
| 육아종합지원센터         | 장난감·도서 대여, 부모교육, 일시보육, 상담 | 지역별. <b>무료가 많습니다</b>                               |
| 건강가정지원센터 / 가족센터  | 부모교육, 가족상담                | 지역별                                                |
| 보건소              | 모유수유 상담, 영유아 발달 상담, 예방접종  | 지역별                                                |

**제도는 미리 알아두어야 급할 때 씁니다.** 출산 전에 지역 육아종합지원센터와 아이돌봄서비스에 한 번 연락해 절차를 파악해두세요.

### 33장의 요약 3줄

1. 산모·신생아 건강관리 지원사업은 **출산 예정일 40일 전부터** 신청할 수 있습니다. 이게 가장 놓치기 쉽습니다.
2. 아이돌봄서비스는 **미리 등록해두어야** 급할 때 씁니다. 대기가 있습니다.
3. 육아종합지원센터는 장난감·도서 대여, 일시보육, 부모교육을 **대부분 무료로** 운영합니다.

## 34장 · 어린이집 · 유치원

### 입소 절차

- 아이사랑(childcare.go.kr)에서 어린이집 **입소 대기 신청**을 합니다. 여러 곳에 동시 신청 가능
- 대기 순번은 우선순위(맞벌이, 다자녀, 형제 재원 등)에 따라 산정됩니다
- 유치원은 "처음학교로"를 통해 모집·선발이 이루어집니다
- 지역에 따라 대기가 매우 길습니다. 필요 시점보다 훨씬 일찍 신청하세요

### 정보공시 읽는 법

아이사랑·유치원알리미에 공개되는 정보 중 실제로 봐야 할 것:

- **교사 대 아동 비율** — 낮을수록 상호작용의 질이 올라갑니다
- **교사 근속연수·이직률** — ★ 자주 바뀌는 곳은 아이의 애착 형성에 불리합니다
- 평가 결과
- 급식·위생 관리
- 안전 점검 이력

### 방문해서 볼 것 8가지

- ☐ **교사와 아이의 상호작용** — 아이 눈높이에서 대화하는가, 지시만 하는가
- ☐ 아이들의 표정
- ☐ **하루 일과에 자유놀이 시간**이 충분한가
- ☐ **매일 실외 활동**이 있는가
- ☐ 화면 사용 정책
- ☐ **훈육 방침** — 체벌·수치 주기·격리를 쓰지 않는가
- ☐ 위생·안전 시설 (가구 고정, 안전문, 모서리)
- ☐ 부모와의 소통 방식

 **결론만 말하면:** 커리큘럼의 화려함보다 **교사의 태도**를 보세요. 유아기 교육의 질을 예측하는 것은 **상호작용의 질**입니다. 학습 중심 프로그램의 장기적 우위는 확인되지 않았습니다. **보통**

### 적응

- **보통 2~6주가 걸립니다.** 우는 것이 곧 문제는 아닙니다
- 짧은 시간부터 점진적으로
- **짧고 일관된 작별 의식.** 물래 가지 않습니다
- 적응기에는 **집안 일과를 흔들지 않습니다**

### 34장의 요약 3줄

1. 정보공시에서 볼 것은 **교사 대 아동 비율**과 **교사 근속연수**입니다. 자주 바뀌는 곳은 애착 형성에 불리합니다.
2. **커리큘럼의 화려함보다 교사의 태도.** 유아기 교육의 질을 예측하는 건 상호작용의 질입니다. **보통**
3. 적응에는 2~6주. 우는 것이 곧 문제는 아닙니다.

# 35장 · 애플 때 어디로 가나

## 판단 기준표

| 상황                | 어디로                    |
|-------------------|------------------------|
| 평일 낮, 경증          | 동네 소아과                 |
| 야간·휴일, 경증         | 달빛어린이병원 ← 아래           |
| 판단이 서지 않음         | ☎ 1339 (응급의료 상담, 24시간) |
| 20장·21장·22장의 🚩 항목 | 응급실 / ☎ 119            |

## 달빛어린이병원

평일 야간과 주말·공휴일에도 소아청소년과 진료를 제공하는 지정 의료기관입니다. 응급실까지 갈 필요가 없는 경증 소아 환자가 적시에 진료받도록 운영됩니다.

- 조회: [e-gen.or.kr](http://e-gen.or.kr) (응급의료포털) 또는 ☎ 1339
- 2026년 6월 기준 전국 152개소 운영
- 운영 시간은 기관마다 다릅니다. 방문 전 반드시 확인하세요

지금 우리 집에서 가장 가까운 달빛어린이병원을 찾아 냉장고에 적어두세요. 새벽에 검색하지 않도록.

## 응급실 vs 야간진료 — 고민될 때

응급실로 가야 하는 것은 20~22장의 🚩 목록입니다. 그 외 대부분(열, 기침, 구토, 발진)은 달빛어린이병원이나 아침 진료로 충분합니다.

응급실은 중증 환자 우선이라 경증은 대기가 길고, 감염 노출 위험도 있습니다. 다만 판단이 서지 않으면 가는 쪽을 택하세요. 1339에 전화해 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

### 📌 35장의 요약 3줄

1. 야간·휴일 경증은 응급실이 아니라 달빛어린이병원입니다. [e-gen.or.kr](http://e-gen.or.kr) 에서 조회하세요.
2. 우리 동네 달빛어린이병원을 지금 찾아 냉장고에 적어두세요. 새벽에 검색하지 않도록.
3. 판단이 안 서면 ☎ 1339 — 24시간, 무료입니다. 전화 한 통이 가장 빠릅니다.

## 36장 · 발달지연이 의심될 때

### 5단계 경로

- 1단계 가정에서 관찰
  - K-DST 문진표 · 이 책의 시기별 경고 신호(37장)
- 2단계 소아청소년과 방문
  - 걱정되는 점을 구체적 사례로 적어 가기
  - 영상 촬영 (걷는 모습, 노는 모습, 걱정되는 행동)
- 3단계 심화평가 의뢰
  - 소아재활의학과 / 소아정신건강의학과 / 발달센터
  - 베일리 영유아 발달검사, 언어평가, ADOS-2 등
- 4단계 치료 시작
  - 언어치료 / 작업치료 / 물리치료 / 행동치료
- 5단계 지원 신청
  - 영유아 발달정밀검사비 지원 (보건소 / 건강보험공단)
  - 발달재활서비스 바우처 (소득 기준)
  - 장애아동수당 · 장애인 등록 (해당 시)
  - 지역 육아종합지원센터 · 발달장애인지원센터

### ★ "기다려 봅시다"를 들었을 때

그냥 받아들이지 마세요. 되물을 문장 세 개를 준비해 가세요.

1. "언제까지 기다려 보면 될까요? 다음 확인 시점을 정해주세요."
2. "그때까지 무엇이 보이면 더 일찍 와야 하나요?"
3. "지금 시작할 수 있는 자극 활동이 있을까요?"

발달 문제에서 기다려 얻는 이익은 거의 없고, 조기 개입의 이익은 큼니다. 재평가 시점을 명시적으로 정하고, 그래도 불안하면 2차 소견을 받는 것이 합리적입니다.

### 병원 갈 때 준비

- ☐ 걱정되는 점을 구체적 사례로 적기
- ☒ "말이 늦어요"
- ☒ "24개월인데 쓰는 단어가 10개 정도이고 두 단어를 붙이지 않아요"
- ☐ 영상 촬영 — 병원에서는 그 행동을 안 하는 경우가 많습니다
- ☐ 아기수첩 / 접종 기록 / 이전 검진 결과
- ☐ 질문 3개를 미리 적기
- ☐ 반드시 물을 것: "다음에 무엇을 보면 다시 와야 하나요?"

### 📌 36장의 요약 3줄

1. "기다려 봅시다"를 그냥 받아들이지 마세요. 다음 확인 시점과 재방문 기준을 물어서 정하고 나오세요.
2. 병원에 갈 땐 구체적 사례로 적어 가고, 영상을 찍어 가세요. 진료실에서는 그 행동을 안 합니다.
3. 발달 문제에서 기다려 얻는 이익은 거의 없고, 조기 개입의 이익은 큼니다.



## 오려 쓰는 한 장 ⑧ — 제도

예방접종 nip.kdca.go.kr → 자녀 등록  
(등록만 하면 일정이 자동 관리됨)

건강검진 The건강보험 앱 → 대상 조회  
문진표는 미리 온라인 작성  
1차 = 생후 14~35일 (가장 잘 놓침)

지원금 복지로 → 모의계산  
출생신고 시 "행복출산 원스톱"

사람 산모·신생아 건강관리  
= 예정일 40일 전부터 신청  
아이돌봄서비스 = 미리 등록

야간진료 달빛어린이병원 e-gen.or.kr  
우리 동네: \_\_\_\_\_  
상담 1339 / 응급 119

### 6부의 요약 3줄

1. 예방접종도우미에 자녀를 등록하는 것 하나로 접종 실수의 대부분이 사라진다.
2. 건강검진 1차(생후 14~35일)가 가장 놓치기 쉽다. 출산 전에 달력에 넣어라.
3. 야간·휴일 경증은 응급실이 아니라 달빛어린이병원. 미리 찾아 적어두어라.

→ 다음: 7부 · 확인한다

## 7부 · 확인한다

---

# 37장 · 경고 신호 총정리

인터넷 검색 대신 이 장을 보세요. 모든 항목은 "즉시 병원에 가라"가 아니라 "전문가에게 물어보라"는 뜻입니다. 확인해서 아무 일 아니면 그걸로 좋은 겁니다.

## 어느 시기든, 즉시 응급실

| 증상                                   | 왜                        |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 생후 3개월 미만 + 체온 38.0℃ 이상              | 신생아 중증 감염. 해열제로 지켜보지 말 것 |
| 호흡 곤란 — 갈비뼈 사이 함몰, 코 벌렁임, 신음, 청색증    | 호흡부전                     |
| 경련                                   | 5분 이상 지속되면 즉시 119        |
| 축 늘어지고 깨워도 반응이 약함                    | 중증 감염·대사 이상·탈수           |
| 목이 뻣뻣하거나 빛을 심하게 싫어함 + 발열             | 수막염                      |
| 누르면 사라지지 않는 붉은·보라색 반점                | 수막알균 감염                  |
| 심한 탈수 — 8~12시간 소변 없음, 눈물 없이 울, 입안 마름 | 탈수                       |
| 버튼형 전자·자석 구슬 삼킴 의심                   | 몇 시간 내 천공 가능. 무증상이어도 즉시  |
| 두부 외상 후 구토 반복·의식 저하·한쪽 힘 빠짐          | 두개내 출혈                   |
| 초록색(담즙성) 구토, 혈변, 젤리 같은 점액혈변          | 장중첩증·장폐색                 |
| 화상, 삼킨 세제·약물                         | 즉시                       |
| 5일 이상 발열 + 눈 충혈·입술 갈라짐·발진·손발 부종      | 가와사키병                    |

## 시기별 발달 경고 신호

### 2개월

- 큰 소리에 반응이 없다 · 움직이는 물체를 눈으로 따라가지 않는다
- 사람을 보고 미소 짓지 않는다 · 손을 입으로 가져가지 않는다
- 엎드렸을 때 머리를 전혀 들지 못한다

### 4개월

- 머리를 가누지 못한다 · 소리를 내지 않는다
- 물건을 입으로 가져가지 않는다 · 사람을 보고 웃지 않는다
- 한쪽 팔·다리만 주로 쓴다

### 6개월

- 양쪽 어느 방향으로도 뒤집지 못한다
- 웃거나 기쁨을 표현하지 않는다 · 자음 웅알이("바바")가 없다
- 물건에 손을 뻗지 않는다 · 몸이 축 늘어지거나 지나치게 뻣뻣하다

### 9개월

- 도움 없이 앉지 못한다 · 자기 이름에 반응하지 않는다

- 아는 사람을 알아보지 못한다 · **옹알이가 없거나 줄었다**
- 눈을 마주치지 않는다

## 12개월 ★ 특히 중요

- 아무것도 가리키지 않는다 ← 가장 중요한 신호
- 손 흔들기·짝짜꿍 등 몸짓이 없다
- 잡고 서지 못한다 · 의미 있는 말소리가 전혀 없다
- 숨긴 물건을 찾지 않는다 · 이전에 하던 것을 못 하게 되었다

## 18개월

- 의미 있는 낱말이 없다 · 다른 사람을 흉내내지 않는다
- 재미있는 것을 보여주려고 가져오지 않는다
- 혼자 걷지 못한다 · 눈맞춤을 피한다

## 24개월

- 두 낱말을 붙여 말하지 못한다 · 낱말이 50개 미만
- 간단한 지시를 따르지 못한다 · 흉내내기·상상놀이를 하지 않는다
- 안정적으로 걷지 못한다 · 획득했던 말·기술을 잃었다

## 만 3세

- 말이 낯선 사람에게 거의 전달되지 않는다 (명료도 75% 미만)
- 문장으로 말하지 않는다 · 다른 아이에게 관심이 없다
- 상상놀이를 하지 않는다 · 부모와 떨어질 때 전혀 진정되지 않는다

## 만 4~5세

- 짧은 문장으로만 말한다 · 또래와 놀지 못한다
- 규칙 있는 놀이를 이해하지 못한다 · 자기 이름·나이를 모른다
- 낮 배변 조절이 전혀 안 된다 · 극도로 위축되거나 공격적이다

## ★ 나이와 무관하게 즉시 평가해야 하는 세 가지

### ① 퇴행(Regression)

하던 것을 못 하게 되는 것은 어느 시기, 어떤 영역이든 즉시 평가 대상입니다.

- 말하던 단어가 사라짐 / 눈맞춤·사회적 반응이 줄어들음 / 걸던 아이가 걷지 못함

### ② 좌우 비대칭

- 만 18개월 이전의 뚜렷한 손잡이 선호는 비정상 신호일 수 있습니다(손잡이는 보통 2~4세 확립)
- 한쪽 팔·다리만 움직임이 적음 / 얼굴이 한쪽만 움직임

### ③ 근긴장 이상

- 지나치게 축 늘어짐 — 안으면 미끄러지듯 흘러내림
- 지나치게 뻣뻣함 — 다리가 가위처럼 교차, 생후 3~4개월 이후에도 주먹을 계속 꼭 쥐

## 부모의 직관을 무시하지 마세요

"뭔가 이상하다"는 부모의 느낌은 유의미한 임상 신호입니다. 부모는 아이를 가장 많이 관찰한 사람입니다.

- 진료실에서 "괜찮다"는 말을 들었는데도 계속 걱정된다면 → 구체적 근거를 적고 재방문하거나 2차 소견
- "지켜보자"는 말을 들었다면 → "언제까지, 무엇을 보면 다시 와야 하나요?"를 반드시 물으세요

### 37장의 요약 3줄

1. 12개월의 가리키기 없음이 이 목록에서 가장 중요한 단일 신호입니다.
2. 퇴행·좌우 비대칭·근긴장 이상은 나이와 무관하게 즉시 평가 대상입니다.
3. 부모의 "뭔가 이상하다"는 느낌은 유의미한 임상 정보입니다. 그냥 넘기지 마세요.

# 38장 · 걱정하지 않아도 되는 것 12가지

불필요한 불안을 줄이는 것도 이 책의 일입니다.

| 흔한 걱정            | 실제                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배밀이를 건너뛰고 바로 걸음  | 흔하며 대개 문제 없습니다                                                                                          |
| 12~15개월에 아직 안 걸음 | <b>18개월까지 걷지 않으면</b> 평가. 그 전엔 정상 범위가 넓습니다                                                               |
| 까치발로 걷는다         | 간헐적이면 흔합니다. <b>항상 까치발이고 종아리가 뻗뻗하면</b> 평가                                                                |
| 밤에 자주 깬다         | 돌 전후까지 흔합니다                                                                                             |
| 이가 늦게 난다         | 첫니는 3~13개월까지 범위가 넓습니다. <b>18개월까지 하나도 없으면</b> 확인                                                         |
| 대천문이 늦게 닫힘       | 보통 9~18개월, 24개월까지도 정상 범위                                                                                |
| 편식이 심하다          | 2~5세엔 정상. <b>성장 곡선이 유지되면</b> 대개 괜찮습니다                                                                   |
| 말이 조금 느리다        | 개인차가 큼니다. 단, 37장의 기준은 확인하세요                                                                             |
| 안짱다리·O다리         | 2세 전 O다리, 3~4세 X다리는 흔한 정상 변화                                                                            |
| 자꾸 넘어진다 (걸음마 초기) | 정상. <b>점점 나빠지면</b> 평가                                                                                   |
| 머리를 자주 부딪친다      | 흔합니다. 22장의  목록만 확인하세요 |
| 감기에 자주 걸린다       | <b>연간 6~8회는</b> 정상입니다. 기관에 다니면 더 많습니다                                                                   |

## 38장의 요약 3줄

1. **연간 감기 6~8회, 12~15개월에 안 걷기, 편식** — 전부 정상 범위입니다.
2. 기준선만 기억하세요. **걷기는 18개월, 첫니는 18개월, 대천문은 24개월.**
3. 이 목록은 안심하라고 있는 것이 아니라, **걱정의 총량을 줄여 진짜 신호에 쓰라고** 있는 것입니다.

# 39장 · 흔한 걱정 행동

부모가 자주 검색하지만 대부분 정상인 것들입니다.

| 행동               | 이해                               | 대응                                                      | 🚩 상담할 때                            |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 손가락 빨기           | 자기 위로 수단. 영유아기에 흔함               | 야단치지 않기. 지루하거나 불안한 순간을 줄이기                              | 만 4세 이후에도 지속, 치열에 영향               |
| 애착 인형·이불         | <b>전이 대상.</b> 부모와 분리를 견디는 건강한 도구 | 뺏지 않기. 여벌 하나 준비                                         | 없어도 됨. 문제 아님                       |
| 자위 행동            | 유아기에 드물지 않은 정상 탐색. 성적 의미 없음      | 야단치거나 창피 주지 않기. <b>다른 활동으로 자연스럽게 전환,</b> 사적인 공간 개념 알려주기 | 강박적으로 반복, 통증·분비물 동반, 갑자기 시작된 성적 연동 |
| 말더듬              | 2~5세에 언어가 생각을 못 따라가서 흔히 발생       | 재촉·교정하지 않기. <b>끝까지 기다려주기.</b> 천천히 말해주기                  | 6개월 이상 지속, 얼굴에 힘이 들어감, 말하기를 회피     |
| 틱 (눈 깜빡임, 헛기침)   | 유아기에 일시적으로 흔함                    | <b>지적하지 않기.</b> 스트레스 줄이기                                | 1년 이상 지속, 일상에 지장                   |
| 분노발작 중 숨을 참음     | 울다가 숨을 멈추고 창백해지거나 잠깐 의식을 잃음      | 옆으로 눕히고 지켜보기                                            | <b>첫 발생 시에는 반드시 진료</b> (빈혈·심장 감별)  |
| 머리 흔들기·박기 (잠들 때) | 자기 진정 행동. 유아기에 흔함                | 침대 주변을 안전하게                                             | 상처가 생김, 낮에도 지속, 발달 지연 동반           |
| 밤에 무서워함          | 3~5세 상상력 발달의 결과                  | 부정하지 말고 <b>통제감</b> 주기 (수면등, 문 열어두기)                     | 일상 기능에 지장, 극심한 회피                  |

## 🚩 39장의 요약 3줄

1. 손가락 빨기·애착 인형·말더듬·틱 — **대부분 정상이고 지적하지 않는 것이 대응**입니다.
2. 유아기 자위 행동은 **성적 의미가 없습니다.** 야단치거나 창피 주지 마세요.
3. 울다가 숨을 멈추는 일은 **첫 발생 시 반드시 진료를** 받으세요(빈혈·심장 감별).

## 40장 · 정보의 진위를 가리는 법

### 3단계 확인

|     |            |                                    |
|-----|------------|------------------------------------|
| 1단계 | 누가 말했는가?   | 학회·공공기관인가, 개인·업체인가                 |
| 2단계 | 원 출처가 있는가? | "연구에 따르면"만 있고 링크가 없으면 신뢰도를 낮춘다     |
| 3단계 | 1차 출처에서 확인 | AAP / CDC / WHO / 질병관리청이 같은 말을 하는가 |

### 위험 신호 체크리스트

- ☐ 제품을 팔고 있다 — 특히 그 제품이 유일한 해결책인 것처럼 말할 때
- ☐ "의사들이 알려주지 않는", "충격적인 진실"
- ☐ 단정적·극단적 — "절대", "무조건", "이것만"
- ☐ 출처가 없거나 어떤 연구인지 없다
- ☐ 한 편의 연구만, 특히 표본이 작은 연구만
- ☐ 상관을 인과로 말한다
- ☐ 공포를 이용한다 — "골든타임을 놓치면"
- ☐ 학회 권고와 배치되는데 이유를 설명하지 않는다
- ☐ 자격이 불분명하다
- ☐ 후기·댓글이 유일한 근거다

### 특히 조심할 네 영역

| 영역             | 왜                                    |
|----------------|--------------------------------------|
| 조기교육·영재교육      | 공포 마케팅이 가장 심합니다. "골든타임" 프레임을 경계하세요   |
| 건강기능식품         | 규제가 느슨하고 효과 근거가 약한 경우가 많습니다          |
| 수면·이유식 유료 프로그램 | 효과가 있는 것도 있지만 무료 공공 자료로 대부분 대체 가능합니다 |
| 대체의학           | 예방접종 반대 정보가 섞여 들어오는 주요 경로입니다         |

### 상충할 때의 결정 규칙

- 안전 (수면·카시트·접종·삼킴)
  - 학회 권고를 그대로 따른다. 개인 판단의 여지를 두지 않는다.
- 건강·의학적 판단
  - 담당 소아과를 우선한다. 불안하면 2차 소견을 받는다.
- 교육·훈육
  - 근거 있는 여러 방법 중 우리 아이 기질과 우리 집 상황에 맞는 것. 정답 하나는 없다.
- 제품 구매
  - 기본값은 "안 산다". 필요성이 증명되면 그때 산다.



## 신뢰할 출처

### 한국

| 곳                            | 용도                |
|------------------------------|-------------------|
| 질병관리청 예방접종도우미 nip.kdca.go.kr | 접종                |
| 국민건강보험공단 nhis.or.kr          | 검진                |
| 아이사랑 childcare.go.kr         | 보육                |
| 복지로 bokjiro.go.kr            | 지원금               |
| 응급의료포털 e-gen.or.kr           | 야간·휴일 진료, 달빛어린이병원 |
| 국가건강정보포털 health.kdca.go.kr   | 질환 정보             |
| 대한소아청소년과학회                   | 진료지침              |
| 제품안전정보센터 safetykorea.kr      | 카시트·유모차 리콜 확인     |

### 국제

| 곳                               | 특징                       |
|---------------------------------|--------------------------|
| AAP HealthyChildren.org         | 가장 실용적인 부모용 1차 자료        |
| CDC Learn the Signs. Act Early. | 발달 이정표(2022 개정), 무료 추적 앱 |
| WHO                             | 신체활동·수면 가이드라인, 성장기준      |
| 하버드 아동발달센터                      | Serve and Return, 실행기능   |
| NHS (영국)                        | 균형 잡히고 읽기 쉬움             |
| Cochrane Library                | 체계적 고찰 — 최고 수준의 근거       |

## 이 책이 인용한 주요 근거

| 주제       | 근거                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 발달 이정표   | CDC *Learn the Signs. Act Early.* 2022 개정 (75백분위)           |
| 안전한 수면   | AAP *Sleep-Related Infant Deaths* (2022)                    |
| 훈육·체벌    | AAP *Effective Discipline to Raise Healthy Children* (2018) |
| 놀이의 가치   | AAP *The Power of Play* (2018)                              |
| 미디어      | AAP *Media and Young Minds* / WHO (2019)                    |
| 신체활동·수면  | WHO 5세 미만 가이드라인 (2019)                                      |
| 대화 차례와 뇌 | Romeo et al., *Psychological Science* (2018)                |
| 대화식 책읽기  | Whitehurst — dialogic reading (PEER/CROWD)                  |
| 땅콩 조기 도입 | Du Toit et al., LEAP study, *NEJM* (2015)                   |
| 자폐 선별    | M-CHAT-R/F, AAP 18·24개월 권고                                  |
| 애착       | Bowlby, Ainsworth, Circle of Security                       |
| 기질       | Thomas & Chess, 뉴욕종단연구                                      |
| 근접발달영역   | Vygotsky                                                    |
| 과정 칭찬    | Dweck; Gunderson et al. (2013)                              |

| 주제        | 근거               |
|-----------|------------------|
| 감정 코칭     | Gottman          |
| 수 감각 보드게임 | Ramani & Siegler |
| 발달선별      | K-DST (국민건강보험공단) |
| 예방접종      | 질병관리청 표준예방접종일정표  |

## 이 책의 한계

- 정리 시점 기준이며 정책·권고는 변경됩니다
- 한국 제도 내용은 개요이며 지자체별로 상이할 수 있습니다
- 의학적 진단·치료를 대체하지 않습니다
- 발달의 정상 범위는 넓습니다. 이정표는 기준이지 목표가 아닙니다

### 40장의 요약 3줄

1. 3단계 — 누가 말했나 / 원 출처가 있나 / 1차 출처가 같은 말을 하나.
2. 공포를 파는 정보는 대개 무언가를 함께 팝니다. "골든타임"이 대표적입니다.
3. 이 책도 같은 기준을 받습니다 → 부록 M · 이 책의 출처

### 7부의 요약 3줄

1. 퇴행 · 좌우 비대칭 · 근긴장 이상은 나이와 무관하게 즉시 평가 대상이다.
2. 걱정 목록만큼 걱정하지 않아도 되는 목록도 중요하다.
3. 안전은 학회 권고 그대로, 교육은 우리 아이에 맞게, 제품은 기본값이 "안 산다".

→ 다음: 부록

## 부록

복사해서 쓰는 부분입니다. 냉장고, 아이 방문, 조부모 댁에 붙이세요.

## 부록 A · 시기별 준비물 마스터

### 원칙 세 가지

1. 기본값은 "안 산다". 필요해진 다음에 사도 늦지 않습니다
2. 안전 관련에는 돈을 아끼지 않습니다. 그 외에는 아껴도 됩니다
3. 아이는 물건이 아니라 부모의 시간과 여유를 필요로 합니다

대여·중고를 적극 활용하되 카시트와 매트리스는 새것으로.

### 출산 전 (필수)

안전 — 카시트(뒤보기) · 아기 잠자리 + 단단하고 평평한 매트리스 · 방수패드 2 · 시트 2~3 · 수면조끼 **수유** — 젖병 2~3 + 신생아 젖꼭지 · 세척솔 · 소독 · 분유 1통 · 수유패드 · 유두 크림 · 수유쿠션 **기저귀·목욕** — 기저귀 1팩(대량 금지) · 물티슈 · 갈이 매트 · 욕조 · 순한 세정제 · 보습제 · 가제수건 10 · 손톱가위 · **코 흡입기** · **체온계(직장·구강 겸용 포함)** **의류** — 배냇저고리 5~7 · 우주복 2~3 · 속싸개 2~3 · 손싸개 · 모자 · 양말 **기타** — 아기 세제 · 건조대 · 기저귀 휴지통 · 수유등 · **그림책 5권**

### 시기별 추가

| 시기      | 추가                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4~6개월   | 이유식 의자(5점식 벨트) · 실리콘 숟가락 · 흡착 그릇 · 방수 턱받이 · 치발기 · <b>아기 칫솔 + 불소치약</b> · 빨대컵/오픈컵 · 놀이매트 |
| 7~12개월  | <b>안전용품 일체</b> · 큰 블록 · 넣기/빼기 · 공 · 밀기 장난감 · 목욕 장난감 · 욕조 미끄럼방지 · 실외용 신발                |
| 13~24개월 | 굵은 크레용 · 큰 도화지 · 3~6조각 퍼즐 · 라이드온 · 유아 식기 · <b>낮은 책장</b> · 낮은 옷걸이·발판 · 안전모              |
| 24~36개월 | 유아 변기 + 발판 · 팬티 · 역할놀이 소품 · 나무/자석 블록 · 안전 가위 · 세발자전거                                   |
| 만 3~5세  | 보드게임 · 레고 · 구슬 꿰기 · 자전거 + 안전모 · 줄넘기 · 짧은 챗터북 · 아이 키 책상(발이 바닥에 닿는)                      |

### ❌ 사면 안 되는 것 (안전)

보행기 · 아기침대 범퍼 · 수면 포지셔너 · **경사형 수면기구** · 이얹이 목걸이 · 만 1세 미만 베개 · 중고 카시트 · SIDS 예방 표방 웨어러블 모니터

### ❌ 굳이 필요 없는 것

신생아 신발 · 흑백 모빌 세트 · 젖병 소독기 · 분유 제조기 · 물티슈 워머 · 대형 놀이매트 세트 · **전자 학습교구** · 플래시카드·한글/영어 조기교육 전집 · 고가 두뇌개발 교구

## 돈 쓸 우선순위

|     |        |                          |
|-----|--------|--------------------------|
| 1순위 | 안전     | 카시트, 안전한 잠자리, 가구 고정, 안전문 |
| 2순위 | 부모의 회복 | 산후도우미, 식사 배달, 가사도우미      |
| 3순위 | 책      |                          |
| 4순위 | 이동     | 유모차, 아기띠                 |
| 5순위 | 그 외    |                          |

## 출산 선물로 요청하면 좋은 것

그림책 · 기저귀·물티슈 · 식사 배달 기프티콘 · 청소 서비스 이용권 · 다음 사이즈 옷

## 부록 B · 5년 캘린더

출산 전에 달력 앱에 전부 등록하세요.

| 시점          | 할 일                          | <input type="checkbox"/> |
|-------------|------------------------------|--------------------------|
| 생후 4주 이내    | BCG 접종                       | <input type="checkbox"/> |
| 생후 1개월 이내   | 출생신고 + 행복출산 원스톱              | <input type="checkbox"/> |
| 생후 14~35일   | 영유아 건강검진 1차                  | <input type="checkbox"/> |
| 생후 1개월      | B형간염 2차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 2개월      | DTaP-IPV·Hib·PCV·로타 1차       | <input type="checkbox"/> |
| 생후 4개월      | 2차 접종 세트                     | <input type="checkbox"/> |
| 생후 4~6개월    | 건강검진 2차 (K-DST 시작)           | <input type="checkbox"/> |
| 생후 6개월      | 3차 접종 세트 + B형간염 3차           | <input type="checkbox"/> |
| 생후 6개월~     | 인플루엔자 (매년 가을)                | <input type="checkbox"/> |
| 생후 9~12개월   | 건강검진 3차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 12~15개월  | MMR·수두·A형간염·일본뇌염·Hib·PCV     | <input type="checkbox"/> |
| 생후 18개월     | 자폐 선별(M-CHAT) 요청             | <input type="checkbox"/> |
| 생후 15~18개월  | DTaP 4차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 18~24개월  | 건강검진 4차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 18~29개월  | 구강검진 1차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 24개월     | 자폐 선별 재확인                    | <input type="checkbox"/> |
| 생후 30~36개월  | 건강검진 5차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 30~41개월  | 구강검진 2차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 42~48개월  | 건강검진 6차 (+시력)                | <input type="checkbox"/> |
| 생후 42~53개월  | 구강검진 3차                      | <input type="checkbox"/> |
| 만 4~6세      | DTaP 5차·IPV 4차·MMR 2차 (취학 전) | <input type="checkbox"/> |
| 생후 54~60개월  | 건강검진 7차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 54~65개월  | 구강검진 4차                      | <input type="checkbox"/> |
| 생후 66~71개월  | 건강검진 8차                      | <input type="checkbox"/> |
| 첫니 후 6개월 이내 | 첫 치과 방문 (이후 6개월마다)           | <input type="checkbox"/> |

접종은 예방접종도우미에 자녀를 등록하면 자동 관리됩니다.

## 부록 C · 월간 점검표

**17** 월령: \_\_\_\_\_개월      날짜: \_\_\_\_\_

### ■ 발달 이정표 (해당 월령 장 확인)

대근육    가능 / 부분 / 아직    메모:  
소근육    가능 / 부분 / 아직    메모:  
언어      가능 / 부분 / 아직    메모:  
인지      가능 / 부분 / 아직    메모:  
사회정서    가능 / 부분 / 아직    메모:

### ■ 경고 신호 (37장)

☐ 해당 없음  
☐ 있음 → 무엇:  
→ 조치: ☐ 관찰    ☐ 소아과 예약 (\_\_\_\_/\_\_\_\_)

### ■ 이번 달 처음 한 것

첫 \_\_\_\_\_ 날짜: \_\_\_\_\_

### ■ 부모

수면: 하루 평균 \_\_\_\_시간  
기분(1~5): 나 \_\_\_\_ 배우자 \_\_\_\_  
☐ 2주 이상 우울·불안이 지속되고 있다 → 상담 예약

### ■ 습관 점검

☐ 매일 책을 읽고 있다  
☐ 하루 실외 활동을 하고 있다  
☐ 화면 노출이 기준 안에 있다  
☐ 안전 점검이 현재 월령에 맞다

### ■ 다음 달

☐ 예방접종:      ☐ 검진:      ☐ 준비물:

## 부록 D · 병원 방문 준비 시트

방문일: \_\_\_\_\_ 월령: \_\_\_\_\_개월 체중: \_\_\_\_\_kg

■ 오늘 물어볼 것 (3개까지)

- 1.
- 2.
- 3.

■ 걱정되는 것 - 구체적으로

언제부터:

얼마나 자주:

어떤 상황에서:

영상 촬영했는가? ☐ 예 ☐ 아니오

■ 현재 상태

수유/식사:

수면:

배변:

복용 중인 약:

■ 반드시 물을 질문

"다음에 무엇을 보면 다시 와야 하나요?"

"언제 다시 확인해야 하나요?"

■ 의사 답변 메모

\_\_\_\_\_

## 부록 E · 응급 대응 한 장 — 채워서 붙이는 양식

119 응급                      1339 응급의료 상담(24시간)

소아 응급실 ①: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 소아 응급실 ②: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 다니는 소아과: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 달빛어린이병원: \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 (e-gen.or.kr에서 확인)

아이 이름 \_\_\_\_\_ 생년월일 \_\_\_\_\_  
 체중 \_\_\_\_\_kg (기준일 \_\_\_\_\_)  
 알레르기 \_\_\_\_\_  
 복용약 \_\_\_\_\_

해열제 용량 (의사에게 확인해 기입)  
 아세트아미노펜 \_\_\_\_\_mL / \_\_\_\_\_시간 간격  
 이부프로펜(6개월~) \_\_\_\_\_mL / \_\_\_\_\_시간

집 주소 (구급대에게 불러줄 정확한 주소)  
 \_\_\_\_\_

### — 즉시 응급실 —

- 3개월 미만 + 38℃ 이상
- hamulhooh · 신음 · 입술이 파래짐
- 경련 5분 이상 · 깨워도 반응 약함
- 눌러도 안 사라지는 붉은 반점
- 초록색 구토 · 혈변 · 점액혈변
- 버튼전지·자석 삼킴 (무증상이어도)

### — 경련 시 —

- ① 옆으로 눕힌다 ② 시간을 잰다
- ③ 입에 아무것도 넣지 않는다
- ④ 붙잡지 않는다 ⑤ 5분 넘으면 119

### — 기도폐쇄 —

- 기침·소리 0 → 개입하지 않는다  
 소리 X, 파래짐 →  
 1세 미만: 등 5회 → 가슴 5회  
 1세 이상: 하임리히



## 부록 F · 부부 합의서

우리는 아래에 합의합니다.

### 1. 야간 담당 방식

### 2. 각자의 주간 회복 시간

나: 요일 \_\_\_\_ 시간

배우자: 요일 \_\_\_\_ 시간

### 3. 2주 이상 우울·불안이 지속되면 서로에게 알리고 병원에 간다.

### 4. 아이에게 체벌하지 않는다.

### 5. 안전 수칙(수면·카시트)은 누구에게도 예외를 두지 않는다.

### 6. 힘들 때 "괜찮다"고 말하지 않고 도움을 요청한다.

### 7. 주 1회 15분 점검 대화를 한다. 요일: \_\_\_\_\_

#### ■ 담당 영역

예방접종·검진 관리/예약 \_\_\_\_\_

기저귀·분유 재고/주문 \_\_\_\_\_

목욕 \_\_\_\_\_

병원 동행 \_\_\_\_\_

어린이집 준비물·연락 \_\_\_\_\_

식사 준비 \_\_\_\_\_

청소·빨래 \_\_\_\_\_

아이 옷 사이즈 확인·구매 \_\_\_\_\_

서명: \_\_\_\_\_ 날짜: \_\_\_\_\_

## 부록 G · 조부모·양육자 위임 한 장

복사해서 아이를 맡길 때 함께 전달하세요.

### ■ 타협 불가 6가지

1. 재울 때는 반드시 등을 대고 눕힌다  
(만 1세까지, 낮잠 포함)
2. 잠자리에 베개·이불·인형을 두지 않는다
3. 차에 탈 때는 언제나 카시트. 예외 없음
4. 때리거나 소리 지르지 않는다
5. 만 1세 전에는 꿀을 주지 않는다
6. 실내외에서 담배 연기에 노출시키지 않는다

### ■ 질식 위험 - 이렇게 잘라주세요

포도·방울토마토 → 세로로 4등분

소시지 → 세로로 갈라서

견과류 → 통째로 주지 않기

떡·사탕·팝콘 → 주지 않기

먹을 때는 앉아서, 지켜보면서

### ■ 우리 아이

이름 \_\_\_\_\_ 월령 \_\_\_\_\_ 체중 \_\_\_\_\_kg

알레르기 \_\_\_\_\_

복용약 \_\_\_\_\_

### ■ 하루 일과

수유/식사 시간 \_\_\_\_\_

낮잠 \_\_\_\_\_

잠자리 루틴 \_\_\_\_\_

### ■ 달래는 방법

\_\_\_\_\_

### ■ 화면

만 2세 미만은 영상통화 외 보여주지 않기

그 이후에도 하루 1시간 이내

### ■ 연락처

엄마 \_\_\_\_\_ 아빠 \_\_\_\_\_

소아과 \_\_\_\_\_ 119 / 1339

집 주소 \_\_\_\_\_

## 부록 H · 여아 건강·위생 요약

| 시기     | 알아둘 것                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 신생아    | 생후 며칠 내 <b>소량의 질 분비물·출혈</b> 은 모체 호르몬에 의한 정상. 유방이 약간 부푸는 것도 정상 — <b>짜지 마세요</b>       |
| 기저귀 시기 | <b>앞에서 뒤로</b> 닦기 · 물티슈 과다 사용 피하기(대변이 아니면 물수건) · 자주 갈고 <b>통풍</b>                     |
| 목욕     | 외음부는 <b>겉면만</b> · 안쪽은 <b>씻지 않습니다</b> · 비누 최소 · <b>거품 목욕·입욕제 피하기</b> · 씻은 뒤 완전히 건조   |
| 영유아기   | 음순유착 — 드물지 않고 대개 저절로 호전. <b>무리하게 벌리지 마세요</b> . 소변이 잘 나오면 대개 경과 관찰                   |
| 배변 훈련기 | " <b>앞에서 뒤로</b> "를 손 위에 손을 얹어 가르치기 · <b>면 팬티</b> · 젖은 옷 · 수영복 오래 입히지 않기             |
| 만 3~5세 | <b>유아 외음질염</b> 이 가장 흔한 시기. 원인은 대개 감염이 아니라 <b>자극</b> (거품 목욕, 향 강한 비누, 꽉 끼는 옷, 닦는 방향) |

### 진료가 필요한 신호

- 설명되지 않는 발열이 유일한 증상 → **요로감염** 의심 (여아에서 더 흔합니다)
- 소변 볼 때 아파하거나 소변을 참는다
- 외음부가 붉고 가렵다고 하거나 자꾸 만진다
- 분비물에 냄새가 나거나 색이 있다
- 배변 훈련이 끝난 아이의 **갑작스러운 야뇨 재발**

### 요로감염 예방

앞에서 뒤로 닦기 · 소변 참지 않기 · 충분한 수분 · **변비 관리**(변비가 위험을 높입니다) · 거품 목욕과 꽉 끼는 옷 피하기

# 부록 I · 성장 기록 · 첫 순간

## 성장 기록

| 월령 | 키(cm) | 체중(kg) | 머리둘레 | 백분위 | 메모 |
|----|-------|--------|------|-----|----|
| 출생 |       |        |      |     |    |
| 1  |       |        |      |     |    |
| 2  |       |        |      |     |    |
| 4  |       |        |      |     |    |
| 6  |       |        |      |     |    |
| 9  |       |        |      |     |    |
| 12 |       |        |      |     |    |
| 18 |       |        |      |     |    |
| 24 |       |        |      |     |    |
| 36 |       |        |      |     |    |

한 시점의 백분위보다 **추세**가 중요합니다. 두 개 이상의 주요 백분위선을 가로질러 떨어지면 상담하세요.

## 첫 순간

|           |            |      |
|-----------|------------|------|
| 첫 미소(사회적) | ___개월 ___일 | 상황:  |
| 첫 웅얼이     | ___개월 ___일 |      |
| 목 가누기     | ___개월 ___일 |      |
| 첫 뒤집기     | ___개월 ___일 |      |
| 혼자 앉기     | ___개월 ___일 |      |
| 첫 이유식     | ___개월 ___일 | 무엇:  |
| 첫니        | ___개월 ___일 |      |
| 기기 시작     | ___개월 ___일 |      |
| 첫 가리키기    | ___개월 ___일 | 무엇을: |
| 잡고 서기     | ___개월 ___일 |      |
| 첫 낱말      | ___개월 ___일 | 무엇:  |
| 첫 걸음      | ___개월 ___일 |      |
| 두 낱말 문장   | ___개월 ___일 | 무엇:  |
| 첫 이름 말하기  | ___개월 ___일 |      |
| 배변 성공     | ___개월 ___일 |      |

## 부록 J · 기관 연락처

| 곳         | 연락처 / 주소               | 용도               |
|-----------|------------------------|------------------|
| 119       | 119                    | 응급               |
| 1339      | 1339                   | 응급의료 상담 (24시간)   |
| 129       | 129                    | 보건복지상담센터         |
| 1577-0199 | 1577-0199              | 정신건강 위기상담 (24시간) |
| 109       | 109                    | 자살예방상담           |
| 예방접종도우미   | nip.kdca.go.kr         | 접종 일정·기록         |
| 국민건강보험공단  | nhis.or.kr / The건강보험 앱 | 검진               |
| 아이사랑      | childcare.go.kr        | 어린이집             |
| 처음학교로     |                        | 유치원              |
| 복지로       | bokjiro.go.kr          | 지원금              |
| 정부24      | gov.kr                 | 출생신고, 행복출산 원스톱   |
| 응급의료포털    | e-gen.or.kr            | 달빛어린이병원          |
| 제품안전정보센터  | safetykorea.kr         | 카시트·유모차 리콜       |

## 우리 동네

소아과 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 달빛어린이병원 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 소아 응급실 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 보건소 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 육아종합지원센터 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_  
 주민센터 \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_

## 부록 K · 환경 · 이동

### 실내 환경

- 온도 20~22℃ 전후, 습도 40~60%
- 아기에게는 **어른보다 한 겹 덜** 입힙니다. 목덜미가 땀에 젖으면 과열입니다
- 이불 대신 수면조끼

### 미세먼지

- 예보를 확인하고 **나쁨 이상이면 실외 활동을 조정**합니다
- 다만 **실외 활동은 근시 예방과 발달에 중요**하므로, 무조건 실내에만 두는 것도 좋지 않습니다. 시간대와 장소를 조정하세요
- 영유아에게 성인용 마스크는 적절하지 않습니다. 호흡을 방해할 수 있으니 착용 여부는 신중히
- 환기는 대기 상태가 나은 시간대에 짧게

### 자외선

- 생후 6개월 미만은 자외선차단제 사용을 권하지 않습니다. 그늘, 긴 옷, 모자로 가리세요
- 6개월 이후에는 얼굴·손등 등 가릴 수 없는 부위에 소량 사용 가능
- 오전 10시~오후 3시 직사광선 피하기

### 이동

| 상황     | 요령                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 장거리 차량 | 2시간마다 정차. 카시트에서 오래 자게 두지 않기(신생아는 각도상 호흡 위험). 뒷좌석에 어른 한 명  |
| 비행기    | 이착륙 시 <b>빨기</b> (수유·꼭꼭이·빨대컵)로 귀 압력 완화. 기저귀·옷 여벌 넉넉히       |
| 대중교통   | 아기띠가 유모차보다 편한 경우가 많습니다                                    |
| 명절 이동  | 낮잠 시간에 맞춰 출발. 도착 후 <b>잠자리 환경을 최대한 비슷하게</b> (같은 이불, 같은 인형) |

공통: 이동 중에도 **취침 루틴의 순서**는 유지하세요. 장소가 바뀌어도 순서가 같으면 아이가 안정됩니다.

## 부록 L · 이 책 활용 순서

---

출산 전    여는 글 → 10장 → 부록 A·B·E·F  
          + 부록 B 캘린더를 달력 앱에 전부 등록

첫 40p    1부 + 2부 - 이 책의 핵심

매달       부록 C 월간 점검표 (5분)

검진 전    30장 + 부록 D 병원 준비 시트

아플 때    20장(열) → 21장(흔한 병) → 필요 시 22장

걱정될 때 37장 경고 신호 → 소아과

월령 바뀔 때 3부에서 해당 장 하나만

정보를 만났을 때 40장 판별 체크리스트

아이 말길 때 부록 G를 복사해 전달

# 부록 M · 이 책의 출처

이 책은 4장에서 "출처가 없는 정보를 의심하라"고 말하고, 40장에서 "'○○ 연구에 따르면'만 있고 어떤 연구인지 없는 글"을 위험 신호로 지목합니다. 그렇다면 이 책도 같은 기준을 통과해야 합니다.

아래는 본문에서 **강함** 또는 **보통** 태그를 붙인 문장의 근거입니다. 논문 전체 목록이 아니라, **판단이 걸린 지점만** 골랐습니다.

## 안전 — 이 책이 "타협하지 말라"고 말한 것들

| 본문 주장                                         | 근거                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 등을 대고, 평평한 곳에, 잠자리엔 아무것도 · 같은 방 다른 잠자리 6~12개월 | AAP, *Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment*, Pediatrics (2022) |
| 뒤보기 카시트를 최대한 오래                               | AAP, *Child Passenger Safety* 정책성명                                                                                                      |
| 보행기 사용 금지                                     | AAP, *Injuries Associated With Infant Walkers*                                                                                          |
| 만 1세 전 꿀 금지                                   | 영아 보툴리누스증 — 질병관리청·CDC 공동 권고                                                                                                             |

## 발달 이정표

| 본문 주장                    | 근거                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 책의 모든 월령 이정표(75백분위 기준) | CDC, *Learn the Signs. Act Early.* 2022 개정판 — Zubler et al., *Evidence-Informed Milestones for Developmental Surveillance Tools*, Pediatrics (2022) |
| K-DST 6개 영역·4단계 판정       | 국민건강보험공단 영유아 건강검진 발달평가 도구                                                                                                                           |
| 18·24개월 자폐 보편적 선별        | AAP, *Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder* (2020) / M-CHAT-R/F                                     |

## 언어와 놀이

| 본문 주장                                          | 근거                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단어 총량보다 <b>주고받은 대화 차례</b> 가 언어·뇌를 예측 <b>강함</b> | Romeo et al., *Beyond the 30-Million-Word Gap: Children's Conversational Exposure Is Associated With Language-Related Brain Function*, Psychological Science (2018) |
| 대화식 책읽기(PEER/CROWD)가 표현 언어를 향상 <b>강함</b>       | Whitehurst et al., dialogic reading 연구군                                                                                                                             |
| 2세 미만은 화면에서 학습을 거의 전이하지 못함 <b>강함</b>           | video deficit effect 연구군 · AAP, *Media and Young Minds* (2016)                                                                                                      |
| 놀이가 발달의 핵심 기전 <b>[보통~강함]</b>                   | AAP 임상보고서, *The Power of Play* (2018)                                                                                                                               |
| 선형 보드게임이 수 감각을 향상 <b>강함</b>                    | Ramani & Siegler, 무작위 시험                                                                                                                                            |
| 신체활동·수면·좌식 권고 수칙                               | WHO, *Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age* (2019)                                                      |



## 훈육과 정서

| 본문 주장                         | 근거                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 체벌은 효과가 없고 해롭다 <b>강함</b>      | AAP 정책성명, *Effective Discipline to Raise Healthy Children* (2018) |
| 한국에서 부모 징계권 조항 삭제             | 민법 제915조 삭제 (2021)                                                |
| 과정 칭찬이 이후 도전을 견디게 함 <b>보통</b> | Gunderson et al., 종단연구 (2013) · Dweck                             |
| 감정 코칭 5단계 <b>보통</b>           | Gottman, *Raising an Emotionally Intelligent Child*               |
| 안전기지·회복(rupture and repair)   | Bowlby · Ainsworth · Tronick(Still Face) · Circle of Security     |
| 기질 3유형과 궁합                    | Thomas & Chess, 뉴욕종단연구                                            |
| 근접발달영역·비계 설정                  | Vygotsky                                                          |

## 먹이기

| 본문 주장                                      | 근거                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 알레르기 유발 식품을 늦추지 않고 이른 시기에 도입 <b>강함</b>     | Du Toit et al., *Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy* (LEAP), NEJM (2015) |
| 분말 분유를 70℃ 이상 물로 조제                        | WHO, *Safe Preparation, Storage and Handling of Powdered Infant Formula*                                           |
| 완전 모유수유아 비타민 D 400 IU/일                    | AAP 권고                                                                                                             |
| 책임 분담 모델(부모는 무엇·언제·어디서, 아이는 얼마나) <b>보통</b> | Ellyn Satter, Division of Responsibility in Feeding                                                                |

## 부모

| 본문 주장                             | 근거                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 산모 우울 치료가 아이의 발달 결과도 개선 <b>강함</b> | 산후우울 개입 연구군 (STAR*D-Child 등)                          |
| EPDS 10문항·절단점                     | Cox et al., Edinburgh Postnatal Depression Scale      |
| 질 좋은 보육에서 안정 애착이 형성됨              | NICHD Study of Early Child Care and Youth Development |

## 이 책이 "근거가 흔들린다"고 표시한 것들

균형을 위해, 유명하지만 재현이 약한 연구도 그대로 적어둡니다.

| 주장            | 현재 상태                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 마시멜로 테스트의 예측력 | Watts, Duncan & Quan (2018) 재현 연구에서 가정 배경 통제 시 예측력이 크게 감소              |
| 3천만 단어 격차     | Hart & Risley (1995) — 표본 42가구, 후속 재현이 부분적                             |
| 모차르트 효과       | 유아 IQ 상승 근거 사실상 없음                                                     |
| MMR 백신과 자폐    | Wakefield (1998) <b>철회됨</b> , 저자 면허 박탈. 이후 대규모 연구에서 반복적으로 부정 <b>강함</b> |

## 한국 제도 (정책은 바뀝니다)

이 부분은 **출처가 아니라 확인**처입니다. 이 책은 금액과 세부 조건을 본문에 적지 않았습니다.

| 항목                  | 확인처                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 예방접종 표준일정           | 질병관리청 예방접종도우미 <a href="http://nip.kdca.go.kr">nip.kdca.go.kr</a> |
| 영유아 건강검진 8차 + 구강 4차 | 국민건강보험공단 <a href="http://nhis.or.kr">nhis.or.kr</a>              |
| 현금성·서비스 지원          | 복지로 <a href="http://bokjiro.go.kr">bokjiro.go.kr</a>             |
| 야간·휴일 소아진료          | 응급의료포털 <a href="http://e-gen.or.kr">e-gen.or.kr</a> (달빛어린이병원)    |

**한계를 밝힙니다.** 위 목록은 본문의 모든 문장을 덮지 않습니다. 태그가 붙지 않은 문장은 대개 학회 자료의 일반적 내용이거나 **관행** 수준입니다. 그리고 이 책은 원 논문을 전수 검토한 것이 아니라 **학회·공공기관의 권고문을 옮긴** 것입니다. 그 한계를 알고 읽어주세요.

## ♥ 닫는 글

### 다시, 새벽 두 시

이 책은 새벽 두 시로 시작했습니다.

아이가 사십 분째 울고 있고, 당신은 한 손으로 검색창에 "신생아 계속 울 때"를 치고 있었죠. 열 개의 글이 서로 다른 말을 하고, 절반은 무언가를 팔고 있고, 결국 아무것도 결정하지 못한 채 휴대폰을 내려놓았습니다.

이제 5년 뒤의 새벽 두 시를 상상해볼게요.

같은 시각에 문이 열립니다. 여섯 살이 된 아이가 잠옷 바람으로 서 있어요. 무서운 꿈을 꿔대요. 당신은 눈도 제대로 못 뜬 채 이불을 들춰줍니다. 아이가 파고들어 옵니다. 3분 뒤에 다시 잠듭니다.

그게 전부입니다. 그리고 그게 이 책이 말하려던 전부입니다.

**아이는 5년 동안 점점 멀리 나갔고, 여전히 당신에게 돌아옵니다.**

그 밤들이 이걸 만든 거예요. 교구도, 학습지도, 완벽한 하루도 아니고 — 울면 누군가 왔던 수천 번의 반복이요.

### 남기고 싶은 네 문장

아이에게 필요한 건 완벽한 부모가 아닙니다. 돌아올 자리가 되어주는, 웬만큼 안정된 어른 한 명이면 됩니다. 그 자리는 화려할 필요도, 늘 열려 있을 필요도 없어요. 아이가 돌아왔을 때 **거기 있기만 하면** 됩니다.

**힘든 게 정상입니다.** 잠을 못 자서 판단이 흐려지고, 아이 울음에 화가 나고, 어떤 날은 아이가 밉기도 할 거예요. 그건 당신이 나쁜 부모라는 뜻이 아니라, **사람이 감당하기 벅찬 일을 하고 있다는** 뜻입니다.

**실수는 회복으로 갚으면 됩니다.** 소리를 질렀다면 사과하세요. 그 과정이 아이에게 "관계는 깨져도 고칠 수 있다"를 가르칩니다. 한 번도 어긋나지 않은 관계에서는 배울 수 없는 것이예요.

**그리고 이 모든 시기는 지나갑니다.** 지금 끝나지 않을 것 같은 밤도, 6주쯤 지나면 다르게 느껴질 거예요. 지금 하루에 열 번 떼쓰는 아이도, 몇 달 뒤엔 문장으로 자기 마음을 말하게 됩니다.

### 👉 내일 아침에 할 한 가지

이 책을 덮고 나서 할 일은 하나면 충분합니다. 아이 월령에 맞는 것 하나만 고르세요.

| 지금      | 내일 아침에 할 한 가지                                  |
|---------|------------------------------------------------|
| 출산 전    | 카시트를 차에 장착해보세요. 설명서를 펴고 30분이면 됩니다              |
| 0~3개월   | 아기가 소리를 내면 <b>똑같이 따라 하고 5초 기다려</b> 보세요. 딱 한 번만 |
| 4~6개월   | 첫니가 났다면 오늘 저녁에 칫솔을 사세요                         |
| 7~12개월  | 무릎으로 앉아 거실을 한 바퀴 둘러보세요. 치울 것이 보일 거예요           |
| 13~24개월 | 아이가 한 단어를 말하면 <b>한 단어를 더 붙여</b> 돌려주세요          |
| 24~36개월 | 아이가 울면 첫 마디를 "괜찮아" 대신 <b>감정 이름</b> 으로 시작해보세요   |
| 만 3~5세  | 저녁 식탁에서 "오늘 뭐가 제일 재미있었어?"를 물어보세요               |
| 모든 시기   | 부록 E를 인쇄해 냉장고에 붙이세요. 5분이면 됩니다                  |

그리고 오늘 아무것도 못 한 것 같은 날이라면, 이렇게 세어보세요.

**아이를 먹였고, 재웠고, 안아줬다면 — 오늘 할 일은 다 하신 겁니다.**

축하드립니다. 그리고 응원합니다.

# 색인

증상·주제 가나다순. 급할 때는 여기서 찾으세요.

## ㄱ

| 항목           | 위치           |
|--------------|--------------|
| 가리키기 (공동주의)  | 13장 · 37장    |
| 가와사키병        | 20장 · 37장    |
| 감기           | 21장          |
| 감정 코칭        | 6장 · 15장     |
| 거짓말          | 7장 · 16장     |
| 건강검진 (영유아)   | 30장 · 부록 B   |
| 결막염          | 21장          |
| 경련 (열성경련)    | 20장 · 부록 E   |
| 경고 신호 (발달)   | 37장 · 각 시기 장 |
| 공동주의         | 13장          |
| 구내염          | 21장          |
| 구강검진         | 30장 · 부록 B   |
| 기도폐쇄         | 22장 · 부록 E   |
| 기저귀 발진       | 23장          |
| 기질           | 3장           |
| 까꿍놀이 (대상영속성) | 12장 · 13장    |
| 꿀 (만 1세 금지)  | 17장 · 18장    |

## ㄴ ~ ㄷ

| 항목                   | 위치        |
|----------------------|-----------|
| 낮잠 전환                | 19장       |
| 낮가림                  | 13장       |
| 네 박자 ★               | 5장        |
| 놀이                   | 9장        |
| 눈 물림 (사시)            | 12장 · 16장 |
| 달빛어린이병원              | 35장       |
| 대상영속성                | 13장       |
| 대화식 책읽기 (PEER/CROWD) | 9장 · 14장  |
| 두부 외상                | 22장       |
| 떼쓰기 (탠트럼)            | 6장 · 14장  |

| 항목             | 위치         |
|----------------|------------|
| 말더듬            | 39장        |
| 머리 부딪힘         | 22장        |
| 모세기관지염 (RSV)   | 21장        |
| 모유 보관          | 17장        |
| 무는 행동          | 15장 · 7장   |
| 미세먼지           | 부록 K       |
| 밤중 수유          | 17장 · 19장  |
| 배변 훈련          | 15장 · 14장  |
| 배밀이 자세 (터미 타임) | 11장 · 12장  |
| 버튼형 전지         | 8장 · 22장   |
| 변비             | 21장        |
| 보행기 (금지)       | 8장 · 부록 A  |
| 복직             | 28장        |
| 부모급여·아동수당      | 32장        |
| 부부 갈등          | 26장 · 부록 F |
| 분리불안           | 13장        |
| 분유 조제          | 17장        |

| 항목             | 위치         |
|----------------|------------|
| 산모·신생아 건강관리 지원 | 33장 · 10장  |
| 산모의 몸 회복       | 24장        |
| 산후우울           | 25장        |
| 상징놀이 (가장놀이)    | 9장 · 15장   |
| 성장 곡선          | 30장 · 부록 I |
| 손가락 빨기         | 39장        |
| 수면 교육          | 19장        |
| 수면 안전 (SIDS)   | 8장         |
| 수면 퇴행          | 19장        |
| 수유 (모유·분유)     | 17장        |
| 수족구병           | 21장        |
| 스크린 (화면)       | 8장 · 13장   |
| 시력검사 · 약시      | 16장 · 30장  |
| 실행기능           | 9장 · 16장   |
| 심폐소생술 (CPR)    | 22장        |

| 항목               | 위치            |
|------------------|---------------|
| 아구창              | 21장 · 23장     |
| 아나필락시스           | 22장 · 18장     |
| 아토피 피부염          | 23장           |
| 아이돌봄서비스          | 33장           |
| 안전 점검 (집안)       | 8장            |
| 애타               | 1장            |
| 애타 인형            | 39장           |
| 야경증 vs 악몽        | 19장           |
| 약 먹이기            | 23장           |
| 어린이집             | 34장 · 16장     |
| 언어 발달            | 9장 · 각 시기 장   |
| 여아 건강·위생 ★       | 부록 H · 각 시기 장 |
| 열                | 20장           |
| 열성경련             | 20장           |
| 영양 보충 (비타민 D·철분) | 17장           |
| 예방접종             | 31장 · 부록 B    |
| 외음질염             | 부록 H · 16장    |
| 요로감염             | 21장 · 부록 H    |
| 울음 (신생아)         | 11장           |
| 유선염              | 17장           |
| 유치원              | 34장           |
| 음순유착             | 부록 H · 13장    |
| 이얏이              | 12장 · 23장     |
| 이유식              | 18장 · 12장     |
| 이중언어             | 9장            |
| 인후염              | 21장           |

| 항목             | 위치        |
|----------------|-----------|
| 자석 구슬          | 8장 · 22장  |
| 자위 행동          | 39장       |
| 자폐 선별 (M-CHAT) | 30장 · 14장 |
| 장염 · 경구수액(ORS) | 21장       |
| 조부모 위임         | 부록 G      |
| 죄책감·번아웃        | 27장       |

| 항목         | 위치        |
|------------|-----------|
| 중이염        | 21장       |
| 지원금        | 32장       |
| 질식 위험 음식   | 8장 · 18장  |
| 책 읽기       | 9장        |
| 첫만남이용권     | 32장       |
| 첫 치과 방문    | 23장 · 12장 |
| 체벌 (금지)    | 7장        |
| 출생신고       | 29장       |
| 취침 루틴      | 19장       |
| 치아 관리      | 23장       |
| 치아 외상      | 23장 · 22장 |
| 칭찬 (과정 칭찬) | 7장 · 15장  |

## ㄱ ~ ㅎ

| 항목          | 위치         |
|-------------|------------|
| 카시트         | 8장 · 10장   |
| 크루프         | 21장        |
| 탈수          | 21장 · 37장  |
| 터미 타임       | 11장        |
| 통잠          | 19장        |
| 퇴행 (발달)     | 37장        |
| 틱           | 39장        |
| 편식          | 18장        |
| 피부 문제       | 23장        |
| 하임리히        | 22장        |
| 해열제 (체중 용량) | 20장 · 부록 E |
| 행복출산 원스톱    | 29장        |
| 화상          | 22장        |
| 화면 (스크린)    | 8장         |
| 환경 설계       | 8장         |
| 훈육          | 7장         |
| K-DST       | 30장        |
| M-CHAT      | 30장        |
| RSV         | 21장        |

## 상황별 빠른 찾기

| 지금 상황             | 어디로           |
|-------------------|---------------|
| 아이가 열이 난다         | 20장           |
| 숨을 못 쉰다 / 이물을 삼켰다 | 22장           |
| 토하고 설사한다          | 21장 장염        |
| 밤에 심하게 보챈다        | 21장 중이염       |
| 경경 짚는 기침          | 21장 크루프       |
| 다른 증상 없이 열만 난다    | 21장 요로감염      |
| 땀을 쓴다             | 6장 · 7장       |
| 말이 늦은 것 같다        | 37장 · 해당 시기 장 |
| 잠을 안 잔다           | 19장           |
| 안 먹는다             | 18장           |
| 뭘 사야 할지 모르겠다      | 부록 A          |
| 내가 너무 힘들다         | 5부            |
| 어디서 진료받아야 할지 모르겠다 | 35장           |